

Buku Ajar

KEPERAWATAN PALIATIF

I Gusti Ayu Putu Desy Rohana • Yuliatil Adawiyah Harahap
Weny Amelia • Hery Ernawati • Sri Wianti

Editor: Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.



BUKU AJAR

KEPERAWATAN PALIATIF

Penulis:

Ns. I Gusti Ayu Putu Desy Rohana, M.Kep., Sp.Kep.Kom.

Yuliatil Adawiyah Harahap, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Weny Amelia., M.Kep., Sp.Kep.MB.

Dr. Hery Ernawati, S.Kep., Ners., M.Kep.

Sri Wianti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:

Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU AJAR KEPERAWATAN PALIATIF

Penulis:

Ns. I Gusti Ayu Putu Desy Rohana, M.Kep., Sp.Kep.Kom.
Yuliatil Adawiyah Harahap, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Weny Amelia., M.Kep., Sp.Kep.MB.
Dr. Hery Ernawati, S.Kep., Ners., M.Kep.
Sri Wianti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor: Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-86-2

Cetakan Pertama : September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, buku ajar yang berjudul "Buku Ajar Keperawatan Paliatif" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan paliatif secara komprehensif, humanis, dan berpusat pada pasien serta keluarga.

Keperawatan paliatif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien dengan penyakit kronis, progresif, mengancam jiwa, atau berada pada fase akhir kehidupan. Fokus utama keperawatan paliatif bukan hanya pada penyembuhan penyakit, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga melalui pengendalian gejala, pengurangan penderitaan, dukungan psikologis, sosial, spiritual, budaya, serta pendampingan dalam pengambilan keputusan yang etis.

Dalam praktik keperawatan paliatif, perawat memiliki peran yang sangat penting sebagai pemberi asuhan, pendidik, pendamping, advokat, komunikator, dan anggota tim kolaboratif. Perawat dituntut mampu melakukan pengkajian secara holistik, mengenali kebutuhan pasien secara menyeluruh, memberikan intervensi yang aman dan bermakna, serta membantu pasien dan keluarga menghadapi proses penyakit dengan lebih tenang, bermartabat, dan sesuai nilai yang diyakini.

Buku ajar ini membahas berbagai aspek penting dalam keperawatan paliatif, mulai dari konsep dasar perawatan paliatif, prinsip asuhan holistik, manajemen nyeri dan gejala, komunikasi terapeutik, dukungan psikososial dan spiritual, asuhan budaya, etik dan legal dalam paliatif, perawatan akhir hayat, pendampingan keluarga, hingga penerapan proses keperawatan pada pasien paliatif. Materi disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh mahasiswa dan dapat digunakan dalam pembelajaran teori, diskusi kasus, praktik laboratorium, maupun praktik klinik.

Selain menekankan penguasaan konsep, buku ini juga mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, empati, kepekaan budaya, kemampuan komunikasi, serta sikap profesional dalam menghadapi pasien dan keluarga pada situasi yang kompleks. Dalam keperawatan paliatif, setiap keputusan dan tindakan harus mempertimbangkan kenyamanan pasien, nilai hidup pasien, harapan keluarga, keselamatan pasien, serta prinsip etik seperti otonomi, kebaikan, tidak merugikan, keadilan, kejujuran, kerahasiaan, dan kesetiaan profesional.

Penulis berharap buku ajar ini dapat membantu mahasiswa memahami bahwa keperawatan paliatif bukan sekadar perawatan pada akhir kehidupan, tetapi merupakan pendekatan perawatan yang dapat diberikan sejak pasien mengalami penyakit serius dan membutuhkan dukungan menyeluruh. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan yang tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga memperhatikan penderitaan emosional, sosial, spiritual, dan budaya yang dialami pasien serta keluarga.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kelengkapan materi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi keperawatan, tenaga kesehatan, serta semua pihak yang memiliki perhatian terhadap peningkatan mutu pelayanan keperawatan paliatif.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam penyusunan buku ajar ini. Semoga buku ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam membentuk calon perawat yang profesional, empatik, komunikatif, dan mampu memberikan asuhan paliatif yang bermutu serta bermartabat.

Penulis

Juni, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 GANGGUAN SISTEM RENAL DAN ELIMINASI.....	1
A. Latar Belakang Klinis.....	3
B. Integrasi Kurikulum Berbasis Sub-CPMK.....	3
C. Definisi Dan Klasifikasi Patofisiologis	3
D. Tujuan, Indikasi, Dan Kontraindikasi	4
E. Manajemen Penilaian Luka Paliatif Untuk Menetapkan Tujuan Kenyamanan	5
F. Alat, Bahan, Dan Persiapan Operasional	7
G. Langkah Prosedur Dan Pencegahan Ulkus Tekan.....	8
H. Patient Safety, Komplikasi, Dan Manajemen Risiko	10
I. Evaluasi Indikator Perbaikan Dan Kenyamanan.....	10
J. Teknik Dokumentasi Legal Keperawatan	11
K. Minicase (Studi Kasus Klinis Paliatif)	12
L. Soal Osce Keperawatan	13
M. Direct Observation Of Procedural Skills (Dops)	19
N. Portofolio	20
O. Ringkasan	21
P. Daftar Pustaka.....	27
BAB 2 ASUHAN SPIRITUAL, BUDAYA, DAN ETIKA DALAM PALIATIF.....	29
A. Teori Dasar	32
B. Template Soal Osce Keperawatan	38
C. Portofolio	55
D. Ringkasan	62
E. Tabel Red Flags & Escalation Asuhan Spiritual, Budaya, dan Etika pada Pasien Paliatif	63
F. Daftar Pustaka.....	66

BAB 3 PERAWATAN AKHIR HAYAT (END-OF-LIFE CARE)	69
A. Konsep Perawatan Akhir Hayat (<i>End of Life Care</i>)	73
B. Prinsip Perawatan Akhir Hayat (End-of-Life Care)	75
C. Tahapan Fase Akhir Kehidupan	76
D. Kebutuhan Pasien pada Fase Akhir Hayat	77
E. Konsep Kenyamanan (Comfort Care)	82
F. Keselamatan Pasien pada Fase Terminal	85
G. Peran Keluarga dalam Perawatan Akhir Hayat	87
H. Proses dan Dampak Berduka pada Keluarga	89
I. Komunikasi dalam Perawatan Akhir Hayat	93
J. Kolaborasi Interprofesional dalam Perawatan Akhir Hayat	96
K. Asuhan Keperawatan Akhir Hayat	98
L. Template Soal Osce Keperawatan	114
M. Ringkasan	138
N. Daftar Pustaka	142
 BAB 4 DUKUNGAN KELUARGA, DAN BEREAVEMENT CARE	 153
A. Konsep Dukungan Keluarga	155
B. Konsep Caregiver	162
C. Bereavement Care	173
D. Rubrik Penilaian	184
E. Soal Osce Keperawatan	185
F. Ringkasan	199
G. Daftar Pustaka	205
 BAB 5 MODEL LAYANAN PALIATIF, HOME CARE, DAN STUDI KASUS TERINTEGRASI	 209
A. Peran Layanan Paliatif dalam Sistem Kesehatan Modern	210
B. Pentingnya Kesiambungan Pelayanan (Continuity of Care)	211
C. Transisi Perawatan: Rumah Sakit Rumah Komunitas	212
D. Peran Perawat dalam Koordinasi Layanan Paliatif	213
E. Definisi Model Layanan Paliatif	214
F. Prinsip Dasar Model Layanan Paliatif	215
G. Jenis Model Layanan Paliatif	218
H. Karakteristik Setiap Model Layanan Paliatif	224
I. Konsep Home Care dalam Paliatif	226

J. Kriteria Pasien Home Care.....	227
K. Peran Perawat dalam Home Care	228
L. Tantangan dan Risiko Home Care	230
M. Konsep Rujukan dalam Paliatif	232
N. Koordinasi Interprofesional.....	234
O. Continuity of Care.....	235
P. Konsep Discharge Planning	238
Q. Komponen Discharge Planning	239
R. Peran Perawat dalam Discharge Planning	241
S. Pentingnya Dokumentasi dalam Paliatif.....	243
T. Komponen Dokumentasi	244
U. Evaluasi Luaran Paliatif.....	245
V. Indikator Keberhasilan Layanan.....	247
W. Integrasi Layanan: Perspektif Kasus Klinis (Pengantar ke Aktivitas)	248
X. Mini-Case: Integrasi Layanan Paliatif.....	250
Y. Soal Osce Keperawatan	251
Z. Rubrik Penilaian Osce Keperawatan	256
AA. Ringkasan.....	260
BB. Daftar Pustaka	264
PROFIL PENULIS	273

BAB 1

GANGGUAN SISTEM RENAL DAN ELIMINASI

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dan filosofi keperawatan paliatif, pendekatan holistik, serta prinsip kualitas hidup dan patient-centered care.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu melakukan penilaian paliatif komprehensif (fisik, psikologis, sosial, spiritual) dan mengidentifikasi kebutuhan prioritas secara sistematis.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merancang dan melaksanakan manajemen gejala utama (nyeri, sesak, GI, kelelahan, distress psikologis) secara aman dan terukur.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan komunikasi paliatif (kabar sulit, perencanaan perawatan/ACP) serta kolaborasi interprofesional dan advokasi pasien–keluarga.	CPMK-3; CPMK-6
CPL-5	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitivitas budaya, dan dukungan spiritual dalam asuhan paliatif termasuk akhir hayat.	CPMK-6; CPMK-1; CPMK-7
CPL-6	Mampu mengevaluasi luaran paliatif, melakukan dokumentasi, discharge/home care planning, serta dukungan caregiver dan bereavement berbasis kebutuhan.	CPMK-7; CPMK-6; CPMK-5

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan paliatif, filosofi perawatan, prinsip kualitas hidup, dan ruang lingkup layanan paliatif.
CPMK-2	Melakukan identifikasi kebutuhan paliatif dan penilaian komprehensif (fisik–psikologis–sosial–spiritual) serta menetapkan prioritas kebutuhan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menerapkan komunikasi paliatif (kabar sulit, perencanaan perawatan/ACP) dan pengambilan keputusan bersama pasien–keluarga secara etis.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan manajemen nyeri dan gejala utama paliatif berbasis bukti, termasuk monitoring efektivitas dan efek samping.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan akhir hayat dan dukungan keluarga/caregiver (termasuk bereavement care) dengan fokus kenyamanan dan keselamatan.
CPMK-6	Menginisiasi kolaborasi interprofesional, dukungan spiritual-budaya, serta advokasi dan koordinasi layanan (home care/rujukan).
CPMK-7	Mengevaluasi luaran paliatif, menyusun dokumentasi dan rencana tindak lanjut, serta refleksi perbaikan mutu layanan berbasis indikator.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 9. Perawatan Luka Tumor, Ulkus Tekan, dan Masalah Integumen	9.1 Menilai luka paliatif (eksudat, bau, nyeri, risiko infeksi) untuk menetapkan tujuan kenyamanan.	9.2 Melaksanakan perawatan luka dan pencegahan ulkus tekan dengan pemantauan indikator perbaikan/kenyamanan.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-7

Uraian Materi

A. Latar Belakang Klinis

Kerusakan integritas kulit dan jaringan pada pasien dengan kondisi terminal atau penyakit kronis lanjut merupakan tantangan besar dalam dunia keperawatan. Luka pada fase ini tidak hanya mewakili kerusakan anatomis, tetapi juga menjadi sumber penderitaan fisik, psikologis, dan sosial yang berat bagi pasien. Tiga jenis masalah integumen yang paling sering ditemui pada area keperawatan kritis dan paliatif adalah luka tumor (malignant fungating wounds), luka tekan (pressure injury), dan berbagai masalah kulit lainnya seperti Incontinence-Associated Dermatitis (IAD) serta dermatitis radiasi.

Pergeseran paradigma dari kuratif (menyembuhkan) ke paliatif (meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup) menuntut perawat memiliki kompetensi yang tervalidasi dalam melakukan penilaian klinis yang akurat dan intervensi yang non-traumatik.

B. Integrasi Kurikulum Berbasis Sub-CPMK

Panduan ini disusun secara runut untuk memfasilitasi pencapaian dua kompetensi utama:

Sub-CPMK 9.1 (Menilai Luka Paliatif): Mahasiswa mampu menilai luka paliatif yang berfokus pada empat pilar gejala lokal, yaitu eksudat, bau, nyeri, dan risiko infeksi, dengan tujuan akhir menetapkan sasaran kenyamanan (*comfort goal specification*).

Sub-CPMK 9.2 (Melaksanakan dan Memantau Perawatan): Mahasiswa mampu melaksanakan prosedur perawatan luka, mengimplementasikan protokol pencegahan ulkus tekan, serta melakukan pemantauan berkala menggunakan indikator perbaikan dan kenyamanan objektif.

C. Definisi Dan Klasifikasi Patofisiologis

1. Luka Tumor (Malignant Cutaneous/Fungating Wounds)

Luka tumor adalah infiltrasi atau ekstrasvasi sel tumor ganas ke dalam epidermis, dermis, dan jaringan subkutan, yang merusak arsitektur kulit normal (White & Kondasinghe, 2022). Luka ini sering kali bermanifestasi sebagai massa yang menyerupai jamur (*fungating*) atau kawah yang melekok ke dalam (*ulcerating*). Karakteristik utamanya meliputi pembuluh darah yang rapuh akibat neovaskularisasi tumor yang abnormal, nekrosis jaringan konstan, serta produksi eksudat yang masif (Zieneldien dkk., 2025).

2. Luka Tekan (Pressure Injury / Dekubitus)

Luka tekan adalah cedera terlokalisasi pada kulit dan/atau jaringan lunak di bawahnya, biasanya terjadi di atas tonjolan tulang (seperti sakrum, koksigeal, kalkaneus, dan ishium) atau terkait dengan penggunaan alat medis (NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2019). Kerusakan ini dipicu oleh tekanan mekanis yang berkepanjangan, gaya gesek (*shear*), gesekan (*friction*), atau mikroiklim kulit yang buruk yang menyebabkan iskemia jaringan lokal, hipoksia, dan akhirnya nekrosis selular (Visconti, 2023). Berdasarkan sistem klasifikasi internasional, luka tekan dibagi menjadi:

- a. **Stadium I:** Eritema yang tidak memucat (*non-blanchable erythema*) pada kulit yang utuh.
- b. **Stadium II:** Hilangnya sebagian tebal kulit (*partial-thickness skin loss*) melibatkan epidermis dan/atau dermis, bermanifestasi sebagai lepuhan (*blisters*) atau ulkus dangkal.
- c. **Stadium III:** Hilangnya seluruh tebal kulit (*full-thickness skin loss*), di mana lemak subkutan terlihat, tetapi otot, tendon, dan tulang belum terpapar.
- d. **Stadium IV:** Hilangnya jaringan secara penuh (*full-thickness tissue loss*) dengan paparan langsung dari otot, tendon, fasia, atau tulang.
- e. **Unstageable:** Dasar luka tertutup sepenuhnya oleh slaf (*slough*) atau eskar (*eschar*) sehingga kedalaman luka tidak dapat dinilai sebelum jaringan mati dibersihkan.

3. Masalah Kulit / Integumen Lainnya

- a. **Incontinence-Associated Dermatitis (IAD):** Kerusakan kulit terlokalisasi yang disebabkan oleh paparan kimiawi dan kelembapan kronis akibat urine dan/atau feses pada area perineal atau perianal (Veloza dkk., 2025).
- b. **Dermatitis Radiasi:** Kerusakan kulit akibat paparan radioterapi, berkisar dari eritema kering hingga deskuamasi basah yang nyeri.

D. Tujuan, Indikasi, Dan Kontraindikasi

1. Tujuan Perawatan Berorientasi Paliatif

- a. Mengendalikan Gejala Lokal (Symptom Control): Meminimalkan produksi bau makro, mengelola volume eksudat agar tidak merembes, dan menghentikan perdarahan kapiler spontan (White & Kondasinghe, 2022).
- b. Promosi Kenyamanan Fisik dan Psikologis: Mengurangi nyeri prosedural selama penggantian balutan dan memulihkan citra tubuh (*body image*) pasien (Zieneldien dkk., 2025).
- c. Perlindungan Jaringan Sekitar: Mencegah maserasi dan kerusakan kulit sehat di sekitar luka (*periwound skin*) (Nagle & Viswanathan, 2023).

- d. Pencegahan Ulkus Baru: Memutus rantai iskemia jaringan pada area tonjolan tulang lainnya pada pasien imobilisasi (Visconti, 2023).

2. Indikasi Tindakan

- a. Pasien dengan malignansi kulit primer atau sekunder yang mengalami ulserasi terbuka (Solehati dkk., 2020).
- b. Pasien dengan keterbatasan mobilitas fisik (bedrest total) yang memiliki skor skala Braden kategori risiko tinggi atau telah mengalami luka tekan Stadium I–IV (Veloza dkk., 2025).
- c. Pasien inkontinensia dengan eritema perineal yang berisiko mengalami denudasi kulit (Veloza dkk., 2025).

3. Kontraindikasi

- a. Kontraindikasi Absolut: Pasien atau wali hukum secara sadar dan tertulis menolak tindakan keperawatan (*Informed Consent* tidak disetujui) (Kemenkes RI, 2022).
- b. Kontraindikasi Relatif:
 - 1) Tindakan *sharp debridement* (debridemen tajam menggunakan gunting/skalpel) pada dasar luka tumor karena struktur vaskularisasi kanker bersifat patologis dan berisiko memicu perdarahan hebat yang fatal (White & Kondasinghe, 2022).
 - 2) Penggunaan balutan hidrofobik oklusif total pada luka yang dicurigai mengalami infeksi bakteri anaerobik akut sebelum diberikan terapi antibiotik spektrum luas (Zieneldien dkk., 2025).

E. Manajemen Penilaian Luka Paliatif Untuk Menetapkan Tujuan Kenyamanan

Perawat harus melakukan penilaian komprehensif menggunakan instrumen berbasis bukti untuk menegakkan diagnosis keperawatan dan menyusun target kenyamanan.

1. Protokol Pengkajian Eksudat

Eksudat dinilai berdasarkan volume dan jenisnya. Pada luka paliatif, eksudat yang berlebih merusak barier protein kulit sehat sekitarnya.

- a. Pengukuran Volume: Dinilai dari persentase kejenuhan balutan lama saat dilepas.
 - 1) *Minimal*: Balutan basah <25%, tidak memerlukan penggantian balutan harian.
 - 2) *Sedang*: Balutan basah 25% - 75% dari area permukaan balutan.
 - 3) *Sangat Banyak (Heavy)*: Balutan jenuh >75% dan cairan merembes ke pakaian atau linen tempat tidur pasien.

b. Warna dan Konsistensi:

- 1) *Serosanguinous* (merah muda, encer): Khas pada luka tumor.
- 2) *Purulen* (kuning/hijau, kental): Menunjukkan tingginya muatan bakteri atau infeksi aktif (Nagle & Viswanathan, 2023).

2. Protokol Pengkajian Bau (Odor Control Assessment)

Aroma tidak sedap ditimbulkan oleh pelepasan asam lemak volatil dari metabolisme bakteri anaerob pada jaringan nekrotik. Penilaian menggunakan modifikasi Skala Toba-Odor:

- a. Skor 1 (Ringan/*Muted*): Bau tercium hanya saat balutan dibuka dalam jarak sangat dekat dengan luka.
- b. Skor 2 (Sedang/*Moderate*): Bau tercium saat perawat berada di samping tempat tidur pasien sebelum balutan dibuka.
- c. Skor 3 (Berat/*Severe*): Bau menyengat langsung tercium saat memasuki ruangan kamar pasien, memicu mual pada pasien maupun keluarga.

3. Protokol Pengkajian Nyeri (Pain Mapping)

Nyeri pada luka paliatif bersifat multidimensional. Perawat menggunakan *Numeric Rating Scale* (NRS) untuk pasien komunikatif atau *Critical-Care Pain Observation Tool* (CPOT) untuk pasien dengan penurunan kesadaran.

- a. Nyeri Latar Belakang (*Background Pain*): Disebabkan oleh kompresi tumor pada saraf atau iskemia jaringan konstan pada luka tekan. Karakteristik: nyeri tumpul atau seperti terbakar yang menetap.
- b. Nyeri Prosedural (*Procedural Pain*): Nyeri akut intensitas tinggi yang dipicu langsung oleh trauma mekanis saat penggantian balutan (misalnya, kasa melekat yang ditarik secara kering).

4. Protokol Pengkajian Risiko Infeksi (Bioburden Management)

Pada konteks paliatif, tanda klasik inflamasi (*rubor, calor, tumor, dolor*) sering kali tersamarkan karena status malnutrisi atau imunosupresi pasien. Perawat wajib memantau kriteria infeksi sekunder lokal seperti:

- a. Jaringan granulasi yang berubah warna menjadi pucat atau mudah berdarah saat disentuh ringan (*pocketing*).
- b. Kenaikan volume eksudat secara mendadak tanpa adanya perubahan terapi sistemik.
- c. Perluasan area kemerahan (*erythema*) di kulit sekitar luka melebihi diameter 2 cm dari tepi luka (Morgan-Jones dkk., 2023).

F. Alat, Bahan, Dan Persiapan Operasional

1. Daftar Inventaris Alat dan Bahan Modern

Sesuai dengan standar prosedur operasional PPNI (2021) dan prinsip *moist wound healing*, berikut adalah daftar kebutuhan logistik:

- a. Instrumen Steril: Gunting jaringan anatomis, pinset bedah, pinset anatomis, kom steril (2 buah), duk bolong steril.
- b. Cairan Irigasi: Cairan NaCl 0,9% steril yang telah dihangatkan hingga suhu 37°C (suhu tubuh), atau larutan *Polyhexamethylene Biguanide* (PHMB) untuk luka dengan biofilm bakteri tinggi.
- c. Bahan Topikal Khusus:
 - 1) *Metronidazole Topikal (Gel 0,75% atau powder)*: Agen pilihan utama antimikroba anaerobik untuk mengontrol bau.
 - 2) *Hydrogel*: Gel berbasis air untuk menghidrasi jaringan eskar kering pada luka tekan.
 - 3) *Zinc Oxide Ointment*: Salep barrier protektif kulit.
- d. Balutan Modern (Modern Dressings):
 - 1) *Calcium Alginate Dressings*: Serat rumput laut yang berubah menjadi gel saat berinteraksi dengan eksudat, berfungsi sebagai hemostatik pembekuan darah minor.
 - 2) *Polyurethane Foam Dressings*: Balutan penyerap cairan tinggi yang melindungi luka dari tekanan eksternal.
 - 3) *Activated Charcoal Dressings*: Balutan karbon aktif untuk menyerap molekul bau.

2. Persiapan Pasien, Perawat, dan Lingkungan

- a. Persiapan Pasien: Lakukan identifikasi pasien secara akurat. Berikan edukasi bahwa fokus tindakan adalah meminimalkan nyeri dan bau, bukan memaksa penutupan luka. Kolaborasi pemberian analgesik opioid kerja cepat atau OAINS 30 hingga 45 menit sebelum balutan dibuka (White & Kondasinghe, 2022).
- b. Persiapan Perawat: Lakukan peninjauan rekam medis terkait dokumentasi karakteristik luka sebelumnya. Kenakan APD lengkap: gaun pelindung, kaca mata goggle (jika ada risiko cipratan cairan), masker ganda (disarankan menyelipkan minyak aromaterapi di antara masker untuk meminimalkan dampak bau bagi perawat agar tetap fokus bertindak), dan sarung tangan steril (PPNI, 2021).
- c. Persiapan Lingkungan: Pastikan pintu dan sampiran ditutup penuh. Matikan kipas angin searah untuk mencegah penyebaran spora bakteri dan kontaminan udara. Nyalakan lampu tindakan dengan pencahayaan terfokus.

G. Langkah Prosedur Dan Pencegahan Ulkus Tekan

1. Fase Prosedural Perawatan Luka Spesifik Berdasarkan Jenis Masalah

- a. Prosedur pada Luka Tumor (Malignant Fungating Wounds)
 - 1) Posisikan pasien secara rileks, letakkan pernakatikan air di bawah area luka.
 - 2) Gunakan sarung tangan bersih. Angkat balutan sekunder secara perlahan. Jika balutan primer melekat pada dasar luka, irigasi secara melimpah dengan NaCl 0,9% hangat. Jangan menarik paksa karena jaringan tumor sangat mudah berdarah (*friable*) (White & Kondasinghe, 2022).
 - 3) Lakukan penilaian parameter eksudat, bau, dan nyeri sesuai sub-CPMK 9.1. Buang balutan kotor ke kantong infeksius.
 - 4) Ganti sarung tangan dengan sarung tangan steril.
 - 5) Pembersihan: Bersihkan luka menggunakan metode irigasi murni tanpa sentuhan fisik langsung pada dasar tumor jika memungkinkan. Semprotkan NaCl 0,9% menggunakan spuit 20 cc dengan jarum nomor 22G untuk menghasilkan tekanan aman (<8 psi) yang tidak memicu perdarahan (Morgan-Jones dkk., 2023).
 - 6) Debridemen: Hindari debridemen mekanis. Biarkan jaringan nekrotik lepas secara autolisis.
 - 7) Aplikasi Topikal & Balutan:
 - a) Oleskan *Metronidazole gel* secara merata pada area yang mengalami nekrosis dan berbau (Zieneldien dkk., 2025).
 - b) Pasang *Calcium Alginate* sebagai balutan primer untuk mengontrol eksudat sekaligus mengantisipasi perdarahan minor spontan.
 - c) Lapsi dengan balutan karbon aktif (*activated charcoal*).
 - 8) Fiksasi perimeter luar dengan plester hipoalergenik.
- b. Prosedur pada Luka Tekan (Pressure Injury)
 - 1) Buka balutan lama dengan hati-hati menggunakan sarung tangan bersih.
 - 2) Gunakan sarung tangan steril setelah melakukan *hand hygiene*.
 - 3) Pembersihan: Lakukan *swabbing* lembut dengan gerakan melingkar dari dalam ke luar menggunakan kasa yang dibasahi NaCl 0,9% hangat atau PHMB.
 - 4) Debridemen Autolitik: Jika dasar luka memiliki jaringan eskar hitam atau slaf kuning, aplikasikan *Hydrogel* setebal 3 mm secara merata untuk merangsang enzim tubuh melunakkan jaringan mati secara alami (Nagle & Viswanathan, 2023).
 - 5) Perlindungan Kulit Sekitar: Oleskan *Zinc Oxide ointment* pada area *periwound* untuk mencegah maserasi akibat rembesan cairan.

- 6) Balutan Primer & Sekunder: Pasang *Foam Dressing* di atas luka. Pastikan ukuran *foam* melebihi tepi luka minimal 2 cm untuk mendistribusikan ulang tekanan mekanis pada area tersebut (Veloza dkk., 2025).
- c. Prosedur pada Masalah Kulit Lainnya (Dermatitis / IAD)
 - 1) Bersihkan area perineal dari sisa feces atau urine menggunakan air hangat dan pembersih kulit dengan pH seimbang (5,5). Jangan menggunakan sabun batang konvensional karena bersifat alkalis dan merusak *acid mantle* kulit (Veloza dkk., 2025).
 - 2) Keringkan kulit dengan cara menepuk lembut menggunakan handuk lembut atau kasa kering, **jangan digosok**.
 - 3) Aplikasikan *skin barrier cream* yang mengandung bahan aktif dimetikon atau *zinc oxide* secara merata sebagai lapisan pelindung transparan.
 - 4) Jika terdapat area deskuamasi basah (lecet berair), tutup dengan balutan non-adheren tipis sebelum memakaikan popok disposibel pada pasien.

2. Protokol Pencegahan Ulkus Tekan Komprehensif

Keberhasilan sub-CPMK 9.2 diukur dari kemampuan perawat menghentikan kejadian luka tekan baru melalui intervensi sistemik berikut:

- a. Protokol Reposisi Posisi Tubuh: Implementasikan jadwal alih baring miring kanan, telentang, miring kiri setiap 2 jam secara konsisten selama 24 jam. Gunakan teknik *log-rolling* dengan bantuan lembar penarik (*draw sheet*) untuk meminimalkan gaya gesek (*shear*) antara kulit pasien dan sprei (Visconti, 2023).
- b. Modifikasi Posisi Tubuh: Saat pasien dalam posisi miring, pertahankan sudut kemiringan 30° (bukan 90°) disangga dengan bantal busa di area punggung dan di antara lutut. Posisi 30° mendistribusikan beban tubuh secara merata dan menghindari tekanan langsung pada trokanter mayor (NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2019).
- c. Manajemen Mikroklimat & Kasur Udara: Pastikan pasien tidur di atas kasur udara anti-dekubitus elektrik (*alternating pressure air mattress*). Jaga agar linen tempat tidur tetap tegang, kering, bebas dari remah-remah makanan atau lipatan kain yang dapat memicu cedera mekanis lokal (Visconti, 2023).
- d. Penyanggaan Tonjolan Tulang (*Floating Heels*): Letakkan bantal di bawah tungkai bawah pasien sehingga tumit (*calcaneus*) menggantung bebas tanpa menyentuh permukaan kasur secara langsung (NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2019).

H. Patient Safety, Komplikasi, Dan Manajemen Risiko

1. Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)

- Manajemen Kedaruratan Perdarahan Luka Tumor: Karena sifat neovaskularisasi tumor yang tidak stabil, perdarahan masif dapat terjadi kapan saja. Perawat harus selalu menyediakan kasa yang telah dibasahi larutan Adrenalin (1:1000) atau produk kalsium alginate di troli tindakan sebagai penanganan darurat lini pertama (White & Kondasinghe, 2022).
- Identifikasi Alergi Perekat: Gunakan hanya plester berbahan dasar silikon atau kertas hipoalergenik pada lansia dan pasien paliatif guna menghindari *Medical Adhesive-Related Skin Injury* (MARSI).

2. Komplikasi Klinis dan Mitigasi Risiko

- Sepsis: Bersumber dari infeksi sekunder luka tekan stadium lanjut yang tidak terkontrol. Mitigasi: Lakukan teknik aseptik yang ketat dan monitor tanda sistemik seperti demam atau penurunan kesadaran (Veloza dkk., 2025).
- Maserasi Periwound: Terjadi akibat kegagalan pemilihan balutan yang sesuai dengan volume eksudat. Mitigasi: Tingkatkan frekuensi penggantian balutan atau ganti balutan primer dengan material yang memiliki daya serap lebih tinggi seperti *hydrofiber* (Nagle & Viswanathan, 2023).

I. Evaluasi Indikator Perbaikan Dan Kenyamanan

Evaluasi keberhasilan asuhan keperawatan mengacu pada indikator yang terukur (sub-CPMK 9.2). Target utama adalah stabilitas kenyamanan, bukan sembuhnya anatomi seluler secara total.

Tabel 1.1 Indikator Keberhasilan Klinis

Domain Kenyamanan	Evaluasi Subjektif (Pasien/Keluarga)	Evaluasi Objektif (Klinis Perawat)
Kontrol Nyeri	Pasien menyatakan nyeri berkurang secara signifikan, berada pada skala ≤ 3 selama prosedur penggantian balutan.	Tanda-tanda vital stabil (nadi dan pernapasan normal), otot wajah rileks, tidak ada gerakan menarik ekstremitas secara mendadak.
Kontrol Aroma	Keluarga menyatakan tidak lagi mencium bau tidak sedap di dalam kamar	Skor skala bau menurun menjadi Skor 1 (tercium hanya dalam jarak sangat

Domain Kenyamanan	Evaluasi Subjektif (Pasien/Keluarga)	Evaluasi Objektif (Klinis Perawat)
	perawatan; pasien merasa nyaman makan di tempat tidur.	dekat dengan dasar luka terbuka).
Keseimbangan Eksudat	Pasien tidak lagi mengeluhkan pakaian yang basah atau sensasi dingin akibat rembesan cairan luka.	Balutan mampu mempertahankan integritasnya tanpa kebocoran (<i>leakage</i>) minimal selama 48 jam; area perimeter kulit sekitar luka bersih dan kering.
Integritas Kulit Sekitar	Pasien tidak merasakan sensasi gatal, perih, atau terbakar pada kulit sehat di sekitar balutan.	Kulit <i>periwound</i> utuh, tidak berwarna putih kapur (bebas maserasi), dan tidak ada pembentukan lesi atau bula baru.
Efektivitas Pencegahan	Keluarga melaporkan kenyamanan posisi tidur pasien yang divariasikan secara berkala.	Seluruh area tonjolan tulang alternatif (sakrum, tumit, skapula) bebas dari kemerahan yang tidak memucat (Skala Braden stabil; tidak terbentuk ulkus tekan baru).

J. Teknik Dokumentasi Legal Keperawatan

Dokumentasi keperawatan harus ditulis secara naratif dan terstruktur pada lembar CPPT (*Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi*) menggunakan format SOAP sebagai bukti aspek legalitas perlindungan hukum perawat (Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 2021).

Perawat wajib mencatatkan data objektif berupa dimensi luka yang diukur menggunakan penggaris kertas sekali pakai:

Dimensi Luka = Panjang (cm) x Lebar (cm) x Kedalaman (cm)

Selain itu, dokumentasikan persentase jaringan pada dasar luka (misal: 60% slaf kuning, 40% jaringan granulasi merah), karakteristik eksudat, gradasi tingkat bau, skala nyeri pra dan pasca-tindakan, serta posisi alih baring yang diterapkan (Solehati dkk., 2020).

K. Minicase (Studi Kasus Klinis Paliatif)

1. Kasus

Ny. S (58 tahun) dirawat di ruang perawatan paliatif dengan diagnosis *Advanced Breast Cancer Stage IV* dengan metastase *cutaneus* pada dinding dada kiri. Berdasarkan pengkajian menggunakan prinsip **sub-CPMK 9.1**, ditemukan adanya massa *fungating* (luka tumor) berukuran 12cm x 10 cm x 3cm.

Luka tampak rapuh, mudah berdarah saat tersentuh, dan tertutup *slough* kekuningan sekitar 40%. Eksudat keluar dalam jumlah sangat banyak (*heavy drainage*), merembes hingga mengotori pakaian dan linen pasien 3 kali sehari. Bau busuk menyengat langsung tercium saat perawat memasuki ruangan (Skor 3 pada Skala Toba-Odor). Pasien mengeluhkan nyeri konstan seperti disayat (skala NRS 5) yang meningkat menjadi skala 8 (nyeri prosedural) saat balutan lamanya dilepas secara kering. Karena kondisi ini, Ny. S menolak makan dan enggan dikunjungi oleh kerabatnya karena merasa malu dengan bau tersebut.

Selain itu, karena pasien mengalami imobilisasi di tempat tidur selama 2 minggu terakhir, hasil pengkajian pada tumit kanan menunjukkan adanya area kemerahan yang tidak memucat saat ditekan (*non-blanchable erythema*), yang menandakan adanya tanda awal Luka Tekan Stadium I.

2. Pertanyaan Analisis Kasus (Bimbingan Praktik)

- Berdasarkan sub-CPMK 9.1, rumuskan analisis prioritas masalah paliatif Ny. S untuk menetapkan tujuan kenyamanannya!
- Sesuai dengan sub-CPMK 9.2, susunlah rencana pemilihan balutan modern (*modern dressing*) dan protokol pencegahan agar luka tekan di tumit pasien tidak memburuk!

3. Penyelesaian Kasus Berorientasi Sub-CPMK

- Analisis Pengkajian Paliatif (sub-CPMK 9.1): Prioritas utama Ny. S bukan penutupan luka, melainkan *comfort goal* (kenyamanan). Bau makro (Skor 3) harus dieradikasi karena mengganggu psikologis dan nutrisi pasien. Nyeri prosedural harus ditekan dari skala 8 menjadi ≤ 3 . Eksudat yang *heavy* harus dikelola agar tidak terjadi maserasi dan menjaga higienitas pasien.

b. Strategi Intervensi & Pencegahan (sub-CPMK 9.2):

- 1) *Manajemen Luka Tumor*: Kolaborasi analgesik (misal: Morfin sirup) 30 menit sebelum tindakan. Melepas balutan lama wajib dibasahi cairan NaCl 0,9% hangat melimpah. Aplikasi topikal menggunakan *Metronidazole powder/gel* untuk eradikasi bakteri anaerob penyebab bau. Balutan primer menggunakan *Calcium Alginate* (mengontrol perdarahan dan menyerap eksudat masif) dikombinasikan dengan balutan sekunder *foam* bertutup karbon aktif (*activated charcoal*).
- 2) *Pencegahan Ulkus Tekan*: Terapkan protokol *floating heels* menggunakan bantal di bawah betis Ny. S agar tumit kanan yang mengalami cedera stadium I tidak menyentuh kasur sama sekali. Lakukan alih baring miring 30° setiap 2 jam secara terjadwal di atas kasur udara (*air mattress*).

L. Soal Osce Keperawatan

1. Penilaian Luka Paliatif dan Pelaksanaan Perawatan Luka Tumor serta Pencegahan Ulkus Tekan.

No	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Penilaian Luka Paliatif dan Pelaksanaan Perawatan Luka Tumor serta Pencegahan Ulkus Tekan.
3	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan penilaian luka paliatif dan prosedur perawatan luka tumor serta pencegahan ulkus tekan
5	Kompetensi	1. Menilai Luka Paliatif 2. Melaksanakan perawatan luka dan mencegah luka tekan
6	Kategori	1. <i>Paliatif</i> 2. Komunikasi 3. <i>Patient safety</i> 4. Edukasi pasien 5. <i>Continuity of care</i>
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien laki-laki (62 tahun) dengan kanker sel skuamosa pada area paha kanan atas mengeluhkan luka tumornya sangat berbau, nyeri saat diganti balutan, dan

		mengeluarkan cairan kuning kemerahan yang banyak. Pasien mengalami bedrest total. TUGAS: 1. Lakukan penilaian luka paliatif (eksudat, bau, nyeri, risiko infeksi) secara lisan kepada penguji. 2. Demonstrasikan langkah pembersihan non-traumatik, aplikasi terapi topikal anti-bau, serta penutupan luka menggunakan prinsip balutan modern (<i>modern dressing</i>). 3. Demonstrasikan 1 teknik reposisi pencegahan ulkus tekan pada tonjolan tulang pasien!
--	--	--

Spo Perawatan Luka & Pencegahan Ulkus Tekan

Skor Penilaian:

0 = Tidak Dilakukan

1 = Dilakukan tetapi kurang tepat/tidak berurutan

2 = Dilakukan dengan sempurna, sistematis, dan steril/bersih

No	Tindakan	Skor		
		0	1	2
FASE ORIENTASI & PENGKAJIAN				
1	Memeriksa program terapi dan mengidentifikasi identitas pasien.			
2	Menjelaskan tujuan tindakan (berorientasi kenyamanan, bau, nyeri)			
3	Mengkaji skala nyeri awal menggunakan instrumen NRS/CPOT.			
4	Mengonfirmasi pemberian analgesik 30 menit sebelum balutan dibuka			
FASE KERJA PERAWATAN LUKA				
5	Menjaga privasi pasien dengan memasang sampiran ruangan			
6	Menggunakan APD pelindung diri lengkap secara benar			
7	Membuka balutan lama secara perlahan dengan bantuan NaCl hangat			

8	Menilai karakteristik eksudat, gradasi bau, dan luas luka			
9	Melakukan irigasi luka dengan NaCl 0,9% hangat secara lembut			
10	Mengaplikasikan metronidazole topikal pada area luka berbau			
11	Memasang calcium alginate pada luka tumor yang berisiko berdarah			
12	Memasang foam dressing sebagai pelindung kompresi mekanis eksternal			
13	Mengaplikasikan zinc ointment/barrier cream di area kulit periwound			
FASE PENCEGAHAN ULKUS TEKAN & TERMINASI				
14	Memposisikan pasien miring 30 derajat dengan sokongan bantal busa			
15	Menerapkan protokol floating heels (tumit menggantung bebas)			
16	Merapikan alat, membuang sampah infeksius, melepas APD.			
17	Mengevaluasi respon kenyamanan subjektif dan skala nyeri akhir.			
18	Mencuci tangan 6 langkah pasca-tindakan.			
19	Mendokumentasikan tindakan keperawatan menggunakan format SOAP			
TOTAL SKOR PEROLEHAN (Maksimal = 38)				

Rubrik Penilaian OSCE

Komponen Penilaian	Skor 0 (Tidak Kompeten)	Skor 1 (Kurang Kompeten)	Skor 2 (Kompeten)	Skor 3 (Sangat Kompeten)	Nilai Maks
Pengkajian Luka Paliatif (Sub-CPMK 9.1)	Peserta ujian tidak melakukan pengkajian luka paliatif sama sekali.	Peserta ujian hanya menngkaji 1-2 parameter saja (misalnya menanyakan nyeri i tanpa menngkaji bau atau	Peserta ujian mengkaji 3 parameter (eksudat, bau, nyeri) secara runtut namun tidak meneta pkan tujuan kenya manan.	Peserta ujian mengkaji ke-4 parameter (eksudat, bau, nyeri, risiko infeksi) secara tepat, runut, dan menetapkan <i>comfort goal</i> bersama pasien.	3

Komponen Penilaian	Skor 0 (Tidak Kompeten)	Skor 1 (Kurang Kompeten)	Skor 2 (Kompeten)	Skor 3 (Sangat Kompeten)	Nilai Maks
		eksudat).			
Teknik Perawatan Luka Non-Traumatis (Sub-CPMK 9.2)	Peserta ujian melakukan tindakan kasar yang berisiko memicu perdarahan tumor.	Peserta ujian membersihkan luka dengan cara digosok keras menggunakan kasa kering, atau memperbaiki penggunaan NaCl hangat.	Peserta ujian membersihkan luka dengan irigasi/swabbing lembut menggunakan NaCl hangat, namun aplikasi topikal metronidazole/alginate terbalik.	Peserta ujian melepas balutan lama dengan sangat lembut (dibasahi), mengirigasi tanpa trauma, mengaplikasikan metronidazole dan kalsium alginate/foam secara tepat dan steril.	3
Implementasi Pencegahan Ulkus	Peserta ujian tidak melakukan tindakan	Peserta ujian memposisikan miring	Peserta ujian melakukan alih	Peserta ujian mendemonstrasikan miring posisi	3

Komponen Penilaian	Skor 0 (Tidak Kompeten)	Skor 1 (Kurang Kompeten)	Skor 2 (Kompeten)	Skor 3 (Sangat Kompeten)	Nilai Maks
Tekan (Sub-CPMK 9.2)	pencegahan atau reposisi posisi tubuh.	ekstrem \$90^{\circ}\$ tanpa penyangga bantal pada area punggung.	baring miring posisi \$30^{\circ}\$ namun menga- baikan posisi tumit pasien yang menempel di kasur.	dengan benar, mengganjal area tonjolan tulang dengan bantal, dan menerapkan teknik <i>floating heels</i> .	
Perilaku Profesional & Keselamatan Pasien	Peserta ujian mengabaikan privasi pasien dan tidak memperhatikan keselamatan (tidak menyiapkan hemostatik).	Peserta ujian menjaga privasi namun tidak memperhatikan respon nyeri pasien selama prosedur tindakan dilakukan.	Peserta ujian menjaga privasi, melakukan komunikasi terapeutik, dan menghentikan	Peserta ujian menunjukkan profesionalisme tinggi, menjaga privasi, komunikatif, responsif terhadap nyeri, dan selalu memprioritaskan keamanan vaskular tumor.	3

Komponen Penilaian	Skor 0 (Tidak Kompeten)	Skor 1 (Kurang Kompeten)	Skor 2 (Kompeten)	Skor 3 (Sangat Kompeten)	Nilai Maks
				tindakan sesaat jika pasien kesakitan.	

M. Direct Observation Of Procedural Skills (Dops)

Format Direct Observational Procedural Skills (DOPS)

Penilaian Luka Paliatif dan Pelaksanaan Perawatan Luka Tumor serta Pencegahan Ulkus Tekan

Nama :

Tanggal :

Tempat :

Kasus : Pasien dengan kebutuhan penilaian dan perawatan luka tumor serta pencegahan ulkus tekan

Setting kasus : ☐ Rawat jalan / poli ☐ Rawat inap

Penilai :

[Beri tanda Check (X) pada kolom penilaian di bawah ini sesuai performa mahasiswa]

No	Aspek Prosedural Yang Diobservasi	Ya	Tidak	Catatan Khusus
1	Membaca rekam medis dan mengidentifikasi riwayat luka.			
2	Menilai kesiapan pasien dan memberikan analgesik pre-prosedural			

	(kolaboratif 30-45 menit sebelum kerja).			
3	Membuka balutan lama secara atraumatik dengan membasahi kasa menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat.			
4	Melakukan pengkajian klinis objektif terhadap eksudat, bau, intensitas nyeri, dan tanda muatan bakteri.			
5	Melakukan teknik pembersihan luka non-sitotoksik (irigasi tekanan rendah atau swabbing lembut).			
6	Mengaplikasikan metronidazole topikal secara merata pada area nekrotik luka tumor yang memicu bau.			
7	Memilih dan memasang balutan primer absorptif (Calcium alginate/foam) sesuai kuantitas cairan luka.			
8	Mengaplikasikan skin barrier cream pada tepi periwound untuk menghindari komplikasi maserasi kulit sehat.			
9	Memposisikan pasien kembali dalam posisi nyaman (Miring 30 derajat atau floating heels).			
10	Melakukan dokumentasi keperawatan SOAP secara lengkap.			

N. Portofolio

Mahasiswa wajib menyusun portofolio sebagai bukti dokumentasi reflektif dari akumulasi pengalaman klinis mengelola masalah integumen.

Komponen Portofolio Wajib:

1. Lembar Logbook Kegiatan: Mencantumkan tanggal, inisial pasien, diagnosis medis, tipe kerusakan kulit (Luka Tumor/Luka Tekan/Dermatitis), dan tindakan spesifik yang telah dilakukan.
2. Lembar Refleksi Klinis (Metode Gibbs):

- a. *Description*: Apa yang terjadi saat Anda merawat luka tersebut?
 - b. *Feelings*: Apa yang Anda rasakan saat menghadapi aroma tidak sedap atau risiko perdarahan pada luka tumor pasien?
 - c. *Evaluation*: Apa hal baik dan hal buruk dari penanganan luka yang Anda berikan?
 - d. *Analysis*: Hubungkan pengalaman klinis Anda dengan teori *moist wound healing* dan manajemen paliatif yang dipelajari.
 - e. *Conclusion*: Apa yang seharusnya Anda lakukan secara berbeda?
 - f. *Action Plan*: Jika menghadapi kasus serupa di masa depan, balutan modern apa yang akan Anda prioritaskan sejak hari pertama?
3. Bukti Dokumentasi Pengkajian Luka Grafis: Menyertakan lembar grafik pelacakan ukuran luka (P x L x D) dan evaluasi penurunan skala bau dari hari ke hari sebagai bentuk capaian sub-CPMK 9.1.

O. Ringkasan

Penilaian luka paliatif (eksudat, bau, nyeri, risiko infeksi) untuk menetapkan tujuan kenyamanan. menitikberatkan pada pergeseran fokus evaluasi keperawatan pada area paliatif. Pada luka tumor ganas dan luka tekan stadium terminal, target intervensi bukan lagi penutupan luka secara anatomis (*closure*), melainkan stabilisasi kenyamanan (*comfort goal*). Hal ini dicapai melalui pemantauan ketat terhadap empat komponen pengganggu, yaitu **eksudat, bau makro, nyeri latar belakang/prosedural, dan risiko infeksi lokal**.

Perawatan luka dan pencegahan ulkus tekan dengan pemantauan indikator perbaikan/kenyamanan, mengoperasionalkan asuhan keperawatan melalui tindakan nyata berupa pembersihan luka non-traumatik menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat atau PHMB untuk menghindari vasokonstriksi jaringan, penggunaan terapi topikal spesifik seperti *Metronidazole* untuk membunuh bakteri anaerob penyebab bau, serta pemilihan balutan sekunder seperti *Foam* dan *Calcium Alginate* yang disesuaikan dengan volume eksudat.

Pencegahan ulkus tekan sekunder wajib dilaksanakan pada seluruh pasien paliatif yang mengalami imobilisasi lama melalui protokol **alih baring posisi 30° setiap 2 jam**, penggunaan kasur udara otomatis, dan penerapan teknik *floating heels* guna melenyapkan tekanan konstan di area kalkaneus.

Tabel Red Flags, Makna Klinis, Dan Tindakan Eskalasi

Tanda Bahaya (<i>Red Flags</i>)	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Darah segar memancar atau mengalir deras dari dasar luka tumor ganas	• Infiltrasi sel kanker merusak dinding pembuluh darah besar (erosi vaskular) • Neovaskularisasi tumor memiliki struktur kapiler yang sangat rapuh dan tidak memiliki lapisan otot elastis	1. Jangan panik. Segera lakukan teknik kompresi mekanis (tekan langsung) menggunakan kasa steril. 2. Basahi kasa dengan larutan Adrenalin/Epinefrin (1:1000) atau aplikasikan balutan <i>Calcium Alginate</i> pekat di area perdarahan. 3. Pertahankan tekanan konstan selama minimal 5–10 menit. 4. Segera panggil dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) atau tim medik darurat.
Suhu >38.5°C atau <36°C, Nadi >100x/mnt, TD Sistolik <90 mmHg, gelisah/penurunan kesadaran	• Kolonisasi bakteri lokal pada luka tekan stadium lanjut atau luka ganas telah menembus pembuluh darah sirkulasi umum. • Memicu respons inflamasi sistemik (<i>SIRS</i>) yang dapat berujung pada gagal organ multipel.	1. Hentikan seluruh prosedur perawatan luka lokal. 2. Posisikan pasien telentang dengan kaki sedikit ditinggikan (<i>Shock Position</i>) jika tekanan darah drop.

		3. Berikan terapi oksigen sesuai kebutuhan pasien. 4. Laporkan segera ke dokter untuk eskalasi berupa kultur darah, rehidrasi cairan intravena agresif, dan memulai antibiotik spektrum luas intravena.
Kulit sekitar luka tekan mendadak berubah hitam pekat, dingin saat diraba, denyut nadi perifer tidak teraba	• Terjadinya oklusi (penyumbatan) total atau destruksi pada arteri suplai darah utama ke area integumen tersebut. • Menandakan kematian jaringan (nekrosis progresif) skala luas yang mengancam ekstremitas.	1. Batalkan rencana reposisi miring ekstrem pada sisi jaringan yang mengalami iskemia. 2. Jaga area tersebut tetap kering dan terlindungi dari gesekan atau tekanan sekecil apa pun. 3. Dokumentasikan batas area kehitaman dengan akurat (gunakan foto medis jika diizinkan). 4. Konsultasikan segera dengan dokter spesialis bedah atau DPJP untuk evaluasi viabilitas jaringan dan manajemen nyeri darurat.
Nyeri ekstrem yang menetap, tidak merespons analgesik standar, atau pasien	• Kanker telah menginvasi periosteum tulang, pleura, atau selubung saraf utama (nyeri neuropatik berat).	1. Hentikan tindakan penggantian balutan saat itu juga. Jangan memaksakan

menjerit saat balutan disentuh	• Adanya kompresi mekanis akut atau infeksi deep-tissue yang tidak terlihat dari permukaan luar luka.	pelepasan kasa yang merekat. 2. Tutup luka sementara dengan kasa lembap NaCl agar tidak terpapar udara luar secara langsung. 3. Lakukan re-assessment nyeri secara detail (PQRST). 4. Laporkan ke Tim Paliatif / DPJP untuk eskalasi dosis analgesik (misal: <i>breakthrough dose</i> Morfin intravena atau subkutan) sebelum tindakan dilanjutkan.
Adanya cairan feses, urine, atau udara yang keluar dari dalam goa luka tumor/luka tekan	Luka telah mengikis lapisan dinding organ dalam (seperti rektum, kandung kemih, atau pleura), menciptakan saluran abnormal baru (<i>fistulasi</i>).	1. Cegah cairan kontaminan (feses/urine) mengalir ke dasar luka tumor/luka tekan sehat lainnya. 2. Gunakan kantong stoma (<i>fistula bag</i>) sementara untuk menampung cairan yang keluar. 3. Bersihkan area sekitar dengan teknik steril guna mencegah infeksi asendens. 4. Eskalasi darurat ke tim bedah terkait untuk menentukan kelayakan intervensi diversi/paliatif.

Form Checklist “Saya sudah bisa”

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Tanggal :
 Tempat Praktik / Skill Lab :

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa mengkaji volume dan karakteristik eksudat secara objektif untuk menentukan jenis balutan yang tepat.			
2	Saya sudah bisa menilai gradasi aroma luka tumor menggunakan skala objektif (Skala Toba-Odor).			
3	Saya sudah bisa membedakan <i>background pain</i> dengan <i>procedural pain</i> pada luka ganas maupun luka tekan.			
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi muatan bakteri (<i>bioburden</i>) dan tanda-tanda infeksi sekunder lokal pada jaringan paliatif.			
5	Saya sudah bisa berdiskusi dengan pasien/keluarga untuk menetapkan sasaran kenyamanan (<i>comfort goal specification</i>).			
6	Saya sudah bisa mengaplikasikan analgesik pre-prosedural secara kolaboratif sesuai batas waktu paruh obat sebelum balutan dibuka.			
7	Saya sudah bisa melakukan teknik pelepasan balutan lama secara atraumatik menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat.			
8	Saya sudah bisa membersihkan luka dengan metode irigasi murni bertekanan rendah (<8 psi) tanpa memicu trauma pembuluh darah tumor.			
9	Saya sudah bisa mengaplikasikan terapi topikal anti-bakteri anaerob (<i>Metronidazole</i> gel/powder) secara merata pada jaringan nekrotik.			

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
10	Saya sudah bisa memilih dan memasang balutan primer absorptif (<i>Calcium Alginate</i> atau <i>Foam</i>) sesuai kebutuhan klinis dasar luka.			
11	Saya sudah bisa mengaplikasikan <i>skin barrier cream</i> / <i>zinc ointment</i> pada area kulit sekitar luka (<i>periwound</i>) untuk mencegah maserasi.			
12	Saya sudah bisa melakukan debridemen autolitik secara aman menggunakan <i>Hydrogel</i> pada eskar/slaf tebal luka tekan.			
13	Saya sudah bisa memposisikan pasien imobilisasi dalam posisi miring 30° secara anatomi yang aman dan terjadwal.			
14	Saya sudah bisa mengimplementasikan protokol <i>floating heels</i> menggunakan sokongan bantal untuk melenyapkan kompresi kalkaneus.			
15	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda-tanda bahaya (<i>Red Flags</i>) seperti perdarahan masif, tanda sepsis, atau iskemia total.			
16	Saya sudah bisa melakukan penanganan darurat lini pertama jika terjadi robekan vaskular atau perdarahan pada luka ganas.			
17	Saya sudah bisa mengevaluasi efektivitas manajemen bau, kontrol nyeri, dan kenyamanan posisi pasca-tindakan.			
18	Saya sudah bisa menghitung dimensi volume luka (P x L x D) dan persentase jaringan dasar luka secara akurat.			
19	Saya sudah bisa menuliskan seluruh hasil asuhan keperawatan integumen secara legal-etis pada lembar CPPT menggunakan format SOAP.			

P. Daftar Pustaka

- Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI). (2022). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK): Tata Laksana Luka Tekan (Pressure Injury)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Morgan-Jones, R., dkk. (2023). Harmonised glossary of wound care terms. *Journal of Wound Care*, 32(Sup7b), 1–45. <https://doi.org/10.12968/jowc.2023.32.Sup7b.1>
- Nagle, S. M., & Viswanathan, S. (2023). Wound assessment and management principles. *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
- National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), & Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). (2019). *Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline*. EPUAP/NPIAP/PPPIA.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2021). *Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan (SPO) Edisi 1*. Jakarta: DPP PPNI.
- Solehati, T., dkk. (2020). Pengkajian dan dokumentasi keperawatan komprehensif pada pasien dengan malignansi cutaneous: Sebuah studi literatur. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 23(3), 185–194.
- Veloza, B. C., dkk. (2025). Pressure injuries: Prevention, treatment, and complications – Part II. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, 100(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.abd.2024.08.003>
- Visconti, A. J. (2023). Pressure injuries: Prevention, evaluation, and management. *American Family Physician (AFP)*, 108(2), 146–154.
- White, D., & Kondasinghe, S. (2022). Managing a malignant wound in palliative care. *Wound Practice and Research*, 30(3), 150–157. <https://doi.org/10.33235/wpr.30.3.150-157>
- Zieneldien, T., dkk. (2025). Malignant fungating wounds in locally aggressive cutaneous squamous cell carcinoma: A case series and palliative review. *Cureus*, 17(3), e54921.

BAB 2

ASUHAN SPIRITUAL, BUDAYA, DAN ETIKA DALAM PALIATIF

Capaian Pembelajaran:

Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitivitas budaya, dan dukungan spiritual dalam asuhan paliatif, termasuk akhir hayat.

Aktivitas Belajar (Scaffolding)

Asuhan Spiritual, Budaya, dan Etika Dalam Paliatif.

Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
CPL 1 – Sikap Profesional dan Etik-Legal	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, empati, bertanggung jawab, menghargai martabat pasien, menjaga privasi dan kerahasiaan, serta menerapkan prinsip etik dan legal dalam asuhan keperawatan paliatif, termasuk pada situasi akhir hayat.
CPL 2 – Pengetahuan Keperawatan Paliatif Holistik	Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar asuhan paliatif yang holistik, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, budaya, dan etika dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga.
CPL 3 – Pengkajian Spiritual, Budaya, dan Psikososial	Mahasiswa mampu melakukan pengkajian keperawatan secara holistik pada pasien paliatif, termasuk mengidentifikasi kebutuhan spiritual, nilai budaya, kondisi emosional, dukungan keluarga, serta tanda spiritual distress.
CPL 4 – Clinical Reasoning dan Pengambilan Keputusan Etis	Mahasiswa mampu menerapkan berpikir kritis dan penalaran klinis dalam mengidentifikasi masalah spiritual, budaya, dan dilema etika, serta mengambil keputusan berdasarkan prinsip autonomy, beneficence, non-maleficence, justice, veracity, fidelity, dan confidentiality.

Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
CPL 5 – Komunikasi Terapeutik dan Edukasi	Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik secara empati, jujur, sensitif, tidak menghakimi, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga dalam konteks paliatif dan perawatan akhir hayat.
CPL 6 – Asuhan Spiritual dan Sensitivitas Budaya	Mahasiswa mampu memberikan dukungan spiritual dan budaya sesuai kebutuhan, nilai, keyakinan, dan preferensi pasien serta keluarga, termasuk memfasilitasi praktik ibadah, ritual, atau keterlibatan tokoh agama/rohaniwan.
CPL 7 – Advokasi dan Kolaborasi Interprofesional	Mahasiswa mampu berperan sebagai advokat pasien dalam pengambilan keputusan paliatif, serta berkolaborasi dengan keluarga, tim kesehatan, tokoh agama, dan profesi lain untuk memenuhi kebutuhan pasien secara holistik.
CPL 8 – Dokumentasi, Refleksi, dan Patient Safety	Mahasiswa mampu mendokumentasikan hasil pengkajian, masalah, intervensi, dan evaluasi asuhan spiritual, budaya, dan etika secara tepat, serta melakukan refleksi patient safety dalam praktik keperawatan paliatif.

Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
CPMK 1	Menjelaskan konsep asuhan paliatif holistik yang mencakup aspek spiritual, budaya, etik-legal, komunikasi, dukungan keluarga, dan perawatan akhir hayat.
CPMK 2	Menganalisis kebutuhan spiritual pasien paliatif, termasuk kebutuhan akan makna hidup, harapan, kedamaian, pengampunan, praktik ibadah, hubungan dengan Tuhan, serta tanda spiritual distress.
CPMK 3	Menganalisis pengaruh nilai budaya terhadap persepsi sakit, penderitaan, kematian, pola komunikasi keluarga, pengambilan keputusan, praktik ritual, dan preferensi perawatan akhir hayat.
CPMK 4	Mengidentifikasi dilema etika dalam asuhan paliatif dan menerapkan prinsip autonomy, beneficence, non-maleficence, justice, veracity, fidelity, dan confidentiality dalam pengambilan keputusan klinis.
CPMK 5	Mendemonstrasikan pengkajian spiritual dan budaya serta komunikasi terapeutik secara empati, sensitif, jujur, tidak menghakimi, dan menghormati nilai pasien dalam situasi paliatif.

**Kode
CPMK**

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

CPMK 6

Menyusun rencana asuhan keperawatan spiritual, budaya, dan etika pada pasien paliatif, termasuk dukungan spiritual, fasilitasi tokoh agama/rohaniwan, edukasi keluarga, advokasi pasien, kolaborasi tim, evaluasi, dan dokumentasi.

Uraian Materi

Asuhan Spiritual, Budaya, Dan Etika Dalam Paliatif.

A. Teori Dasar

Asuhan paliatif merupakan pendekatan perawatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa. Pendekatan ini bersifat holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, *spiritual*, budaya, dan etika. Dalam praktik keperawatan paliatif, perawat tidak hanya berperan dalam mengelola gejala, tetapi juga dalam memahami makna hidup, nilai, keyakinan, dan preferensi pasien serta keluarga.

1. Asuhan Spiritual dalam Paliatif

Spiritual merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan makna, tujuan hidup, hubungan dengan diri sendiri, orang lain, alam, dan/atau Tuhan. Pada pasien paliatif, kebutuhan spiritual sering meningkat terutama ketika menghadapi kondisi terminal, penderitaan, dan ketidakpastian.

Kebutuhan spiritual dapat meliputi:

- a. Kebutuhan akan makna dan tujuan hidup
- b. Kebutuhan akan harapan dan kedamaian
- c. Kebutuhan untuk memaafkan dan dimaafkan
- d. Kebutuhan akan praktik keagamaan atau ritual tertentu
- e. Kebutuhan akan hubungan dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi

Perawat perlu melakukan **pengkajian spiritual**, yang dapat mencakup:

- a. Keyakinan agama atau *spiritual* pasien
- b. Praktik ibadah yang dijalankan
- c. Sumber kekuatan dan harapan pasien
- d. *Spiritual distress* (misalnya merasa putus asa, marah pada Tuhan)

Intervensi keperawatan *spiritual* meliputi:

- a. Mendengarkan secara empati
- b. Memberikan dukungan emosional
- c. Memfasilitasi praktik ibadah
- d. Menghubungkan dengan tokoh agama atau rohaniwan
- e. Menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman

2. Asuhan Budaya dalam Paliatif

Budaya memengaruhi cara individu memahami penyakit, penderitaan, kematian, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks paliatif, sensitivitas budaya sangat penting karena setiap pasien memiliki nilai dan kepercayaan yang berbeda.

Aspek budaya yang perlu diperhatikan:

- a. Persepsi tentang sakit dan kematian
- b. Pola komunikasi dalam keluarga
- c. Peran keluarga dalam pengambilan keputusan
- d. Praktik tradisional atau ritual budaya
- e. Preferensi perawatan akhir hayat

Dalam praktik keperawatan, pendekatan **cultural competence** diperlukan, yaitu:

- a. Menghormati perbedaan budaya
- b. Tidak menghakimi keyakinan pasien
- c. Menggali nilai dan preferensi pasien
- d. Menyesuaikan intervensi dengan budaya pasien

Contoh:

- a. Beberapa budaya lebih mengutamakan keputusan keluarga dibandingkan individu
- b. Ada pasien yang menginginkan ritual tertentu menjelang akhir hayat

3. Asuhan Etika dalam Paliatif

Asuhan paliatif sering melibatkan dilema etika, terutama dalam pengambilan keputusan terkait perawatan akhir hayat. Oleh karena itu, perawat harus memahami prinsip-prinsip etika dalam praktik keperawatan.

Prinsip etika utama:

- a. Autonomy (otonomi): menghormati keputusan pasien

Definisi:

Hak pasien untuk membuat keputusan tentang dirinya sendiri berdasarkan informasi yang adekuat.

Makna dalam paliatif:

- 1) Pasien berhak mengetahui kondisi kesehatannya
- 2) Pasien berhak menerima atau menolak terapi
- 3) Pasien berhak menentukan tujuan perawatan (misalnya fokus pada kenyamanan)

Implementasi dalam praktik:

- 1) Memberikan *informed consent*
- 2) Menghormati keputusan pasien, meskipun berbeda dengan tenaga kesehatan
- 3) Melibatkan pasien dalam *Advance Care Planning* (ACP)

Contoh:

Pasien menolak tindakan resusitasi perawat harus menghormati keputusan tersebut selama pasien kompeten.

b. Beneficence: melakukan tindakan yang terbaik bagi pasien

Definisi:

Kewajiban tenaga kesehatan adalah untuk melakukan tindakan yang memberikan manfaat terbaik bagi pasien.

Makna dalam paliatif:

- 1) Fokus pada peningkatan kualitas hidup
- 2) Mengurangi nyeri dan gejala
- 3) Memberikan kenyamanan

Implementasi:

- 1) Memberikan manajemen nyeri optimal
- 2) Memberikan dukungan psikologis dan spiritual
- 3) Menyesuaikan intervensi dengan kondisi pasien

Contoh:

Memberikan analgesik untuk mengurangi nyeri meskipun pasien dalam fase terminal

c. Non-maleficence: tidak membahayakan pasien

Definisi:

Kewajiban untuk tidak menyebabkan bahaya atau memperburuk kondisi pasien.

Makna dalam paliatif:

- 1) Menghindari tindakan yang tidak memberikan manfaat
- 2) Menghindari *over-treatment*
- 3) Menghindari penderitaan tambahan

Implementasi:

- 1) Tidak melakukan tindakan invasif yang tidak perlu
- 2) Menghindari terapi agresif pada kondisi terminal tanpa manfaat
- 3) Mempertimbangkan risiko versus manfaat

Contoh:

Tidak melanjutkan terapi agresif yang hanya memperpanjang penderitaan tanpa meningkatkan kualitas hidup.

d. Justice: keadilan dalam pelayanan

Definisi:

Memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua pasien.

Makna dalam paliatif:

- 1) Tidak diskriminatif
- 2) Akses yang sama terhadap pelayanan paliatif
- 3) Distribusi sumber daya secara adil

Implementasi:

- 1) Memberikan perawatan tanpa membedakan status sosial
- 2) Menjamin akses layanan paliatif
- 3) Menggunakan sumber daya secara bijak

Contoh:

Semua pasien berhak mendapatkan manajemen nyeri, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Isu etika dalam paliatif meliputi:

- 1) Penolakan terapi
- 2) *Do Not Resuscitate* (DNR) / *Allow Natural Death* (AND)
- 3) Penghentian terapi
- 4) Pengambilan keputusan bersama (*shared decision making*)
- 5) *Advance Care Planning* (ACP)

Peran perawat dalam aspek etika:

- 1) Memberikan informasi yang jujur dan jelas
- 2) Mendukung pengambilan keputusan pasien
- 3) Menjadi advokat pasien
- 4) Berkolaborasi dengan tim kesehatan

e. Veracity (Kejujuran)

Definisi:

Kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jujur dan transparan.

Implementasi:

- 1) Menyampaikan diagnosis dan prognosis secara tepat
- 2) Menghindari informasi yang menyesatkan
- 3) Menyesuaikan cara penyampaian dengan kondisi pasien

Dilema:

Keluarga meminta agar diagnosis tidak disampaikan perawat harus menyeimbangkan antara kejujuran dan sensitivitas budaya.

f. Fidelity (Kesetiaan/Komitmen)

Definisi:

Menjaga kepercayaan pasien dan komitmen profesional.

Implementasi:

- 1) Menepati janji kepada pasien
- 2) Menjaga hubungan terapeutik
- 3) Konsisten dalam perawatan

g. Confidentiality (Kerahasiaan)

Definisi:

Menjaga informasi pasien agar tidak disebarluaskan tanpa izin.

Implementasi:

- 1) Tidak membocorkan informasi medis
- 2) Hanya berbagi informasi dengan tim yang berwenang
- 3) Menghormati privasi pasien

4. Integrasi Spiritual, Budaya, dan Etika

Dalam praktik paliatif, ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Perawat harus mampu:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan spiritual dan budaya pasien
- b. Mengintegrasikannya dalam rencana perawatan
- c. Mengambil keputusan yang etis bersama pasien dan keluarga

Pendekatan ini sejalan dengan patient-centered care dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh:

Seorang pasien laki-laki usia 60 tahun dengan kanker stadium lanjut dirawat di ruang paliatif. Pasien tampak sering diam, menolak makan, dan mengatakan "Saya sudah tidak ada harapan." Keluarga meminta agar kondisi sebenarnya tidak disampaikan kepada pasien karena takut pasien semakin sedih. Pasien juga meminta untuk bertemu pemuka agama.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

- Identifikasi masalah spiritual yang dialami pasien.
- Jelaskan bagaimana perawat melakukan pengkajian spiritual pada kasus ini.
- Identifikasi aspek budaya yang memengaruhi keputusan keluarga.
- Jelaskan dilema etika yang muncul pada kasus tersebut.
- Bagaimana perawat dapat mengambil peran dalam pengambilan keputusan yang etis?

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/*skill lab* kala II

Fokus:

- Pengkajian *spiritual* dan budaya
- Komunikasi terapeutik
- Pengambilan keputusan etis

Mahasiswa diharapkan mampu:

- Mengidentifikasi kebutuhan *spiritual* pasien
- Berkomunikasi empati
- Menghormati nilai budaya pasien
- Mengambil keputusan berdasarkan prinsip etika

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
<i>Knows / Knows How</i>	<i>Mini-case + self assessment</i>
<i>Shows How</i>	OSCE komunikasi paliatif & pengkajian <i>spiritual</i>

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene dan keselamatan pasien
- Komunikasi empati
- Pengkajian *spiritual* dan budaya
- Menghormati nilai pasien
- Pengambilan keputusan etis

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman dan konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen dan keputusan	Tepat dan jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empati dan jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

B. Template Soal Osce Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor <i>station</i>	
2	Judul <i>station</i>	Asuhan Spiritual, Budaya, dan Etika dalam Paliatif
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta dalam melakukan pengkajian <i>spiritual</i> , mengidentifikasi aspek budaya, serta menerapkan prinsip etika (<i>autonomy, beneficence, non-maleficence, justice</i>) dalam komunikasi dan pengambilan keputusan pada pasien paliatif.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. <i>Spiritual</i> 2. Psikososial 3. Budaya 4. Etika 5. Komunikasi
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien laki-laki usia 60 tahun dengan kanker stadium lanjut dirawat di ruang paliatif. Pasien tampak sedih, mengatakan “hidup saya sudah tidak berarti”, dan ingin bertemu tokoh agama. Pasien juga sering bertanya tentang kondisi penyakitnya. Namun, keluarga meminta agar kondisi sebenarnya tidak disampaikan kepada pasien karena takut pasien semakin putus asa. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian <i>spiritual</i> pada pasien 2. Identifikasi masalah <i>spiritual</i> dan psikososial 3. Lakukan komunikasi terapeutik secara empati 4. Identifikasi dilema etika pada kasus

		5. Jelaskan pendekatan etika yang tepat (<i>autonomy, beneficence, veracity</i>)
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien laki-laki usia 60 tahun dengan kanker stadium lanjut dirawat di ruang paliatif. Pasien tampak sedih, mengatakan “hidup saya sudah tidak berarti”, dan ingin bertemu tokoh agama. Pasien juga sering bertanya tentang kondisi penyakitnya. Namun, keluarga meminta agar kondisi sebenarnya tidak disampaikan kepada pasien karena takut pasien semakin putus asa. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian <u>spiritual</u> pada pasien 2. Identifikasi masalah <u>spiritual</u> dan psikososial 3. Lakukan komunikasi terapeutik secara <u>empati</u> 4. Identifikasi dilema etika pada kasus 5. Jelaskan pendekatan etika yang tepat (<i>autonomy, beneficence, veracity</i>) INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai kemampuan peserta dalam menggali kebutuhan <u>spiritual</u> pasien 2. Menilai komunikasi <u>empati</u> (verbal dan nonverbal) 3. Menilai kemampuan mengidentifikasi dilema etika 4. Menilai penerapan prinsip etika (<i>autonomy, beneficence, non-maleficence, justice, veracity</i>) 5. Menilai perilaku profesional (privasi, sikap, empati, tidak menghakimi)
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: Pasien laki-laki usia 60 tahun dengan kanker stadium lanjut (terminal). KS (Klien Standar) berperan sebagai pasien. 2. Riwayat penyakit sekarang: Pasien menderita kanker stadium lanjut. <u>Kondisi</u> semakin menurun. Pasien tampak lemas, sering diam, nafsu makan menurun, dan lebih banyak

		berbaring. Pasien mulai mempertanyakan makna hidup dan merasa hidupnya tidak berarti. 3. Riwayat perawatan saat ini: Pasien sedang menjalani perawatan paliatif di ruang rawat. Ini bukan perawatan pertama, namun kondisi saat ini lebih memburuk <u>dibandingkan</u> sebelumnya. 4. Riwayat penyakit keluarga: Tidak ada anggota keluarga yang mengalami penyakit serupa. Keluarga sangat protektif terhadap pasien. 5. Riwayat kebiasaan sosial dan psikologis: Pasien tampak sedih, cemas, dan menarik diri. Lebih banyak diam, kontak mata minimal, dan suara pelan. Pasien merasa takut menghadapi kematian. Keluarga cenderung tidak terbuka mengenai kondisi pasien. 6. Kebutuhan dan masalah <u>spiritual</u>: Pasien merasa hidupnya tidak bermakna, takut meninggal, dan merasa belum siap secara <i>spiritual</i>. 7. Harapan terhadap kondisi: Pasien berharap dapat merasa lebih tenang, tidak terlalu menderita, dan mendapatkan kedamaian di akhir hidupnya. Pasien ingin bertemu tokoh agama untuk mendapatkan ketenangan. 8. Bila peserta menanyakan tentang kondisi penyakit: Jawaban KS: "Saya sebenarnya sakit apa ya? Saya ingin tahu kondisi saya yang sebenarnya..." 9. Bila peserta menanyakan perasaan pasien: Jawaban KS: "Saya merasa hidup saya sudah tidak berarti... saya takut mati..." 10. Bila peserta menanyakan kebutuhan <u>spiritual</u>: Jawaban KS: "Saya ingin bertemu ustadz/pemuka agama... saya ingin lebih tenang..." 11. Bila peserta menanyakan keluarga: Jawaban KS:
--	--	---

		"Keluarga saya tidak ingin saya tahu kondisi saya... mereka bilang saya tidak perlu tahu..." 12. Kondisi saat OSCE berlangsung: KS duduk atau berbaring di tempat tidur dengan ekspresi sedih, kontak mata minimal, suara pelan, dan tampak lemah. Lingkungan menggambarkan ruang perawatan paliatif. Peran harus dilakukan secara konsisten dan realistis agar tidak membingungkan peserta.
10	Setting station	Ruang Rawat Paliatif - Tempat tidur pasien - KS berperan sebagai pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin dewasa 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. <i>Handrub/hand sanitizer</i> 2. Tisu 3. Kursi untuk peserta 4. Tempat tidur pasien (bed) 5. Bantal dan selimut pasien 6. Lembar pengkajian / catatan pasien (opsional) 7. Alat tulis (pulpen) 8. Jam/timer (untuk pengaturan waktu OSCE) 9. Lembar jawaban peserta 10. Tirai/penutup untuk menjaga privasi (jika tersedia)

		Peran laboran: 1. Menyiapkan dan merapikan ruang serta peralatan sebelum dan sesudah ujian 2. Memastikan posisi tempat tidur, kursi, dan lingkungan sesuai setting station 3. Mengecek ketersediaan handrub dan kelengkapan alat 4. Memastikan ruang ujian siap sebelum peserta berikutnya masuk
12	Penulis	Ns. Weny Amelia, M.Kep., Sp.Kep.MB
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

Sop Edukasi Dan Demonstrasi Asuhan *Spiritual*, Budaya Dan Etika Pada Pasien Paliatif

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. <i>Handrub</i> /sabun cuci tangan b. Tisu c. Lembar pengkajian/catatan d. Alat tulis				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama, tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien (<i>confidentiality</i>)				

C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
11	Melakukan <i>hand hygiene</i> sebelum kontak				
12	Membangun hubungan terapeutik (kontak mata, sikap empati)				
13	Mengkaji kondisi emosional pasien (sedih, cemas, takut)				
14	Mengkaji kebutuhan <i>spiritual</i> pasien (keyakinan, ibadah, harapan)				
15	Mengidentifikasi tanda spiritual distress (putus asa, kehilangan makna hidup)				
16	Mengkaji nilai dan latar belakang budaya pasien				
17	Mengkaji peran keluarga dalam pengambilan keputusan				
18	Mengidentifikasi masalah etika (misal: pasien ingin tahu kondisi, keluarga menolak)				
19	Menerapkan komunikasi empati (mendengarkan aktif, validasi perasaan)				
20	Tidak menghakimi keyakinan pasien (non-maleficence)				

21	Menghormati pilihan pasien (autonomy)				
22	Menjelaskan secara jujur dan sensitif sesuai kondisi pasien (veracity)				
23	Memberikan dukungan spiritual sesuai kebutuhan pasien (beneficence)				
24	Menawarkan bantuan untuk menghadirkan tokoh agama				
25	Mengedukasi pasien/keluarga secara sederhana dan empati				
26	Melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan				
27	Mengidentifikasi respons pasien terhadap intervensi				
28	Menjaga sikap profesional (tenang, sabar, empati)				
D	Tahap Terminasi				
29	Menyimpulkan hasil interaksi				
30	Mengevaluasi respons pasien (subjektif dan objektif)				
31	Memberikan reinforcement positif				
32	Membuat kontrak waktu selanjutnya				

33	Mengakhiri interaksi dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
34	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi serta hasil pengkajian <i>spiritual</i> , budaya, masalah etika, intervensi, dan respons pasien				
F	Penampilan Profesional				
35	Aman, empati, menghargai pasien, tidak menghakimi, menjaga privasi				

Form Penilaian Osce Keperawatan Station: Asuhan Spiritual, Budaya, Dan Etika Pada Pasien Paliatif

Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali kondisi emosional, kebutuhan <i>spiritual</i> , nilai budaya, serta tanda <i>spiritual distress</i> pasien					2	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis (misalnya <i>spiritual distress</i>) dan menyusun rencana intervensi yang sesuai					2	

3	Implementasi keperawatan: asuhan <i>spiritual</i> dan komunikasi	Melakukan komunikasi empati, memberikan dukungan <i>spiritual</i> , menghormati keyakinan pasien, serta melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan					4	
4	Penerapan prinsip etika	Mengidentifikasi dan menerapkan prinsip etika (<i>autonomy, beneficence, non-maleficence, veracity, justice</i>) dalam kasus					1	
5	Perilaku profesional	Menunjukkan sikap empati, menjaga privasi, tidak menghakimi, sistematis, aman, dan respons					1	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = Tidak dilakukan
- 1 = Dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = Dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = Dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

Rubrik Penilaian Osce Keperawatan Station: Asuhan Spiritual, Budaya, Dan Etika Pada Pasien Paliatif

Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada pasien paliatif, meliputi kondisi emosional, kebutuhan <i>spiritual</i> , keyakinan agama, makna hidup, nilai budaya, serta tanda <i>spiritual distress</i> (putus asa, takut mati, kehilangan					2	

harapan). Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan menginterpretasikan data secara tepat.					
2. Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menetapkan diagnosis keperawatan (misalnya distress spiritual) serta menyusun rencana asuhan keperawatan yang sesuai dengan kondisi pasien paliatif. Peserta diharapkan mampu menghubungkan data hasil pengkajian dengan diagnosis dan intervensi yang tepat.				2	
3. Implementasi Keperawatan (Asuhan <i>Spiritual</i> dan Komunikasi) Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam melakukan tindakan keperawatan berupa komunikasi terapeutik, pemberian dukungan <i>spiritual</i> , serta respons terhadap kebutuhan pasien. Peserta diharapkan mampu menunjukkan empati, mendengarkan aktif, memfasilitasi kebutuhan spiritual (misalnya menawarkan bantuan tokoh agama), serta melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan secara tepat.				4	
4. Penerapan Prinsip Etika Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan menerapkan prinsip etika dalam kasus paliatif, meliputi <i>autonomy</i> (menghormati keputusan pasien), <i>beneficence</i> (memberikan manfaat), <i>non-maleficence</i> (tidak merugikan), <i>veracity</i> (kejujuran), dan <i>justice</i> (keadilan). Peserta diharapkan mampu mengenali dilema etika dan memberikan respons yang tepat.				1	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menunjukkan sikap profesional sesuai prinsip etik dan legal, meliputi komunikasi terapeutik, menjaga privasi (<i>confidentiality</i>), tidak				1	

menghakimi, bersikap empati, sistematis, teliti, serta respons terhadap kebutuhan pasien.						
---	--	--	--	--	--	--

IDeskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian	Pengkajian dilakukan sangat terbatas dan tidak sistematis, tidak menggali aspek spiritual, budaya, dan emosional secara adekuat	Pengkajian cukup lengkap meliputi sebagian aspek spiritual, budaya, dan emosional, namun belum sistematis atau kurang mendalam	Pengkajian lengkap, sistematis, mencakup aspek spiritual, budaya, emosional, serta mampu mengidentifikasi <i>spiritual distress</i> dan menginterpretasikan data dengan tepat
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus, serta tidak mampu menyusun rencana keperawatan	Menetapkan diagnosis tetapi tidak tepat sebagai prioritas (misalnya tidak mengidentifikasi <i>spiritual distress</i>), rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan	Diagnosis cukup tepat namun belum sepenuhnya sesuai prioritas, rencana keperawatan kurang lengkap atau kurang spesifik terhadap kebutuhan	Diagnosis tepat (misalnya <i>spiritual distress</i>) dan rencana keperawatan sesuai, relevan, serta mencakup intervensi spiritual, komunikasi, dan dukungan pasien

			pasien paliatif	
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan tindakan atau tindakan tidak sesuai, tidak menunjukkan komunikasi terapeutik dan tidak memberikan dukungan spiritual	Melakukan tindakan sangat terbatas, komunikasi kurang empati, tidak menggali kebutuhan spiritual secara adekuat, dan tidak melibatkan pasien	Melakukan komunikasi terapeutik dan dukungan spiritual cukup baik, sebagian besar langkah benar, namun masih kurang dalam kedalaman empati, sistematika, atau respons terhadap kebutuhan pasien	Melakukan komunikasi terapeutik secara empati, mendengarkan aktif, memvalidasi perasaan pasien, memberikan dukungan spiritual, menawarkan bantuan tokoh agama, serta melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan secara tepat dan sistematis
4. Penerapan Prinsip Etika	Tidak memahami dan tidak menerapkan prinsip etika dalam tindakan	Menyebutkan prinsip etika tetapi tidak mampu menerapkannya dalam kasus (misalnya mengabaikan autonomy pasien)	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, namun masih kurang dalam komunikasi terapeutik, privasi,	Mampu mengidentifikasi dilema etika dan menerapkan prinsip etika (autonomy, beneficence, non-maleficence, veracity, justice) secara tepat, konsisten, dan sesuai konteks pasien

			empati, dan sikap	
5. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak menjaga privasi, tidak empatik, dan tidak memperhatikan kenyamanan pasien	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, namun masih kurang dalam komunikasi terapeutik, privasi, empati, dan sikap.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi cukup jelas, menjaga privasi dan kenyamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, komunikasi terapeutik baik, empati, tidak menghakimi, menjaga privasi, menghargai pasien, serta bertindak sistematis, teliti, dan etis.

Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji:.....

DOPS (*Does*)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada **Asuhan keperawatan spiritual, Budaya, dan etika pada pasien paliatif**
- *Checklist* dan umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS) pada Asuhan Spiritual, Budaya, dan Etika Pada Pasien Paliatif

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien Paliatif
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan klinik mahasiswa dalam melakukan tindakan atau asuhan keperawatan secara nyata di lahan praktik..	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan <i>spiritual</i> dan komunikasi kepada pasien dengan kanker stadium lanjut di ruang paliatif.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, komunikasi terapeutik, penalaran klinik, penerapan prinsip etika, serta profesionalisme dalam praktik nyata.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pengetahuan tentang perawatan paliatif, tetapi juga dari kemampuan menggali kebutuhan <i>spiritual</i> pasien, respons emosi pasien, serta mengambil keputusan secara etis.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran.	Seorang pasien laki-laki usia 60 tahun dengan kanker stadium lanjut tampak sedih, mengatakan hidupnya tidak berarti, takut mati, dan ingin bertemu tokoh agama. Keluarga meminta agar kondisi pasien tidak dijelaskan secara terbuka.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh mulai dari interaksi awal hingga penyampaian rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian <i>spiritual</i> dan emosional, menggali nilai budaya dan peran keluarga, mengidentifikasi <i>spiritual distress</i> , melakukan komunikasi empati, serta menyampaikan rencana dukungan <i>spiritual</i> dan pendekatan etika kepada pasien.

Aspek yang dinilai	Aspek meliputi pengkajian, komunikasi terapeutik, penalaran klinik, penerapan prinsip etika, edukasi, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa dalam menggali makna hidup pasien, kebutuhan <i>spiritual</i> , konflik keluarga, serta kemampuan menerapkan prinsip <i>autonomy</i> , <i>beneficence</i> , <i>non-maleficence</i> , <i>veracity</i> , dan <i>justice</i> dalam komunikasi dan tindakan.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa mahasiswa secara langsung menggunakan checklist DOPS yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu mengidentifikasi <i>spiritual distress</i> , menghormati pilihan pasien, menjaga komunikasi yang empati, serta menyeimbangkan antara keinginan pasien dan keluarga secara etis..
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat spesifik, singkat, dan berorientasi pada perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi empati, namun perlu meningkatkan kemampuan dalam menggali aspek budaya dan menjelaskan dilema etika dengan lebih jelas.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan asuhan secara holistik, empatik, dan etis. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi jika masih membutuhkan arahan dalam komunikasi atau analisis etika. Mahasiswa dinyatakan remedial jika belum mampu melakukan pengkajian dan komunikasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa	Pada kasus paliatif, mahasiswa dinilai tidak hanya memahami

	mencapai level <i>does</i> dalam piramida Miller.	teori, tetapi juga mampu memberikan asuhan <i>spiritual</i> , budaya, dan etika secara langsung, tepat, dan profesional di lahan praktik.
--	---	---

C. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE dan DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel Portofolio pada Asuhan Spiritual, Budaya, dan Etika pada Pasien Paliatif

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien Paliatif
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan paliatif, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian <i>spiritual</i> , memahami nilai budaya, menerapkan prinsip etika, melakukan komunikasi terapeutik, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat pasien paliatif, tetapi juga menunjukkan perkembangan

		kemampuannya dalam memberikan dukungan <i>spiritual</i> , memahami budaya pasien, dan mengambil keputusan etis setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE memuat hasil ujian keterampilan komunikasi terapeutik dan pengkajian <i>spiritual</i> , sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa memberikan asuhan pada pasien paliatif di ruang perawatan.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus pasien kanker stadium lanjut dengan <i>spiritual distress</i> , mencakup kondisi emosional, kebutuhan <i>spiritual</i> , konflik keluarga, diagnosis keperawatan, intervensi dukungan <i>spiritual</i> , serta evaluasi respons pasien.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya komunikasi yang jujur dan empati, menjaga privasi pasien, menghormati keputusan pasien, serta menghindari tindakan yang dapat menambah <i>spiritual distress</i> atau konflik keluarga.

Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi empati dan dukungan <i>spiritual</i> , namun perlu meningkatkan kemampuan dalam menggali aspek budaya dan menganalisis dilema etika secara lebih mendalam.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman praktik paliatif yang menunjukkan konsistensi dalam pengkajian <i>spiritual</i> , komunikasi empati, dan penerapan prinsip etika dalam berbagai situasi pasien.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa konsisten mampu mengidentifikasi <i>spiritual distress</i> , menghormati <i>autonomy</i> pasien, dan memberikan asuhan yang empati dan etis.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan paliatif, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep <i>spiritual</i> , budaya, dan etika, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam praktik klinik nyata secara profesional.

Tabel *Case Report* pada Asuhan Spiritual, Budaya, dan Etika pada Pasien Paliatif

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien Paliatif
Hakikat <i>Case Report</i>	<i>Case report</i> merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, <i>case report</i> berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan tentang pasien laki-laki usia 60 tahun dengan kanker stadium lanjut yang mengalami <i>spiritual distress</i> , merasa hidup tidak bermakna, dan takut menghadapi kematian.
Tujuan	<i>Case report</i> bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan kondisi pasien, tetapi juga menjelaskan masalah <i>spiritual</i> , konflik keluarga, penerapan prinsip etika, serta perkembangan kondisi emosional pasien setelah intervensi.
Isi laporan	Isi <i>case report</i> biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Mahasiswa menuliskan keluhan pasien (merasa hidup tidak berarti, takut mati), data emosional dan <i>spiritual</i> , konflik keluarga terkait informasi penyakit, diagnosis <i>spiritual distress</i> , intervensi dukungan <i>spiritual</i> dan komunikasi empati, serta evaluasi peningkatan ketenangan pasien.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengidentifikasi <i>spiritual distress</i> , memahami nilai

	kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	budaya dan konflik keluarga, menerapkan prinsip etika, serta mengevaluasi respons pasien terhadap dukungan yang diberikan..
Nilai edukatif	<i>Case report</i> membantu mahasiswa mengembangkan <i>clinical reasoning</i> , keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus paliatif, mahasiswa belajar pentingnya komunikasi empati, penghormatan terhadap nilai pasien, serta pengambilan keputusan etis dalam situasi kompleks.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, <i>case report</i> menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep <i>spiritual</i> , budaya, dan etika, tetapi juga mampu menerapkannya dalam asuhan keperawatan paliatif secara nyata dan terdokumentasi dengan baik.

Tabel. Refleksi *Patient Safety* pada Asuhan Spiritual, Budaya, dan Etika pada Pasien Paliatif

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien Paliatif
Hakikat refleksi <i>patient safety</i>	Refleksi <i>patient safety</i> merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus paliatif, mahasiswa merefleksikan bahwa <i>spiritual distress</i> , komunikasi yang tidak tepat, serta konflik antara pasien dan keluarga dapat memperburuk kondisi psikologis dan kualitas hidup pasien.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan dalam komunikasi,

	mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	tidak menghormati keputusan pasien, atau mengabaikan kebutuhan <i>spiritual</i> dapat berdampak pada <i>distress</i> pasien dan kualitas pelayanan.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien paliatif adalah <i>spiritual distress</i> , konflik keluarga dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya komunikasi yang jujur dan empati.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien secara holistik	Risiko yang diidentifikasi antara lain: meningkatnya <i>spiritual distress</i> , kecemasan dan ketakutan terhadap kematian, konflik antara keinginan pasien dan keluarga, pelanggaran <i>autonomy</i> pasien, serta komunikasi yang tidak tepat..
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya melakukan komunikasi empati, menghormati keputusan pasien (<i>autonomy</i>), memberikan dukungan <i>spiritual</i> , melibatkan keluarga secara tepat, menjaga privasi, serta melakukan kolaborasi dengan tenaga profesional (misalnya tokoh agama).
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa dalam asuhan paliatif, komunikasi yang baik, penghormatan terhadap nilai pasien, dan penerapan prinsip etika merupakan kunci untuk

		menjaga keselamatan dan kualitas hidup pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan keperawatan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko, mengambil keputusan etis, dan meningkatkan kualitas praktik secara berkelanjutan dalam asuhan paliatif.

D. Ringkasan

Asuhan Spiritual, Budaya, dan Etika pada Pasien Paliatif

Bab ini menekankan bahwa asuhan keperawatan paliatif tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga mencakup aspek *spiritual*, budaya, dan etika yang sangat memengaruhi kualitas hidup pasien. Pasien paliatif sering mengalami *spiritual distress* seperti kehilangan makna hidup, rasa putus asa, ketakutan terhadap kematian, serta konflik nilai yang membutuhkan pendekatan holistik dan empati dari perawat. Oleh karena itu, fokus utama asuhan keperawatan adalah membantu pasien mencapai ketenangan, mempertahankan martabat, serta memberikan dukungan sesuai keyakinan dan nilai yang dianut.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pada pasien paliatif tidak hanya terbatas pada kondisi fisik, tetapi juga harus mencakup kondisi emosional, kebutuhan *spiritual*, keyakinan agama, makna hidup, nilai budaya, serta peran keluarga dalam pengambilan keputusan. Pengkajian juga harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda *spiritual distress* seperti perasaan hidup tidak bermakna, kecemasan terhadap kematian, menarik diri, serta keinginan untuk mendapatkan dukungan *spiritual*. Selain itu, penting untuk menggali nilai budaya yang memengaruhi cara pasien dan keluarga dalam memaknai penyakit, pengambilan keputusan, dan perawatan di akhir hayat.

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian holistik yang mencakup aspek *bio-psiko-sosio-spiritual*, dilanjutkan dengan identifikasi masalah keperawatan seperti *spiritual distress*, ansietas, atau konflik dalam pengambilan keputusan. Perawat kemudian menyusun rencana asuhan yang berfokus pada komunikasi terapeutik, dukungan *spiritual*, penghormatan terhadap nilai budaya, serta penerapan prinsip etika seperti *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, *veracity*, dan *justice*. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa asuhan yang diberikan benar-benar berpusat pada pasien (*patient-centered care*).

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan komunikasi terapeutik yang meliputi empati, pendengaran aktif, serta memberikan respons yang mendukung kebutuhan pasien. Tindakan keperawatan meliputi memberikan dukungan emosional, memfasilitasi kebutuhan *spiritual* (misalnya menghadirkan tokoh agama), menghormati pilihan pasien, menjaga privasi, serta melibatkan keluarga secara tepat. Dalam situasi dilema etika, mahasiswa dituntut mampu menyeimbangkan antara keinginan pasien dan keluarga dengan tetap mengutamakan prinsip etika dan keselamatan pasien.

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan melihat respons pasien, seperti peningkatan ketenangan, berkurangnya kecemasan, kemampuan pasien mengekspresikan perasaan, serta terpenuhinya kebutuhan *spiritual*. Selain itu,

keberhasilan juga terlihat dari kemampuan keluarga memahami kondisi pasien dan berpartisipasi dalam perawatan secara suportif. Apabila ditemukan konflik etika yang kompleks, penolakan pasien terhadap perawatan, atau *distress* yang semakin berat, maka mahasiswa harus melakukan eskalasi kepada tim kesehatan atau pembimbing klinik untuk penanganan lebih lanjut.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa asuhan keperawatan paliatif harus dilakukan secara holistik, empati, dan berlandaskan nilai *spiritual*, budaya, dan etika. Mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan, tetapi juga kepekaan, keterampilan komunikasi, serta kemampuan pengambilan keputusan etis dalam situasi kompleks. Hal ini menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab maupun praktik klinik keperawatan paliatif.

E. Tabel Red Flags & Escalation Asuhan Spiritual, Budaya, dan Etika pada Pasien Paliatif

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Pasien menyatakan putus asa, hidup tidak bermakna, atau ingin menyerah	Menunjukkan <i>spiritual distress</i> berat dan risiko penurunan kualitas hidup	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab, lakukan komunikasi empati, dan kolaborasi dengan psikolog/rohaniawan
Pasien menunjukkan ketakutan ekstrem terhadap kematian	Menandakan kecemasan tinggi dan distress psiko <i>spiritual</i>	Lakukan pendekatan terapeutik, laporkan, dan kolaborasi dengan tim paliatif
Pasien menarik diri, tidak mau berkomunikasi	Indikasi distress emosional atau <i>spiritual</i> yang memburuk	Lakukan pendekatan bertahap, laporkan bila berlanjut, dan evaluasi kebutuhan dukungan lanjutan
Konflik antara pasien dan keluarga terkait keputusan perawatan	Dilema etika yang dapat memengaruhi keselamatan dan kualitas hidup pasien	Diskusikan dengan tim kesehatan, eskalasi ke komite etik bila diperlukan
Keluarga melarang pasien mengetahui kondisi penyakitnya	Potensi pelanggaran prinsip <i>autonomy</i> dan <i>veracity</i>	Konsultasikan dengan tim kesehatan, lakukan pendekatan komunikasi sensitif, dan pertimbangkan aspek budaya

Pasien meminta informasi kondisi tetapi tidak diberikan	Risiko ketidakjujuran dan konflik etika	Laporkan dan diskusikan dengan tim untuk menentukan pendekatan komunikasi yang tepat
Penolakan pasien terhadap tindakan medis penting	Risiko keselamatan pasien dan konflik dalam pengambilan keputusan	Lakukan edukasi, klarifikasi keputusan pasien, dan eskalasi ke tim bila perlu
Pasien menunjukkan tanda <i>distress</i> berat (menangis terus, gelisah)	Menandakan kebutuhan intervensi segera secara emosional dan <i>spiritual</i>	Berikan dukungan langsung, laporkan, dan kolaborasi dengan tim psikososial
Tidak terpenuhinya kebutuhan <i>spiritual</i> pasien	Dapat memperburuk kondisi psikologis dan kualitas hidup	Fasilitasi kebutuhan <i>spiritual</i> , hubungkan dengan tokoh agama, dan laporkan bila tidak terpenuhi
Pelanggaran privasi atau kerahasiaan pasien	Risiko masalah etik dan legal	Segera perbaiki tindakan, laporkan kepada pembimbing, dan lakukan sesuai standar etik
Komunikasi tidak empati atau menyinggung nilai pasien	Dapat menyebabkan <i>distress</i> tambahan dan menurunkan kepercayaan	Evaluasi diri, perbaiki komunikasi, dan laporkan bila berdampak signifikan
Keputusan klinik tidak melibatkan pasien	Pelanggaran prinsip <i>autonomy</i> dan <i>patient-centered care</i>	Laporkan dan dorong keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Asuhan Asuhan *Spiritual*, Budaya, dan Etika pada Pasien Paliatif

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep asuhan keperawatan paliatif secara sederhana	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian <i>spiritual</i> pada pasien paliatif	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa mengkaji kondisi emosional pasien (cemas, takut, sedih)	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda <i>spiritual distress</i>	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menggali keyakinan agama dan makna hidup pasien	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengkaji nilai budaya yang memengaruhi perawatan pasien	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan (misalnya <i>spiritual distress</i>)	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan <i>spiritual</i> yang sesuai	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa melakukan komunikasi terapeutik secara empati	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa memberikan dukungan <i>spiritual</i> sesuai kebutuhan pasien	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menghormati keputusan pasien (<i>autonomy</i>)	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menerapkan prinsip etika dalam asuhan keperawatan	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa mengidentifikasi dilema etika dalam kasus paliatif	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menjaga privasi dan kerahasiaan pasien	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa melibatkan keluarga secara tepat dalam perawatan	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan paliatif	☐	☐	_____
18	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, empati, dan tidak menghakimi	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

F. Daftar Pustaka

- American Nurses Association. (2015). *Code of ethics for nurses with interpretive statements*. American Nurses Association.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Ferrell, B. R., & Coyle, N. (2015). *Oxford textbook of palliative nursing* (4th ed.). Oxford University Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelayanan paliatif di fasilitas kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Profil kesehatan Indonesia 2023*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Puchalski, C. M., Vitillo, R., Hull, S. K., & Reller, N. (2014). Improving the *spiritual* dimension of whole person care: Reaching national and international consensus. *Journal of Palliative Medicine*, 17(6), 642–656. <https://doi.org/10.1089/jpm.2014.9427>
- Royal College of Nursing. (2021). *Spirituality in nursing care: A pocket guide*. Royal College of Nursing.
- Sulmasy, D. P. (2017). *Spirituality, religion, and clinical care*. *Chest*, 152(6), 1248–1255. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2017.05.001>
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). *Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- World Health Organization. (2018). *Integrating palliative care and symptom relief into primary health care: A WHO guide for planners, implementers and managers*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2020). *Palliative care*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>

BAB 3

PERAWATAN AKHIR HAYAT (END-OF-LIFE CARE)

Identitas Bab

- **CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) Terkait**

CPL-3: Mampu merancang dan melaksanakan manajemen gejala utama (nyeri, sesak, GI, kelelahan, *distress* psikologis) secara aman dan terukur.

CPL-6: Mampu mengevaluasi luaran paliatif, melakukan dokumentasi, *discharge/home care planning*, serta dukungan *caregiver* dan bereavement berbasis kebutuhan.

- **CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) Terkait**

CPMK Utama

CPMK-5: Melaksanakan asuhan akhir hayat dan dukungan keluarga/*caregiver* (termasuk *bereavement care*) dengan fokus pada kenyamanan dan keselamatan.

CPMK Penguat

CPMK-3: Menerapkan komunikasi paliatif (kabar sulit, perencanaan perawatan/ACP (*Advance Care Planning*) dan pengambilan keputusan bersama pasien–keluarga secara etis.

CPMK-6: Menginisiasi kolaborasi interprofesional, dukungan *spiritual*-budaya, serta advokasi dan koordinasi layanan (*home care*/rujukan).

CPMK-7: Mengevaluasi luaran paliatif, menyusun dokumentasi dan rencana tindak lanjut, serta melakukan refleksi untuk perbaikan mutu layanan berbasis indikator.

- **Sub-CPMK Bab (*Learning Outcomes* Bab)**

Sub-CPMK 1: Mengidentifikasi tanda fase akhir hayat dan menetapkan prioritas kenyamanan serta keselamatan.

Sub-CPMK 2: Melaksanakan asuhan akhir hayat (*comfort care*) dan dukungan keluarga sesuai tujuan perawatan (pengkajian, diagnosis keperawatan, rencana intervensi, evaluasi).

A. Capaian Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar perawatan akhir hayat (*end-of-life care*).
2. Menjelaskan prinsip perawatan akhir hayat (*end-of-life care*).

3. Mengidentifikasi dan menjelaskan tahapan fase akhir kehidupan.
4. Mengidentifikasi kebutuhan pasien pada fase akhir hayat.
5. Memahami konsep kenyamanan (*comfort care*) dalam asuhan keperawatan.
6. Mengidentifikasi keselamatan pasien pada fase terminal.
7. Menjelaskan peran keluarga dalam perawatan akhir hayat.
8. Mengidentifikasi dan menjelaskan proses dan dampak berduka pada keluarga.
9. Melakukan komunikasi dalam perawatan akhir hayat.
10. Melakukan kolaborasi interprofesional dalam perawatan akhir hayat.
11. Melakukan asuhan keperawatan akhir hayat.

B. Indikator Ketercapaian

Peserta didik dinyatakan mencapai kompetensi apabila mampu:

1. Konsep dan Prinsip Perawatan Akhir Hayat

- a. Menjelaskan pengertian *end-of-life care*.
- b. Menjelaskan tujuan perawatan (*quality of life dan comfort*).
- c. Mengidentifikasi prinsip perawatan (holistik, *patient-centered*, kolaboratif).

2. Tahapan Fase Akhir Kehidupan

- a. Menyebutkan tahapan fase akhir kehidupan.
- b. Menjelaskan karakteristik setiap fase.
- c. Mengidentifikasi tanda klinis pada fase terminal dan menjelang kematian.
- d. Menentukan fase pasien berdasarkan kasus sederhana.

3. Kebutuhan Pasien Fase Akhir Hayat

- a. Mengidentifikasi kebutuhan fisik (nyeri, gejala, nutrisi).
- b. Mengidentifikasi kebutuhan psikologis pasien.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan sosial pasien.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan *spiritual* pasien.

4. *Comfort Care* dan Keselamatan Pasien

- a. Menjelaskan konsep *comfort care*.
- b. Mengidentifikasi komponen *comfort care*.
- c. Menentukan prioritas tindakan berbasis kenyamanan pasien.
- d. Mengidentifikasi risiko keselamatan pasien pada fase terminal.

5. Peran Keluarga dan Proses Berduka

- a. Menjelaskan peran keluarga dalam perawatan akhir hayat.
- b. Mengidentifikasi kebutuhan keluarga pasien.
- c. Mengidentifikasi tahapan dan respons berduka.
- d. Memberikan dukungan awal pada keluarga yang berduka.

6. Komunikasi dan Kolaborasi

- a. Menjelaskan prinsip komunikasi terapeutik.

- b. Melakukan komunikasi empati dengan pasien dan keluarga.
- c. Menyampaikan informasi secara jelas dan sensitif.
- d. Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan.

7. Asuhan Keperawatan Akhir Hayat

- a. Melakukan pengkajian pasien fase terminal.
- b. Menentukan masalah/diagnosis keperawatan.
- c. Menyusun rencana intervensi berbasis *comfort care*.
- d. Melaksanakan tindakan keperawatan secara aman.
- e. Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan.

C. Peta Konsep Bab (*Concept Map*)

Perawatan Akhir Hayat (*End-of-Life Care*) bagian dari perawatan paliatif berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kenyamanan pasien tidak berorientasi kuratif, tetapi pada pengurangan penderitaan menggunakan pendekatan holistik (bio-psiko-sosial-*spiritual*). Prinsip Perawatan Akhir Hayat holistik *patient-centered care* berbasis kebutuhan pasien kolaboratif (interprofesional) komunikasi efektif dan empati. Tahapan Fase Akhir Kehidupan fase stabil fase penurunan fase terminal fase menjelang kematian (*actively dying*) setiap fase memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda. Kebutuhan Pasien Fase Akhir Hayat Fisik (nyeri, gejala, nutrisi, hidrasi) Psikologis (kecemasan, dukungan emosional, penerimaan) Sosial: dukungan keluarga, interaksi sosial, lingkungan *Spiritual* (makna hidup, keyakinan, ketenangan batin). *Comfort Care* pendekatan utama dalam fase terminal fokus pada kenyamanan dan kualitas hidup tidak menekankan tindakan invasif. Peran keluarga bagian dari unit perawatan memberikan dukungan emosional dan sosial terlibat dalam pengambilan keputusan menghadapi proses berduka (*bereavement*). Komunikasi dan Kolaborasi komunikasi terapeutik dengan pasien & keluarga penyampaian informasi secara empati kolaborasi tim kesehatan (dokter, perawat, dll.). Asuhan Keperawatan Akhir Hayat pengkajian komprehensif diagnosis keperawatan perencanaan berbasis *comfort care* implementasi tindakan evaluasi hasil.

D. Kata Kunci

Perawatan akhir hayat, *end-of-life care*, perawatan paliatif, kualitas hidup, *comfort care*, fase akhir kehidupan, fase terminal, kebutuhan pasien, kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial, kebutuhan *spiritual*, manajemen nyeri, pengendalian gejala, dukungan emosional, dukungan *spiritual*, peran keluarga, berduka (*bereavement*), komunikasi terapeutik, kolaborasi interprofesional, asuhan keperawatan, keselamatan pasien, *dignified death*.

Pendahuluan

Perawatan akhir hayat (*end-of-life care*) merupakan bagian integral dari perawatan paliatif yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dengan kondisi terminal. Tujuan pelayanan kesehatan pada fase ini tidak lagi berorientasi pada kesembuhan, melainkan pada kenyamanan dan pengurangan penderitaan/ketidaknyamanan. Pendekatan yang digunakan bersifat holistik dengan memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan *spiritual* pasien (Nicole, 2023; OECD, 2025). Oleh karena itu, perawatan akhir hayat menjadi bagian penting dalam praktik keperawatan yang berpusat pada pasien.

Umumnya, pasien yang sedang menjalani fase akhir kehidupan mengalami penurunan kondisi fisik yang progresif disertai berbagai gejala yang mengganggu. Gejala yang sering muncul seperti nyeri, sesak napas, kelelahan, serta gangguan psikologis. Selain itu, pasien juga menghadapi tantangan emosional dan *spiritual* terkait makna hidup dan penerimaan kondisi penyakit (Pun et al., 2023; NICE, 2023). Kondisi ini menuntut tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Perawatan akhir hayat tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga melibatkan keluarga sebagai bagian dari unit perawatan. Keluarga berperan dalam memberikan dukungan emosional, membantu pengambilan keputusan, serta mendampingi pasien. Selain itu, keluarga juga akan menghadapi proses berduka yang memerlukan perhatian dan dukungan (Rosa et al., 2022; Xiao et al., 2021). Dengan demikian, pendekatan yang digunakan harus mampu mengakomodasi kebutuhan pasien dan keluarga secara bersamaan.

Dalam praktik keperawatan, perawat memiliki peran penting dalam memberikan asuhan pada pasien fase akhir hayat. Perawat dituntut mampu melakukan pengkajian secara komprehensif serta merencanakan intervensi yang tepat. Selain itu, perawat juga harus mampu melakukan komunikasi terapeutik dan berkolaborasi dengan tim kesehatan. Dengan pemahaman yang baik, perawat dapat memberikan asuhan yang humanis, bermartabat, dan berorientasi pada kualitas hidup pasien (Paladino et al., 2023; Radionova et al., 2020).

A. Konsep Perawatan Akhir Hayat (*End of Life Care*)

Perawatan akhir hayat (*end-of-life care*) merupakan bagian integral dari perawatan paliatif yang diberikan kepada pasien dengan kondisi terminal, di mana tujuan utama pelayanan kesehatan mengalami pergeseran dari pendekatan kuratif menuju peningkatan kualitas hidup (*quality of life*). Pada fase ini, keberhasilan perawatan tidak lagi diukur dari kesembuhan penyakit, melainkan dari kemampuan dalam mengurangi penderitaan dan meningkatkan kenyamanan pasien. Fokus utama meliputi pengendalian gejala fisik seperti nyeri dan sesak napas, serta pemenuhan kebutuhan psikologis, sosial, dan *spiritual*. Pendekatan ini sejalan dengan temuan bahwa manajemen gejala merupakan inti dari perawatan paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien pada fase akhir kehidupan (Nicole, 2023; OECD, 2025).

Secara konseptual, perawatan akhir hayat didefinisikan sebagai serangkaian layanan kesehatan yang diberikan pada fase terakhir kehidupan, yang mencakup manajemen gejala, dukungan emosional, serta pendampingan *spiritual* bagi pasien dan keluarganya. Layanan ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga dapat diberikan di rumah atau komunitas sesuai kebutuhan pasien. Pendekatan yang digunakan bersifat multidisiplin, melibatkan berbagai tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh studi terbaru yang menekankan pentingnya pendekatan interprofesional dalam meningkatkan kualitas pelayanan paliatif dan *end-of-life care* (Serra et al., 2023).

Perawatan paliatif merupakan pendekatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa melalui pencegahan dan pengurangan penderitaan. Pendekatan ini dilakukan melalui identifikasi dini, penilaian yang komprehensif, serta penatalaksanaan masalah fisik, psikososial, dan *spiritual*. Dalam konteks ini, perawatan akhir hayat menjadi bagian penting dari spektrum perawatan paliatif yang berfokus pada fase menjelang kematian. Hal ini diperkuat oleh penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa kontrol nyeri dan gejala merupakan prioritas utama dalam pelayanan *end-of-life care* (Amano et al., 2022; Hedman et al., 2024).

Perkembangan konsep perawatan akhir hayat menunjukkan bahwa layanan ini tidak hanya terbatas pada hari-hari terakhir kehidupan, tetapi juga dapat dimulai sejak pasien memasuki fase penyakit lanjut. Literatur terbaru menekankan pentingnya integrasi perawatan paliatif lebih awal dalam perjalanan penyakit untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi intervensi yang tidak perlu.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas hidup pasien sejak dini serta mempersiapkan pasien dan keluarga dalam menghadapi proses akhir kehidupan. Dengan demikian, perawatan akhir hayat bersifat dinamis dan berkelanjutan, tidak hanya reaktif terhadap kondisi kritis pasien (Serra et al., 2023).

Perawatan akhir hayat juga menekankan pendekatan holistik yang mencakup empat dimensi utama, yaitu fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dimensi fisik berkaitan dengan pengendalian nyeri dan gejala, sedangkan dimensi psikologis berfokus pada dukungan emosional dan mekanisme koping pasien. Dimensi sosial melibatkan hubungan interpersonal serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, sementara dimensi *spiritual* berkaitan dengan pencarian makna hidup dan kebutuhan religius pasien. Pendekatan ini sesuai dengan konsep multidimensional suffering dalam paliatif, di mana penderitaan pasien tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikososial (Habib et al., 2023).

Selain berfokus pada pasien, perawatan akhir hayat juga melibatkan keluarga sebagai bagian dari unit perawatan. Pendekatan ini dikenal sebagai *patient and family-centered care*, di mana keluarga dilibatkan dalam pengambilan keputusan, perawatan sehari-hari, serta dukungan emosional pasien. Keterlibatan keluarga terbukti meningkatkan kualitas perawatan serta pengalaman pasien selama fase akhir kehidupan. Hal ini juga berdampak pada kesiapan keluarga dalam menghadapi proses berduka dan meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan kesehatan (Hedman et al., 2024).

Dalam praktiknya, perawatan akhir hayat juga berkaitan erat dengan aspek etika dan hak pasien. Pasien memiliki hak untuk menentukan pilihan terkait perawatan yang diinginkan, termasuk menolak tindakan medis tertentu yang dianggap tidak memberikan manfaat. Prinsip otonomi, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice* menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis pada fase ini. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan empati menjadi komponen penting dalam memastikan bahwa perawatan sesuai dengan nilai dan preferensi pasien (Serra et al., 2023).

Dengan demikian, perawatan akhir hayat merupakan pendekatan komprehensif yang berorientasi pada kualitas hidup, penghormatan terhadap martabat pasien, serta keterlibatan keluarga sebagai bagian integral dalam proses perawatan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mencakup dimensi psikososial dan *spiritual* secara menyeluruh. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep ini sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang humanis dan bermakna. Hal ini pada akhirnya akan mendukung tercapainya kematian yang bermartabat (*dignified death*) bagi setiap individu (Nicole, 2023; OECD, 2025).

B. Prinsip Perawatan Akhir Hayat (End-of-Life Care)

Prinsip utama dalam perawatan akhir hayat adalah pendekatan holistik (*bio-psiko-sosio-spiritual*) yang memandang pasien sebagai individu yang utuh. Hal ini berarti perawatan tidak hanya berfokus pada gejala fisik, tetapi juga pada aspek emosional, sosial, dan spiritual. Pendekatan holistik memungkinkan tenaga kesehatan memahami pengalaman penderitaan pasien secara menyeluruh (Webb et al., 2024; Yang et al., 2023). Selain itu, pemenuhan aspek martabat (*dignity*) pasien juga menjadi bagian penting dalam perawatan akhir hayat, yang mencakup penghormatan terhadap nilai, preferensi, dan pengalaman hidup pasien (Yanez et al., 2025). Pendekatan ini merupakan bagian dari rekomendasi global dalam pelayanan paliatif modern yang menekankan perawatan komprehensif dan berpusat pada pasien (Haroen et al., 2025).

Prinsip berikutnya adalah berpusat pada pasien (*patient-centered care*), di mana keputusan perawatan didasarkan pada nilai dan preferensi pasien. Dalam pendekatan ini, pasien memiliki peran aktif dalam menentukan pilihan terapi yang sesuai dengan kondisi dan keinginannya, sementara tenaga kesehatan bertindak sebagai fasilitator yang memberikan informasi dan dukungan dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini telah menjadi standar dalam pelayanan kesehatan modern, khususnya dalam perawatan paliatif yang menekankan partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan dan penghormatan terhadap kebutuhan individual pasien (Kuosmanen et al., 2021; Stevenson-Baker, 2023).

Prinsip berbasis kebutuhan menekankan bahwa setiap intervensi harus disesuaikan dengan kondisi dan prioritas pasien. Kebutuhan pasien pada fase akhir hayat bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan penyakit, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun *spiritual*. Oleh karena itu, pengkajian harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan intervensi tetap relevan dan sesuai dengan kondisi terkini pasien. Pendekatan ini membantu menghindari tindakan yang tidak perlu serta meningkatkan efektivitas perawatan (Birgisdóttir et al., 2021).

Prinsip kolaboratif (*interprofessional*) menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan yang komprehensif. Tim interprofesional biasanya terdiri dari dokter, perawat, psikolog, rohaniawan, dan pekerja sosial. Kolaborasi ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan pasien secara menyeluruh dan terintegrasi, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun *spiritual*. Pendekatan ini telah menjadi standar dalam praktik paliatif modern karena perawatan paliatif secara efektif membutuhkan keterlibatan tim interprofesional yang berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Pornrattanakavee et al., 2022).

Prinsip terakhir adalah komunikasi efektif dan empati, yang merupakan kunci dalam perawatan akhir hayat. Komunikasi yang baik membantu pasien dan keluarga memahami kondisi serta pilihan perawatan yang tersedia, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait terapi. Selain itu, komunikasi pada akhir hayat terbukti berperan dalam meningkatkan kualitas perawatan melalui pengambilan keputusan bersama, penyesuaian komunikasi dengan kebutuhan pasien, serta pendekatan yang empati terhadap kondisi pasien dan keluarga (Khonsari et al., 2024).

C. Tahapan Fase Akhir Kehidupan

Fase akhir kehidupan merupakan proses yang dinamis dan bertahap, ditandai dengan perubahan kondisi klinis, penurunan fungsi fisik, serta peningkatan kebutuhan perawatan pasien. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Pemahaman terhadap tahapan ini sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk menentukan intervensi yang tepat, terutama dalam mengoptimalkan kualitas hidup pasien melalui pendekatan perawatan paliatif yang komprehensif dan berpusat pada pasien (Mitchell et al., 2022).

1. Fase Stabil

Pada fase ini, pasien masih mampu menjalankan sebagian besar aktivitas sehari-hari meskipun telah didiagnosis menderita penyakit kronis progresif. Kondisi klinis relatif stabil karena terapi yang diberikan masih efektif dalam mengontrol gejala.

Pada tahap ini, pendekatan paliatif mulai diperkenalkan secara dini (*early palliative care*), dengan fokus pada:

- a. Manajemen gejala ringan hingga sedang
- b. Edukasi pasien dan keluarga
- c. Perencanaan perawatan jangka panjang (*advance care planning*)

Pendekatan ini penting untuk mencegah penurunan kualitas hidup di fase berikutnya serta membantu pasien dalam pengambilan keputusan terkait perawatan (Gilissen et al., 2021).

2. Fase Penurunan

Fase penurunan ditandai dengan memburuknya kondisi fisik secara bertahap dan progresif. Pasien mulai mengalami peningkatan gejala seperti kelelahan, nyeri, atau penurunan nafsu makan, serta penurunan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, terjadi penurunan status fungsional yang signifikan, sehingga pasien menjadi lebih bergantung pada

bantuan orang lain. Pada fase ini, kebutuhan terhadap perawatan suportif meningkat, termasuk:

- a. Pengelolaan gejala yang lebih intensif
- b. Dukungan nutrisi dan hidrasi
- c. Pemantauan kondisi secara berkala

Fase ini juga sering menjadi titik penting untuk mengevaluasi kembali tujuan perawatan (*goals of care*), apakah masih bersifat kuratif atau sudah beralih ke paliatif sepenuhnya (Harnischfeger et al., 2022).

3. Fase Terminal

Fase terminal merupakan tahap lanjutan ketika kondisi pasien mengalami penurunan yang signifikan dan tidak reversibel, dengan harapan hidup yang terbatas, umumnya dalam hitungan hari hingga minggu.

Pada fase ini, fokus utama perawatan beralih sepenuhnya pada:

- a. Kenyamanan pasien (*comfort care*)
- b. Pengendalian gejala berat seperti nyeri, sesak napas, dan agitasi
- c. Dukungan psikologis, *spiritual*, dan sosial

Intervensi medis yang bersifat invasif atau tidak memberikan manfaat signifikan biasanya mulai dikurangi atau dihentikan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kualitas hidup dan martabat pasien hingga akhir hayat (NICE, 2023).

4. Fase Menjelang Kematian

Fase menjelang kematian (*actively dying phase*) merupakan tahap akhir yang ditandai dengan perubahan fisiologis yang signifikan akibat kegagalan sistem organ secara progresif.

Beberapa tanda klinis yang umum ditemukan meliputi:

- a. Penurunan kesadaran hingga tidak responsif
- b. Perubahan pola napas (misalnya napas *cheyne-stokes*)
- c. Penurunan perfusi perifer (kulit dingin, sianosis)
- d. Penurunan intake makanan dan cairan

Pada fase ini, tujuan utama perawatan adalah memastikan pasien berada dalam kondisi nyaman dan bebas dari penderitaan. Selain itu, dukungan emosional dan komunikasi yang efektif dengan keluarga menjadi sangat penting untuk membantu proses penerimaan dan menghadapi kematian (Bowers et al., 2023; Carr & Rigby, 2025).

D. Kebutuhan Pasien pada Fase Akhir Hayat

Kebutuhan pasien pada fase akhir hayat bersifat multidimensional, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan perawatan paliatif berfokus

pada peningkatan kualitas hidup melalui pengendalian gejala, kenyamanan, serta dukungan komprehensif bagi pasien dan keluarga. Selain itu, perawatan juga mempertimbangkan nilai, preferensi, dan kondisi klinis pasien secara individual. Keterlibatan keluarga menjadi bagian penting dalam proses perawatan untuk mendukung aspek emosional dan pengambilan keputusan. Dengan pendekatan holistik, diharapkan pasien dapat menjalani fase akhir kehidupan dengan lebih bermartabat dan nyaman.

1. Kebutuhan Fisik

Kebutuhan fisik merupakan aspek utama dalam perawatan pasien fase akhir hayat yang berfokus pada kenyamanan (*comfort care*) dan pengendalian gejala secara optimal. Kondisi fisik pasien pada fase ini umumnya mengalami penurunan progresif yang memerlukan intervensi suportif yang tepat. Penanganan yang adekuat dapat mengurangi penderitaan serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan. Selain itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat individual dan disesuaikan dengan kondisi klinis pasien (Mitchell et al., 2022). Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kondisi pasien.

a. Manajemen nyeri

Nyeri merupakan salah satu gejala paling umum yang dialami pasien pada fase akhir kehidupan, terutama pada penyakit kronis seperti kanker. Penilaian nyeri perlu dilakukan secara rutin menggunakan instrumen yang sesuai untuk menentukan tingkat keparahan dan respons terhadap terapi. Penatalaksanaan nyeri melibatkan terapi farmakologis seperti opioid dan non-opioid serta pendekatan non-farmakologis. Tujuan utama dari manajemen nyeri adalah mencapai kenyamanan maksimal tanpa menimbulkan efek samping yang signifikan. Pendekatan ini harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individual pasien (NICE, 2023).

b. Pengendalian gejala

Pasien pada fase akhir kehidupan sering mengalami berbagai gejala seperti sesak napas, mual, muntah, kelelahan, dan konstipasi. Gejala-gejala ini dapat menurunkan kualitas hidup jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pengendalian gejala dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan medis dan suportif. Penatalaksanaan yang tepat dapat mencegah komplikasi serta memberikan kenyamanan bagi pasien. Selain itu, pemantauan gejala secara berkala sangat penting untuk menyesuaikan intervensi yang diberikan (Harnischfeger et al., 2022).

c. Nutrisi dan hidrasi minimal

Pada fase akhir kehidupan, kebutuhan nutrisi dan hidrasi pasien cenderung menurun secara fisiologis. Kondisi ini merupakan bagian dari proses alami menjelang akhir kehidupan dan tidak selalu memerlukan intervensi agresif. Pemberian nutrisi dan cairan difokuskan pada kenyamanan pasien serta disesuaikan dengan toleransi individu. Intervensi seperti menjaga kelembapan mulut dan pemberian makanan dalam porsi kecil dapat membantu meningkatkan kenyamanan. Selain itu, tindakan invasif sebaiknya dihindari jika tidak memberikan manfaat klinis yang signifikan (NICE, 2023).

2. Kebutuhan Psikologis

Kebutuhan psikologis pada pasien fase akhir hayat merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan emosional pasien. Pasien sering mengalami kecemasan, ketakutan terhadap kematian, serta perasaan tidak berdaya akibat kondisi penyakit yang progresif. Oleh karena itu, perawatan paliatif tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan kondisi mental dan emosional pasien secara menyeluruh. Pendekatan psikologis yang tepat dapat membantu pasien menghadapi kondisi penyakitnya dengan lebih baik. Selain itu, dukungan yang diberikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien (NICE, 2023).

a. Mengurangi kecemasan

Kecemasan merupakan respons psikologis yang umum dialami pasien pada fase akhir kehidupan, terutama akibat ketidakpastian kondisi dan ketakutan terhadap kematian. Kondisi ini sering berkaitan dengan *distress* psikologis yang dapat memengaruhi kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, perawatan paliatif menekankan pentingnya intervensi untuk mengurangi kecemasan melalui pendekatan psikologis dan komunikasi terapeutik. Penanganan kecemasan yang optimal dapat membantu pasien merasa lebih tenang dan meningkatkan kenyamanan (Nowels et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa aspek psikologis merupakan bagian penting dalam perawatan paliatif.

b. Dukungan emosional

Dukungan emosional merupakan kebutuhan penting bagi pasien dalam menghadapi kondisi terminal yang dialaminya. Pasien sering mengalami perasaan sedih, takut, dan kesepian yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologisnya. Intervensi seperti *dignity therapy* terbukti dapat membantu meningkatkan kualitas hidup serta mencegah penurunan kondisi mental pada pasien paliatif. Selain itu, komunikasi yang empati dari tenaga kesehatan dan keluarga berperan penting dalam memberikan rasa aman. Dukungan emosional yang optimal dapat membantu pasien menjalani fase akhir kehidupan dengan lebih bermakna (Seiler et al., 2024).

c. Penerimaan kondisi

Penerimaan terhadap kondisi penyakit merupakan proses psikologis yang penting dalam fase akhir kehidupan. Proses ini berkaitan dengan kemampuan pasien dalam mengelola *distress* psikologis serta beradaptasi terhadap kondisi terminal yang dialaminya. Berbagai intervensi psikologis dalam perawatan paliatif terbukti membantu pasien dan keluarga dalam menghadapi situasi ini. Dukungan psikososial yang tepat dapat meningkatkan penerimaan diri dan mengurangi beban emosional. Dengan adanya penerimaan, pasien dapat menjalani fase akhir kehidupan dengan lebih tenang dan bermakna (Wu et al., 2025).

d. Komunikasi terapeutik

Komunikasi terapeutik merupakan bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan psikologis pasien pada fase akhir kehidupan. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan empati dapat membantu pasien memahami kondisi penyakit serta mengurangi kecemasan yang dirasakan. Selain itu, komunikasi yang efektif memungkinkan pasien mengekspresikan perasaan, harapan, dan ketakutan yang dialaminya. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam membangun hubungan saling percaya dengan pasien. Dengan komunikasi yang baik, pasien dapat merasa lebih dihargai dan didukung secara emosional (Bharadwaj et al., 2024; Pun et al., 2023).

e. Keterlibatan keluarga

Keterlibatan keluarga merupakan bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan psikologis pasien pada fase akhir kehidupan. Kehadiran keluarga dapat memberikan rasa aman, dukungan emosional, serta meningkatkan kenyamanan pasien. Selain itu, keluarga berperan dalam membantu proses pengambilan keputusan terkait perawatan pasien. Keterlibatan keluarga dalam komunikasi perawatan terbukti meningkatkan pemahaman kondisi pasien serta kualitas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perawatan paliatif tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga melibatkan keluarga secara aktif (McAndrew et al., 2025; Pun et al., 2023).

3. Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial pada pasien fase akhir hayat berkaitan dengan hubungan interpersonal, dukungan sosial, serta interaksi pasien dengan lingkungan sekitarnya. Pada fase ini, pasien sering mengalami keterbatasan dalam berinteraksi akibat penurunan kondisi fisik, sehingga dapat menimbulkan perasaan isolasi sosial. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan sosial menjadi penting untuk menjaga kesejahteraan emosional dan kualitas hidup pasien. Dukungan sosial yang optimal dapat membantu pasien merasa tetap terhubung

dengan orang lain. Selain itu, interaksi sosial yang baik juga berperan dalam mengurangi perasaan kesepian pada pasien (Pun et al., 2023).

a. Dukungan sosial

Dukungan sosial merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien pada fase akhir kehidupan. Dukungan ini dapat berasal dari keluarga, teman, maupun tenaga kesehatan yang memberikan perhatian dan kepedulian kepada pasien. Kehadiran orang-orang terdekat dapat membantu pasien merasa lebih dihargai dan tidak merasa sendiri dalam menghadapi penyakitnya. Selain itu, dukungan sosial juga berkontribusi dalam menurunkan tingkat stres dan kecemasan pada pasien. Dengan adanya dukungan sosial yang baik, pasien dapat menjalani fase akhir kehidupan dengan lebih nyaman (Bharadwaj et al., 2024).

b. Interaksi sosial dan komunikasi

Interaksi sosial dan komunikasi merupakan bagian penting dalam memenuhi kebutuhan sosial pasien pada fase akhir kehidupan. Komunikasi yang efektif antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan dapat membantu menjaga hubungan interpersonal yang positif. Selain itu, interaksi sosial memungkinkan pasien untuk tetap terlibat dalam lingkungan sosialnya meskipun dalam kondisi terbatas. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan perasaan terisolasi dan menurunkan kesejahteraan psikologis pasien. Oleh karena itu, upaya untuk mempertahankan komunikasi yang baik perlu terus dilakukan (Pun et al., 2023).

c. Peran lingkungan dan dukungan komunitas

Lingkungan sosial dan dukungan komunitas memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan sosial pasien pada fase akhir kehidupan. Lingkungan yang suportif, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, layanan paliatif, dan komunitas sosial, dapat membantu meningkatkan kenyamanan pasien. Selain itu, dukungan komunitas dapat memberikan akses terhadap bantuan sosial serta sumber daya yang dibutuhkan pasien dan keluarga. Lingkungan yang kondusif juga dapat mengurangi beban perawatan yang dialami keluarga. Dengan adanya dukungan lingkungan yang baik, kualitas hidup pasien dapat meningkat (WHO, 2020).

4. Kebutuhan *Spiritual*

Kebutuhan *spiritual* pada pasien fase akhir hayat berkaitan dengan pencarian makna hidup, keyakinan, serta hubungan dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Pada fase ini, pasien sering merefleksikan kehidupan yang telah dijalani dan menghadapi pertanyaan eksistensial terkait makna penderitaan dan kematian. Pemenuhan kebutuhan *spiritual* menjadi penting karena dapat

memberikan ketenangan batin dan membantu pasien menghadapi akhir kehidupan dengan lebih damai. Selain itu, dukungan *spiritual* juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan *spiritual* merupakan bagian integral dalam perawatan paliatif (WHO, 2020).

a. Pencarian makna dan tujuan hidup

Pada fase akhir kehidupan, pasien sering mengalami kebutuhan untuk memahami makna hidup dan tujuan keberadaan mereka. Proses ini melibatkan refleksi terhadap pengalaman hidup, hubungan dengan orang lain, serta pencapaian yang telah diraih. Ketidakmampuan menemukan makna hidup dapat menyebabkan *distress spiritual* yang berdampak pada kondisi psikologis pasien. Oleh karena itu, dukungan dari tenaga kesehatan dan keluarga sangat penting dalam membantu pasien menemukan makna dan tujuan hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, pasien dapat menghadapi kematian dengan lebih tenang (Prieto-Crespo et al., 2024).

b. Dukungan keyakinan dan praktik keagamaan

Dukungan terhadap keyakinan dan praktik keagamaan merupakan bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien. Aktivitas seperti berdoa, membaca kitab suci, atau mengikuti ritual keagamaan dapat memberikan ketenangan dan harapan bagi pasien. Tenaga kesehatan perlu menghormati dan memfasilitasi kebutuhan spiritual sesuai dengan keyakinan pasien. Selain itu, keterlibatan tokoh agama atau pembimbing spiritual dapat membantu pasien dalam menghadapi kondisi terminal. Dengan dukungan *spiritual* yang sesuai, pasien dapat merasakan kedamaian batin (WHO, 2020).

c. Ketenangan batin dan penerimaan spiritual

Ketenangan batin merupakan salah satu tujuan utama dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien pada fase akhir kehidupan. Kondisi ini ditandai dengan penerimaan terhadap penyakit, kehidupan, dan kematian sebagai bagian dari proses alami. Dukungan spiritual yang tepat dapat membantu pasien mengurangi ketakutan dan meningkatkan rasa damai. Selain itu, pendekatan spiritual juga dapat memperkuat mekanisme koping pasien dalam menghadapi kondisi terminal. Dengan adanya ketenangan batin, pasien dapat menjalani fase akhir kehidupan dengan lebih bermakna (Austin et al., 2025).

E. Konsep Kenyamanan (Comfort Care)

Comfort care merupakan pendekatan utama dalam perawatan akhir hayat yang berfokus pada pengurangan penderitaan dan peningkatan kualitas hidup pasien. Pendekatan ini menekankan pemberian perawatan yang berorientasi pada

kenyamanan dengan mengurangi gejala yang mengganggu serta mendukung kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual pasien. Dalam praktiknya, *comfort care* tidak lagi berfokus pada upaya kuratif, tetapi lebih pada peningkatan kesejahteraan pasien secara menyeluruh. Intervensi yang diberikan disesuaikan dengan kondisi dan preferensi pasien untuk menjaga martabat dan kenyamanan hingga akhir kehidupan (K. L. Quinn et al., 2020; Stadnyk et al., 2024). Oleh karena itu, *comfort care* menjadi prinsip penting dalam perawatan paliatif.

1. Komponen *Comfort Care*

Comfort care terdiri dari beberapa komponen utama yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasien secara holistik. Setiap komponen saling berkaitan dalam mendukung kenyamanan pasien pada fase akhir kehidupan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan spiritual. Dengan pemenuhan komponen secara menyeluruh, pasien dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik meskipun dalam kondisi terminal.

Adapun komponen utama *comfort care* meliputi:

a. *Relief of pain* (pengurangan nyeri)

Pengelolaan nyeri merupakan prioritas utama dalam *comfort care* karena nyeri adalah gejala yang paling sering dialami oleh pasien pada fase akhir kehidupan dan sangat memengaruhi kualitas hidup. Nyeri bersifat multidimensional sehingga membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Penanganan dilakukan melalui terapi farmakologis dan nonfarmakologis. Manajemen nyeri yang optimal terbukti penting dalam meningkatkan kenyamanan pasien pada fase terminal (Hedman et al., 2024; Macharia et al., 2023).

b. *Relief of distressing symptoms*

Selain nyeri, pasien juga mengalami gejala lain seperti sesak napas, mual, kelelahan, dan kecemasan. Gejala ini perlu ditangani secara komprehensif untuk mencegah penurunan kualitas hidup. Pendekatan paliatif menekankan pemenuhan kebutuhan fisik pasien sebagai bagian dari perawatan holistik (Hossain et al., 2025; Macharia et al., 2023).

c. *Emotional support*

Dukungan emosional membantu pasien menghadapi kecemasan, ketakutan, dan perubahan psikologis selama fase akhir kehidupan. Peran tenaga kesehatan dan keluarga sangat penting dalam memberikan empati serta rasa aman kepada pasien. Perawatan paliatif mencakup aspek psikologis sebagai bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan pasien (Hossain et al., 2025).

d. *Spiritual care*

Pemenuhan kebutuhan spiritual membantu pasien menemukan makna hidup, menerima kondisi penyakit, serta mencapai ketenangan batin. Aspek spiritual merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien paliatif dan harus dipenuhi secara holistik (Hossain et al., 2025; Urbano Chamorro & Miangolarra Page, 2025).

2. Pendekatan dalam Comfort Care

Pendekatan dalam *comfort care* menekankan pada pemberian perawatan yang berfokus pada kenyamanan pasien secara menyeluruh, terutama pada fase akhir kehidupan. Pendekatan ini bersifat holistik karena tidak hanya memperhatikan kondisi fisik, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien serta meminimalkan penderitaan yang dialami (Cerqueira et al., 2025; Wantonoro et al., 2022).

a. Pendekatan holistik

Pendekatan holistik merupakan dasar utama dalam *comfort care*, di mana pasien dipandang sebagai individu yang utuh dengan kebutuhan yang saling berkaitan antara aspek fisik, emosional, sosial, dan *spiritual*. Perawatan tidak hanya difokuskan pada penyakit, tetapi juga pada pengalaman pasien secara keseluruhan (Bryk et al., 2023; Wantonoro et al., 2022). Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan intervensi yang lebih komprehensif, seperti pengelolaan nyeri, dukungan psikologis, serta pemenuhan kebutuhan spiritual. Pendekatan holistik dalam perawatan paliatif terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup pasien serta mengurangi penderitaan pada fase terminal (De Luca et al., 2025; Haroen et al., 2023).

b. Pendekatan interdisipliner

Comfort care melibatkan kerja sama tim interdisipliner yang terdiri dari berbagai tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, pekerja sosial, dan rohaniwan. Setiap anggota tim memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pasien sesuai dengan bidang keahliannya (MacMartin et al., 2024). Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek kebutuhan pasien terpenuhi secara terintegrasi. Pendekatan interdisipliner dalam perawatan paliatif terbukti meningkatkan koordinasi pelayanan, kualitas perawatan, serta kepuasan pasien dan keluarga (Pornrattanakavee et al., 2022).

c. Pendekatan berpusat pada pasien (*patient-centered care*)

Pendekatan ini menempatkan pasien sebagai pusat dari setiap pengambilan keputusan dalam perawatan. Nilai, preferensi, keyakinan, dan kebutuhan pasien harus dihormati dan dijadikan dasar dalam menentukan rencana

perawatan (Ito et al., 2022). Tenaga kesehatan perlu melibatkan pasien dan keluarga dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam menentukan pilihan terapi, perawatan lanjutan, serta keputusan terkait akhir kehidupan (*end-of-life decision*). Pendekatan ini terbukti meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan pasien dalam perawatan paliatif (MacMartin et al., 2024).

d. Komunikasi terapeutik

Komunikasi yang efektif dan empati merupakan komponen penting dalam *comfort care*. Komunikasi terapeutik membantu membangun hubungan yang saling percaya antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga (Hossain et al., 2025; WHO, 2020). Melalui komunikasi yang baik, tenaga kesehatan dapat memahami kebutuhan, kekhawatiran, serta harapan pasien. Selain itu, komunikasi juga penting dalam menyampaikan informasi terkait kondisi penyakit, prognosis, serta rencana perawatan secara jujur namun tetap penuh empati (Hossain et al., 2025).

Komunikasi yang terbuka dan suportif dapat mengurangi kecemasan pasien serta membantu pasien dan keluarga dalam menghadapi fase akhir kehidupan dengan lebih tenang (Hossain et al., 2025; WHO, 2020).

e. Pendekatan berbasis keluarga (*family-centered care*)

Dalam *comfort care*, keluarga memiliki peran penting sebagai sistem pendukung utama bagi pasien. Oleh karena itu, pendekatan berbasis keluarga perlu diterapkan dengan melibatkan keluarga dalam proses perawatan (Hossain et al., 2025; WHO, 2020). Kesehatan perlu memberikan edukasi, dukungan emosional, serta bimbingan kepada keluarga agar mampu merawat pasien dengan baik. Selain itu, keluarga juga perlu dipersiapkan secara psikologis dalam menghadapi kemungkinan kehilangan (Hossain et al., 2025). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas perawatan pasien, tetapi juga membantu keluarga dalam proses berduka (*grieving process*) setelah pasien meninggal (Hossain et al., 2025; WHO, 2020).

Pendekatan dalam *comfort care* menekankan perawatan yang holistik, kolaboratif, dan berpusat pada pasien serta keluarga. Dengan penerapan pendekatan yang tepat, *comfort care* dapat membantu pasien mencapai kenyamanan optimal dan menjalani fase akhir kehidupan dengan lebih bermakna.

F. Keselamatan Pasien pada Fase Terminal

Keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama meskipun pasien berada dalam kondisi terminal. Pada fase ini, fokus perawatan beralih dari kuratif menjadi upaya menjaga kenyamanan, mencegah komplikasi, dan meminimalkan risiko

cedera. Keselamatan pasien dalam perawatan paliatif berkaitan dengan pengelolaan risiko klinis, termasuk kejadian tidak diinginkan akibat intervensi yang tidak tepat. Perawat berperan penting dalam memastikan bahwa tindakan yang diberikan aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Pendekatan keselamatan ini terbukti penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien pada akhir hayat (Paladino et al., 2023).

Pendekatan keselamatan pasien pada fase terminal dikenal sebagai *appropriate care*, yaitu pemberian intervensi yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan prognosis pasien. Pada pasien paliatif, intervensi yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko komplikasi dan menurunkan kualitas hidup. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan risiko setiap tindakan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya perawatan yang berpusat pada pasien dan penghormatan terhadap martabat pasien. Dengan demikian, keselamatan pasien dapat terjaga melalui intervensi yang tepat dan proporsional (Dewidar et al., 2026).

Aspek Keselamatan Pasien

1. Pencegahan Luka Tekan

Pencegahan luka tekan merupakan salah satu indikator keselamatan pasien pada perawatan paliatif. Pasien terminal memiliki risiko tinggi mengalami luka tekan akibat imobilitas, malnutrisi, dan kondisi penyakit yang progresif. Luka tekan dapat menyebabkan nyeri hebat, infeksi, serta memperburuk kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, intervensi seperti reposisi, perawatan kulit, dan penggunaan alat bantu sangat diperlukan. Penelitian menunjukkan bahwa pencegahan luka tekan merupakan bagian penting dalam keselamatan pasien paliatif (Ven et al., 2025).

2. Pencegahan Jatuh

Risiko jatuh meningkat pada pasien terminal akibat kelemahan fisik, gangguan keseimbangan, serta penggunaan obat tertentu. Jatuh dapat menyebabkan cedera serius yang memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, perawat perlu melakukan asesmen risiko jatuh serta memastikan lingkungan yang aman. Intervensi seperti penggunaan alat bantu dan edukasi keluarga juga sangat penting. Pencegahan jatuh merupakan bagian dari strategi keselamatan pasien dalam perawatan paliatif (Dewidar et al., 2026).

3. Penggunaan Alat Medis Secara Tepat

Penggunaan alat medis harus dilakukan secara tepat dan sesuai indikasi untuk menghindari komplikasi. Pada pasien terminal, penggunaan alat yang tidak perlu dapat meningkatkan risiko infeksi dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, perawat perlu mengevaluasi kebutuhan penggunaan alat secara berkala. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan

benar-benar memberikan manfaat. Penggunaan alat yang tepat merupakan bagian dari prinsip keselamatan pasien dalam perawatan paliatif (Dewidar et al., 2026).

4. Pengurangan Intervensi yang Tidak Perlu

Pada fase terminal, intervensi medis yang berlebihan dapat meningkatkan risiko komplikasi serta menurunkan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, penting untuk menghindari tindakan yang tidak memberikan manfaat klinis yang signifikan. Pendekatan ini dikenal sebagai *appropriate care*, yang menekankan pada perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Perawat perlu berkolaborasi dengan tim kesehatan dalam menentukan tindakan yang tepat. Dengan mengurangi intervensi yang tidak perlu, keselamatan dan kenyamanan pasien dapat lebih terjaga (Dewidar et al., 2026).

G. Peran Keluarga dalam Perawatan Akhir Hayat

Keluarga merupakan bagian integral dalam perawatan pasien terminal karena memiliki peran penting dalam memberikan dukungan secara menyeluruh selama fase akhir kehidupan. Dalam perawatan paliatif, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pendamping, tetapi juga sebagai mitra tenaga kesehatan dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan *spiritual* pasien (Rosa et al., 2022; Xiao et al., 2021).

Peran Keluarga dalam Perawatan Akhir Hayat

1. Pendamping utama pasien

Keluarga berperan sebagai pendamping utama yang selalu berada di sisi pasien selama proses perawatan. Kehadiran keluarga memberikan rasa aman, kenyamanan, serta mengurangi perasaan kesepian yang sering dialami oleh pasien pada fase terminal. Dukungan ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien, terutama dalam menghadapi kondisi penyakit yang semakin memburuk (Kim & Kim, 2024; Paterson & Maritz, 2024).

2. Pengambil keputusan

Dalam kondisi tertentu, pasien mungkin tidak mampu mengambil keputusan terkait perawatan yang akan dijalani. Dalam situasi ini, keluarga berperan sebagai pengambil keputusan yang mewakili kepentingan dan keinginan pasien. Peran ini mencakup penentuan pilihan terapi, perawatan lanjutan, hingga keputusan terkait tindakan pada fase akhir kehidupan (*end-of-life decision*). Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan keluarga sangat diperlukan agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan nilai dan preferensi pasien (Pun et al., 2023).

3. Pemberi dukungan emosional

Keluarga juga berperan sebagai sumber dukungan emosional utama bagi pasien. Dukungan ini dapat berupa perhatian, empati, kasih sayang, serta kehadiran secara fisik maupun psikologis. Dukungan emosional yang diberikan keluarga dapat membantu mengurangi kecemasan, ketakutan, dan stres yang dialami pasien, sehingga pasien dapat menjalani fase akhir kehidupan dengan lebih tenang dan bermakna (McCauley et al., 2024).

4. Pemberi perawatan langsung (*caregiver*)

Keluarga sering berperan sebagai *caregiver* utama yang memberikan perawatan langsung kepada pasien, seperti membantu aktivitas sehari-hari (makan, mandi, mobilisasi), pemberian obat, serta pemantauan kondisi pasien. Peran ini sangat penting terutama pada pasien yang dirawat di rumah (*home care*), di mana keluarga menjadi ujung tombak dalam keberlangsungan perawatan. Peran *caregiver* juga menuntut kesiapan fisik, emosional, dan pengetahuan yang memadai (Alshakhs et al., 2024; Suresh et al., 2025).

5. Fasilitator komunikasi

Keluarga berperan sebagai penghubung antara pasien dan tenaga kesehatan, terutama ketika pasien mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi. Keluarga membantu menyampaikan:

- a. Keluhan pasien
- b. Preferensi perawatan
- c. Nilai dan keyakinan pasien

Peran ini penting untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan tetap sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasien. Keterlibatan keluarga dalam komunikasi terbukti meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan memastikan perawatan yang berpusat pada pasien (*patient-centered care*) (Agustini et al., 2026; Engel et al., 2023). Selain itu, keluarga membantu menjembatani komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan dalam situasi kompleks pada fase akhir kehidupan.

6. Pendukung kebutuhan spiritual dan sosial

Selain dukungan emosional, keluarga juga berperan dalam memenuhi kebutuhan spiritual pasien, seperti mendampingi ibadah, memberikan dukungan religius, serta membantu pasien menemukan makna dalam kondisi yang dihadapi. Keluarga juga menjaga hubungan sosial pasien dengan lingkungan sekitar, sehingga pasien tidak merasa terisolasi pada fase akhir kehidupan. Dukungan *spiritual* dan sosial terbukti meningkatkan kualitas hidup serta menurunkan *distress* pada pasien paliatif (Best et al., 2023; Kang et al., 2023).

H. Proses dan Dampak Berduka pada Keluarga

Proses berduka (*grief*) merupakan respons emosional, psikologis, dan sosial yang dialami individu ketika menghadapi kehilangan, terutama pada kondisi kematian orang yang dicintai. Dalam konteks perawatan akhir hayat, keluarga tidak hanya mengalami kehilangan setelah kematian, tetapi juga telah melalui proses berduka sejak sebelum kematian terjadi. Oleh karena itu, pemahaman tentang tahapan dan dampak berduka menjadi penting dalam memberikan perawatan yang komprehensif.

1. Tahapan Berduka (*Grief Process*)

Proses berduka (*grief*) merupakan respons emosional, psikologis, dan sosial yang muncul akibat kehilangan, terutama kehilangan orang yang dicintai. Dalam konteks perawatan akhir hayat, keluarga tidak hanya mengalami duka setelah kematian, tetapi juga sejak menghadapi kondisi terminal pasien. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tahapan berduka menjadi penting untuk menggambarkan dinamika emosional yang dialami keluarga (Tyrrell et al., 2026). Salah satu teori klasik yang paling dikenal dalam menjelaskan proses berduka adalah model yang dikemukakan oleh Kübler-Ross, yang membagi proses berduka menjadi lima tahap, yaitu penolakan (*denial*), kemarahan (*anger*), tawar-menawar (*bargaining*), depresi (*depression*), dan penerimaan (*acceptance*). Setiap tahap menggambarkan respons emosional individu dalam menghadapi kehilangan, khususnya pada kondisi penyakit terminal (Rosa et al., 2022; Tyrrell et al., 2026).

a. Penolakan (*Denial*)

Penolakan merupakan mekanisme pertahanan diri yang umum digunakan individu untuk melindungi diri dari tekanan emosional akibat realitas yang menyakitkan. Pada tahap ini, individu dapat menolak diagnosis atau kondisi yang dihadapi, meragukan hasil pemeriksaan, atau menghindari pembicaraan terkait penyakit. Meskipun penolakan yang berkepanjangan dapat berdampak negatif, fase ini sebenarnya merupakan respons normal yang membantu individu memproses informasi secara bertahap. Dalam praktik klinis, penting bagi tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi secara jelas, namun tetap menghormati cara individu dalam menerima kenyataan tanpa memaksakan penerimaan secara langsung (Rosa et al., 2022; Tyrrell et al., 2026).

b. Kemarahan (*Anger*)

Kemarahan muncul ketika individu mulai menyadari kenyataan yang dihadapi. Emosi ini dapat diarahkan kepada berbagai pihak, seperti tenaga kesehatan, anggota keluarga, diri sendiri, bahkan kepada Tuhan atau keadaan yang

dianggap tidak adil. Kemarahan juga dapat muncul dalam bentuk iritabilitas, kehilangan kesabaran, atau reaksi emosional yang meningkat. Penting bagi tenaga kesehatan dan keluarga untuk memahami bahwa kemarahan merupakan respons yang normal, sehingga perlu dihadapi dengan empati tanpa mengabaikan kemungkinan adanya kritik yang valid (Stroebe et al., 2017).

c. Tawar-menawar (*Bargaining*)

Tahap tawar-menawar ditandai dengan upaya individu untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi yang dihadapi. Individu dapat melakukan "negosiasi", baik secara internal maupun dengan pihak lain, termasuk dalam konteks medis, sosial, atau *spiritual*. Misalnya, individu mungkin berjanji untuk mengikuti pengobatan atau memperbaiki perilaku tertentu dengan harapan kondisi dapat membaik. Dalam beberapa kasus, tawar-menawar juga dapat mencerminkan pola pikir yang tidak rasional, seperti mengaitkan penyakit dengan rasa bersalah. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan dukungan tanpa memperkuat harapan yang tidak realistis (Rosa et al., 2022; Tyrrell et al., 2026).

d. Depresi (*Depression*)

Depresi merupakan tahap di mana individu mulai merasakan dampak emosional yang mendalam akibat kehilangan. Gejala yang muncul dapat berupa kesedihan, kelelahan, kehilangan minat terhadap aktivitas (*anhedonia*), serta penarikan diri dari lingkungan sosial. Tahap ini sering kali merupakan puncak dari proses berduka karena individu mulai sepenuhnya menyadari realitas yang dihadapi. Oleh karena itu, dukungan emosional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk membantu individu melewati fase ini dengan lebih adaptif (Stroebe et al., 2017).

e. Penerimaan (*Acceptance*)

Penerimaan merupakan tahap di mana individu mulai menerima kenyataan tanpa lagi menolak atau melawan kondisi yang terjadi. Pada tahap ini, individu cenderung lebih tenang dan mulai berfokus pada hal-hal yang bermakna, seperti memperbaiki hubungan, mengenang pengalaman hidup, atau mempersiapkan diri menghadapi kematian. Namun, penting untuk dipahami bahwa penerimaan bukan berarti hilangnya kesedihan, melainkan kemampuan untuk hidup berdampingan dengan kenyataan tersebut. Selain itu, tahap ini bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai oleh semua individu, melainkan salah satu kemungkinan dalam proses berduka (Rosa et al., 2022; Tyrrell et al., 2026).
Catatan Penting:

Kelima tahap tersebut tidak selalu dialami secara berurutan, dan individu dapat berpindah-pindah antartahap atau mengalami beberapa tahap secara bersamaan. Oleh karena itu, model Kübler-Ross lebih tepat dipahami sebagai kerangka untuk memahami respons emosional individu, bukan sebagai proses yang bersifat linear dan universal (Rosa et al., 2022; Tyrrell et al., 2026).

Meskipun tahapan berduka memberikan gambaran mengenai respons emosional individu terhadap kehilangan, proses tersebut tidak berhenti pada aspek psikologis semata. Respons berduka yang dialami keluarga selanjutnya dapat berkembang menjadi berbagai bentuk manifestasi yang lebih luas, baik sebelum maupun setelah kematian pasien. Setiap tahap berduka dapat memunculkan dampak yang berbeda, tergantung pada kemampuan coping individu, dukungan sosial yang tersedia, serta konteks situasi yang dihadapi.

Dalam konteks perawatan akhir hayat, keluarga sering kali telah mengalami proses berduka bahkan sebelum kematian terjadi, yang dikenal sebagai *anticipatory grief*. Setelah kematian, proses tersebut berlanjut dalam bentuk *bereavement*, yang dapat berkembang secara adaptif maupun menjadi kondisi yang lebih kompleks, seperti *complicated grief*. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa tahapan berduka tidak hanya menggambarkan proses emosional, tetapi juga berkaitan erat dengan berbagai dampak psikologis yang dialami keluarga.

2. Dampak Berduka pada Keluarga

Dampak berduka pada keluarga merupakan konsekuensi dari proses kehilangan yang dialami, baik pada fase sebelum maupun setelah kematian pasien. Dampak ini mencakup berbagai aspek psikologis, emosional, dan sosial yang dapat memengaruhi kualitas hidup keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam perawatan pasien terminal dapat meningkatkan risiko stres emosional, kecemasan, dan kelelahan, terutama ketika dukungan yang diterima tidak memadai

a. *Anticipatory Grief* (Duka sebelum kematian)

Anticipatory grief merupakan respons emosional yang dialami keluarga sebelum kematian pasien terjadi, terutama pada kondisi penyakit terminal. Proses ini muncul ketika keluarga mulai menyadari kemungkinan kehilangan, sehingga duka sudah dirasakan sebelum kematian aktual. Penelitian menunjukkan bahwa *anticipatory grief* berkaitan dengan peningkatan beban psikologis seperti kecemasan, depresi, dan stres pada *caregiver* (Gavin et al., 2021; Kustanti et al., 2023). Bentuk respons yang muncul meliputi:

- 1) Perasaan sedih, cemas, takut, dan tidak berdaya
- 2) Kekhawatiran terhadap proses kematian dan penderitaan pasien

- 3) Perubahan peran dalam keluarga, terutama menjadi *caregiver* utama
- 4) Konflik emosional antara harapan kesembuhan dan penerimaan kondisi terminal

Selain itu, keluarga yang merawat pasien paliatif sering mengalami tekanan emosional dan kebutuhan dukungan yang meningkat seiring mendekatnya kematian pasien (Paulsen et al., 2025). Meskipun bersifat *distressing*, *anticipatory grief* juga dapat memberikan manfaat adaptif, seperti:

- 1) Membantu persiapan emosional menghadapi kehilangan
- 2) Memberikan kesempatan menyelesaikan hubungan dan komunikasi dengan pasien
- 3) Mengurangi intensitas duka setelah kematian dalam beberapa kasus

b. Bereavement (Duka setelah kematian)

Bereavement adalah proses berduka yang terjadi setelah kematian pasien dan merupakan respons normal terhadap kehilangan. Proses ini melibatkan berbagai aspek emosional, kognitif, sosial, dan *spiritual* yang berbeda pada setiap individu. Reaksi yang umum terjadi meliputi:

- 1) Kesedihan mendalam dan rasa kehilangan
- 2) Gangguan tidur dan nafsu makan
- 3) Perasaan bersalah atau penyesalan
- 4) Penurunan fungsi sosial

Namun, penelitian menunjukkan bahwa pengalaman *anticipatory grief* sebelumnya dapat memengaruhi proses *bereavement*, baik memperberat maupun membantu adaptasi setelah kematian (Jiang et al., 2025). Di sisi lain, proses *bereavement* juga dapat berkembang menjadi adaptasi positif, seperti:

- 1) Penerimaan terhadap kehilangan
- 2) Penemuan makna baru dalam kehidupan
- 3) Peningkatan ketahanan psikologis (*resilience*)

c. *Complicated Grief* (Duka Berkepanjangan)

Pada beberapa individu, proses berduka dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih kompleks, yaitu *complicated grief*. Kondisi ini ditandai dengan duka yang berkepanjangan, intens, dan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Individu dengan *complicated grief* dapat mengalami kesulitan menerima kehilangan, kerinduan yang terus-menerus, serta penarikan diri dari lingkungan sosial. Risiko terjadinya kondisi ini lebih tinggi pada keluarga dengan dukungan sosial yang rendah atau beban *caregiving* yang tinggi (Amano et al., 2022).

I. Komunikasi dalam Perawatan Akhir Hayat

Komunikasi merupakan komponen kunci dalam perawatan akhir hayat yang berperan penting dalam memastikan kualitas perawatan pasien serta kesejahteraan keluarga. Komunikasi yang efektif memungkinkan pertukaran informasi yang jelas, pengambilan keputusan yang tepat, serta pemberian dukungan emosional yang optimal bagi pasien dan keluarga. Dalam konteks perawatan paliatif, komunikasi juga mencakup aspek empati, sensitivitas, serta penghormatan terhadap nilai dan preferensi pasien (Engel et al., 2023). Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, meningkatkan kecemasan, serta memperburuk pengalaman pasien dan keluarga dalam menghadapi akhir kehidupan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk membangun hubungan terapeutik yang saling percaya serta mendukung pengambilan keputusan bersama (Paladino et al., 2023).

1. Tujuan Komunikasi dalam Perawatan Akhir Hayat

Komunikasi dalam perawatan akhir hayat memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- a. Menyampaikan informasi terkait kondisi pasien, diagnosis, dan prognosis secara jelas dan jujur. Komunikasi yang transparan membantu pasien dan keluarga memahami kondisi penyakit serta perjalanan penyakit secara realistis (Dias et al., 2024).
- b. Membantu pasien dan keluarga dalam pengambilan Keputusan. Komunikasi yang efektif mendukung *proses shared decision-making* sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan nilai dan preferensi pasien (Paladino et al., 2023).
- c. Memberikan dukungan emosional. Interaksi komunikasi yang empati dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan kenyamanan psikologis, serta membantu pasien dan keluarga menghadapi situasi akhir kehidupan (Serra et al., 2023).
- d. Mengidentifikasi nilai, kebutuhan, dan preferensi pasien. Komunikasi memungkinkan tenaga kesehatan memahami keinginan pasien terkait perawatan, termasuk tujuan perawatan dan pilihan intervensi (Engel, 2023).
- e. Meningkatkan kualitas hubungan antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga
Hubungan terapeutik yang baik dibangun melalui komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh empati (Dias et al., 2024).

Komunikasi yang efektif terbukti meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta kepuasan keluarga dalam perawatan paliatif

2. Prinsip Komunikasi dalam Perawatan Akhir Hayat

Prinsip komunikasi dalam perawatan akhir hayat meliputi:

- a. Kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi. Komunikasi yang jujur dan transparan membantu pasien serta keluarga memahami kondisi secara realistis dan membangun kepercayaan terhadap tenaga kesehatan (Dias et al., 2024).
- b. Empati terhadap kondisi emosional pasien dan keluarga. Empati menjadi komponen penting dalam komunikasi paliatif karena dapat mengurangi *distress* emosional serta meningkatkan kenyamanan pasien (Paladino et al., 2023).
- c. Kejelasan informasi agar mudah dipahami. Informasi harus disampaikan secara sederhana, terstruktur, dan sesuai dengan tingkat pemahaman pasien agar tidak menimbulkan kebingungan (Paladino et al., 2023).
- d. Sensitivitas budaya dan spiritual. Komunikasi perlu mempertimbangkan nilai budaya dan keyakinan spiritual pasien karena hal ini memengaruhi persepsi terhadap penyakit dan keputusan perawatan (Engel et al., 2023).
- e. Partisipasi aktif pasien dan keluarga. Keterlibatan pasien dan keluarga dalam komunikasi mendukung *proses shared decision-making* serta meningkatkan kepuasan terhadap perawatan (Paladino et al., 2023).

Pendekatan komunikasi yang berpusat pada pasien (*patient-centered communication*) menjadi dasar dalam praktik komunikasi paliatif modern karena menekankan penghormatan terhadap preferensi, kebutuhan, dan nilai individu pasien

3. Strategi Komunikasi dalam Perawatan Akhir Hayat

a. *Advance Care Planning* (ACP)

Advance care planning merupakan proses komunikasi berkelanjutan antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga untuk merencanakan perawatan di masa depan sesuai dengan nilai dan preferensi pasien. ACP terbukti meningkatkan kualitas perawatan akhir hayat, meningkatkan kesesuaian perawatan dengan keinginan pasien, serta mengurangi intervensi yang tidak diinginkan (Dias et al., 2024).

b. *Active Listening* (Mendengarkan Aktif)

Tenaga kesehatan perlu mendengarkan secara penuh tanpa menghakimi serta memberikan respons yang menunjukkan perhatian. Mendengarkan aktif membantu memahami kebutuhan pasien secara lebih mendalam serta meningkatkan kualitas hubungan terapeutik (Paladino et al., 2023).

c. Komunikasi Nonverbal

Bahasa tubuh, kontak mata, serta ekspresi wajah berperan penting dalam menunjukkan empati dan perhatian kepada pasien. Komunikasi nonverbal

yang positif dapat memperkuat pesan verbal serta meningkatkan kenyamanan pasien dalam situasi akhir hayat (Dias et al., 2024).

d. Validasi Emosi

Mengakui dan menghargai perasaan pasien dan keluarga dapat memperkuat hubungan terapeutik, meningkatkan rasa percaya, serta membantu pasien menghadapi kondisi terminal dengan lebih baik (Engel et al., 2023).

4. Hambatan dalam Komunikasi Perawatan Akhir Hayat

Hambatan dalam komunikasi perawatan akhir hayat merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga. Hambatan ini dapat mengurangi efektivitas komunikasi, memengaruhi pengambilan keputusan, serta menurunkan kualitas perawatan paliatif.

Beberapa hambatan yang sering terjadi meliputi:

- a. Kurangnya keterampilan komunikasi tenaga kesehatan. Tidak semua tenaga kesehatan memiliki pelatihan khusus dalam komunikasi paliatif, terutama dalam menyampaikan berita buruk atau membahas prognosis. Keterbatasan ini dapat menyebabkan komunikasi yang kurang jelas, kurang empati, atau bahkan menghindari percakapan penting (Paladino et al., 2023).
- b. Perbedaan budaya dan bahasa. Perbedaan latar belakang budaya dan bahasa antara tenaga kesehatan dengan pasien atau keluarga dapat menyebabkan miskomunikasi, terutama dalam memahami nilai, keyakinan, dan preferensi terkait perawatan akhir hayat.
- c. Ketidaksiapan emosional pasien dan keluarga. Pasien dan keluarga sering mengalami kecemasan, ketakutan, atau penolakan terhadap kondisi terminal, sehingga sulit menerima informasi yang diberikan. Kondisi emosional ini menjadi hambatan dalam komunikasi yang efektif (Paladino et al., 2023).
- d. Ketakutan dalam menyampaikan berita buruk. Tenaga kesehatan sering merasa tidak nyaman atau takut menyampaikan informasi terkait prognosis buruk karena khawatir menimbulkan *distress* emosional pada pasien dan keluarga. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak lengkap atau tertunda (Dias et al., 2024).
- e. Keterbatasan waktu pelayanan. Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu dalam pelayanan kesehatan sering menjadi hambatan dalam melakukan komunikasi yang mendalam dan berkualitas dengan pasien dan keluarga (Paladino et al., 2023).

Hambatan-hambatan tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas komunikasi, ketidakpuasan pasien dan keluarga, serta pengambilan keputusan yang kurang optimal dalam perawatan akhir hayat.

5. Dampak Komunikasi yang Efektif dalam Perawatan Akhir Hayat

Komunikasi yang efektif dalam perawatan akhir hayat memberikan berbagai manfaat penting bagi pasien maupun keluarga. Komunikasi yang baik tidak hanya meningkatkan pemahaman terhadap kondisi penyakit, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pengalaman pasien pada fase akhir kehidupan. Beberapa dampak komunikasi yang efektif antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas hidup pasien. Komunikasi yang baik membantu pasien memahami kondisi kesehatannya, mengurangi ketidakpastian, serta mendukung perawatan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasien (Dias et al., 2024).
- b. Mengurangi kecemasan dan stres keluarga. Keluarga yang mendapatkan informasi yang jelas dan dukungan emosional melalui komunikasi yang empati cenderung mengalami tingkat kecemasan dan stres yang lebih rendah (Paladino et al., 2023).
- c. Membantu pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai pasien. Komunikasi yang efektif memungkinkan penerapan *shared decision-making* sehingga keputusan perawatan lebih sesuai dengan nilai, preferensi, dan tujuan hidup pasien (Paladino et al., 2023).
- d. Meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan kesehatan. Pasien dan keluarga yang terlibat dalam komunikasi yang terbuka dan jelas menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap pelayanan kesehatan (Engel et al., 2023).
- e. Mengurangi konflik antara keluarga dan tenaga kesehatan. Komunikasi yang efektif dapat meminimalkan kesalahpahaman serta perbedaan persepsi antara keluarga dan tenaga kesehatan, sehingga mengurangi potensi konflik dalam pengambilan keputusan (Paladino et al., 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pengalaman akhir hayat bagi pasien dan keluarga, termasuk dalam aspek emosional, psikologis, dan pengambilan keputusan (Engel et al., 2023).

J. Kolaborasi Interprofesional dalam Perawatan Akhir Hayat

Perawatan akhir hayat merupakan pelayanan yang kompleks karena mencakup kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan *spiritual* pasien. Kompleksitas ini menuntut pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Oleh karena itu, kolaborasi interprofesional sangat diperlukan untuk memberikan perawatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama antartenantaga kesehatan dalam mencapai tujuan perawatan yang optimal. Dengan kolaborasi yang baik, pelayanan

dapat lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan pasien (Pornrattanakavee et al., 2022).

Perawatan akhir hayat melibatkan berbagai tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, psikolog, rohaniwan, dan pekerja sosial. Dokter berperan dalam menegakkan diagnosis, menentukan prognosis, serta menetapkan rencana terapi yang sesuai. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan perawatan langsung, memantau kondisi pasien, serta menjadi penghubung antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Psikolog membantu pasien dan keluarga dalam menghadapi tekanan emosional, kecemasan, serta proses berduka. Sementara itu, rohaniwan dan pekerja sosial berperan dalam memenuhi kebutuhan *spiritual*, sosial, dan dukungan praktis bagi pasien (Khonsari et al., 2024).

Kolaborasi interprofesional memungkinkan adanya koordinasi yang efektif antara tenaga kesehatan sehingga pelayanan menjadi lebih menyeluruh dan berkesinambungan. Setiap profesi memiliki peran yang saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pasien secara holistik. Komunikasi yang baik dalam tim membantu menyelaraskan tujuan perawatan dengan nilai, preferensi, dan kondisi pasien. Selain itu, koordinasi yang efektif dapat mencegah terjadinya miskomunikasi dan kesalahan dalam pemberian layanan. Hal ini sangat penting dalam situasi akhir hayat yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat (Moons et al., 2024).

Kerja sama tim interprofesional juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembagian tugas yang jelas dan terstruktur. Pendekatan ini membantu mengurangi duplikasi tindakan serta meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, kolaborasi yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan rasa aman bagi keluarga. Keterlibatan berbagai profesi juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek. Dengan demikian, perawatan yang diberikan menjadi lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pasien (Rubbai et al., 2024).

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, kolaborasi interprofesional juga berperan dalam memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga. Pendekatan yang terkoordinasi dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap tim kesehatan. Hal ini juga membantu menciptakan lingkungan perawatan yang lebih suportif dan manusiawi. Keluarga merasa lebih dilibatkan dalam proses perawatan sehingga meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan. Oleh karena itu, kolaborasi interprofesional menjadi kunci utama dalam mewujudkan perawatan akhir hayat yang berkualitas, holistik, dan berfokus pada pasien (Gafer et al., 2024).

K. Asuhan Keperawatan Akhir Hayat

Asuhan keperawatan akhir hayat merupakan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan kondisi terminal dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, mengurangi penderitaan, serta memberikan dukungan menyeluruh kepada pasien dan keluarga. Pelayanan ini berfokus pada pendekatan paliatif yang menekankan kenyamanan pasien (*comfort care*) dibandingkan dengan upaya kuratif. Asuhan yang diberikan bersifat holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan *spiritual* sesuai dengan kebutuhan individu pasien. Perawat memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan tersebut secara komprehensif. Dengan demikian, asuhan keperawatan dapat diberikan secara tepat dan berorientasi pada kualitas hidup pasien (Dias et al., 2024).

Dalam praktiknya, asuhan keperawatan akhir hayat tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga melibatkan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perawatan. Pendekatan ini dikenal sebagai *family-centered care*, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga. Keluarga berperan sebagai pendamping utama serta sumber dukungan emosional bagi pasien. Selain itu, keterlibatan keluarga juga membantu dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai dan preferensi pasien. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kualitas perawatan serta kepuasan keluarga (Engel et al., 2023).

Perawat dalam asuhan akhir hayat memiliki tanggung jawab untuk memberikan perawatan yang berfokus pada kenyamanan pasien, seperti manajemen nyeri dan pengendalian gejala. Selain itu, perawat juga berperan dalam memberikan dukungan emosional serta membantu pasien menghadapi proses menjelang akhir kehidupan. Komunikasi terapeutik menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh perawat dalam situasi ini. Perawat juga berfungsi sebagai penghubung antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya. Peran ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan kebutuhan pasien terpenuhi (Paladino et al., 2023).

Selain aspek klinis, asuhan keperawatan akhir hayat juga mencakup dukungan *spiritual* dan psikososial bagi pasien dan keluarga. Perawat perlu menghargai nilai, keyakinan, serta budaya yang dianut oleh pasien dalam memberikan perawatan. Dukungan *spiritual* dapat membantu pasien mencapai ketenangan dan penerimaan terhadap kondisi yang dialami. Di sisi lain, keluarga juga membutuhkan pendampingan dalam menghadapi proses kehilangan dan berduka (Paladino et al., 2023). Oleh karena itu, asuhan keperawatan akhir hayat harus dilakukan secara manusiawi, dengan empati, dan berfokus pada martabat pasien.

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian merupakan tahap awal dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien secara komprehensif sebagai dasar dalam pemberian asuhan keperawatan. Pada perawatan akhir hayat, pengkajian dilakukan secara holistik karena pasien sering mengalami masalah yang kompleks, meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial secara bersamaan. Pengkajian yang baik memungkinkan tenaga kesehatan mengenali kebutuhan pasien secara lebih tepat dan menyesuaikan intervensi yang diberikan. Selain itu, pengkajian kebutuhan pasien juga terbukti meningkatkan komunikasi serta kualitas perawatan paliatif (Radionova et al., 2020). Oleh karena itu, pengkajian menjadi komponen penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien terminal.

a. Keluhan Utama

Keluhan utama pada pasien *end-of-life* umumnya berkaitan dengan gejala yang menimbulkan ketidaknyamanan signifikan. Nyeri merupakan keluhan yang paling dominan, diikuti oleh *dyspnea*, kelelahan (*fatigue*), anoreksia, mual, serta penurunan kesadaran. Selain gejala fisik, pasien juga sering mengungkapkan keluhan emosional seperti ketakutan terhadap kematian, kecemasan, dan perasaan tidak berdaya.

Dalam praktik klinik, pengkajian keluhan utama tidak hanya berfokus pada "apa yang dirasakan pasien", tetapi juga pada bagaimana pengalaman subjektif tersebut memengaruhi kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, penggunaan skala seperti *Numeric Rating Scale* (NRS) untuk nyeri atau *Edmonton Symptom Assessment System* (ESAS) sangat dianjurkan untuk memperoleh gambaran yang objektif dan terukur (Hui; Bruera, 2017; Wiffen et al., 2017).

b. Riwayat Penyakit Sekarang

Riwayat penyakit sekarang pada pasien terminal mencakup perjalanan penyakit sejak diagnosis hingga kondisi terkini. Informasi yang dikaji meliputi jenis penyakit terminal (misalnya kanker stadium lanjut, gagal ginjal terminal, gagal jantung), progresivitas penyakit, terapi yang telah dijalani (kuratif maupun paliatif), serta respons terhadap terapi tersebut.

Perawat perlu mengidentifikasi fase penyakit (*stable, unstable, deteriorating, terminal*) karena hal ini akan menentukan kebutuhan intervensi. Pada fase terminal, sering ditemukan penurunan fungsi organ yang progresif, penurunan kesadaran, dan meningkatnya ketergantungan total terhadap *caregiver*.

Selain itu, penting untuk mengeksplorasi perubahan kondisi dalam beberapa hari atau minggu terakhir, seperti penurunan intake makanan, perubahan pola napas, dan penurunan mobilitas, karena hal ini merupakan indikator klinis

mendekati kematian (*National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2019*).

c. Riwayat Penyakit Dahulu

Riwayat penyakit dahulu memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan pasien sebelum memasuki fase terminal. Penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit paru kronis, atau gangguan neurologis sering memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan kompleksitas perawatan.

Selain itu, riwayat hospitalisasi berulang, penggunaan obat jangka panjang (misalnya opioid, steroid), serta riwayat alergi juga perlu dikaji secara mendalam. Informasi ini penting untuk:

- 1) Menentukan risiko komplikasi
- 2) Menyesuaikan terapi paliatif
- 3) Menghindari interaksi obat yang merugikan

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *person-centered care*, di mana keputusan klinis didasarkan pada kondisi individual pasien (Villanueva-Quispe et al., 2025).

d. Pengkajian Biologis (Fisik)

Pengkajian biologis difokuskan pada identifikasi kondisi fisik pasien serta gejala yang muncul pada fase terminal, seperti nyeri, sesak napas, kelelahan, mual, dan gangguan tidur. Gejala-gejala tersebut sering terjadi secara bersamaan dan dapat menurunkan kualitas hidup pasien secara signifikan. Oleh karena itu, perawat perlu melakukan pengkajian secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memantau perubahan kondisi pasien. Pengkajian ini juga mencakup pemeriksaan tanda vital, status nutrisi, serta fungsi organ tubuh. Dengan pengkajian yang komprehensif, perawat dapat mengenali masalah utama yang dialami pasien secara tepat (Hao et al., 2021).

Selain itu, penggunaan instrumen atau skala penilaian seperti skala nyeri, skala sesak napas, dan skala penilaian kelelahan sangat membantu dalam mengidentifikasi tingkat keparahan gejala. Pendekatan ini memungkinkan perawat untuk melakukan evaluasi yang lebih objektif dan terukur. Pengkajian yang terstandar juga memudahkan pemantauan efektivitas intervensi yang diberikan. Hal ini penting karena kondisi pasien terminal dapat berubah secara cepat dan memerlukan penyesuaian perawatan. Dengan demikian, penggunaan alat ukur yang tepat dapat meningkatkan kualitas asuhan keperawatan (Radionova et al., 2020).

Pengkajian biologis yang akurat menjadi dasar dalam perencanaan intervensi keperawatan untuk meningkatkan kenyamanan pasien (*comfort care*). Intervensi yang diberikan dapat berupa manajemen nyeri, pengendalian gejala,

serta pemenuhan kebutuhan dasar pasien. Perawat juga perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai respons pasien terhadap intervensi yang diberikan. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan penderitaan serta meningkatkan kualitas hidup pasien pada fase akhir kehidupan. Oleh karena itu, pengkajian biologis memiliki peran penting dalam keberhasilan perawatan paliatif (Paladino et al., 2023).

e. Pengkajian Psikologis

Pengkajian psikologis bertujuan untuk menilai kondisi emosional pasien yang sering mengalami kecemasan, ketakutan, depresi, dan *distress*. Kondisi psikologis ini merupakan respons umum terhadap penyakit terminal dan dapat berdampak signifikan terhadap kualitas hidup pasien. Perawat perlu menggunakan komunikasi terapeutik untuk menggali perasaan, persepsi, serta harapan pasien terhadap kondisi yang dialami. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi tanda-tanda *distress* psikologis yang dapat memperburuk kondisi pasien. Dengan pengkajian yang tepat, perawat dapat memberikan dukungan emosional yang sesuai (Paladino et al., 2023).

Pengkajian psikologis juga mencakup identifikasi mekanisme koping yang digunakan pasien dalam menghadapi penyakitnya. Mekanisme koping yang adaptif dapat membantu pasien dalam menerima kondisi dan meningkatkan ketahanan psikologis. Sebaliknya, koping yang maladaptif dapat menyebabkan peningkatan kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, perawat perlu menilai kemampuan pasien dalam mengelola stres serta memberikan intervensi yang tepat. Pendekatan ini penting untuk mendukung kesejahteraan emosional pasien pada fase akhir kehidupan (Hao et al., 2021).

Selain itu, penggunaan instrumen atau alat ukur seperti skala kecemasan dan depresi dapat membantu dalam menilai kondisi psikologis pasien secara objektif. Pengkajian yang terstruktur memungkinkan perawat untuk memantau perubahan kondisi emosional pasien secara berkala. Hal ini penting karena kondisi psikologis pasien dapat berubah seiring perkembangan penyakit. Evaluasi yang berkelanjutan juga membantu dalam menilai efektivitas intervensi yang diberikan. Dengan demikian, pengkajian psikologis berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien terminal (Radionova et al., 2020).

f. Pengkajian Sosial

Pengkajian sosial meliputi hubungan pasien dengan keluarga, dukungan sosial, serta kondisi lingkungan yang memengaruhi proses perawatan. Dukungan keluarga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pasien terminal. Perawat perlu memahami

dinamika keluarga, termasuk peran masing-masing anggota dalam memberikan perawatan serta beban yang dialami *caregiver*. Hubungan sosial yang baik dapat membantu pasien merasa lebih didukung secara emosional selama fase akhir kehidupan. Dengan pengkajian sosial yang tepat, perawat dapat mengidentifikasi kebutuhan pasien dan keluarga secara komprehensif (Wang et al., 2024).

Pengkajian sosial juga mencakup identifikasi dukungan dari lingkungan sekitar seperti teman, komunitas, serta akses terhadap sumber daya sosial dan layanan kesehatan. Dukungan sosial tidak hanya berasal dari keluarga, tetapi juga dari jaringan sosial yang lebih luas seperti komunitas dan tenaga sosial profesional. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial yang kuat, baik emosional maupun instrumental, berperan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien paliatif serta mengurangi beban *caregiver*. Selain itu, kebutuhan dukungan sosial *caregiver* juga perlu diperhatikan karena mereka sering mengalami beban fisik dan emosional selama merawat pasien (Suresh et al., 2025). Dengan demikian, pengkajian sosial berperan penting dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan paliatif secara menyeluruh.

g. Pengkajian *Spiritual*

Pengkajian *spiritual* bertujuan untuk mengidentifikasi keyakinan, nilai hidup, serta kebutuhan *spiritual* pasien dalam menghadapi kondisi terminal. Aspek *spiritual* sering menjadi sumber kekuatan yang membantu pasien menemukan makna dan ketenangan dalam menghadapi penyakit dan kematian. Perawat perlu memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengekspresikan keyakinan serta kebutuhan *spiritual*nya melalui komunikasi yang empati. Pendekatan yang menghargai nilai dan kepercayaan pasien dapat meningkatkan rasa damai dan penerimaan terhadap kondisi yang dialami. Oleh karena itu, pengkajian *spiritual* menjadi bagian penting dalam asuhan keperawatan paliatif (Tan-Ho et al., 2020).

Pengkajian *spiritual* juga mencakup identifikasi *spiritual distress*, seperti kehilangan makna hidup, keputusasaan, atau konflik keyakinan yang sering muncul pada pasien terminal. Kondisi ini dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Perawat perlu menggunakan pendekatan yang sensitif serta dapat bekerja sama dengan rohaniwan untuk memenuhi kebutuhan *spiritual* pasien. Penelitian menunjukkan bahwa *spiritual care* merupakan komponen penting dalam perawatan paliatif karena berhubungan dengan makna hidup dan kesejahteraan pasien (B. Quinn & Connolly, 2023). Selain itu, *spiritual distress*

juga berkaitan erat dengan depresi dan keputusan pada pasien terminal sehingga perlu dikaji secara sistematis (Martins et al., 2024).

h. Pengkajian Fungsional

Pengkajian fungsional dilakukan untuk menilai kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau *Activity of Daily Living* (ADL). Penurunan fungsi fisik merupakan kondisi yang umum terjadi pada pasien terminal dan berkaitan erat dengan kualitas hidup serta tingkat kemandirian pasien. Perawat perlu menilai kemampuan pasien dalam aktivitas seperti makan, mobilisasi, berpindah, dan perawatan diri. Penurunan kemampuan ADL juga dapat menjadi indikator perkembangan penyakit dan prognosis pasien. Dengan pengkajian yang tepat, perawat dapat menentukan tingkat ketergantungan serta kebutuhan bantuan yang diperlukan (Soeda et al., 2024).

Pengkajian fungsional juga penting untuk merencanakan intervensi yang bertujuan mempertahankan kemandirian pasien selama mungkin. Penggunaan instrumen seperti *Functional Independence Measure* (FIM) atau *RUG-ADL* dapat membantu menilai tingkat fungsi pasien secara objektif dan terstandar. Penelitian menunjukkan bahwa penilaian ADL dan status fungsional merupakan indikator penting dalam menentukan kebutuhan perawatan dan kualitas hidup pasien paliatif (Dai et al., 2024; Soeda et al., 2024). Selain itu, perubahan status fungsional perlu dipantau secara berkala karena kondisi pasien terminal dapat mengalami penurunan secara cepat. Dengan demikian, pengkajian fungsional berperan penting dalam menjaga keselamatan, kenyamanan, serta martabat pasien pada fase akhir kehidupan (Dai et al., 2024).

i. Pengkajian Kultural (Budaya)

Pengkajian kultural meliputi nilai, kepercayaan, dan praktik budaya yang dianut oleh pasien dan keluarga. Faktor budaya berperan penting dalam memengaruhi cara pasien memandang penyakit, proses perawatan, serta makna kematian. Perawat perlu memahami serta menghormati latar belakang budaya pasien agar asuhan yang diberikan sesuai dengan nilai yang dianut. Sensitivitas budaya juga membantu membangun hubungan terapeutik yang lebih baik antara perawat dan pasien. Dengan demikian, perawatan menjadi lebih diterima, bermakna, dan berpusat pada pasien (Burke et al., 2023).

Pengkajian kultural juga mencakup identifikasi peran keluarga, pola pengambilan keputusan, serta praktik budaya yang berkaitan dengan perawatan dan proses akhir kehidupan. Perbedaan budaya dapat memengaruhi komunikasi, preferensi perawatan, serta keterlibatan keluarga dalam pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa budaya

memengaruhi persepsi terhadap hidup dan mati, serta kebutuhan *spiritual* dan sosial pasien dalam perawatan paliatif (Monette, 2021). Oleh karena itu, perawat perlu menyesuaikan pendekatan komunikasi dan intervensi sesuai dengan nilai budaya pasien. Dengan pengkajian kultural yang tepat, asuhan keperawatan dapat diberikan secara lebih holistik, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

j. Pengkajian Lingkungan

Pengkajian lingkungan mencakup kondisi tempat tinggal pasien, ketersediaan fasilitas perawatan, serta dukungan lingkungan sekitar yang memengaruhi proses perawatan. Lingkungan fisik yang tidak memadai, seperti keterbatasan ruang, ventilasi, atau fasilitas dasar, dapat menjadi hambatan dalam pemberian asuhan keperawatan yang optimal. Perawat perlu menilai keamanan, kenyamanan, serta kesiapan lingkungan dalam mendukung perawatan pasien, terutama pada perawatan berbasis rumah. Selain itu, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan perawatan. Dengan pengkajian lingkungan yang tepat, perawatan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata pasien sehingga lebih efektif dan aman (Tan et al., 2025).

Pengkajian lingkungan juga mencakup akses terhadap layanan kesehatan, seperti jarak ke fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, serta kemudahan memperoleh obat dan alat kesehatan. Akses layanan kesehatan merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas dan kontinuitas perawatan paliatif. Penelitian menunjukkan bahwa faktor geografis, ekonomi, dan ketersediaan fasilitas sangat memengaruhi akses terhadap layanan paliatif, terutama pada pasien di daerah terpencil (Shi et al., 2025). Oleh karena itu, perawat perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan dan sistem pelayanan kesehatan dalam merencanakan asuhan keperawatan. Dengan demikian, pengkajian lingkungan berperan penting dalam memastikan keberlanjutan, keamanan, dan kualitas perawatan akhir hayat.

k. Pengkajian Edukasi dan Pengetahuan

Pengkajian edukasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pasien dan keluarga mengenai kondisi penyakit, prognosis, serta perawatan yang akan dilakukan. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan kecemasan, ketidakpastian, serta kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait perawatan. Perawat perlu mengidentifikasi kebutuhan informasi serta kesiapan pasien dan keluarga dalam menerima edukasi. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa materi edukasi sesuai dengan tingkat literasi dan kondisi

pasien. Dengan pengkajian ini, edukasi dapat diberikan secara tepat dan efektif sesuai kebutuhan pasien (Hagelin et al., 2025).

Pengkajian edukasi juga mencakup kemampuan pasien dan keluarga dalam memahami informasi serta keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Edukasi dalam perawatan paliatif tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga pada keluarga dan *caregiver* sebagai bagian dari sistem perawatan. Penelitian menunjukkan bahwa program edukasi paliatif membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat, kemampuan caregiving, serta kesiapan menghadapi akhir kehidupan (Seckin et al., 2025). Oleh karena itu, perawat perlu menyampaikan informasi secara jelas, sederhana, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengkajian edukasi mendukung tercapainya perawatan yang berpusat pada pasien dan keluarga

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan pernyataan klinis mengenai respons pasien terhadap kondisi kesehatan atau proses penyakit yang dialami. Pada pasien dengan kondisi terminal, diagnosis keperawatan difokuskan pada respons holistik yang meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan *spiritual*. Penetapan diagnosis harus didasarkan pada hasil pengkajian yang komprehensif sehingga masalah pasien dapat diidentifikasi secara akurat. Diagnosis keperawatan juga membantu perawat dalam menentukan prioritas masalah serta kebutuhan perawatan pasien. Dengan demikian, diagnosis yang tepat menjadi dasar dalam penyusunan rencana intervensi yang efektif (Alanazi et al., 2024).

Diagnosis keperawatan yang umum pada pasien akhir hayat antara lain nyeri kronis, gangguan pola tidur, ansietas, ketidakberdayaan, *spiritual distress*, dan risiko isolasi sosial. Masalah fisik seperti nyeri sering menjadi keluhan utama yang memengaruhi kenyamanan pasien, sedangkan masalah psikologis seperti ansietas dan ketidakberdayaan berkaitan dengan kondisi emosional dalam menghadapi penyakit terminal. Selain itu, *spiritual distress* dapat muncul akibat pencarian makna hidup dan kesiapan menghadapi kematian, sedangkan isolasi sosial dapat terjadi akibat keterbatasan interaksi. Penelitian menunjukkan bahwa perawatan paliatif menekankan identifikasi respons pasien secara holistik untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pasien serta keluarga (Wantonoro et al., 2022). Oleh karena itu, penetapan diagnosis keperawatan yang tepat sangat penting dalam mendukung keberhasilan asuhan keperawatan akhir hayat.

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan pada pasien akhir hayat berfokus pada peningkatan kenyamanan (*comfort care*) dan kualitas hidup pasien secara menyeluruh.

Pendekatan yang digunakan bersifat holistik dengan memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan *spiritual*. Intervensi diberikan berdasarkan hasil pengkajian dan diagnosis keperawatan yang telah ditetapkan. Perawat memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pelayanan serta memastikan kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal. Dengan intervensi yang tepat, penderitaan pasien dapat diminimalkan dan kualitas hidup dapat ditingkatkan (Dias et al., 2024).

a. Manajemen Nyeri dan Gejala

Manajemen nyeri dan gejala merupakan intervensi utama dalam perawatan akhir hayat karena pasien sering mengalami nyeri, sesak napas, dan kelelahan. Intervensi meliputi terapi farmakologis dan nonfarmakologis yang diberikan secara terintegrasi. Perawat perlu melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas terapi. Pendekatan multidisiplin sangat penting dalam mengoptimalkan pengendalian gejala. Dengan manajemen yang tepat, kenyamanan pasien dapat meningkat secara signifikan (Chapman et al., 2022).

b. Dukungan Psikologis

Dukungan psikologis bertujuan membantu pasien menghadapi kecemasan, ketakutan, dan *distress* emosional. Perawat menggunakan komunikasi terapeutik dan empati dalam memberikan asuhan. Pendekatan ini membantu pasien mengekspresikan perasaan serta meningkatkan penerimaan terhadap kondisi. *Distress* psikologis terbukti dapat memperburuk gejala fisik sehingga perlu ditangani secara bersamaan. Oleh karena itu, dukungan psikologis menjadi bagian penting dalam intervensi paliatif (Chapman et al., 2022).

c. Dukungan Sosial

Dukungan sosial melibatkan keluarga dan lingkungan sebagai bagian dari sistem perawatan pasien. Perawat perlu mendorong keterlibatan keluarga dalam proses perawatan untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Keluarga juga berperan dalam membantu implementasi intervensi yang diberikan. Dukungan sosial yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan pasien serta keberhasilan terapi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan sangat diperlukan (Wang et al., 2024).

d. Dukungan *Spiritual*

Dukungan *spiritual* diberikan untuk membantu pasien menemukan makna hidup dan mencapai ketenangan. Perawat perlu menghormati keyakinan pasien serta memfasilitasi kebutuhan spiritualnya. Intervensi dapat berupa pendampingan ibadah atau kolaborasi dengan rohaniwan. Aspek *spiritual* berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien terminal. Oleh karena itu, dukungan *spiritual* menjadi bagian integral dalam perawatan paliatif (Prieto-Crespo et al., 2024).

e. Perawatan Kenyamanan (*Comfort Care*)

Perawatan kenyamanan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar pasien seperti kebersihan, posisi tubuh, dan lingkungan yang nyaman. Perawat perlu memastikan pasien berada dalam kondisi yang aman dan bebas dari gangguan. Intervensi sederhana seperti lingkungan yang tenang dan perhatian dari tenaga kesehatan dapat memberikan dampak besar terhadap kenyamanan pasien. Pendekatan ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Dengan demikian, *comfort care* menjadi inti dari perawatan akhir hayat (Paladino et al., 2023).

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari rencana intervensi keperawatan yang telah disusun berdasarkan hasil pengkajian dan diagnosis keperawatan. Pada tahap ini, perawat memberikan tindakan langsung kepada pasien sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Implementasi dalam perawatan akhir hayat berfokus pada peningkatan kenyamanan, pengendalian gejala, serta dukungan holistik bagi pasien dan keluarga. Perawat juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa intervensi dilakukan secara aman, efektif, dan sesuai dengan kondisi pasien yang dinamis. Dengan implementasi yang tepat, tujuan asuhan keperawatan dapat tercapai secara optimal (Paladino et al., 2023).

Implementasi keperawatan pada pasien akhir hayat harus dilakukan secara berkesinambungan, berpusat pada pasien, kolaboratif, serta melibatkan keluarga sebagai bagian dari perawatan. Pendekatan ini penting karena kondisi pasien terminal sering mengalami perubahan yang cepat dan kompleks. Perawat perlu melakukan pemantauan secara terus-menerus serta menyesuaikan intervensi sesuai respons pasien. Selain itu, kolaborasi dengan tim kesehatan seperti dokter dan tenaga profesional lain diperlukan untuk memberikan perawatan yang komprehensif. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi perawatan paliatif yang terintegrasi dapat meningkatkan kualitas hidup pasien serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat pada akhir hayat (De Campos et al., 2022).

Karakteristik Implementasi Keperawatan

a. Berkesinambungan

Implementasi keperawatan harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan kondisi pasien. Perubahan kondisi pasien terminal dapat terjadi dengan cepat sehingga memerlukan pemantauan yang intensif. Perawat perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap respons pasien terhadap intervensi yang diberikan. Tindakan yang dilakukan harus fleksibel

dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Dengan pendekatan ini, kualitas perawatan dapat tetap terjaga (Dias et al., 2024).

b. Berpusat pada Pasien (*Patient-Centered Care*)

Implementasi keperawatan harus berfokus pada kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien. Perawat perlu menghormati keputusan pasien serta melibatkan pasien dalam setiap proses perawatan. Pendekatan ini membantu meningkatkan kepuasan dan kualitas hidup pasien. Selain itu, perawatan yang berpusat pada pasien juga mendukung hubungan terapeutik yang lebih baik. Dengan demikian, pasien merasa lebih dihargai dan diperhatikan (Burke et al., 2023).

c. Kolaboratif dengan Tim Kesehatan

Implementasi keperawatan memerlukan kerja sama dengan tim kesehatan lain seperti dokter, psikolog, dan rohaniwan. Kolaborasi ini penting untuk memberikan perawatan yang holistik dan komprehensif. Setiap tenaga kesehatan memiliki peran yang saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pasien. Perawat berperan sebagai koordinator dalam memastikan kesinambungan perawatan. Dengan kolaborasi yang baik, kualitas pelayanan dapat ditingkatkan (Wantonoro et al., 2022).

d. Melibatkan Keluarga

Keluarga merupakan bagian penting dalam perawatan pasien akhir hayat. Perawat perlu melibatkan keluarga dalam proses perawatan serta memberikan edukasi yang diperlukan. Keterlibatan keluarga dapat meningkatkan dukungan emosional dan kenyamanan pasien. Selain itu, keluarga juga berperan dalam pengambilan keputusan terkait perawatan pasien. Dengan melibatkan keluarga, perawatan menjadi lebih efektif dan bermakna (Wang et al., 2024). Implementasi keperawatan juga harus memperhatikan aspek keselamatan pasien serta etika dalam pemberian perawatan akhir hayat. Perawat perlu memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau penderitaan tambahan bagi pasien. Prinsip etika seperti menghormati martabat pasien, otonomi, serta memberikan perawatan yang manusiawi harus menjadi dasar dalam implementasi. Selain itu, dokumentasi tindakan keperawatan secara akurat juga penting untuk menjaga kontinuitas perawatan. Dengan memperhatikan aspek keselamatan dan etika, implementasi keperawatan dapat dilakukan secara profesional dan berkualitas (Paladino et al., 2023).

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan kepada pasien. Pada

perawatan akhir hayat, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan karena kondisi pasien dapat berubah secara cepat dan kompleks. Perawat perlu membandingkan kondisi pasien sebelum dan sesudah intervensi untuk menilai keberhasilan tindakan yang dilakukan. Evaluasi juga membantu dalam mengidentifikasi masalah yang belum teratasi serta kebutuhan baru yang muncul selama perawatan. Dengan demikian, evaluasi menjadi dasar dalam penyesuaian rencana asuhan keperawatan selanjutnya (Demuro et al., 2024).

Evaluasi keperawatan pada pasien akhir hayat tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan *spiritual*. Pendekatan evaluasi yang holistik penting karena kualitas hidup merupakan indikator utama keberhasilan perawatan paliatif. Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi berbasis *quality of life* digunakan secara luas untuk menilai outcome perawatan paliatif pada pasien terminal (Demuro et al., 2024). Selain itu, penggunaan instrumen *Patient-Reported Outcome Measures* (PROMs) membantu menilai kondisi pasien secara subjektif dan lebih komprehensif (Li et al., 2024). Dengan evaluasi yang komprehensif, kualitas pelayanan dan kesejahteraan pasien dapat ditingkatkan.

Aspek Evaluasi Keperawatan

a. Perubahan Kondisi Fisik Pasien

Evaluasi dilakukan dengan menilai perubahan kondisi fisik pasien seperti nyeri, sesak napas, kelelahan, dan gejala lainnya. Perawat perlu menggunakan indikator yang terukur untuk menilai efektivitas intervensi yang diberikan. Pemantauan kondisi fisik dilakukan secara berkala karena kondisi pasien terminal dapat berubah dengan cepat. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam menentukan apakah intervensi perlu dilanjutkan atau dimodifikasi. Dengan demikian, kondisi pasien dapat dikelola secara optimal (Demuro et al., 2024).

b. Tingkat Kenyamanan Pasien

Tingkat kenyamanan pasien merupakan indikator utama dalam perawatan akhir hayat. Evaluasi dilakukan dengan mengamati ekspresi pasien, keluhan, serta respons terhadap tindakan keperawatan. Perawat perlu memastikan bahwa pasien merasa nyaman baik secara fisik maupun psikologis. Lingkungan yang mendukung juga berperan dalam meningkatkan kenyamanan pasien. Dengan evaluasi yang tepat, kualitas hidup pasien dapat terus ditingkatkan (Demuro et al., 2024).

c. Respons Emosional Pasien

Evaluasi juga mencakup respons emosional pasien seperti kecemasan, ketakutan, dan *distress*. Perawat perlu menilai bagaimana pasien beradaptasi terhadap kondisi terminal yang dialami. Respons emosional yang positif menunjukkan efektivitas dukungan psikologis yang diberikan. Sebaliknya, *distress* emosional perlu segera ditangani dengan intervensi yang sesuai. Dengan demikian, kesejahteraan psikologis pasien dapat terjaga (Li et al., 2024).

d. Kepuasan Pasien dan Keluarga

Kepuasan pasien dan keluarga menjadi indikator penting dalam keberhasilan asuhan keperawatan paliatif. Evaluasi dilakukan dengan menilai persepsi pasien dan keluarga terhadap pelayanan yang diberikan. Keterlibatan keluarga dalam evaluasi juga membantu dalam meningkatkan kualitas perawatan. Perawat perlu memastikan bahwa kebutuhan dan harapan pasien serta keluarga terpenuhi. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan menjadi lebih bermakna dan berkualitas (Demuro et al., 2024).

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus:

Seorang pasien perempuan berusia 65 tahun dengan diagnosis kanker payudara stadium lanjut dirawat di rumah sakit. Pasien mengeluhkan nyeri hebat pada area dada dan punggung dengan skala nyeri 7/10. Selain itu, pasien tampak lemah, mengalami penurunan nafsu makan, dan lebih banyak berbaring di tempat tidur.

Keluarga menyampaikan bahwa pasien sering terlihat cemas, sulit tidur, dan beberapa kali mengungkapkan ketakutan terhadap kematian. Pasien juga mulai jarang berinteraksi dengan anggota keluarga.

Hasil pengkajian menunjukkan:

1. Kesadaran *compos mentis*, namun tampak lemah
2. Nyeri skala 7/10
3. Nafsu makan menurun
4. Ekspresi wajah tampak meringis
5. Pasien tampak menarik diri dari lingkungan
6. Keluarga terlihat cemas dan sering bertanya tentang kondisi pasien

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pasien berdasarkan konsep perawatan akhir hayat.

Pertanyaan Diskusi:

1. Analisis masalah keperawatan yang dialami pasien berdasarkan pendekatan holistik (bio-psiko-sosio-*spiritual*), sertakan data pendukung dari kasus untuk setiap aspek.
 2. Analisis fase akhir kehidupan yang sedang dialami pasien berdasarkan karakteristik klinis pada kasus, serta jelaskan alasan penentuan fase tersebut.
 3. Jelaskan kebutuhan utama pasien pada kondisi tersebut sesuai konsep *end-of-life care*.
 4. Rencanakan intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan (*comfort care*) pasien.
 5. Jelaskan peran keluarga dalam mendukung kondisi pasien pada kasus ini.
- Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok, kemudian presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi / Skill Lab Perawatan Akhir Hayat (*End-of-Life Care*)

Deskripsi Kegiatan

Mahasiswa melakukan simulasi asuhan keperawatan pada pasien fase terminal di ruang paliatif. Kegiatan ini menekankan kemampuan mahasiswa dalam:

1. Melakukan pengkajian singkat kondisi pasien.
2. Memberikan intervensi *comfort care*.
3. Berkomunikasi secara empati dengan pasien dan keluarga.
4. Menjaga keselamatan dan martabat pasien.

Skenario Singkat

Seorang pasien laki-laki berusia 70 tahun dengan kanker paru stadium lanjut dirawat di ruang paliatif. Pasien tampak lemah, mengalami sesak napas ringan, dan mengeluh nyeri dengan skala 6/10. Pasien tampak gelisah dan mengatakan takut menghadapi kematian. Keluarga berada di samping pasien dan terlihat cemas serta sering bertanya tentang kondisi pasien. Mahasiswa diminta melakukan tindakan keperawatan sesuai kondisi pasien.

Tujuan Skill Lab

Mahasiswa mampu:

1. Melakukan pengkajian dasar pada pasien terminal.
2. Memberikan intervensi *comfort care* secara tepat.
3. Menunjukkan komunikasi terapeutik yang empati.
4. Menjaga keselamatan dan kenyamanan pasien.

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
<i>Knows/ Knows How</i>	<i>Mini-case & diskusi</i>
<i>Shows How</i>	OSCE perawatan akhir hayat

Critical Items (WAJIB LULUS)

Mahasiswa harus melakukan semua poin berikut, jika tidak maka tidak lulus:

1. Hand *hygiene* sebelum dan sesudah tindakan
2. Identifikasi pasien & menjaga privasi
3. Penilaian kondisi pasien (nyeri, sesak, kesadaran)
4. Pemberian intervensi *comfort care* (posisi nyaman, dukungan dasar)
5. Melaporkan kondisi bila ditemukan tanda memburuk (*red flags*)

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	<i>Minor error</i>	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & sistematis	Cukup tepat	Ragu	Keliru
Intervensi <i>comfort care</i>	Tepat & komprehensif	Cukup	Kurang	Tidak sesuai
Komunikasi	Empati & jelas	Baik	Kurang	Buruk

L. Template Soal Osce Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor <i>station</i>	
2	Judul <i>station</i>	Asuhan Keperawatan pada Pasien Fase Terminal (<i>End-of-Life Care</i>)
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan <i>station</i>	Menilai kemampuan peserta dalam melakukan pengkajian fokus, menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan dan melakukan intervensi <i>comfort care</i> , serta berkomunikasi terapeutik dengan pasien fase terminal.
5	Kompetensi	1. Komunikasi terapeutik dan edukasi 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Aman dan nyaman 2. Nyeri 3. Psikososial 4. <i>Spiritual</i> 5. Perawatan paliatif
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien perempuan usia 65 tahun dirawat di ruang paliatif dengan kanker payudara stadium lanjut. Pasien mengeluh nyeri pada dada dan punggung sejak 3 hari terakhir yang mengganggu istirahat, tampak meringis, sulit tidur, cemas, dan takut menghadapi kematian. Nafsu makan menurun. Keluarga mengatakan pasien lebih banyak diam, jarang berinteraksi, dan tampak lemah serta lebih sering berbaring. Hasil pengkajian awal: kesadaran <i>compos mentis</i>, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 96 x/menit, frekuensi napas

		22 x/menit, suhu 36,8°C, tampak gelisah, kontak mata kurang, dan berbicara pelan. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan data yang diperoleh. 3. Tuliskan rencana intervensi keperawatan (<i>comfort care</i>) yang sesuai. 4. Lakukan tindakan keperawatan untuk meningkatkan kenyamanan pasien. 5. Lakukan komunikasi terapeutik kepada pasien dan keluarga terkait kondisi pasien.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien perempuan usia 65 tahun dirawat di ruang paliatif dengan kanker payudara stadium lanjut. Pasien mengeluh nyeri pada dada dan punggung sejak 3 hari terakhir yang mengganggu istirahat, tampak meringis, sulit tidur, cemas, dan takut menghadapi kematian. Nafsu makan menurun. Keluarga mengatakan pasien lebih banyak diam, jarang berinteraksi, dan tampak lemah serta lebih sering berbaring. Hasil pengkajian awal: kesadaran <i>compos mentis</i>, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 96 x/menit, frekuensi napas 22 x/menit, suhu 36,8°C, tampak gelisah, kontak mata kurang, dan berbicara pelan. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan data yang diperoleh. 3. Tuliskan rencana intervensi keperawatan (<i>comfort care</i>) yang sesuai. 4. Lakukan tindakan keperawatan untuk meningkatkan kenyamanan pasien.

		5. Lakukan komunikasi terapeutik kepada pasien dan keluarga terkait kondisi pasien. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus, yaitu karakteristik nyeri (lokasi, durasi, kualitas), kondisi psikologis pasien (kecemasan dan ketakutan), pola tidur, nafsu makan, serta respons pasien terhadap penyakit. 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan, seperti nyeri kronis ditandai dengan keluhan nyeri, tampak meringis, gangguan istirahat, serta ansietas ditandai dengan rasa takut dan gelisah. 3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti manajemen nyeri nonfarmakologis, pengaturan posisi nyaman, pemenuhan kebutuhan dasar, serta dukungan emosional. 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam melakukan tindakan keperawatan, meliputi cuci tangan, menjaga privasi pasien, memberikan posisi nyaman, serta tindakan yang tidak invasif sesuai kondisi pasien terminal. 5. Menilai kemampuan peserta dalam melakukan komunikasi terapeutik, meliputi sikap empati, penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana, serta kemampuan memvalidasi perasaan pasien dan keluarga. 6. Monitor perilaku profesional peserta. 7. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang telah ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: perempuan usia 65 tahun dengan kanker payudara stadium lanjut. KS berperan sebagai pasien.

		2. Keluhan utama: nyeri pada dada dan punggung sejak 3 hari terakhir, terasa terus-menerus dan mengganggu istirahat. 3. Riwayat penyakit sekarang: pasien mengalami penurunan kondisi dalam beberapa minggu terakhir, nafsu makan menurun, lebih sering berbaring, dan aktivitas sangat terbatas. 4. Kondisi psikologis: pasien merasa cemas, takut menghadapi kematian, sulit tidur, dan lebih banyak diam. 5. Respons saat dikaji nyeri: pasien mengatakan nyeri terasa cukup mengganggu, sering membuat tidak nyaman, dan tampak meringis sambil memegang area nyeri. 6. Respons emosional: bila peserta menunjukkan empati, pasien dapat sedikit lebih terbuka; bila tidak, pasien tetap diam dan tampak cemas. 7. Interaksi sosial: pasien jarang berinteraksi, kontak mata kurang, dan berbicara pelan. 8. Keluarga: dapat diperankan oleh KS tambahan atau disampaikan secara verbal bahwa keluarga tampak cemas dan sering menanyakan kondisi pasien. 9. Harapan pasien: pasien berharap nyeri berkurang dan merasa lebih nyaman. 10. Sikap selama simulasi: pasien tampak lemah, posisi berbaring, ekspresi wajah meringis, suara pelan, dan respons lambat. 11. Jika peserta tidak melakukan komunikasi dengan baik: pasien tetap tampak cemas, tidak banyak merespons, dan terlihat tidak nyaman. 12. Peran harus dilakukan secara konsisten sesuai skenario agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Perawatan Paliatif 1. Tempat tidur pasien 2. <i>Manekin</i> pasien dewasa 3. Klien standar (KS) berperan sebagai pasien 4. Penguji

		5. Laboran Tata letak ruang: 1. Tempat tidur pasien dengan manekin 2. Kursi untuk keluarga/pendamping 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/<i>handrub</i> 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. <i>Handrub/hand sanitizer</i> 3. Tisu 4. Bantal tambahan untuk posisi nyaman 5. Selimut 6. Skala nyeri (<i>Numeric Rating Scale/NRS</i>) 7. Stetoskop (opsional untuk pengkajian dasar) 8. Tensimeter dan termometer (alat tanda vital) 9. Pengalas/perlak 10. Lembar jawaban peserta Laboran ada. Peran laboran: Merapikan ulang alat-alat setelah digunakan oleh peserta, serta memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). <i>Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik</i> (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2019). <i>Standar intervensi keperawatan Indonesia</i> (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

		Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). <i>Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan</i> (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI. (2021). <i>Pedoman standar prosedur operasional keperawatan</i> (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. World Health Organization. (2020). <i>Palliative care</i>. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care National Institute for Health and Care Excellence. (2024). <i>End of life care for adults</i>. https://www.nice.org.uk
--	--	---

**Sop Pemberian *Comfort Care* Pada Pasien Fase Terminal
(*End-Of-Life Care*)**

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih bila perlu b. <i>Handrub</i> /sabun cuci tangan c. Bantal tambahan d. Selimut e. Tisu f. Skala nyeri (NRS) g. Tensimeter dan termometer (opsional)				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan pasien/keluarga bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				

10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien dan keluarga				
C	Tahap Kerja				
11	Melakukan <i>hand hygiene</i>				
12	Menggunakan sarung tangan bersih bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh (bila diperlukan)				
13	Mengkaji kondisi pasien meliputi nyeri, kenyamanan, posisi, dan kondisi psikologis				
14	Mengkaji tingkat nyeri menggunakan skala nyeri (NRS)				
15	Mengidentifikasi kebutuhan kenyamanan pasien				
16	Mengatur posisi pasien senyaman mungkin (<i>semi-Fowler</i> /miring sesuai kondisi)				
17	Memberikan dukungan fisik (bantal, selimut, lingkungan nyaman)				
18	Mengurangi stimulus yang mengganggu (suara bising, pencahayaan berlebihan)				
19	Memberikan sentuhan terapeutik sesuai kondisi pasien				
20	Melakukan komunikasi terapeutik (empati, mendengarkan aktif)				

21	Memvalidasi perasaan pasien (kecemasan, ketakutan)				
22	Memberikan dukungan emosional dan <i>spiritual</i> sesuai kebutuhan pasien				
23	Melibatkan keluarga dalam perawatan pasien				
24	Menghindari tindakan invasif yang tidak perlu				
25	Memantau respons pasien terhadap tindakan				
26	Merapikan pasien dan lingkungan				
D	Tahap Terminasi				
27	Menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan				
28	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
29	Memberikan <i>reinforcement</i> positif kepada pasien/keluarga				
30	Membuat kontrak waktu tindakan selanjutnya				
31	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
32	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian, tindakan <i>comfort care</i> , respons pasien, dan tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				

33	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				
----	--	--	--	--	--

Form Penilaian Osce Keperawatan

Station: Asuhan Keperawatan Pada Pasien Fase Terminal (*End-Of-Life Care*)

Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali kondisi pasien meliputi nyeri (karakteristik), kondisi psikologis (cemas/takut), pola tidur, nafsu makan, serta respons pasien terhadap penyakit					2	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis keperawatan yang tepat dan menyusun rencana intervensi (<i>comfort care</i>) yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan (<i>comfort care</i>)	Melakukan tindakan peningkatan kenyamanan (posisi nyaman, dukungan fisik, lingkungan, nonfarmakologis) secara tepat dan sistematis					4	

4	Komunikasi terapeutik	Menunjukkan empati, mendengarkan aktif, memvalidasi perasaan, serta melibatkan pasien dan keluarga dalam komunikasi					1	
5	Perilaku profesional	Menjaga privasi, keselamatan pasien, sikap sopan, sistematis, teliti, dan responsif					1	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

Rubrik Penilaian Osce Keperawatan Station: Asuhan Keperawatan Pada Pasien Fase Terminal
(End-Of-Life Care)

Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menggali data fokus pasien fase terminal, meliputi karakteristik nyeri, kondisi psikologis (kecemasan/ketakutan), pola tidur, nafsu makan, serta respons pasien terhadap penyakit. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan relevan dengan kondisi paliatif.					2	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menetapkan diagnosis keperawatan prioritas (misalnya nyeri kronis, ansietas, gangguan kenyamanan) serta menyusun rencana intervensi <i>comfort care</i> yang sesuai dengan kondisi pasien fase terminal.					2	
3. Implementasi: Keperawatan (Comfort Care) Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam melakukan tindakan keperawatan untuk meningkatkan kenyamanan pasien, meliputi pengaturan posisi, dukungan fisik, pengurangan stimulus, komunikasi terapeutik, serta dukungan emosional dan <i>spiritual</i> secara aman, sistematis, dan sesuai kondisi pasien.					4	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menunjukkan sikap profesional, meliputi komunikasi terapeutik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, menjaga					2	

privasi, memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pasien, serta bersikap empati, teliti, dan responsif.						
---	--	--	--	--	--	--

Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
▪ Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan dengan kondisi pasien terminal.	Pengkajian dilakukan secara terbatas, tidak sistematis, dan hanya menggali sebagian kecil data (misalnya, hanya nyeri saja).	Melakukan pengkajian cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting (nyeri, psikologis, tidur, nafsu makan), namun masih ada data yang terlewat.	Melakukan pengkajian secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi nyeri, kondisi psikologis, pola tidur, nafsu makan, serta respons pasien, dan mampu menyampaikan hasil dengan tepat.
▪ Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menetapkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus,	Diagnosis ditetapkan tetapi tidak tepat atau tidak sesuai prioritas, serta rencana	Menetapkan diagnosis yang cukup tepat dan menyusun rencana yang cukup sesuai,	Menetapkan diagnosis prioritas secara tepat dan

	serta tidak menyusun rencana keperawatan.	keperawatan tidak relevan.	tetapi masih kurang lengkap atau kurang spesifik.	menyusun rencana <i>comfort care</i> yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan pasien terminal.
▪ Implementasi: Keperawatan (<i>Comfort Care</i>)	Tidak melakukan tindakan atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dan berisiko bagi pasien.	Melakukan tindakan sangat terbatas, tidak sistematis, dan banyak langkah penting yang tidak dilakukan.	Melakukan tindakan cukup baik, sebagian besar langkah benar, tetapi masih ada kekurangan dalam urutan atau kelengkapan.	Melakukan tindakan <i>comfort care</i> secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi posisi nyaman, dukungan fisik, lingkungan, komunikasi terapeutik, serta dukungan emosional dan <i>spiritual</i> .

▪ Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak menjaga privasi, tidak empati, dan tidak memperhatikan keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang sangat terbatas, komunikasi kurang baik, dan kurang memperhatikan privasi atau kenyamanan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional cukup baik, komunikasi cukup jelas, memperhatikan privasi dan kenyamanan, namun masih ada kekurangan kecil.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi empati, menjaga privasi, keselamatan pasien, serta bersikap teliti, responsif, dan etis selama tindakan.
-------------------------------	--	---	--	---

Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	<i>BORDERLINE</i>	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

.....

Penguji :

DOPS (Does)

Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Pasien Fase Terminal (*End-of-Life Care*)

Komponen	Deskripsi	Kasus Pasien Fase Terminal
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa saat melakukan tindakan keperawatan di lahan praktik secara nyata dan terfokus.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan <i>comfort care</i> pada pasien kanker stadium lanjut di ruang paliatif.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, intervensi keperawatan, serta profesionalisme dalam praktik nyata.	Mahasiswa dinilai tidak hanya memahami konsep paliatif, tetapi juga mampu mengkaji kondisi pasien, memberikan kenyamanan, serta berkomunikasi dengan pasien dan keluarga secara empati.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di	Seorang pasien perempuan usia 65 tahun dengan kanker

	lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran.	stadium lanjut, mengeluh nyeri, tampak lemah, cemas, sulit tidur, dan mengalami penurunan nafsu makan.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh mulai dari awal interaksi hingga implementasi tindakan dan komunikasi.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian fokus (nyeri dan kondisi psikologis), mengatur posisi nyaman, memberikan dukungan emosional, serta berkomunikasi dengan pasien dan keluarga.
Aspek yang dinilai	Aspek meliputi pengkajian, penalaran klinik, implementasi tindakan, komunikasi terapeutik, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa dalam mengkaji nyeri, mengenali kecemasan, memberikan posisi nyaman, serta menunjukkan komunikasi empati dan menjaga privasi pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format penilaian terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data dengan masalah utama (misalnya nyeri dan ansietas) serta memberikan intervensi <i>comfort care</i> yang tepat.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi, tetapi perlu meningkatkan pengkajian nyeri secara lebih sistematis atau

		memperdalam dukungan emosional.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu memberikan asuhan secara aman, empati, dan sistematis. Perlu supervisi jika masih membutuhkan arahan. Remedial jika belum memenuhi standar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mencapai kompetensi pada level does dalam praktik nyata.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori paliatif, tetapi juga mampu menerapkan <i>comfort care</i> secara langsung, aman, dan profesional pada pasien terminal.

Portofolio

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan Pasien Fase Terminal (*End-of-Life Care*)

Komponen	Deskripsi	Kasus Pasien Fase Terminal
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan pasien fase terminal, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, memberikan <i>comfort care</i> , menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi,	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat pasien

	refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	terminal, tetapi juga menunjukkan perkembangan kemampuan dalam memberikan kenyamanan, komunikasi terapeutik, dan dukungan emosional setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan performa nyata di lahan praktik.	OSCE memuat hasil simulasi <i>comfort care</i> dan komunikasi terapeutik, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa memberikan asuhan pada pasien terminal di ruang paliatif.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan kasus pasien kanker stadium lanjut dengan keluhan nyeri dan kecemasan, hasil pengkajian, diagnosis (nyeri kronis, ansietas), intervensi <i>comfort care</i> , serta evaluasi kenyamanan pasien.
Refleksi <i>patient safety</i>	Refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya menjaga kenyamanan pasien, menghindari tindakan invasif yang tidak perlu, menjaga privasi, serta melakukan komunikasi yang empati untuk

		mengurangi <i>distress</i> pasien.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari <i>Clinical Instructor</i> (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi empati dan pengaturan posisi pasien, namun perlu meningkatkan pengkajian nyeri secara lebih sistematis dan dokumentasi keperawatan.
Karakteristik penilaian	Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang menekankan konsistensi performa mahasiswa, bukan hanya satu kali penilaian.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman praktik dalam memberikan <i>end-of-life care</i> , menunjukkan kemampuan yang konsisten dalam pengkajian, komunikasi, dan <i>comfort care</i> .
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa dalam berbagai situasi praktik.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan <i>feedback</i> , terlihat bahwa mahasiswa konsisten mampu memberikan perawatan yang nyaman, empati, dan aman pada pasien terminal.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tampak dalam performa nyata yang berulang dan berkembang.	Pada kasus pasien terminal, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori paliatif, tetapi juga mampu menerapkan <i>comfort care</i>

		secara konsisten dalam praktik klinik.
--	--	--

Tabel. *Case report* pada Asuhan Keperawatan Pasien Fase Terminal (*End-of-Life Care*)

Komponen	Deskripsi	Kasus Pasien Fase Terminal
Hakikat <i>Case Report</i>	<i>Case report</i> merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, <i>case report</i> berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang pasien perempuan usia 65 tahun dengan kanker stadium lanjut yang mengalami nyeri, kecemasan, penurunan nafsu makan, dan kondisi fisik yang semakin melemah.
Tujuan	<i>Case report</i> bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan kondisi pasien terminal, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas seperti nyeri dan ansietas, tindakan <i>comfort care</i> , serta perubahan kondisi pasien setelah intervensi.
Isi laporan	Isi <i>case report</i> mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Mahasiswa menuliskan keluhan nyeri dada dan punggung, kecemasan, gangguan tidur, data pengkajian, diagnosis (nyeri kronis, ansietas), intervensi <i>comfort care</i> (posisi nyaman, dukungan emosional), serta evaluasi kenyamanan pasien.

Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan nyeri dan kecemasan dengan kebutuhan paliatif, memilih intervensi yang tepat, serta mengevaluasi perubahan kenyamanan pasien.
Nilai edukatif	<i>Case report</i> membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan refleksi praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus pasien terminal, mahasiswa belajar pentingnya pendekatan holistik, komunikasi empati, serta fokus pada kenyamanan dan martabat pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, <i>case report</i> menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep <i>end-of-life care</i> , tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh dan humanis.

Tabel. Refleksi *Patient Safety* pada Asuhan Keperawatan Pasien Fase Terminal (*End-of-Life Care*)

Komponen	Deskripsi	Kasus Pasien Fase Terminal
Hakikat refleksi <i>patient safety</i>	Refleksi <i>patient safety</i> merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus pasien terminal, mahasiswa merefleksikan bahwa kondisi pasien yang lemah, nyeri, dan kecemasan tinggi dapat meningkatkan risiko ketidaknyamanan dan penurunan kualitas hidup bila tidak ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan, termasuk pada fase akhir kehidupan.	Mahasiswa memahami bahwa tindakan yang tidak tepat, seperti intervensi yang tidak perlu atau komunikasi yang kurang empati, dapat memperburuk kondisi pasien dan menurunkan martabat pasien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa fokus utama adalah menjaga kenyamanan pasien, mengurangi nyeri dan kecemasan, serta memastikan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi antara lain nyeri tidak terkontrol, kecemasan dan <i>distress</i> psikologis, risiko luka tekan akibat imobilitas, komunikasi yang tidak efektif, serta tindakan medis yang tidak sesuai kebutuhan pasien.

Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pengkajian nyeri secara berkala, pengaturan posisi nyaman, menjaga lingkungan yang tenang, komunikasi empati, melibatkan keluarga, serta menghindari tindakan invasif yang tidak perlu.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi menunjukkan pembelajaran yang diperoleh dan dampaknya terhadap praktik selanjutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada pasien terminal, keselamatan tidak hanya tentang mencegah cedera, tetapi juga menjaga kenyamanan, martabat, dan kualitas hidup pasien melalui pendekatan holistik dan empati.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan keperawatan, tetapi juga mampu mengidentifikasi risiko dan meningkatkan kualitas asuhan secara berkelanjutan pada pasien akhir hayat.

M. Ringkasan

Asuhan Keperawatan pada Pasien Fase Terminal (*End-of-Life Care*)

Bab ini menekankan bahwa perawatan akhir hayat (*end-of-life care*) merupakan bagian penting dari perawatan paliatif yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dengan kondisi terminal. Pada fase ini, tujuan perawatan tidak lagi bersifat kuratif, tetapi beralih pada pengurangan penderitaan, pengendalian gejala, serta pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan *spiritual* pasien. Pendekatan yang digunakan bersifat holistik dan berpusat pada pasien serta keluarga, dengan tetap menjaga martabat pasien hingga akhir kehidupan.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pada pasien fase terminal harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian holistik, dilanjutkan dengan penetapan diagnosis keperawatan seperti nyeri kronis, ansietas, gangguan tidur, *distress spiritual*, atau risiko isolasi sosial. Berdasarkan diagnosis tersebut, perawat menyusun rencana intervensi yang berfokus pada *comfort care*. Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan klinik yang aman, empati, dan sistematis. Tindakan keperawatan meliputi pengaturan posisi pasien agar nyaman, pemberian dukungan fisik seperti bantal dan lingkungan yang tenang, pengurangan stimulus yang mengganggu, serta komunikasi terapeutik yang melibatkan pasien dan keluarga. Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam membantu pasien dan keluarga memahami kondisi serta menghadapi proses akhir kehidupan.

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kenyamanan pasien, respons terhadap intervensi, kondisi emosional, serta kepuasan pasien dan keluarga. Indikator keberhasilan perawatan pada fase ini bukan kesembuhan, tetapi meningkatnya kenyamanan, berkurangnya nyeri dan kecemasan, serta tercapainya ketenangan pasien. Perawat juga perlu melakukan evaluasi berkelanjutan karena kondisi pasien terminal dapat berubah dengan cepat.

Dalam praktiknya, keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama. Perawat harus mampu mengenali risiko seperti nyeri tidak terkontrol, kecemasan berat, risiko luka tekan, serta intervensi yang tidak sesuai. Selain itu, penting untuk menjaga komunikasi yang baik, menghormati keputusan pasien, dan melibatkan keluarga dalam setiap proses perawatan.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa asuhan keperawatan pada pasien fase terminal harus dilakukan secara holistik, empati, dan berpusat pada kenyamanan serta martabat pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu melakukan tindakan keperawatan, tetapi juga mampu memberikan dukungan emosional, berkomunikasi secara efektif, serta menjaga keselamatan dan kualitas

hidup pasien hingga akhir hayat. Hal ini menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab maupun praktik klinik keperawatan paliatif.

Tabel *Red Flags* dan Eskalasi

Asuhan Keperawatan Pasien Fase Terminal (*End-of-Life Care*)

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Nyeri berat tidak terkontrol	Menunjukkan manajemen nyeri tidak adekuat, meningkatkan penderitaan pasien	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/dokter, evaluasi dan optimalkan manajemen nyeri
Sesak napas berat (<i>dyspnea</i>)	Tanda <i>distress</i> pernapasan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan berat	Eskalasi segera, posisi <i>semi-fowler</i> , laporkan untuk penanganan lanjutan
Penurunan kesadaran	Menunjukkan perburukan kondisi klinis atau fase menjelang kematian	Laporkan segera, lakukan pemantauan ketat, siapkan dukungan pasien dan keluarga
Agitasi atau gelisah berat	Dapat menunjukkan <i>distress</i> psikologis atau gejala terminal (<i>terminal agitation</i>)	Segera laporkan, berikan lingkungan tenang, dukungan emosional
Kecemasan atau ketakutan ekstrem	Menunjukkan <i>distress</i> psikologis yang signifikan	Lakukan komunikasi terapeutik, laporkan bila tidak teratasi
Tidak mampu makan/minum sama sekali	Menunjukkan penurunan kondisi dan kebutuhan evaluasi perawatan	Laporkan, evaluasi kebutuhan nutrisi/hidrasi sesuai kondisi paliatif
Luka tekan atau risiko tinggi luka tekan	Akibat imobilitas, dapat meningkatkan nyeri dan komplikasi	Lakukan reposisi, laporkan jika luka muncul atau memburuk

Tanda infeksi (demam, luka, sekret abnormal)	Dapat memperburuk kondisi pasien terminal	Laporkan untuk evaluasi medis dan penanganan lanjut
Keluarga tampak sangat cemas atau konflik keputusan	Dapat menghambat pengambilan keputusan dan perawatan pasien	Libatkan tim kesehatan, lakukan komunikasi dan edukasi
Penolakan atau ketidaksesuaian keputusan perawatan	Risiko tindakan yang tidak sesuai dengan preferensi pasien	Eskalasi ke tim interprofesional, lakukan diskusi lanjut
Tindakan invasif yang tidak sesuai kondisi	Dapat meningkatkan penderitaan tanpa manfaat klinis	Diskusikan dengan tim, evaluasi kembali tujuan perawatan
Tanda menjelang kematian (napas tidak teratur, penurunan respons)	Menunjukkan pasien memasuki fase akhir kehidupan	Segera laporkan, siapkan dukungan <i>comfort care</i> dan keluarga

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Asuhan Keperawatan Pasien Fase Terminal (*End-of-Life Care*)

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik/ Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep <i>end-of-life care</i> secara sederhana	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian holistik (fisik, psikologis, sosial, <i>spiritual</i>)	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa mengkaji nyeri (lokasi, durasi, karakteristik) pada pasien	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi kondisi psikologis pasien (cemas, takut, <i>distress</i>)	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengkaji kebutuhan <i>spiritual</i> pasien	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan pada pasien fase terminal	☐	☐	_____

7	Saya sudah bisa menyusun rencana intervensi <i>comfort care</i> yang sesuai	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengatur posisi pasien untuk meningkatkan kenyamanan	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa memberikan dukungan fisik (lingkungan nyaman, bantal, dll)	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa melakukan komunikasi terapeutik secara empati	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa memberikan dukungan emosional kepada pasien	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa melibatkan keluarga dalam perawatan pasien	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa mengenali tanda perburukan kondisi pasien (<i>red flags</i>)	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional (empati, aman, teliti, responsif)	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

N. Daftar Pustaka

- Agustini, N. L. P. I. B., Israfil, I., Suyasa, I. G. P. D., & Sujianto, U. (2026). Critical Aspects in Assessing Palliative End-of-Life Care : A Narrative Review of Family Support and *Spiritual* Needs. *Indonesian Contemporary Nursing Journal*, 10(2), 179–193. <https://doi.org/10.20956/icon.v10i2.44511>
- Alanazi, M. A., Shaban, M. M., Ramadan, O. M. E., Zaky, M. E., Mohammed, H. H., Amer, F. G. M., & Shaban, M. (2024). Navigating end-of-life decision-making in nursing: a systematic review of ethical challenges and palliative care practices. *BMC Nursing*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-02087-5>
- Alshakhs, S., Park, T., McDarby, M., Reid, M. C., Czaja, S., Adelman, R., Sweet, E., Jedlicka, C. M., Delgado, D., & Phongtankuel, V. (2024). Interventions for Family *Caregivers* of Patients Receiving Palliative/Hospice Care at Home: A Scoping Review. *Journal of Palliative Medicine*, 27(1), 112–127. <https://doi.org/10.1089/jpm.2023.0160>
- Amano, K., Ichikura, K., Hisamura, K., Sakurai, H., Yanaizumi, R., Takahashi, S., Shimizu, Y., Kawada, K., Takahashi, O., Matsushima, E., Takeuchi, T., & Takahashi, H. (2022). Characteristics and Social Support Needs Predicting Anticipatory Grief in the Spouses of Patients with Cancer at the End of Life. *International Journal of Clinical Medicine*, 13(03), 98–120. <https://doi.org/10.4236/ijcm.2022.133009>
- Austin, P. D., Lee, W., Keall, R., & Lovell, M. R. (2025). Efficacy of *spiritual* interventions in palliative care: An umbrella review of systematic reviews. *Palliative Medicine*, 39(1), 70–85. <https://doi.org/10.1177/02692163241287650>
- Best, M. C., Vivat, B., & Gijssberts, M. J. (2023). *Spiritual* Care in Palliative Care. *Religions*, 14(3), 1–11. <https://doi.org/10.3390/rel14030320>
- Bharadwaj, A., Oliver, D. P., Washington, K. T., Benson, J., Pitzer, K., White, P., & Demir, G. (2024). Family *Caregiver* Communication and Perceptions of Involvement in Hospice Care. *Journal of Palliative Medicine*, 27(5), 614–621. <https://doi.org/10.1089/jpm.2023.0576>
- Birgisdóttir, D., Duarte, A., Dahlman, A., Sallerfors, B., Rasmussen, B. H., & Fürst, C. J. (2021). A novel care guide for personalised palliative care – a national initiative for improved quality of care. *BMC Palliative Care*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12904-021-00874-4>
- Bowers, B., Antunes, B. C. P., Etkind, S., Hopkins, S. A., Winterburn, I., Kuhn, I., Pollock, K., & Barclay, S. (2023). Anticipatory prescribing in community end-of-life care: systematic review and narrative synthesis of the evidence since 2017. *BMJ Supportive and Palliative Care*, 13(e3), E612–E623. <https://doi.org/10.1136/spcare-2022-004080>
- Bryk, A., Roberts, G., Hudson, P., Harms, L., & Gerdtz, M. (2023). The concept of

- holism applied in recent palliative care practice: A scoping review. *Palliative Medicine*, 37(1), 26–39. <https://doi.org/10.1177/02692163221129999>
- Burke, C., Doody, O., & Lloyd, B. (2023). Healthcare practitioners' perspectives of providing palliative care to patients from culturally diverse backgrounds: a qualitative systematic review. *BMC Palliative Care*, 22(1), 1–25. <https://doi.org/10.1186/s12904-023-01285-3>
- Carr, M. R., & Rigby, M. (2025). A guide to end of life care: recognizing dying, advance care planning, and symptom management. *British Journal of Surgery*, 112(12), 1–4. <https://doi.org/10.1093/bjs/znaf226>
- Cerqueira, P., Pereira, S., Costa, R., & Garrido Gomes, A. (2025). Navigating Alternative Medicine Preferences in Palliative Care: Challenges and Collaborative Solutions. *Cureus*, 17(1), 1–5. <https://doi.org/10.7759/cureus.77864>
- Chapman, E. J., Pini, S., Edwards, Z., Elmokhallati, Y., Murtagh, F. E. M., & Bennett, M. I. (2022). Conceptualising effective symptom management in palliative care: a novel model derived from qualitative data. *BMC Palliative Care*, 21(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12904-022-00904-9>
- Dai, Y., Ding, J., Daveson, B. A., Chen, Y., Connolly, A., & Johnson, C. E. (2024). Validating performance status and activities of daily living assessment tools for Chinese palliative care in a cancer setting: A cross-cultural psychometric study. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 11(12), 100613. <https://doi.org/10.1016/j.apjon.2024.100613>
- De Campos, A. P., Levoy, K., Pandey, S., Wisniewski, R., Dimauro, P., Ferrell, B. R., & Rosa, W. E. (2022). Integrating Palliative Care into Nursing Care. *American Journal of Nursing*, 122(11), 40–45. <https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000897124.77291.7d>
- De Luca, E., Sena, B., Butcher, K., & de Wal, L. J. (2025). *Spirituality* and palliative care: international models and new perspectives. *Frontiers in Sociology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1523685>
- Demuro, M., Bratzu, E., Lorrai, S., & Preti, A. (2024). Quality of Life in Palliative Care: A Systematic Meta-Review of Reviews and Meta-Analyses. *Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health*, 20(1). <https://doi.org/10.2174/0117450179183857240226094258>
- Dewidar, O., Sabri, H., Ghogomu, E., Jaitly, S., Legacy, M. C., Bush, S. H., Rice, J., & Welch, V. (2026). Prevalence, risk factors and management of pressure injuries and their implications for palliative care: A rapid overview of reviews. *Palliative Medicine*, 40(1), 21–30. <https://doi.org/10.1177/02692163251393817>
- Dias, C., Rodrigues, I. T., Gonçalves, H., & Duarte, I. (2024). Communication strategies

- for adults in palliative care: the speech-language therapists' perspective. *BMC Palliative Care*, 23(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01382-x>
- Engel, M., Kars, M. C., Teunissen, S. C. C. M., & van der Heide, A. (2023). Effective communication in palliative care from the perspectives of patients and relatives: A systematic review. *Palliative and Supportive Care*, 21(5), 890–913. <https://doi.org/10.1017/S1478951523001165>
- Gafer, N., Gebre, N., Jabeen, I., Ashrafizadeh, H., Rassouli, M., & Mahmoud, L. (2024). A model for integrating palliative care into Eastern Mediterranean health systems with a primary care approach. *BMC Palliative Care*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01590-5>
- Gavin, N., Shan, M., Johns, S., Judge, K., & Fowler, N. (2021). *The Relationship Between Family Caregivers' Anticipatory Grief and Severity of Dementia*. 5(1), 955–956. <https://doi.org/10.1093/geroni/igab046.3449>
- Gilissen, J., Hunt, L., Van Den Block, L., Van Der Steen, J., Tahir, P., & Ritchie, C. (2021). Earlier initiation of palliative care in the disease trajectory of people living with dementia: A scoping review protocol. *BMJ Open*, 11(6), 1–8. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-044502>
- Habib, M. H., Schlögl, M., Raza, S., Chwistek, M., & Gulati, A. (2023). Interventional pain management in cancer patients—a scoping review. *Annals of Palliative Medicine*, 12(6), 1198–1214. <https://doi.org/10.21037/apm-23-433>
- Hagelin, C. L., Melin-Johansson, C., Österlind, J., Bisholt, B., & Pusa, S. (2025). Correction to: Online education in palliative care - A national exploratory multimethod study (BMC Palliative Care, (2024), 23, 1, (283), 10.1186/s12904-024-01615-z). *BMC Palliative Care*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12904-025-01662-0>
- Hao, Y., Zhan, L., Huang, M., Cui, X., Zhou, Y., & Xu, E. (2021). Nurses' knowledge and attitudes towards palliative care and death: a learning intervention. *BMC Palliative Care*, 20(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12904-021-00738-x>
- Harnischfeger, N., Rath, H. M., Oechsle, K., & Bergelt, C. (2022). Addressing palliative care and end-of-life issues in patients with advanced cancer: a systematic review of communication interventions for physicians not specialised in palliative care. *BMJ Open*, 12(6), 2–7. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-059652>
- Haroen, H., Harun, H., Sari, C. W. M., & Witdiawati, W. (2023). Uncovering Methods and Outcomes of Palliative Care for Geriatric Patients: A Scoping Review. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 16(September), 2905–2920. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S429323>
- Haroen, H., Maulana, S., Harun, H., Mirwanti, R., Sari, C. W. M., Platini, H., Arovah, N.

- I., Padila, P., Amirah, S., & Pardosi, J. F. (2025). The benefits of early palliative care on psychological well-being, functional status, and health-related quality of life among cancer patients and their *caregivers*: a systematic review and meta-analysis. *BMC Palliative Care*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12904-025-01737-y>
- Hedman, C., Fürst, P., Strang, P., Schelin, M. E. C., Lundström, S., & Martinsson, L. (2024). Pain prevalence and pain relief in end-of-life care – a national registry study. *BMC Palliative Care*, 23(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01497-1>
- Hossain, A., Hasan, M., Rahman, T., Almarzooqi, A., Rahman, S. A., Hijazi, H., & Alameddine, M. (2025). Palliative care needs and quality of life among adults with advanced chronic illnesses in low-income communities of Bangladesh. *BMC Palliative Care*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01643-9>
- Hui; Bruera. (2017). ESAS 25y later. *J Pain Symptom Manage*, 53(3), 1. Tevis SE, James TA, Kuerer HM, et al. Patient-R. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2016.10.370>.The
- Ito, K., George, N., Wilson, J., Bowman, J., Aaronson, E., & Ouchi, K. (2022). Primary palliative care recommendations for critical care clinicians. *Journal of Intensive Care*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s40560-022-00612-9>
- Jiang, Y., Wang, C., Zheng, P., Wang, X., Hu, S., Ma, L., Chen, Y., & Zhao, J. (2025). Validation of the Anticipatory Grief Scale through Confirmatory Factor Analysis and Latent Profile Analysis. *Nursing in Critical Care*, 30(4), e70117. <https://doi.org/10.1111/nicc.70117>
- Kang, K.-A., Kim, D.-B., Koh, S.-J., Park, M.-H., Park, H. Y., Yoon, D. H., Yoon, S.-J., Lee, S.-J., Choi, J.-E., Han, H.-S., & Chun, J. (2023). *Spiritual Care Guide in Hospice • Palliative Care*. *Journal of Hospice and Palliative Care*, 26(4), 149–159. <https://doi.org/10.14475/jhpc.2023.26.4.149>
- Khonsari, S., Johnston, B., Patterson, H., & Mayland, C. (2024). Mechanisms of end-of-life communication contributing to optimal care at the end of life: a review of reviews. *BMJ Supportive & Palliative Care*. <https://doi.org/10.1136/spcare-2024-004904>
- Kim, Y., & Kim, D. H. (2024). Interventions for family involvement enhance end-of-life care for hospitalized patients: an integrative review. *BMC Nursing*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12912-024-02538-z>
- Kuosmanen, L., Hupli, M., Ahtiluoto, S., & Haavisto, E. (2021). Patient participation in shared decision-making in palliative care – an integrative review. *Journal of Clinical Nursing*, 30(23–24), 3415–3428. <https://doi.org/10.1111/jocn.15866>

- Kustanti, C. Y., Chu, H., Kang, X. L., Pien, L.-C., Chen, R., Tsai, H.-T., & Chou, K.-R. (2023). Anticipatory grief prevalence among *caregivers* of persons with a life-threatening illness: A meta-analysis. *BMJ Supportive & Palliative Care*, 13(e3), e1074 LP-e1083. <https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2021-003338>
- Li, Y., Hung, V., Ho, K., Kavalieratos, D., Warda, N., Zimmermann, C., & Quinn, K. L. (2024). The Validity of Patient-Reported Outcome Measures of Quality of Life in Palliative Care: A Systematic Review. *Journal of Palliative Medicine*, 27(4), 545–562. <https://doi.org/10.1089/jpm.2023.0294>
- Macharia, J. M., Raposa, B. L., Sipos, D., Melczer, C., Toth, Z., & Káposztás, Z. (2023). The Impact of Palliative Care on Mitigating Pain and Its Associated Effects in Determining Quality of Life among Colon Cancer Outpatients. *Healthcare (Switzerland)*, 11(22). <https://doi.org/10.3390/healthcare11222954>
- MacMartin, M., Zhang, J., & Barnato, A. (2024). The role of specialty palliative care interdisciplinary team members in acute care decision support: a qualitative study protocol. *BMC Palliative Care*, 23(1), 23–27. <https://doi.org/10.1186/s12904-023-01328-9>
- Martins, H., Silva, R. S., Bragança, J., Romeiro, J., & Caldeira, S. (2024). *Spiritual Distress, Hopelessness, and Depression in Palliative Care: Simultaneous Concept Analysis. Healthcare (Switzerland)*, 12(10), 1–15. <https://doi.org/10.3390/healthcare12100960>
- McAndrew, N. S., Camarda, A., Fortney, C. A., McCracken, C., Bartowitz, J., & Rosa, W. E. (2025). Rapid Review of Family *Caregiver* Engagement in Hospice and End-of-Life Patient Care: Implications for Nursing Practice. *Journal of Hospice and Palliative Nursing*, 27(4), 172–181. <https://doi.org/10.1097/NJH.0000000000001133>
- McCauley, R., Ryan, K., McQuillan, R., Selman, L. E., & Foley, G. (2024). Supportive relationships between patients and family *caregivers* in specialist palliative care: a qualitative study of barriers and facilitators. *BMJ Supportive & Palliative Care*, 14(2), 233 LP – 242. <https://doi.org/10.1136/spcare-2023-004371>
- Mitchell, S., Barclay, S., Evans, C., & Sleeman, K. (2022). Palliative and end-of-life care in primary care during the COVID-19 pandemic and beyond. *British Journal of General Practice*, 72(714), 6–7. <https://doi.org/10.3399/BJGP22X718025>
- Monette, E. M. (2021). Cultural Considerations in Palliative Care Provision: A Scoping Review of Canadian Literature. *Palliative Medicine Reports*, 2(1), 146–156. <https://doi.org/10.1089/pmr.2020.0124>
- Moons, L., Ombelet, F., Deschodt, M., De Roo, M. L., Oldenburger, E., Bossuyt, I., &

- Pype, P. (2024). Interprofessional collaboration between hospital-based palliative care teams and general healthcare workers: A realist review protocol. *PLoS ONE*, 19(11 November), 1–12. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0310709>
- National Institute for Health and Care Excellence [NICE]. (2019). End of life care for adults: service delivery NICE guideline [NG142]. *Nice.Org.Uk*, October. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng142>
- NICE. (2023). *Care of dying adults in the last days of life*. <https://doi.org/10.1093/med/9780198834502.003.0095>
- Nicole, D. (2023). Pain Management in Palliative Care: Optimizing Symptom Relief and Quality of Life. *Journal of Pain Management and Therapy*, 7(2), 1–2. <https://doi.org/10.35841/aapmt-7.2.136>
- Nowels, M. A., Kalra, S., Duberstein, P. R., Coakley, E., Saraiya, B., George, L., & Kozlov, E. (2023). Palliative Care Interventions Effects on Psychological Distress: A Systematic Review & Meta-Analysis. *Journal of Pain and Symptom Management*, 65(6), e691–e713. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2023.02.001>
- OECD. (2025). *Health at a Glance 2025: OECD Indicators*. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/11/health-at-a-glance-2025_a894f72e/8f9e3f98-en.pdf
- Paladino, J., Sanders, J. J., Fromme, E. K., Block, S., Jacobsen, J. C., Jackson, V. A., Ritchie, C. S., & Mitchell, S. (2023). Improving serious illness communication: a qualitative study of clinical culture. *BMC Palliative Care*, 22(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12904-023-01229-x>
- Paterson, L. A., & Maritz, J. E. (2024). Nurses' experiences of the family's role in end-of-life care. *Health SA Gesondheid*, 29, 1–10. <https://doi.org/10.4102/hsag.v29i0.2565>
- Paulsen, B. T., Kærgaard Johansen, M. L., Lund, S. K., Enggaard, H., & Jørgensen, L. (2025). Anticipatory grief - A neglected phenomenon among relatives of patients with incurable cancer: A qualitative study. *European Journal of Oncology Nursing*, 74(October 2024). <https://doi.org/10.1016/j.ejon.2024.102730>
- Pornrattanakavee, P., Srichan, T., Seetalarom, K., Saichaemchan, S., Oer-areemitr, N., & Prasongsook, N. (2022). Impact of interprofessional collaborative practice in palliative care on outcomes for advanced cancer inpatients in a resource-limited setting. *BMC Palliative Care*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12904-022-01121-0>
- Prieto-Crespo, V., Arevalo-Buitrago, P., Olivares-Luque, E., García-Arcos, A., & López-

- Soto, P. J. (2024). Impact of *Spiritual* Support Interventions on the Quality of Life of Patients Who Receive Palliative Care: A Systematic Review. *Nursing Reports*, 14(3), 1906–1921. <https://doi.org/10.3390/nursrep14030142>
- Pun, J., Chow, J. C. H., Fok, L., & Cheung, K. M. (2023). Role of patients' family members in end-of-life communication: an integrative review. *BMJ Open*, 13(2), 1–12. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-067304>
- Quinn, B., & Connolly, M. (2023). *Spirituality* in palliative care. *BMC Palliative Care*, 22(1), 10–11. <https://doi.org/10.1186/s12904-022-01116-x>
- Quinn, K. L., Shurrab, M., Gitau, K., Kavalieratos, D., Isenberg, S. R., Stall, N. M., Stukel, T. A., Goldman, R., Horn, D., Cram, P., Detsky, A. S., & Bell, C. M. (2020). Association of Receipt of Palliative Care Interventions With Health Care Use, Quality of Life, and Symptom Burden Among Adults With Chronic Noncancer Illness: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA*, 324(14), 1439–1450. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.14205>
- Radionova, N., Becker, G., Mayer-Steinacker, R., Gencer, D., Rieger, M. A., & Preiser, C. (2020). The views of physicians and nurses on the potentials of an electronic assessment system for recognizing the needs of patients in palliative care. *BMC Palliative Care*, 19(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12904-020-00554-9>
- Rosa, W. E., Buck, H. G., Squires, A. P., Kozachik, S. L., Huijter, H. A.-S., Bakitas, M., Boit, J. M., Bradley, P. K., Cacchione, P. Z., Chan, G. K., Crisp, N., Dahlin, C., Daoust, P., Davidson, P. M., Davis, S., Doumit, M. A. A., Fink, R. M., Herr, K. A., Hinds, P. S., ... Ferrell, B. R. (2022). International consensus-based policy recommendations to advance universal palliative care access from the American Academy of Nursing Expert Panels. *Nursing Outlook*, 70(1), 36–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.outlook.2021.06.018>
- Rubbai, Y. S., Chong, M. C., Tang, L. Y., Abdullah, K. L., Mohammad, W. T., Mohajer, S., & Namazinia, M. (2024). Barriers in providing quality end-of-life care as perceived by nurses working in critical care units: an integrative review. *BMC Palliative Care*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01543-y>
- Seckin, M., Tiwana, R., Fry, D., & Bailey, C. (2025). Key themes and approaches in palliative and end-of-life care education for the general public: a systematic review. *BMC Palliative Care*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12904-025-01852-w>
- Seiler, A., Amann, M., Hertler, C., Christ, S. M., Schettler, M., Kaeppli, B. M., Jung-Amstutz, J., Nigg, C., Pestalozzi, B. C., Imesch, P., Dummer, R., Blum, D., & Jenewein, J. (2024). Effects of dignity therapy on psychological *distress* and wellbeing of palliative care patients and family *caregivers* – a randomized controlled study. *BMC Palliative Care*, 23(1), 1–15.

<https://doi.org/10.1186/s12904-024-01408-4>

- Serra, S., Spampinato, M. D., Riccardi, A., Guarino, M., Fabbri, A., Orsi, L., & De Iaco, F. (2023). Pain Management at the End of Life in the Emergency Department: A Narrative Review of the Literature and a Practical Clinical Approach. *Journal of Clinical Medicine*, 12(13), 1–33. <https://doi.org/10.3390/jcm12134357>
- Shi, Z., Du, M., Zhu, S., Lei, Y., Xu, Q., Li, W., Gu, W., Zhao, N., Chen, Y., Liu, W., Wang, H., & Jiang, Y. (2025). Factors influencing accessibility of palliative care: a systematic review and meta-analysis. *BMC Palliative Care*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12904-025-01704-7>
- Soeda, R., Ishikawa, A., Oyamada, S., Mitsuhashi, M., Okano, S., Yokosawa, A., Okutsu, T., & Tsuji, T. (2024). Trajectories of Activities of Daily Living in the Last Eight Weeks of Life Among Patients With Terminal Cancer in a Palliative Care Unit: A Retrospective Study. *Palliative Medicine Reports*, 5(1), 63–69. <https://doi.org/10.1089/pmr.2023.0043>
- Stadnyk, A., Casimiro, H. J., & Reis-Pina, P. (2024). Mindfulness on Symptom Control and Quality of Life in Patients in Palliative Care: A Systematic Review. *American Journal of Hospice and Palliative Medicine*, 41(6), 706–714. <https://doi.org/10.1177/10499091231190879>
- Stevenson-Baker, S. (2023). Promoting person-centred care at the end of life. *Nursing Standard (Royal College of Nursing (Great Britain): 1987)*, 38(11), 76–82. <https://doi.org/10.7748/ns.2023.e12171>
- Stroebe, M., Schut, H., & Boerner, K. (2017). Cautioning Health-Care Professionals: Bereaved Persons Are Misguided Through the Stages of Grief. *Omega (United States)*, 74(4), 455–473. <https://doi.org/10.1177/0030222817691870>
- Suresh, A., T S, G., & Jaya, S. (2025). Factors influencing *caregiver* burden and its prevalence level amongst family *caregivers* of patients with palliative care needs and serious illnesses. *BMC Palliative Care*, 24(1), 4–11. <https://doi.org/10.1186/s12904-025-01925-w>
- Tan-Ho, G., Choo, P. Y., Patinadan, P. V., Low, C. X., & Ho, A. H. Y. (2020). Blessings or burdens: An Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) study on the motivations and their impact on end-of-life caregiving among Asian family *caregivers*. *BMC Palliative Care*, 19(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12904-020-00638-6>
- Tan, L., Sheri, S., Goh, Y. Y., Fong, R., Govindasamy, R., Ong, Y. T., Abdul Hamid, N. A. B., Low, T. L. X., & Krishna, L. K. R. (2025). Experiences of healthcare professionals providing palliative care in home settings - a scoping review. *BMC Palliative Care*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12904-025-01728-z>
- Tyrrell, P., Harberger, S., & Siddiqui, W. (2026). *Kubler-Ross Stages of Dying and*

Subsequent Models of Grief(Archived).

- Urbano Chamorro, I. M., & Miangolarra Page, J. C. (2025). Health-related quality of life in palliative care: determinants identified in a hospital-based observational study. *BMC Palliative Care*, 1, 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12904-025-01974-1>
- Ven, S., Fulbrook, P., Burston, A., Lovegrove, J., & Miles, S. J. (2025). Pressure injury risk assessment for palliative care patients in the acute hospital setting: a scoping review. *BMC Palliative Care*, 24(1), 212. <https://doi.org/10.1186/s12904-025-01842-y>
- Villanueva-Quispe, A., Rivarola-Hidalgo, M., Fuentes-Yufra, A., Ale-Sánchez, M., Copaja-Corzo, C., Flores-Cohaila, J. A., & Miranda-Chavez, B. (2025). Need for palliative care in patients with chronic diseases in a hospital in a developing country. *Palliative Care and Social Practice*, 19. <https://doi.org/10.1177/26323524251404072>
- Wang, C., Bi, S., Lu, Y., Li, Y., Han, B., Xu, M., Meng, G., & Zhou, Q. (2024). Availability and stability of palliative care for family members of terminally ill patients in an integrated model of health and social care. *BMC Palliative Care*, 23(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01475-7>
- Wantonoro, W., Suryaningsih, E. K., Anita, D. C., & Nguyen, T. Van. (2022). Palliative Care: A Concept Analysis Review. *SAGE Open Nursing*, 8(63). <https://doi.org/10.1177/23779608221117379>
- Webb, L., Yarwood, G., Witham, G., Wright, S., & Galvani, S. (2024). Providing holistic end-of-life care for people with a history of problem substance use: a mixed methods cohort study of interdisciplinary service provision and integrated care. *BMC Palliative Care*, 23(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01416-4>
- WHO. (2020). *Palliative Care*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>.
- Wiffen, P. J., Wee, B., Derry, S., Bell, R. F., & Moore, R. A. (2017). Opioids for cancer pain - an overview of Cochrane reviews. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2017(3). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012592>
- Wu, H., Dong, P., Chai, Y., Huang, P., & Huang, H. (2025). Psychological distress interventions for family members in palliative care: a scoping review. *BMC Palliative Care*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12904-025-01873-5>
- Xiao, J., Brenneis, C., Ibrahim, N., Bryan, A., & Fassbender, K. (2021). Definitions of Palliative Care Terms: A Consensus-Oriented Decision-Making Process. *Journal of Palliative Medicine*, 24(9), 1342–1350. <https://doi.org/10.1089/jpm.2020.0679>
- Yanez, R. J. V., de Freitas Corpes, E., Sixsmith, J., Fernandes, A. F. C., de Souza Aquino,

- P., Castro, R. C. M. B., & Jorge, H. M. F. (2025). Use of dignity therapy in palliative care: a comprehensive scoping review. *BMC Palliative Care*, 24(1), 1–27. <https://doi.org/10.1186/s12904-025-01812-4>
- Yang, Y., Zhao, X., Cui, M., & Wang, Y. (2023). Dimensions of *spiritual* well-being in relation to physical and psychological symptoms: a cross-sectional study of advanced cancer patients admitted to a palliative care unit. *BMC Palliative Care*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12904-023-01261-x>

BAB 4

DUKUNGAN KELUARGA, DAN BEREAVEMENT CARE

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dan filosofi keperawatan paliatif, pendekatan holistik, serta prinsip kualitas hidup dan patient-centered care.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu melakukan penilaian paliatif komprehensif (fisik, psikologis, sosial, spiritual) dan mengidentifikasi kebutuhan prioritas secara sistematis.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merancang dan melaksanakan manajemen gejala utama (nyeri, sesak, GI, kelelahan, psikologis) secara aman dan terukur.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan komunikasi paliatif (kabar sulit, perencanaan perawatan/ACP) serta kolaborasi interprofesional dan advokasi pasien–keluarga.	CPMK-3; CPMK-6
CPL-5	Menunjukkan profesionalisme, sensitivitas budaya, dan dukungan spiritual dalam asuhan paliatif termasuk akhir hayat.	CPMK-6; CPMK-1; CPMK-7
CPL-6	Mampu mengevaluasi luaran paliatif, melakukan dokumentasi, discharge/home care planning, serta dukungan dan bereavement berbasis kebutuhan.	CPMK-7; CPMK-6; CPMK-5

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan paliatif, filosofi perawatan, prinsip kualitas hidup, dan ruang lingkup layanan paliatif.
CPMK-2	Melakukan identifikasi kebutuhan paliatif dan penilaian komprehensif (fisik–psikologis–sosial–spiritual) serta menetapkan prioritas kebutuhan.
CPMK-3	Menerapkan komunikasi paliatif (kabar sulit, perencanaan perawatan/ACP) dan pengambilan keputusan bersama pasien–keluarga secara etis.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan manajemen nyeri dan gejala utama paliatif berbasis bukti, termasuk monitoring efektivitas dan efek samping.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan akhir hayat dan dukungan keluarga (termasuk bereavement care) dengan fokus kenyamanan dan keselamatan.
CPMK-6	Menginisiasi kolaborasi interprofesional, dukungan spiritual-budaya, serta advokasi dan koordinasi layanan (home care/rujukan).
CPMK-7	Mengevaluasi luaran paliatif, menyusun dokumentasi dan rencana tindak lanjut, serta refleksi perbaikan mutu layanan berbasis indikator.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 13. Dukungan Keluarga, dan Bereavement Care	13.1 Menilai beban dan kebutuhan dukungan keluarga secara terstruktur.	13.2 Melaksanakan intervensi dukungan keluarga dan rencana bereavement care dengan indikator tindak lanjut.	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-7

Uraian Materi

Konsep dukungan keluarga, peran, dan prinsip bereavement care dalam konteks keperawatan paliatif berbasis Family-Centered Nursing (FCN).

Aktivitas Belajar (Scaffolding)

Dukungan keluarga, peran, dan bereavement care merupakan komponen utama dalam keperawatan paliatif yang menempatkan pasien dan keluarga sebagai satu kesatuan unit asuhan. Menurut World Health Organization, perawatan paliatif bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga melalui pengurangan penderitaan secara komprehensif. Oleh karena itu, pemahaman konsep ini dalam kerangka Family-Centered Nursing penting agar mahasiswa mampu memberikan asuhan yang holistik, dan berbasis bukti.

A. Konsep Dukungan Keluarga

1. Dukungan Keluarga dalam Keperawatan Paliatif Berbasis

Family Centered Nursing

Keperawatan paliatif menempatkan pasien dan keluarga sebagai satu kesatuan unit perawatan (*unit of care*). Pendekatan ini sejalan dengan definisi dari WHO yang menegaskan bahwa perawatan paliatif bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya melalui pencegahan serta pengurangan penderitaan secara komprehensif (*World Health Organization, 2023*). Dalam konteks ini, keluarga bukan sekadar sistem pendukung, melainkan bagian integral dari proses pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan.

Pendekatan *Family Centered Nursing* (FCN) berakar pada teori sistem keluarga yang memandang keluarga sebagai sistem terbuka dan dinamis, di mana perubahan pada satu anggota akan memengaruhi seluruh sistem keluarga (Wright & Leahey, 2021). Perspektif ini diperkuat oleh Friedman, Bowden, dan Jones (2019) yang menyatakan bahwa keluarga memiliki struktur, fungsi, dan proses interaksi yang memengaruhi status kesehatan anggotanya. Struktur keluarga meliputi komposisi dan pola hubungan, sedangkan fungsi keluarga mencakup fungsi afektif, sosialisasi, reproduksi, ekonomi, dan perawatan kesehatan. Dalam konteks paliatif, fungsi perawatan kesehatan (*health care function*) menjadi dominan karena keluarga berperan langsung dalam pengambilan keputusan, perawatan sehari-hari, serta dukungan emosional.

Maglaya (2009) dalam kerangka keperawatan keluarga menekankan pentingnya pengkajian keluarga secara komprehensif yang mencakup karakteristik demografis, tahap perkembangan keluarga, lingkungan sosial, serta mekanisme koping dan dukungan sosial. Pada situasi paliatif, tahap

perkembangan keluarga dapat mengalami gangguan atau krisis situasional akibat penyakit terminal, sehingga perawat perlu membantu keluarga beradaptasi terhadap perubahan peran dan potensi kehilangan. Sementara itu, menurut Allender, Rector, dan Warner (2022), pendekatan keperawatan komunitas dan keluarga harus menekankan pemberdayaan (*empowerment*), peningkatan kapasitas keluarga, serta kemitraan aktif antara perawat dan keluarga dalam pengambilan keputusan kesehatan.

Pedoman dari *National Consensus Project for Quality Palliative Care* menegaskan bahwa dukungan terhadap keluarga harus dilakukan secara berkelanjutan sejak fase diagnosis hingga pascakematian sebagai bagian dari standar mutu pelayanan paliatif (*National Consensus Project for Quality Palliative Care* [NCP], 2021). Oleh karena itu, pengkajian keluarga secara komprehensif, yang meliputi struktur, fungsi, pola komunikasi, coping, nilai budaya, dan sumber daya menjadi komponen esensial dalam praktik FCN pada keperawatan paliatif.

Salah satu klasifikasi yang paling banyak dirujuk dalam literatur keperawatan dikemukakan oleh House (1981), yang membedakan dukungan keluarga ke dalam empat kategori utama: dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasional, dan dukungan penilaian (*appraisal support*). Klasifikasi ini telah diadopsi secara luas dalam penelitian keperawatan karena sifatnya yang komprehensif dan aplikatif. Berikut penjelasan dan contoh pengaplikasian setiap komponen dukungan keluarga dalam praktik keperawatan pasien paliatif :

a. Dukungan Emosional (*Emotional Support*)

Dukungan emosional mengacu pada pemberian empatik, rasa percaya, perhatian, rasa aman, dan rasa dimiliki oleh anggota keluarga kepada individu yang sakit. Thirsk et al. (2021), dalam penelitian taksonomi tentang dukungan keluarga di perawatan kritis, mengidentifikasi bahwa dukungan emosional merupakan komponen fundamental yang memengaruhi kemampuan pasien dalam mengatasi stres akibat penyakit.

Tabel 4.1 Contoh dalam Praktik Keperawatan:

Tatanan Praktik	Contoh Dukungan Emosional	Implikasi Keperawatan
<i>Palliatif Care</i>	Anak yang memeluk dan menemani orang tuanya yang menjalani perawatan kanker stadium lanjut serta memberikan kata-kata penguatan	Perawat menciptakan lingkungan yang mendukung ekspresi afeksi dan kedekatan emosional antara pasien dan keluarga

Tatanan Praktik	Contoh Dukungan Emosional	Implikasi Keperawatan
Keluarga dan Komunitas	- Pasangan yang mendampingi pasien kanker saat menjalani kemoterapi dan mendengarkan keluhan efek samping dengan penuh empatik - Anggota keluarga atau tetangga yang memberikan semangat dan dukungan moral kepada pasien kanker selama proses pengobatan	- Perawat memfasilitasi komunikasi terbuka antara pasien dan keluarga terkait pengalaman penyakit - Perawat memberdayakan dukungan sosial di lingkungan keluarga dan komunitas untuk memperkuat coping pasien

b. Dukungan Instrumental (*Instrumental Support*)

Dukungan instrumental mencakup bantuan langsung dalam bentuk materi, sumber daya, atau pelayanan fisik, seperti membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, bantuan finansial, atau bantuan dalam perawatan langsung. Penelitian Rekawati (2014) dalam disertasinya tentang model keperawatan keluarga santun lansia menunjukkan bahwa dukungan instrumental merupakan salah satu variabel dominan yang mempengaruhi kualitas perawatan lansia di rumah.

Tabel 4.2 Contoh dalam Praktik Keperawatan:

Tatanan Praktik	Contoh Dukungan Instrumental	Implikasi Keperawatan
<i>Palliatif Care</i>	Keluarga yang membantu pasien kanker dalam aktivitas sehari-hari seperti memandikan, membantu makan, dan mengatur posisi untuk mengurangi nyeri	Perawat melatih keluarga teknik perawatan dasar, mobilisasi aman, serta manajemen kenyamanan pasien
Keluarga dan Komunitas	- Anggota keluarga yang menyiapkan makanan sesuai kebutuhan nutrisi pasien kanker selama kemoterapi - Keluarga yang mengantar dan mendampingi pasien	- Perawat memberikan edukasi terkait kebutuhan nutrisi dan perawatan pasien kanker - Perawat membantu koordinasi perawatan, termasuk jadwal terapi

Tatanan Praktik	Contoh Dukungan Instrumental	Implikasi Keperawatan
	kanker saat kontrol atau menjalani terapi di fasilitas kesehatan	dan akses layanan kesehatan

c. Dukungan Informasional (*Informational Support*)

Dukungan informasional diberikan dalam bentuk pemberian nasihat, arahan, saran, atau umpan balik yang membantu individu dalam memahami kondisi kesehatannya dan mengambil keputusan yang tepat. Thirsk et al. (2021) menekankan bahwa keluarga sering berperan sebagai "jembatan informasi" antara pasien dan sistem pelayanan kesehatan, terutama dalam situasi di mana pasien mengalami keterbatasan kognitif atau kecemasan yang mengganggu pemahaman informasi medis.

Tabel 4.3 Contoh dalam Praktik Keperawatan:

Tatanan Praktik	Contoh Dukungan Informasional	Implikasi Keperawatan
<i>Palliatif Care</i>	Keluarga yang mencari informasi tentang perawatan luka kanker, manajemen nyeri, atau efek samping terapi, kemudian menyampaikannya kepada anggota keluarga lain	Perawat memverifikasi akurasi informasi, meluruskan miskonsepsi, serta melengkapi dengan pendekatan evidence-based nursing (EBN)
Keluarga dan Komunitas	- Anggota keluarga yang menjelaskan kembali kepada pasien kanker mengenai jadwal kemoterapi dan cara mengelola efek samping di rumah - Kader kesehatan yang memberikan edukasi kepada keluarga tentang tanda bahaya pada pasien kanker, seperti infeksi atau penurunan kondisi	- Perawat menyediakan materi edukasi yang mudah dipahami terkait perawatan pasien kanker di rumah - Perawat melatih keluarga dan kader sebagai perpanjangan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan pengambilan keputusan

d. Dukungan Penilaian (*Appraisal Support*)

Dukungan penilaian mencakup pemberian umpan balik evaluatif, afirmasi, dan perbandingan sosial yang membantu individu dalam menilai situasi dan

kemampuannya secara realistis. Dukungan ini penting dalam proses adaptasi terhadap penyakit kronis dan perubahan peran akibat sakit.

Tabel 4.4 Contoh dalam Praktik Keperawatan:

Tatanan Praktik	Contoh Dukungan Penilaian	Implikasi Keperawatan
<i>Palliatif Care</i>	Pasangan atau anggota keluarga yang memberikan afirmasi bahwa pasien kanker telah berjuang dengan baik dalam menjalani pengobatan dan perawatan di rumah	Perawat memvalidasi persepsi positif keluarga, memperkuat coping adaptif, serta memberikan klarifikasi bila terdapat penilaian yang kurang tepat
Keluarga dan Komunitas	- Anggota keluarga yang mengapresiasi kemampuan pasien kanker dalam mengelola efek samping terapi secara mandiri - Kelompok dukungan (support group) pasien kanker yang saling berbagi pengalaman dan memberikan umpan balik positif terkait proses pengobatan	- Perawat mendorong pemberian penguatan positif dalam keluarga untuk meningkatkan kepercayaan diri pasien - Perawat memfasilitasi kelompok sebaya sebagai sumber appraisal support dan adaptasi psikososial

2. Tahapan Proses Keperawatan Pelibatan Keluarga Dalam Dukungan Keluarga Paliatif Care

Pelibatan keluarga dalam program perawatan pasien paliatif merupakan implementasi esensial dari pendekatan *family-centered nursing* yang menempatkan keluarga sebagai unit perawatan bersama pasien. Secara konseptual, keperawatan paliatif tidak hanya berfokus pada pengendalian gejala pasien, tetapi juga pada dukungan psikososial keluarga, termasuk dalam menghadapi perubahan peran, beban *caregiver*, dan proses adaptasi terhadap penyakit kronis hingga fase akhir kehidupan (Ferrell et al., 2020; World Health Organization, 2023). Dalam kerangka proses keperawatan, pelibatan keluarga dimulai sejak tahap pengkajian dengan mengidentifikasi kesiapan, kemampuan, serta kebutuhan keluarga dalam memberikan perawatan, termasuk aspek coping,

komunikasi, dan dukungan sosial. Data ini menjadi dasar dalam penetapan diagnosis keperawatan berbasis standar NANDA International (2020) dan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), seperti manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, gangguan proses keluarga, serta ketegangan peran pemberi asuhan.

Selanjutnya, pada tahap perencanaan, perawat merumuskan intervensi yang berorientasi pada peningkatan kapasitas keluarga melalui edukasi, dukungan emosional, dan fasilitasi pengambilan keputusan, dengan mengacu pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) dan luaran yang terukur melalui Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) (PPNI, 2020). Intervensi ini mencakup penguatan coping keluarga, peningkatan peran caregiver, serta perbaikan proses keluarga dalam merawat pasien paliatif. Pada tahap implementasi, tindakan keperawatan dilakukan melalui komunikasi terapeutik, pemberian informasi terkait kondisi pasien, fasilitasi keterlibatan keluarga dalam perawatan langsung, serta dukungan dalam perawatan di rumah (home care) dan pengambilan keputusan klinis secara kolaboratif (Hudson et al., 2018). Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien sekaligus mengurangi beban *caregiver*.

Tahap evaluasi dilakukan dengan menilai perubahan pada luaran keperawatan keluarga, seperti peningkatan coping, efektivitas peran *caregiver*, dan kualitas interaksi keluarga dalam mendukung pasien, serta kemampuan keluarga dalam menghadapi proses berduka (bereavement) secara adaptif (Kent et al., 2021). Dengan demikian, integrasi pelibatan keluarga dalam proses keperawatan paliatif berbasis *family-centered nursing* merupakan strategi berbasis bukti yang tidak hanya meningkatkan kualitas asuhan pasien, tetapi juga memperkuat ketahanan psikososial keluarga secara berkelanjutan, sehingga pelayanan keperawatan menjadi lebih holistik, humanistik, dan berorientasi pada mutu.

Berikut tahapan prosedur pelibatan keluarga dalam perawatan pasien paliatif berbasis *family-centered nursing* yang disusun secara sistematis dalam bentuk tabel sesuai prinsip praktik keperawatan dan standar Persatuan Perawat Nasional Indonesia:

Tabel 4.5. Prosedur Pelibatan Keluarga Dalam Proses Perawatan

No	Tahapan Prosedur	Tindakan Keperawatan
1	Identifikasi Pasien	Mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis)

No	Tahapan Prosedur	Tindakan Keperawatan
2	Orientasi	Menjelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur kepada pasien dan keluarga
3	Persiapan	Melakukan kebersihan tangan 6 langkah sesuai standar keselamatan pasien
4	Validasi Kesiapan Keluarga	Mengidentifikasi kesiapan, kemampuan, dan kebutuhan keluarga untuk terlibat dalam perawatan
5	Hubungan Terapeutik	Membangun hubungan terapeutik antara perawat, pasien, dan keluarga
6	Edukasi Perawatan	Mendiskusikan rencana dan cara perawatan di rumah (home care atau rumah singgah)
7	Dukungan Psikologis	Memotivasi keluarga untuk mengembangkan aspek positif dalam rencana perawatan
8	Pengambilan Keputusan	Memfasilitasi keluarga dalam membuat keputusan terkait perawatan pasien
9	Informasi Kondisi Pasien	Menjelaskan kondisi kesehatan pasien secara jujur, jelas, dan <i>empatik</i>
10	Informasi Tingkat Ketergantungan	Menginformasikan tingkat ketergantungan pasien kepada keluarga
11	Eksplorasi Harapan	Mengidentifikasi dan menyampaikan harapan pasien kepada keluarga
12	Penguatan Komunikasi	Menganjurkan keluarga untuk bersikap asertif dalam proses perawatan
13	Pelibatan Aktif	Mendorong dan melibatkan keluarga secara aktif dalam perawatan pasien
14	Terminasi	Melakukan kebersihan tangan kembali setelah tindakan
15	Dokumentasi	Mendokumentasikan seluruh tindakan dan <i>respons</i> pasien serta keluarga secara lengkap dan akurat

Tabel ini mencerminkan integrasi aspek edukasi, terapeutik, dan kolaboratif dalam pelibatan keluarga, yang bertujuan meningkatkan kualitas asuhan paliatif serta memperkuat peran keluarga sebagai *caregiver* utama dalam perawatan berkelanjutan.

B. Konsep Caregiver

1. Peran dan Dinamika *Caregiver* dalam Perawatan Paliatif

Dalam konteks penyakit kronis progresif atau terminal, anggota keluarga sering mengambil peran sebagai *caregiver* informal yang memberikan perawatan langsung di rumah. Peran ini meliputi manajemen gejala, pemberian obat, bantuan aktivitas sehari-hari, dukungan emosional, serta koordinasi layanan kesehatan (Ferrell et al., 2020). Keterlibatan aktif keluarga dalam perawatan terbukti meningkatkan kenyamanan pasien dan mengurangi angka rawat ulang apabila didukung oleh edukasi yang memadai.

Friedman et al. (2019) menegaskan bahwa perubahan status kesehatan salah satu anggota keluarga dapat menyebabkan pergeseran peran (*role reallocation*) dalam sistem keluarga. Dalam situasi paliatif, pergeseran ini sering kali menempatkan satu anggota keluarga sebagai *primary caregiver*, yang berpotensi mengalami konflik peran dan kelelahan. Konsep ini selaras dengan temuan Kent et al. (2021) yang menjelaskan bahwa *caregiver burden* merupakan beban multidimensional yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.

Maglaya (2009) menambahkan bahwa kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi perawatan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sumber daya, dan dukungan eksternal yang tersedia. Oleh karena itu, dalam pendekatan FCN, perawat perlu melakukan pengkajian sistematis terhadap kesiapan *caregiver*, kapasitas koping, serta kebutuhan edukasi. Intervensi yang direkomendasikan meliputi pendidikan kesehatan, pelatihan keterampilan perawatan di rumah, dukungan emosional, serta fasilitasi akses terhadap layanan komunitas (Allender et al., 2022; NCP, 2021). Dengan demikian, penguatan kapasitas *caregiver* merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga. Berdasarkan analisis konsep Liu et al. (2020), beban *caregiver* terdiri atas lima dimensi yang harus diases secara terpisah:

Tabel 4.6 Dimensi Beban *Caregiver*

Dimensi	Definisi	Indikator Klinis
1. Fisik	Gangguan kesehatan fisik yang dialami <i>caregiver</i> akibat tuntutan perawatan	Kelelahan kronis, gangguan tidur, nyeri punggung, penurunan berat badan, hipertensi
2. Psikologis	Beban emosional dan mental yang dirasakan <i>caregiver</i>	Depresi, kecemasan, perasaan terjebak, mudah marah, kesedihan berkepanjangan
3. Sosial	Gangguan pada kehidupan sosial dan hubungan interpersonal	Isolasi sosial, berkurangnya waktu bersama teman/keluarga lain, konflik peran
4. Finansial	Beban ekonomi akibat biaya perawatan dan kehilangan pendapatan	Pengeluaran meningkat, pendapatan menurun, utang, ketidakmampuan menabung
5. Peran	Konflik antara peran sebagai <i>caregiver</i> dengan peran lain dalam hidup	Tidak dapat bekerja, mengabaikan anak/pasangan, kehilangan identitas diri

2. Dukungan Emosional dan Dukungan Pengambilan Keputusan *Caregiver* dalam Perawatan Paliatif

Asesmen beban *caregiver* yang terstruktur merupakan fondasi penting dalam memberikan intervensi keperawatan yang tepat sasaran. Berikut adalah 5 langkah asesmen beban *caregiver* terstruktur yang mengintegrasikan identifikasi *caregiver*, penilaian tugas perawatan, pengukuran beban menggunakan instrumen baku, identifikasi kebutuhan dukungan, serta pemetaan sumber daya yang tersedia (Braine & Wray, 2016; Liu et al., 2020).

a. Identifikasi *Caregiver*

Perawat perlu mengidentifikasi secara jelas siapa *caregiver* utama, berapa lama telah menjalani peran tersebut, intensitas waktu perawatan (jam/hari atau hari/minggu), serta keberadaan *caregiver* pendamping. Informasi ini penting karena durasi dan intensitas caregiving berkorelasi positif dengan tingkat beban yang dirasakan (Liu et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa

caregiver yang merawat lebih dari 40 jam/minggu memiliki risiko depresi dua kali lipat.

b. Kaji Tugas *Caregiver*

Perawat perlu memahami secara spesifik berbagai tugas yang dilakukan oleh *caregiver* dalam kehidupan sehari-hari, karena kompleksitas tugas tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat beban yang dirasakan. Tugas *caregiver* dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu aktivitas dasar sehari-hari (*Activities of Daily Living/ADL*) seperti membantu mandi, makan, toileting, dan berpindah tempat; aktivitas instrumental (*Instrumental Activities of Daily Living/IADL*) yang meliputi kegiatan memasak, mengantar pasien berobat, serta mengelola administrasi dan pemberian obat; perawatan medis khusus seperti melakukan injeksi, perawatan luka, dan manajemen penggunaan alat medis; serta dukungan emosional berupa pengawasan, pemberian semangat, dan pendampingan pasien. Semakin beragam dan kompleks tugas yang harus dilakukan, maka semakin tinggi pula potensi beban fisik, psikologis, dan emosional yang dialami oleh *caregiver*, sehingga penting bagi perawat untuk melakukan pengkajian yang komprehensif terhadap peran dan kebutuhan *caregiver* dalam proses asuhan keperawatan (Braine & Wray, 2016).

c. Kaji beban *Caregiver*

Perawat mengukur tingkat beban *caregiver* secara kuantitatif dengan menggunakan instrumen yang telah tervalidasi untuk memastikan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Salah satu instrumen yang sering digunakan adalah Zarit Burden Interview (ZBI), yang terdiri dari 22 item dengan rentang skor 0–88, di mana skor 0–20 menunjukkan beban ringan, 21–40 menunjukkan beban sedang, 41–60 menunjukkan beban berat, dan skor di atas 60 menunjukkan beban sangat berat. Selain itu, Caregiver Strain Index (CSI) juga digunakan sebagai alat ukur yang terdiri dari 13 item dengan jawaban ya atau tidak, di mana skor ≥ 7 mengindikasikan adanya *strain* atau tekanan yang signifikan pada *caregiver*. Penggunaan instrumen baku ini memungkinkan perawat untuk melakukan penilaian secara objektif, mendeteksi secara dini tingkat beban yang dialami *caregiver*, serta mengevaluasi efektivitas intervensi keperawatan melalui pengukuran yang dilakukan secara berulang. Berikut adalah instrument pengkajian yang dapat digunakan untuk mengukur beban *caregiver*.

Tabel 4.6 Dimensi Beban *Caregiver*

No	Pernyataan (ZBI)
1	Apakah Anda merasa bahwa anggota keluarga Anda meminta lebih banyak bantuan daripada yang dibutuhkannya?
2	Apakah Anda merasa terbebani karena waktu yang Anda habiskan bersama anggota keluarga Anda tidak cukup untuk diri Anda sendiri?
3	Apakah Anda merasa stres antara merawat anggota keluarga Anda dan memenuhi tanggung jawab lain (pekerjaan/keluarga)?
4	Apakah Anda merasa malu terhadap perilaku anggota keluarga Anda?
5	Apakah Anda merasa marah ketika berada di sekitar anggota keluarga Anda?
6	Apakah Anda merasa bahwa anggota keluarga Anda secara negatif memengaruhi hubungan Anda dengan anggota keluarga atau teman lain?
7	Apakah Anda merasa takut akan masa depan anggota keluarga Anda?
8	Apakah Anda merasa bahwa anggota keluarga Anda bergantung pada Anda?
9	Apakah Anda merasa tegang ketika berada di sekitar anggota keluarga Anda?
10	Apakah Anda merasa kesehatan Anda terganggu karena keterlibatan Anda dalam merawat anggota keluarga Anda?
11	Apakah Anda merasa tidak memiliki cukup privasi karena anggota keluarga Anda?
12	Apakah Anda merasa kehidupan sosial Anda terganggu karena Anda merawat anggota keluarga Anda?
13	Apakah Anda merasa tidak nyaman mengundang teman ke rumah karena anggota keluarga Anda?
14	Apakah Anda merasa bahwa anggota keluarga Anda mengharapkan Anda untuk merawatnya seolah-olah Anda adalah satu-satunya orang yang dapat diandalkan?
15	Apakah Anda merasa tidak memiliki cukup uang untuk merawat anggota keluarga Anda selain untuk kebutuhan lainnya?
16	Apakah Anda merasa tidak mampu lagi merawat anggota keluarga Anda dalam waktu yang lebih lama?
17	Apakah Anda merasa kehilangan kendali atas hidup Anda sejak anggota keluarga Anda sakit?

No	Pernyataan (ZBI)
18	Apakah Anda ingin menyerahkan perawatan anggota keluarga Anda kepada orang lain?
19	Apakah Anda merasa ragu atau tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan terhadap anggota keluarga Anda?
20	Apakah Anda merasa seharusnya Anda melakukan lebih banyak untuk anggota keluarga Anda?
21	Apakah Anda merasa bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam merawat anggota keluarga Anda?
22	Secara keseluruhan, seberapa terbebani Anda dalam merawat anggota keluarga Anda?

Sumber : Seng et al, 2010)

Pengukuran beban *caregiver* juga dapat dihitung dengan menggunakan alat ukur berikut, yaitu Modified Caregiver Strain Index (MCSI) dalam Bahasa Indonesia yang disusun kembali dalam bentuk tabel penilaian:

Petunjuk:

Berikut adalah daftar hal-hal yang sering dianggap sulit oleh *caregiver*. Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan kondisi Anda.

- Ya, secara rutin = 2
- Ya, kadang-kadang = 1
- Tidak = 0

No	Pernyataan	Ya, Rutin (2)	Ya, Kadang (1)	Tidak (0)
1	Tidur saya terganggu (misalnya pasien sering bangun malam atau gelisah)	☐	☐	☐
2	Merawat pasien terasa tidak praktis/menyulitkan (misalnya membutuhkan waktu lama atau perjalanan jauh)	☐	☐	☐
3	Merawat pasien menyebabkan kelelahan fisik (misalnya mengangkat, memindahkan, membutuhkan tenaga ekstra)	☐	☐	☐
4	Peran merawat membatasi kebebasan saya (misalnya tidak bisa bepergian atau bersosialisasi)	☐	☐	☐

No	Pernyataan	Ya, Rutin (2)	Ya, Kadang (1)	Tidak (0)
5	Terjadi perubahan dalam keluarga (misalnya rutinitas terganggu, kurang privasi)	☐	☐	☐
6	Terjadi perubahan dalam rencana pribadi (misalnya membatalkan pekerjaan atau liburan)	☐	☐	☐
7	Ada tuntutan lain terhadap waktu saya (misalnya dari anggota keluarga lain)	☐	☐	☐
8	Terjadi penyesuaian emosional (misalnya konflik atau stres emosional)	☐	☐	☐
9	Perilaku pasien terkadang mengganggu (misalnya mudah lupa atau menuduh orang lain)	☐	☐	☐
10	Perubahan kondisi pasien membuat saya merasa kehilangan sosok sebelumnya	☐	☐	☐
11	Terjadi penyesuaian dalam pekerjaan (misalnya mengurangi jam kerja atau izin)	☐	☐	☐
12	Merawat pasien menimbulkan beban finansial	☐	☐	☐
13	Saya merasa sangat kewalahan dalam merawat pasien	☐	☐	☐

HASIL SKOR :

Tabel 8. Pengukuran Beban *Caregiver*, Instrumen Pengkajian Modified Caregiver Strain Index (MCSI)
(Sumber : Seng et al, 2010)

d. Kaji Kebutuhan Dukungan

Berdasarkan hasil pengukuran beban dan kompleksitas tugas *caregiving*, perawat perlu mengidentifikasi kebutuhan dukungan *caregiver* secara komprehensif dan kolaboratif. Kebutuhan ini bersifat individual dan dinamis, sehingga harus dirumuskan bersama *caregiver* agar intervensi yang diberikan tepat sasaran. Secara umum, terdapat lima domain kebutuhan utama, yaitu kebutuhan informasi, pelatihan, emosional, sosial, dan spiritual. Kebutuhan informasi meliputi pemahaman tentang penyakit, prosedur perawatan, prognosis, serta tanda bahaya, misalnya, *caregiver* membutuhkan penjelasan

mengenai perjalanan penyakit kanker atau pilihan terapi yang tepat untuk penanganan kanker. Kebutuhan pelatihan berkaitan dengan keterampilan teknis, seperti cara memandikan pasien tirah baring, melakukan injeksi insulin, atau merawat luka dengan benar.

Selain itu, kebutuhan emosional mencakup dukungan psikologis untuk mengurangi stres, seperti melalui konseling atau kelompok dukungan (*support group*). Kebutuhan sosial meliputi bantuan dari keluarga dan kesempatan istirahat, misalnya pembagian tugas perawatan atau pemanfaatan layanan konseling keluarga. Sementara itu, kebutuhan spiritual berkaitan dengan dukungan sesuai keyakinan, seperti pendampingan rohani atau konsultasi dengan tokoh agama saat menghadapi kondisi kritis. Dengan mengkaji kelima aspek tersebut secara menyeluruh, perawat dapat merancang intervensi yang holistik, berfokus pada *caregiver*, serta meningkatkan kualitas hidup *caregiver* dan pasien.

e. Kaji Sumber Daya

Langkah terakhir dalam asesmen terstruktur adalah memetakan sumber daya yang tersedia bagi *caregiver*. Tahap ini sangat penting karena intervensi keperawatan harus bersifat realistis dan disesuaikan dengan kondisi nyata yang dimiliki *caregiver*, bukan hanya berdasarkan standar ideal. Asesmen sumber daya mencakup beberapa aspek utama, yaitu sumber daya internal, keluarga, komunitas, dan finansial, yang secara keseluruhan berperan dalam menentukan kemampuan *caregiver* dalam menjalankan perannya.

Sumber daya internal meliputi kapasitas psikologis dan kognitif *caregiver*, seperti strategi koping yang digunakan, keyakinan, nilai-nilai, serta motivasi dalam merawat. Misalnya, *caregiver* yang mampu menggunakan strategi koping adaptif seperti pemecahan masalah dan memiliki keyakinan spiritual yang kuat cenderung lebih resilien dalam menghadapi stres dibandingkan dengan *caregiver* yang menggunakan koping maladaptif seperti menghindar. Sumber daya keluarga berkaitan dengan dukungan dari anggota keluarga lain, baik berupa bantuan langsung dalam perawatan maupun dukungan emosional, serta perlu dikaji adanya konflik keluarga yang dapat menghambat pembagian peran. Sementara itu, sumber daya komunitas mencakup akses terhadap layanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu lansia, layanan *home care*, kelompok dukungan *caregiver*, serta program bantuan sosial dari pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Terakhir, sumber daya finansial meliputi kondisi ekonomi *caregiver*, seperti pendapatan, tabungan, kepemilikan asuransi kesehatan, dan akses terhadap bantuan atau subsidi, di mana keterbatasan finansial diketahui sebagai salah satu faktor yang paling

berpengaruh terhadap tingginya beban *caregiver* (Braine & Wray, 2016; Liu et al., 2020).

Proses keperawatan selanjutnya yaitu penentuan diagnosis dan intervensi keperawatan, pada tahap ini dapat dikaitkan dengan penerapan dukungan keluarga. Dukungan emosional dan dukungan pengambilan keputusan merupakan komponen esensial dalam perawatan paliatif berbasis *family-centered nursing* yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dan *caregiver* melalui pendekatan holistik terhadap aspek psikologis, spiritual, dan sosial. Dukungan emosional bertujuan memfasilitasi penerimaan kondisi selama masa stres dengan membantu pasien dan keluarga mengidentifikasi, mengekspresikan, serta mengelola *respons* emosional seperti kecemasan, marah, sedih, hingga berduka, yang sering muncul pada kondisi penyakit terminal (Ferrell et al., 2020). Intervensi ini relevan dengan berbagai diagnosis keperawatan seperti koping tidak efektif, spiritual *distress*, berduka, keputusasaan, dan penurunan koping keluarga, serta diarahkan untuk mencapai luaran berupa peningkatan status koping, keberdayaan meningkat, harapan meningkat, dan proses keluarga membaik. Dalam praktiknya, perawat berperan melalui komunikasi terapeutik, pemberian empatik, fasilitasi ekspresi emosi, serta dukungan langsung seperti kehadiran fisik dan sentuhan terapeutik, yang terbukti efektif dalam menurunkan *distress* psikologis dan meningkatkan kesejahteraan emosional pasien dan *caregiver* (Hudson et al., 2018).

Di sisi lain, dukungan pengambilan keputusan menjadi aspek krusial dalam membantu pasien dan *caregiver* menghadapi pilihan kompleks terkait terapi, perawatan lanjutan, maupun keputusan akhir hayat. Perawat berperan sebagai fasilitator dengan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan berbasis bukti, serta membantu klarifikasi nilai, preferensi, dan harapan pasien maupun keluarga, tanpa mengabaikan prinsip otonomi pasien (Elwyn et al., 2017). Intervensi ini berkaitan dengan diagnosis seperti gangguan proses keluarga, keletihan, ketidakmampuan koping keluarga, penyangkalan tidak efektif, ketegangan peran pemberi asuhan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan koping keluarga, perilaku kesehatan cenderung beresiko, dan manajemen kesehatan tidak efektif. Luarannya yang diharapkan dari intervensi ini berupa peningkatan keberdayaan, kepatuhan, komunikasi, manajemen kesehatan meningkat, perilaku kesehatan membaik, serta kualitas pengambilan keputusan. Prosedur dukungan ini meliputi identifikasi persepsi masalah, diskusi alternatif solusi, eksplorasi tujuan perawatan, serta penghormatan terhadap hak pasien dalam menerima atau menolak informasi.

Integrasi dukungan emosional dan pengambilan keputusan dalam perawatan paliatif tidak hanya meningkatkan kualitas asuhan pasien, tetapi juga memperkuat kapasitas *caregiver* dalam menghadapi beban perawatan dan proses adaptasi terhadap penyakit hingga fase akhir kehidupan. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi *World Health Organization* yang menekankan pentingnya dukungan komprehensif bagi pasien dan keluarga sebagai satu kesatuan dalam layanan paliatif (WHO, 2023). Dengan demikian, perawat memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa *caregiver* memperoleh dukungan emosional yang adekuat serta dilibatkan secara aktif dan bermakna dalam pengambilan keputusan.

Berikut tahapan prosedur dukungan emosional dan dukungan pengambilan keputusan pada *caregiver* dalam perawatan paliatif yang disusun secara sistematis dalam bentuk tabel sesuai standar praktik keperawatan dan prinsip *Family Centered Nursing* berdasarkan pedoman Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI):

Tabel 4.9. Prosedur Dukungan Emosional

No	Tahapan Prosedur	Tindakan Keperawatan
1	Identifikasi Pasien	Mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis)
2	Orientasi	Menjelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur kepada pasien dan keluarga
3	Persiapan	Melakukan kebersihan tangan 6 langkah
4	Pengkajian Emosi	Mengidentifikasi fungsi emosi seperti marah, frustrasi, dan amuk pada pasien
5	Identifikasi Pencetus	Mengidentifikasi faktor atau situasi yang memicu <i>respons</i> emosional
6	Fasilitasi Ekspresi	Memfasilitasi pasien mengungkapkan perasaan cemas, marah, atau sedih dapat menggunakan Emotional expression therapy untuk menurunkan kecemasan (Pennebaker, 2018)
7	Dukungan <i>Empatik</i>	Memberikan pernyataan suportif dan <i>empatik</i> terutama pada fase berduka. Perawat dapat menggunakan Teknik komunikasi empatik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien terminal, menurunkan <i>distress</i> psikologis, dan memberi kekuatan psikis pada keluarga (Back et al, 2019)

No	Tahapan Prosedur	Tindakan Keperawatan
8	Sentuhan Terapeutik	Memberikan sentuhan untuk meningkatkan rasa aman dan dukungan emosional
9	Keamanan	Tetap bersama pasien saat ansietas meningkat dan memastikan keselamatan
10	Reduksi Stres Kognitif	Mengurangi tuntutan berpikir saat pasien dalam kondisi lelah atau sakit. Perawat dapat menganjurkan <i>caregiver</i> untuk melakukan terapi relaksasi seperti tarik nafas dalam, mendengarkan musik, art terapi, dll.
11	Edukasi Emosi	Menjelaskan konsekuensi jika emosi seperti rasa bersalah dan malu tidak diatasi
12	Anjuran Ekspresi	Mendorong pasien mengungkapkan perasaan secara terbuka
13	Refleksi Pengalaman	Menganjurkan pasien mengidentifikasi pengalaman emosional sebelumnya dan <i>respons</i> yang digunakan
14	Koping Adaptif	Mengajarkan mekanisme koping yang adaptif dan sehat
15	Rujukan	Merujuk ke layanan konseling atau psikolog bila diperlukan
16	Terminasi	Melakukan kebersihan tangan 6 langkah setelah tindakan
17	Dokumentasi	Mendokumentasikan tindakan dan <i>respons</i> pasien secara lengkap

Dalam praktik keperawatan paliatif, shared decision-making (SDM) merupakan proses kolaboratif antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan untuk menentukan pilihan perawatan yang sesuai dengan nilai, preferensi, dan kondisi klinis pasien. Misalnya, pada pasien kanker stadium lanjut yang mengalami penurunan kondisi dan dihadapkan pada pilihan melanjutkan kemoterapi atau berfokus pada perawatan paliatif, perawat memfasilitasi proses pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami mengenai manfaat, risiko, serta dampak masing-masing pilihan terapi. Perawat dapat menyampaikan: *"Ada beberapa pilihan perawatan yang dapat dipertimbangkan. Kami ingin membantu Bapak/Ibu memahami setiap pilihan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang paling sesuai dengan"*

keinginan dan nilai yang dimiliki.” Pendekatan ini mencerminkan prinsip transparansi dan penghormatan terhadap otonomi pasien (Elwyn et al., 2017).

Selanjutnya, perawat melakukan eksplorasi nilai dan preferensi pasien serta keluarga dengan pertanyaan terbuka seperti: *“Apa yang paling penting bagi Bapak/Ibu dalam kondisi saat ini?”* atau *“Apa harapan yang ingin dicapai dari perawatan ini?”* Perawat juga memastikan bahwa *caregiver* terlibat secara aktif dalam diskusi, sekaligus memberikan dukungan emosional untuk mengurangi kecemasan dan konflik keputusan. Dalam proses ini, perawat berperan sebagai fasilitator yang membantu menyeimbangkan informasi klinis dengan nilai personal pasien, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama (*informed and shared choice*). Implementasi SDM terbukti meningkatkan kepuasan pasien, memperkuat hubungan terapeutik, serta mendukung kualitas hidup dalam perawatan paliatif (Stacey et al., 2017; World Health Organization, 2023).

Tabel 4.10 Prosedur Dukungan Pengambilan Keputusan

No	Tahapan Prosedur	Tindakan Keperawatan
1	Identifikasi Pasien	Mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas
2	Orientasi	Menjelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur
3	Persiapan	Melakukan kebersihan tangan 6 langkah
4	Pengkajian Persepsi	Mengidentifikasi persepsi pasien/keluarga terhadap masalah dan konflik yang dihadapi
5	Klarifikasi Nilai	Membantu pasien dan keluarga mengklarifikasi nilai, keyakinan, dan harapan
6	Analisis Alternatif	Mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan tindakan
7	Eksplorasi Tujuan	Memotivasi pasien dan keluarga mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan
8	Penghormatan Otonomi	Menghormati hak pasien dalam menerima atau menolak informasi
9	Edukasi Alternatif	Menjelaskan berbagai alternatif solusi secara jelas dan objektif
10	Pemberian Informasi	Memberikan informasi sesuai kebutuhan pasien dan keluarga
11	Terminasi	Melakukan kebersihan tangan 6 langkah setelah tindakan

No	Tahapan Prosedur	Tindakan Keperawatan
12	Dokumentasi	Mendokumentasikan seluruh proses dan <i>respons</i> pasien/keluarga

Kedua prosedur ini menekankan integrasi aspek psikologis, komunikasi terapeutik, dan pemberdayaan *caregiver*, yang berperan penting dalam meningkatkan coping, kualitas pengambilan keputusan, serta kualitas hidup pasien dan keluarga dalam perawatan paliatif.

Dalam praktik keperawatan paliatif, komunikasi empatik diterapkan melalui interaksi terapeutik yang berfokus pada pemahaman pengalaman pasien dan *caregiver* secara holistik. Misalnya, pada pasien kanker stadium lanjut yang mengalami nyeri kronis dan kecemasan, perawat memulai interaksi dengan teknik active listening dan memberikan *respons* reflektif: *"Saya memahami bahwa Ibu merasa sangat tidak nyaman dengan nyeri yang dirasakan, dan itu pasti membuat Ibu merasa cemas."* Pernyataan ini menunjukkan validasi terhadap perasaan pasien serta membantu membangun hubungan saling percaya. Selanjutnya, perawat memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengekspresikan emosi tanpa interupsi serta menggunakan komunikasi nonverbal seperti kontak mata dan sentuhan terapeutik untuk memperkuat dukungan emosional (Back et al., 2019; Halpern, 2020).

Pada *caregiver*, komunikasi empatik difokuskan pada pengakuan terhadap beban perawatan (*caregiver burden*) yang dialami. Perawat dapat menyampaikan: *"Bapak sudah melakukan yang terbaik dalam merawat Ibu, dan wajar jika merasa lelah atau kewalahan."* Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi perasaan bersalah serta meningkatkan coping *caregiver*. Selain itu, perawat memfasilitasi diskusi terkait pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang jelas dan sensitif terhadap kondisi emosional keluarga, serta memastikan bahwa nilai dan preferensi pasien tetap dihormati. Implementasi komunikasi empatik terbukti meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga, memperkuat hubungan terapeutik, serta mendukung kualitas hidup dalam perawatan paliatif (Ferrell et al., 2020; World Health Organization, 2023).

C. Bereavement Care

1. Konsep *Bereavement Care*

Bereavement care atau perawatan duka cita merupakan komponen esensial dalam pelayanan paliatif yang mencakup dukungan kepada keluarga sebelum dan setelah kematian pasien (Aldridge et al., 2022). Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa proses berduka merupakan *respons* alami terhadap

kehilangan, namun dapat berkembang menjadi *prolonged grief disorder* (gangguan berduka berkepanjangan) pada sebagian individu (Aldridge et al., 2022). Dukungan proses keluarga dalam menghadapi kehilangan bertujuan memfasilitasi individu dan keluarga dalam menjalani proses berduka secara adaptif dan bermakna (Ferrell et al., 2020; *World Health Organization*, 2023). *Bereavement care* tidak hanya diberikan setelah kematian pasien, tetapi telah dimulai sejak fase terminal melalui pengenalan *respons* emosional, spiritual, dan sosial terhadap kehilangan yang akan atau telah terjadi (Ferrell et al., 2020).

Kehilangan anggota keluarga merupakan peristiwa krisis yang mengganggu keseimbangan sistem keluarga dan menuntut reorganisasi struktur serta fungsi, termasuk perubahan peran, pola interaksi, dan tanggung jawab antar anggota dalam keluarga (Friedman et al., 2019). Proses adaptasi terhadap kehilangan dipengaruhi oleh pola komunikasi, tingkat kohesi, serta mekanisme koping yang dimiliki keluarga, di mana komunikasi terbuka dan kohesi yang kuat mendukung proses berduka yang lebih sehat. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran penting dalam membantu keluarga mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber dukungan internal maupun eksternal guna memfasilitasi adaptasi yang efektif, mempertahankan fungsi keluarga, serta meningkatkan resiliensi dalam menghadapi kehilangan (Maglaya, 2009).

2. Prinsip Bereavement Care dalam Kerangka Family Care Nursing (FCN)

Dalam kerangka Family Centered Nursing (FCN), dukungan berduka dilakukan dengan mempertahankan hubungan terapeutik antara perawat dan keluarga, memberikan komunikasi yang jujur dan empatik, serta menghormati nilai budaya dan spiritual keluarga (NCP, 2021). Prinsip utama bereavement care meliputi:

Tabel 4.11 Prinsip Bereavement Care

No.	Prinsip	Deskripsi
1.	Pengakuan terhadap kehilangan	Memvalidasi pengalaman kehilangan keluarga
2.	Dukungan emosional dan spiritual	Memberikan pendampingan psikologis dan rohani
3.	Identifikasi risiko komplikasi berduka	Mendeteksi dini tanda <i>Prolonged Grief Disorder</i> (PGD) atau gangguan berduka berkepanjangan
4.	Tindak lanjut atau rujukan	Memastikan keberlanjutan dukungan

Sejalan dengan pendekatan keperawatan komunitas menurut Allender et al. (2022), dukungan berduka juga dapat melibatkan jejaring sosial dan sumber daya komunitas untuk memperkuat proses adaptasi keluarga. Dalam konteks

Indonesia yang multikultural, sensitivitas budaya dan komunikasi transkultural menjadi kompetensi penting dalam praktik bereavement care (Allender et al., 2022). Menurut Worden (2018), terdapat empat tugas berduka yang harus diselesaikan individu:

Tabel 4.12. Tahapan dan Tugas Berduka

No.	Tugas	Deskripsi
1.	Tugas I	Menerima realitas kehilangan
2.	Tugas II	Memproses rasa sakit karena berduka
3.	Tugas III	Menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa mendiang
4.	Tugas IV	Menemukan hubungan baru dengan mendiang sambil tetap hidup

Edukasi mengenai tahapan berduka yang meliputi penyangkalan, marah, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan dapat membantu pasien dan keluarga memahami bahwa respons tersebut merupakan proses normal dalam menghadapi kehilangan, sehingga meningkatkan kemampuan adaptasi (Worden, 2018).

Anticipatory Grief (duka antisipatif)

Persiapan *bereavement care* dalam keperawatan paliatif dimulai sejak pasien memasuki fase akhir kehidupan dengan tujuan membantu keluarga menghadapi proses kehilangan secara adaptif (Ferrell et al., 2020). Perawat berperan aktif dalam membangun komunikasi empatik dan terapeutik untuk mempersiapkan keluarga terhadap kemungkinan kematian secara sensitif dan bertahap, sehingga meningkatkan kesiapan psikologis serta meminimalkan *respons* syok saat kematian terjadi. Perawat juga mendorong keluarga untuk menjalani proses *anticipatory grieving*, seperti menyampaikan pesan terakhir, memperkuat hubungan emosional, serta menyelesaikan hal-hal yang belum tersampaikan selama pasien masih hidup (Aldridge et al., 2022). Pendekatan ini memungkinkan keluarga memaknai proses perpisahan secara lebih konstruktif. Dukungan keperawatan tetap berlanjut setelah kematian melalui tindak lanjut, konseling, maupun rujukan ke layanan profesional bila diperlukan. Pendekatan berkelanjutan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan adaptasi keluarga terhadap kehilangan serta menurunkan risiko terjadinya *prolonged grief disorder* (Aldridge et al., 2022; World Health Organization, 2023).

3. Tahap Proses Keperawatan Bereavement Care

Pengkajian merupakan tahap awal yang komprehensif terhadap kondisi psikologis, spiritual, dan sosial keluarga yang mengalami kehilangan. Berdasarkan Ferrell et al. (2020) dan NANDA International (2020), komponen pengkajian meliputi:

Tabel 4.13 Komponen Pengkajian *Bereavement Care*

No.	Komponen Pengkajian	Fokus Asesmen
1.	Jenis kehilangan	Kematian pasangan, orang tua, anak, atau anggota keluarga lain
2.	Tahap berduka	Fase berduka yang sedang dialami (penyangkalan, marah, tawar-menawar, depresi, penerimaan)
3.	Sifat keterikatan	Kualitas hubungan dengan yang meninggal (dekat, konflik, tergantung)
4.	<i>Respons</i> awal	Reaksi emosional, fisik, kognitif, dan perilaku terhadap kehilangan
5.	Faktor risiko	Riwayat gangguan jiwa, kurangnya dukungan sosial, konflik keluarga, kematian mendadak
6.	Sumber dukungan	Dukungan keluarga, teman, komunitas, dan keyakinan spiritual

Tahapan intervensi keperawatan dapat dilakukan. Tindakan pemberian motivasi pada pasien dan keluarga untuk mengungkapkan emosi, memperkuat dukungan sosial, serta mendiskusikan strategi koping merupakan pendekatan berbasis bukti yang terbukti efektif dalam mencegah komplikasi berduka, seperti *prolonged grief disorder* (Kent et al., 2021). Selain itu, edukasi mengenai tahapan berduka yang meliputi penyangkalan, marah, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan dapat membantu pasien dan keluarga memahami bahwa respons tersebut merupakan proses normal dalam menghadapi kehilangan, sehingga meningkatkan kemampuan adaptasi (Worden, 2018). Perawat juga memfasilitasi identifikasi ketakutan terdalam serta membantu individu melewati setiap fase berduka secara bertahap melalui pendekatan terapeutik yang sensitif terhadap nilai budaya dan spiritual (Hudson et al., 2018). Pada tahap implementasi, perawat berperan dalam memberikan dukungan emosional melalui sikap empatik, penerimaan tanpa menghakimi, serta fasilitasi ekspresi perasaan kehilangan.

Luaran keperawatan yang diharapkan meliputi perbaikan tingkat berduka, peningkatan harapan, keberdayaan, status spiritual, serta penerimaan terhadap perubahan citra diri. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai efektivitas intervensi dan kesiapan pasien maupun keluarga dalam melanjutkan proses adaptasi. Dengan demikian, dukungan proses berduka dalam *bereavement care* merupakan intervensi esensial dalam perawatan paliatif yang tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga pada keluarga sebagai unit perawatan, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup, mencegah komplikasi

psikososial, dan memastikan proses kehilangan dijalani secara sehat, bermakna, dan bermartabat.

Berikut tahapan prosedur Dukungan Proses Berduka pada *Bereavement Care* dalam perawatan paliatif yang disusun secara sistematis dalam bentuk tabel serta diperkaya dengan *Evidence Based Nursing* (EBN) sebagai dasar ilmiah intervensi, mengacu pada praktik berbasis bukti dan standar Persatuan Perawat Nasional Indonesia:

Tabel 4.14. Prosedur Dukungan Proses Berduka

No	Tahapan Prosedur	Tindakan Keperawatan
1	Identifikasi Pasien	Verifikasi minimal dua identitas pasien
2	Orientasi	Menjelaskan tujuan dan langkah prosedur
3	Persiapan	Melakukan kebersihan tangan 6 langkah
4	Identifikasi Kehilangan	Mengkaji jenis kehilangan yang dialami
5	Identifikasi Tahap Berduka	Mengidentifikasi fase berduka pasien/keluarga
6	Keterikatan	Mengidentifikasi hubungan/keterikatan dengan yang hilang
7	<i>Respons</i> Awal	Mengkaji reaksi awal terhadap kehilangan
8	Sikap Empatik	Menunjukkan empatik dan penerimaan. Perawat dapat menggunakan Teknik komunikasi empatik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien terminal, menurunkan <i>distress</i> psikologis, dan memberi kekuatan psikis pada keluarga (Back et al, 2019)
9	Fasilitasi Ekspresi	Memotivasi pasien mengungkapkan perasaan kehilangan
10	Dukungan Sosial	Memotivasi dukungan keluarga/orang terdekat
11	Strategi Koping	Mendiskusikan mekanisme <i>coping</i>
12	Edukasi Berduka	Menjelaskan tahapan berduka sebagai proses normal
13	Identifikasi Ketakutan	Mendorong identifikasi ketakutan terbesar
14	Ekspresi Lanjutan	Menganjurkan ekspresi emosi berkelanjutan
15	Pendampingan Proses	Mengajarkan melalui proses berduka bertahap
16	Terminasi	Kebersihan tangan setelah tindakan
17	Dokumentasi	Mendokumentasikan tindakan dan <i>respons</i>

Tabel di atas menunjukkan bahwa intervensi dukungan proses berduka dalam *bereavement care* tidak hanya bersifat empatik dan terapeutik, tetapi juga

berbasis *Evidence-Based Nursing* (EBN) yang mengintegrasikan bukti ilmiah, pengalaman klinis, serta kebutuhan pasien dan keluarga. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan adaptasi berduka, memperkuat koping keluarga, serta mencegah terjadinya komplikasi psikososial seperti prolonged grief disorder, sehingga pelayanan keperawatan paliatif menjadi lebih holistik, bermutu, dan berorientasi pada kesejahteraan pasien serta keluarga.

Dalam keperawatan paliatif, persiapan *bereavement care* dimulai sejak pasien memasuki fase akhir kehidupan dengan tujuan membantu keluarga menghadapi proses kehilangan secara adaptif. Misalnya, pada pasien dengan penyakit terminal yang menunjukkan penurunan kondisi secara progresif, perawat melakukan komunikasi empatik untuk mempersiapkan keluarga terhadap kemungkinan kematian dengan cara yang sensitif dan bertahap. Perawat dapat menyampaikan: ***“Kami melihat kondisi Ibu semakin menurun dan penting bagi keluarga untuk mempersiapkan diri secara emosional. Kami akan mendampingi Bapak/Ibu melalui proses ini.”*** Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kesiapan psikologis keluarga serta mengurangi shock saat kematian terjadi (Ferrell et al., 2020).

Selanjutnya, perawat memfasilitasi keluarga dalam mengekspresikan perasaan, mengidentifikasi makna kehilangan, serta memperkuat dukungan sosial dan spiritual. Perawat juga memberikan edukasi mengenai proses berduka yang normal, termasuk tahapan seperti penyangkalan, marah, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan, serta membantu keluarga mengenali tanda risiko *complicated grief*. Selain itu, perawat mendorong keluarga untuk melakukan *anticipatory grieving*, seperti menyampaikan pesan terakhir, memperkuat hubungan, dan menyelesaikan hal-hal yang belum tersampaikan. Setelah kematian, perawat tetap memberikan dukungan lanjutan melalui tindak lanjut, konseling, atau rujukan bila diperlukan. Pendekatan ini terbukti meningkatkan adaptasi keluarga terhadap kehilangan dan menurunkan risiko gangguan berduka berkepanjangan (Aldridge et al., 2022; World Health Organization, 2023).

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-5	OSCE end-of-life care + rubrik	Ketepatan comfort care, dukungan keluarga, dan keselamatan tindakan sesuai tujuan perawatan (skor rubrik).	15	Lembar penilaian: rencana comfort care
CPMK-6	Proyek rencana kolaborasi spiritual-budaya & koordinasi layanan	Kualitas pemetaan kebutuhan spiritual-budaya, rencana kolaborasi/rujukan, dan indikator tindak lanjut (skor rubrik).	10	Rencana kolaborasi; peta rujukan
CPMK-7	Portofolio laporan kasus & rencana tindak lanjut/home care	Kelengkapan evaluasi luaran berbasis indikator dan kualitas rencana tindak lanjut (discharge/home care) terukur.	15	Laporan kasus; rencana tindak lanjut

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)**Rubrik CPMK-5 (Aktivitas 3)**

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan comfort care & keselamatan tindakan	Tidak sesuai tujuan perawatan; risiko tinggi	Cukup sesuai; ada kekurangan bermakna	Sesuai; aman; konsisten	Sangat sesuai; sangat aman; antisipatif komplikasi
5.2 Kualitas dukungan keluarga & bereavement readiness	Tidak responsif; tanpa rencana	Respons ada; rencana umum	Respons baik; rencana tindak lanjut jelas	Dukungan sangat baik; rencana bereavement sangat jelas & terukur

Rubrik CPMK-6 (Aktivitas 1)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Pemetaan kebutuhan spiritual-budaya & preferensi	Tidak teridentifikasi	Teridentifikasi sebagian	Teridentifikasi jelas	Sangat jelas; mempertimbangkan nilai/ritual kunci
6.2 Kualitas rencana kolaborasi/rujukan & advokasi	Tidak ada rencana; peran tidak jelas	Ada rencana; koordinasi kurang runtut	Koordinasi jelas; indikator tindak lanjut ada	Koordinasi sangat efektif; indikator komprehensif & keberlanjutan kuat

Rubrik CPMK-7 (Aktivitas 2)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Evaluasi luaran paliatif berbasis indikator	Tidak menggunakan indikator	Indikator terbatas; analisis minim	Indikator memadai; analisis jelas	Indikator komprehensif; analisis kritis & akurat
7.2 Kualitas rencana tindak lanjut/home care	Tidak spesifik; tidak terukur	Cukup spesifik; sebagian terukur	Spesifik; terukur; realistis	Sangat spesifik, terukur, realistis; koordinasi layanan jelas

Aktivitas 1 — *Proyek Rencana Kolaborasi***Proyek Rencana Kolaborasi Spiritual-Budaya & Koordinasi Layanan Paliatif**

Mata Kuliah : Keperawatan Paliatif 2

Bab : Dukungan Keluarga, *Caregiver*, dan Bereavement Care
CPMK : CPMK-6

Bobot : 10%

1. Kasus

Seorang pasien perempuan, Ny. S (56 tahun), didiagnosis menderita kanker serviks stadium IV dan saat ini menjalani perawatan paliatif di rumah setelah beberapa kali menjalani kemoterapi di rumah sakit. Kondisi pasien menunjukkan penurunan signifikan, dengan keluhan nyeri kronis, kelelahan berat, nafsu makan menurun, serta ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari.

Ny. S tinggal bersama suami dan dua orang anak dewasa. Suami berperan sebagai *caregiver* utama, namun terlihat mengalami kelelahan fisik dan emosional. Anak pertama bekerja di luar kota dan jarang pulang, sedangkan anak kedua tinggal bersama orang tua tetapi kurang terlibat dalam perawatan.

Secara spiritual, keluarga Ny. S memiliki keyakinan agama yang kuat dan rutin menjalankan ibadah. Namun, keluarga menunjukkan tanda-tanda kecemasan terkait kondisi pasien yang semakin memburuk serta belum siap menghadapi kemungkinan kematian. Dalam beberapa kesempatan, suami pasien menyatakan, ***"Kami masih berharap ada keajaiban"*** dan tampak menghindari pembicaraan tentang kondisi terminal.

Lingkungan tempat tinggal pasien berada di komunitas dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan lanjutan, namun terdapat kader kesehatan aktif serta tokoh agama yang dihormati masyarakat. Saat ini, pasien belum mendapatkan layanan *home care* terstruktur, dan keluarga belum pernah mendapatkan edukasi khusus terkait perawatan paliatif maupun persiapan menghadapi kematian.

2. Tugas Mahasiswa

Berdasarkan kasus di atas, lakukan analisis dan susun **rencana kolaborasi spiritual-budaya serta koordinasi layanan paliatif** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemetaan Kebutuhan Spiritual dan Budaya : identifikasi secara rinci terkait nilai dan keyakinan spiritual pasien dan keluarga; seperti praktik ibadah dan spiritual yang relevan; dan preferensi pasien/keluarga terkait perawatan penyakit dan persiapan perawatan akhir hayat.
- b. Analisis Kebutuhan Dukungan : uraikan kebutuhan dukungan spiritual, dukungan psikologis, dan dukungan keluarga serta *caregiver*.
- c. Rencana Kolaborasi Interprofesional : susun rencana kolaborasi yang melibatkan tenaga kesehatan lainnya (dokter, fisioterapi, dll.) dan tenaga non-kesehatan yang terkait (tokoh agama, kader, dll.), lengkapi dengan peran masing-masing pihak, serta bentuk intervensi yang dapat diberikan.
- d. Rencana Rujukan dan Koordinasi Layanan : buatlah peta rujukan layanan yang mencakup layanan kesehatan sampai dengan layanan komunitas.
- e. Indikator Tindak Lanjut (*Follow-up*): Tentukan indikator keberhasilan intervensi dan rencana evaluasi tindak lanjut.

3. Format Pengumpulan Tugas

- a. Bentuk: Narasi ilmiah + tabel/diagram (bila perlu)
- b. Panjang: 3–5 halaman
- c. Font: Times New Roman 12, spasi 1,5

d. Sertakan referensi (minimal 3 sumber ilmiah terbaru)

4. Petunjuk Pengerjaan Tugas

- Gunakan pendekatan family-centered nursing (FCN)
- Integrasikan aspek spiritual, budaya, dan psikososial
- Terapkan prinsip komunikasi empatik dan paliatif
- Gunakan *evidence-based nursing* (EBN) dalam menyusun rencana

5. Kriteria Penilaian

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Pemetaan kebutuhan spiritual-budaya & preferensi	Tidak teridentifikasi	Teridentifikasi sebagian	Teridentifikasi jelas	Sangat jelas dan mendalam, termasuk nilai/ritual kunci
6.2 Kualitas rencana kolaborasi/rujukan & advokasi	Tidak ada rencana	Rencana kurang runtut	Rencana jelas & ada indikator	Sangat sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan

Aktivitas 2 — *Portofolio*

Portofolio Laporan Kasus & Rencana Tindak Lanjut/Home Care Paliatif

Mata Kuliah : Keperawatan Paliatif 2

Bab : Dukungan Keluarga, *Caregiver*, dan Bereavement Care

CPMK : CPMK-7

Bobot : 15%

1. Kasus

Tn. A (62 tahun) didiagnosis menderita kanker paru stadium IV sejak 3 tahun lalu dan telah menjalani beberapa siklus kemoterapi. Saat ini pasien dirawat di rumah dengan pendekatan paliatif. Kondisi pasien meliputi sesak napas ringan, nyeri dada (skala 5/10), kelelahan, serta penurunan nafsu makan. Pasien masih sadar penuh, namun tampak cemas terhadap kondisi kesehatannya.

Istri pasien berperan sebagai *caregiver* utama, dibantu oleh anak perempuan yang tinggal serumah. Istri pasien mengeluhkan kelelahan dan kesulitan dalam mengelola perawatan sehari-hari, terutama dalam pemberian obat dan pemantauan kondisi pasien. Keluarga memiliki dukungan spiritual yang cukup baik, namun belum memahami sepenuhnya perawatan paliatif di rumah.

Pasien telah mendapatkan intervensi keperawatan berupa:

- a. Edukasi manajemen nyeri dan sesak
- b. Dukungan emosional kepada pasien dan keluarga
- c. Pelibatan keluarga dalam perawatan dasar
- d. Edukasi terkait tanda bahaya

Namun, belum terdapat rencana tindak lanjut yang terstruktur setelah kunjungan terakhir perawat. (Silahkan membuat data tambahan jika diperlukan)

2. Tugas Mahasiswa

Mahasiswa diminta menyusun portofolio laporan kasus keperawatan paliatif yang mencakup evaluasi luaran berbasis indikator serta rencana tindak lanjut (*discharge planning/home care*) secara terukur dan realistis, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Ringkasan kasus : Identitas pasien (inisial, usia, diagnosis), kondisi klinis, dan peran keluarga/*caregiver*.
- b. Identifikasi Masalah Lanjutan : buatlah hasil identifikasi masalah pasien yang masih mungkin ada dari kondisi kasus tersebut, buatlah hasil perhitungan beban *caregiver*, dan narasikan kebutuhan lanjutan keluarga.
- c. Rencana Tindak Lanjut (Home Care/Discharge Planning) : intervensi keperawatan lanjutan, edukasi keluarga, jadwal pemantauan dan pengobatan pasien, tanda bahaya yang harus diawasi, dan strategi peningkatan koping keluarga.

- d. Indikator Evaluasi Tindak Lanjut : buat narasi penentu keberhasilan *caregiver* (misalnya kontrol nyeri, kecemasan menurun, dll.).

3. Format Pengumpulan Tugas

- Bentuk: Laporan ilmiah (portofolio kasus)
- Panjang: 4–6 halaman
- Font: Times New Roman 12, spasi 1,5
- Sertakan minimal 3 referensi ilmiah terbaru

D. Rubrik Penilaian

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Evaluasi luaran paliatif berbasis indikator	Tidak menggunakan indikator	Indikator terbatas; analisis minim	Indikator memadai; analisis jelas	Indikator komprehensif; analisis kritis, sistematis, dan akurat
7.2 Kualitas rencana tindak lanjut/home care	Tidak spesifik; tidak terukur	Cukup spesifik; sebagian terukur	Spesifik; terukur; realistis	Sangat spesifik, terukur, realistis; disertai koordinasi layanan yang jelas dan berkelanjutan

Aktivitas 3 : Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini- case
Shows How	OSCE Dukungan Proses Berduka

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan* OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi pasien, keluarga, & privasi
- Penilaian Tahapan Komunikasi Terapeutik
- Prosedur Dukungan Proses berduka & Komunikasi Empatik

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

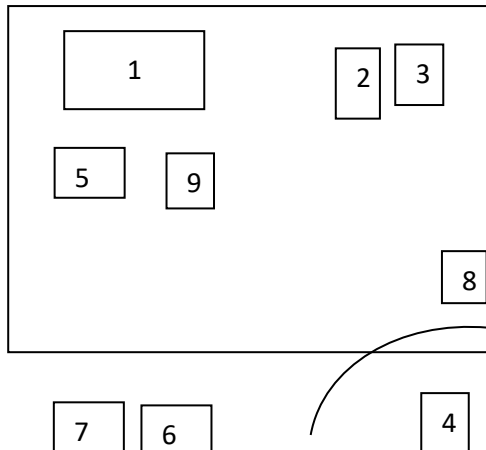
- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan pemberian dukungan

E. Soal Osce Keperawatan

1.	Nomor station	 (Dikosongkan)
2.	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Berdukacita di Rumah Sakit
3.	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis, perencanaan keperawatan, serta edukasi pada <i>caregiver</i> dengan bereavement.
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairandanelektrolit 4. Nutrisi 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u>

		Ny. R (52 tahun) datang ke ruang konseling keperawatan dengan keluhan tidak bisa tidur, tidak nafsu makan, dan sering menangis tiba-tiba. Suami Ny. R meninggal 3 minggu yang lalu akibat kanker paru stadium IV. Selama 2 tahun terakhir, Ny. R menjadi <i>caregiver</i> utama yang merawat suaminya sehari-hari, mulai dari mengantar kontrol, memberi obat, memandikan, hingga memasang NGT. Sejak suaminya meninggal, Ny. R: - Hanya tidur 1-2 jam per malam - Makan hanya 1 kali sehari (porsi kecil) - Tidak mau keluar rumah - Menolak diajak bicara oleh anak-anaknya - Masih menyimpan semua obat dan peralatan suami di kamar - Sering berbicara sendiri sambil memeluk foto suami Tidak ada riwayat gangguan jiwa sebelumnya. Tidak ada ide bunuh diri. <u>TUGAS :</u> 1. Sebutkan kepada penguji data pengkajian fokus berdasarkan skenario yang terjadi pada kasus. 2. Sebutkan kepada penguji diagnosis keperawatan yang tepat dari kasus jawaban berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Lakukan edukasi yang tepat kepada ibu (<i>caregiver</i>) dan lakukan demonstrasi latihan relaksasi napas dalam.
8.	Instruksi untuk penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Ny. R (52 tahun) datang ke ruang konseling keperawatan dengan keluhan tidak bisa tidur, tidak nafsu makan, dan sering menangis tiba-tiba. Suami Ny. R meninggal 3 minggu yang lalu akibat kanker paru stadium IV. Selama 2 tahun terakhir, Ny. R menjadi <i>caregiver</i> utama yang merawat suaminya sehari-hari, mulai dari mengantar kontrol, memberi obat, memandikan, hingga memasang NGT. Sejak suaminya meninggal, Ny. R: - Hanya tidur 1-2 jam per malam - Makan hanya 1 kali sehari (porsi kecil) - Tidak mau keluar rumah - Menolak diajak bicara oleh anak-anaknya

	- Masih menyimpan semua obat dan peralatan suami di kamar - Sering berbicara sendiri sambil memeluk foto suami Tidak ada riwayat gangguan jiwa sebelumnya. Tidak ada ide bunuh diri. <u>TUGAS :</u> 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario yang terjadi pada Klien Standar. 2. Sebutkan kepada penguji diagnosis keperawatan yang tepat dari kasus jawaban berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. Jawaban Benar : a) Bereavement (Duka cita tidak teratasi) berhubungan dengan kematian orang yang dicintai (suami), ditandai dengan: sedih berkepanjangan, insomnia, anoreksia, menarik diri, menyalahkan diri, dan kehilangan minat beraktivitas. b) Gangguan pola tidur berhubungan dengan stres psikologis pascakelahiran, ditandai dengan tidur hanya 1-2 jam per malam dan keluhan lelah. 3. Lakukan edukasi yang tepat kepada ibu (<i>caregiver</i>) dan lakukan demonstrasi latihan relaksasi napas dalam. <u>INSTRUKSI PENGUJI:</u> 1. Penguji menilai ketepatan peserta dalam melakukan pengkajian fokus berduka yang meliputi menggali keluhan, onset, gejala fisik/emosi/kognitif/perilaku, riwayat bunuh diri, sistem pendukung, dan koping yang biasa digunakan. 2. Penguji menilai ketepatan penegakan diagnosis keperawatan : Bereavement (Duka cita tidak teratasi) dan Gangguan Pola Tidur. 3. Penguji mengukur ketepatan pelaksanaan edukasi tentang cara mengatasi duka yang adaptif, termasuk normalisasi proses duka, strategi koping, dan langkah-langkah demonstrasi latihan relaksasi napas dalam.
--	---

		4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9.	Instruksi untuk klien standar	Menggunakan klien standar yang terlatih menampakkan muka tampak lesu, mata sembab, suara lirih dan kadang putus, Menangis saat menyebut "suami" atau "meninggal" Klien terlatih untuk menyampaikan skenario berikut : "Saya tidak bisa tidur, tidak mau makan, sering nangis. Sudah 3 minggu." "Suami saya meninggal karena kanker paru. Saya yang rawat beliau 2 tahun." "Sedih sekali. Kadang marah sama Tuhan. Kadang saya menyalahi diri sendiri." "Malas. Kadang 2 hari tidak mandi." "Tidak. Saya tutup pintu kalau ada yang datang." "Saya sulit tidur. Tapi kadang saya berharap tidur dan tidak bangun lagi." "Anak bungsu saya. Tapi dia kerja sampai malam." "Saya hanya duduk di kamar suami." Saya orangnya kuat biasanya." Tidak menambahkan info apa pun jika tidak ditanya.
10.	<i>Setting</i> <i>Station:</i>	Ruangan Rawat Jalan - Tempat tidur pasien - Manekin dewasa/kaki dengan luka - laboran <i>tata letak ruang :</i> 1. Tempat tidur dan manekin 2. Meja penguji 3. Kursi penguji 4. Pintu masuk 5. Trolley alat 6. Wastafel 7. Tempat sampah 8. Kursi laboran 9. Perawat (Mahasiswa) 

1 1	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan : 1. Meja dan 2 kursi (penguji dan laboran) 2. Meja peralatan/trolley 3. Bed Pemeriksaan 4. Wastafel atau simulasi wastafel 5. Tempat sampah 6. Klien Standar (Perempuan) 7. Plastik Kuning 8. Alat pemeriksaan tanda-tanda vital 9. Alat tulis Kantor (Kertas, pena, pensil, penghapus) 10. Media Edukasi (Mekanisme Koping dan Dukungan Proses Berduka) 11. Handscoon disposable Laboran ada Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan oleh peserta dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian. Laboran memastikan posisi luka seperti semula.
1 2.	Penulis	Ns. I Gusti Ayu Putu Desy Rohana, M.Kep., Sp.Kep.Kom (Poltekkes Kemenkes Palembang)
1 3.	Referensi	Lynn, P., Taylor, C. R. (2019). <i>Taylor's Handbook of Clinical Nursing Skills</i>. Britania Raya: Lippincott Williams & Wilkins. Potter, P. A., Perry, A. G., Ostendorf, W., Cobbett, S. (2019). <i>Canadian Clinical Nursing Skills and Techniques E-Book</i>. Amerika Serikat: Elsevier Health Sciences. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) <i>Standar Intervensi Keperawatan Indonesia</i>. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI . Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) <i>Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan</i>. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI

SPO Dukungan Proses Berduka
(Gunakan SPO dari PPNI)

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan	Kompeten
----	------------------	-----------	----------

		Ya	Tidak	Ya	Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
	1. Mengecek catatan medis dan perawatan				
	2. Menyiapkan alat dan perlengkapan 1. Alat pemeriksaan tanda-tanda vital 2. Alat tulis Kantor (Kertas, pena, pensil, penghapus) 3. Media Edukasi (Mekanisme Koping dan Dukungan Proses Berduka) 4. Handscoon disposable				
	3. Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
	1. Menyampaikan salam terapeutik				
	2. Menyampaikan nama dan peran perawat				
	3. Mengecek identitas pasien, minimal nama dan tanggal lahir dengan aktif				
	4. Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
	5. Memberi kesempatan bertanya				
	6. Memulai tindakan dengan baik				
	7. Jaga privasi				
C	Tahap Kerja (No 1 sd 19 : sistematis)				
	1. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah				
	2. Identifikasi kehilangan yang dihadapi				
	3. Identifikasi proses berduka yang dialami				
	4. Identifikasi keterikatan pada orang yang meninggal				
	5. Identifikasi reaksi awal terhadap kehilangan				
	6. Tunjukkan sikap menerima dan empatik				
	7. Motivasi agar klien mau mengungkapkan rasa kehilangan				
	8. Motivasi untuk menguatkan dukungan keluarga atau orang terdekat				
	9. Diskusi strategi koping yang digunakan				
	10. Jelaskan kepada pasien dan keluarga bahwa sikap mengingkari, marah, tawar-menawar,				

	depresi, dan menerima adalah wajar dalam menghadapi kehilangan				
	11. Anjurkan untuk mengidentifikasi ketakutan terbesar pada kehilangan				
	12. Anjurkan mengekspresikan perasaan tentang kehilangan				
	13. Ajarkan melawati proses berduka secara bertahap				
	14. Ajarkan pasien Teknik relaksasi (dengan nafas dalam misalnya)				
	15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah				
	16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien				
D	Tahap terminasi				
	1. simpulkan kegiatan				
	2. evaluasi respons (subyektif dan obyektif)				
	3. reinforcement positif				
	4. kontrak waktu selanjutnya				
	5. akhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
	E. hari_tanggal_jam, kegiatan, metode pemberian oksigen, kecepatan aliran) serta respons dan kemungkinan efek lain yang dirasakan pasien jika ada				
F	Penampilan Profesional				
	F. Aman, Nyaman, Teliti, Cermat, Tepat, Responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN**STATION 1 : Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Berdukacita di Rumah Sakit****Form Penilaian**

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
1. Pengkajian Keperawatan					3	
2. Diagnosis Keperawatan					2	
3. Implementasi Keperawatan					5	

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN**STATION 1 : Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Berdukacita di Rumah Sakit****Rubrik**

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam melakukan pengkajian berduka secara komprehensif dengan menggali keluhan utama (insomnia, anoreksia, menangis, menarik diri), mengidentifikasi onset dan durasi kehilangan, serta mengeksplorasi respons berduka meliputi aspek emosional, fisik, kognitif, dan perilaku. Peserta juga diharapkan mampu mengkaji risiko seperti riwayat bunuh diri, mengidentifikasi sistem pendukung, dan menilai mekanisme koping yang digunakan sebagai dasar					3	

penentuan asuhan keperawatan yang tepat.						
2. Diagnosis Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan menyampaikan diagnosis keperawatan secara tepat berdasarkan data. Diagnosis yang diharapkan adalah Bereavement (duka cita tidak teratasi) dan Gangguan pola tidur					2	
3. Implementasi Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam memberikan edukasi dan mendemonstrasikan intervensi kepada klien. Edukasi meliputi pemahaman bahwa proses berduka adalah hal yang normal, pengenalan strategi koping adaptif, serta pentingnya dukungan sosial. Selain itu, peserta juga dinilai dalam mendemonstrasikan teknik relaksasi napas secara benar untuk membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kenyamanan klien.					5	

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Lampiran Rubrik

STATION 1 : Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Berdukacita di Rumah Sakit

Kompetensi	Score (S)				Bobot (B)	Nilai (S x B)
	0	1	2	3		
Pengkajian	Tidak melakukan pengkajian atau tidak relevan	Peserta menyampaikan akan 1-2 poin pengkajian berduka : 1. Menggali keluhan utama (insomnia, anoreksia, menangis, menarik diri) 2. Mengidentifikasi onset dan durasi kehilangan 3. Mengkaji respons berduka (emosional, fisik, kognitif, perilaku) 4. Mengkaji risiko	Peserta menyampaikan akan 3-5 poin pengkajian berduka : 1. Menggali keluhan utama (insomnia, anoreksia, menangis, menarik diri) 2. Mengidentifikasi onset dan durasi kehilangan 3. Mengkaji respons berduka (emosional, fisik, kognitif, perilaku) 4. Mengkaji risiko	Peserta mampu menyampaikan seluruh poin dari pengkajian berduka : 1. Menggali keluhan utama (insomnia, anoreksia, menangis, menarik diri) 2. Mengidentifikasi onset dan durasi kehilangan 3. Mengkaji respons berduka (emosional, fisik, kognitif, perilaku) 4. Mengkaji risiko	3	

		(riwayat bunuh diri) 5. Mengidentifikasi sistem pendukung (keluarga) 6. Mengkaji mekanisme koping yang digunakan	(riwayat bunuh diri) 5. Mengidentifikasi sistem pendukung (keluarga) 6. Mengkaji mekanisme koping yang digunakan	(riwayat bunuh diri) 5. Mengidentifikasi sistem pendukung (keluarga) 6. Mengkaji mekanisme koping yang digunakan		
Diagnosis keperawatan	Peserta tidak mampu menyebutkan diagnosis sama sekali	Peserta menyebutkan diagnosis yang tidak tepat atau hanya satu diagnosis yang benar prinsip berikut : 1. Bereavement (Duka cita tidak teratasi) berhubungan dengan kematian orang yang dicintai (suami),	Peserta Menyebutkan dua diagnosis namun kurang lengkap/kurang tepat dengan memperhatikan : 1. Bereavement (Duka cita tidak teratasi) berhubungan dengan kematian orang yang dicintai	Peserta Menyebutkan kedua diagnosis dengan tepat dan sesuai data dengan memperhatikan : 1. Bereavement (Duka cita tidak teratasi) berhubungan dengan kematian orang yang dicintai (suami),	2	

		ditandai dengan: sedih berkepanjangan, insomnia, anoreksia, menarik diri, menyalahkan diri, dan kehilangan minat beraktivitas. 2. Gangguan pola tidur berhubungan dengan stres psikologis pascakelahiran, ditandai dengan tidur hanya 1-2 jam per malam dan keluhan lelah.	(suami), ditandai dengan: sedih berkepanjangan, insomnia, anoreksia, menarik diri, menyalahkan diri, dan kehilangan minat beraktivitas. 2. Gangguan pola tidur berhubungan dengan stres psikologis pascakelahiran, ditandai dengan tidur hanya 1-2 jam per malam dan keluhan	ditandai dengan: sedih berkepanjangan, insomnia, anoreksia, menarik diri, menyalahkan diri, dan kehilangan minat beraktivitas. 2. Gangguan pola tidur berhubungan dengan stres psikologis pascakelahiran, ditandai dengan tidur hanya 1-2 jam per malam dan keluhan lelah.		
--	--	--	--	--	--	--

			lelah.			
Imple	Peserta ujian tidak melakukan edukasi/intervensi sama sekali dengan kriteria sebagai berikut : 1. Edukasi Proses Berduka 2. Edukasi strategi coping adaptif 3. Edukasi dukungan proses berduka 1. Demonstrasi teknik relaksasi napas dalam. 2. Edukasi strategi coping	Peserta ujian melakukan Edukasi sangat terbatas dan tidak sistematis dengan kriteria sebagai berikut : 1. Edukasi Proses Berduka 2. Edukasi strategi coping adaptif 3. Edukasi dukungan proses berduka 1. Demonstrasi teknik relaksasi napas dalam.	Peserta ujian melakukan Edukasi cukup lengkap, demonstrasi kurang tepat dengan kriteria sebagai berikut : 1. Edukasi Proses Berduka 2. Edukasi strategi coping adaptif 3. Edukasi dukungan proses berduka 1. Demonstrasi teknik relaksasi napas dalam.	Peserta ujian melakukan Edukasi lengkap, jelas, dan demonstrasi relaksasi dilakukan dengan benar dengan kriteria sebagai berikut : 1. Edukasi Proses Berduka 2. Edukasi strategi coping adaptif 3. Edukasi dukungan proses berduka 1. Demonstrasi teknik relaksasi napas dalam.	5	

	ada ptif					
	3.Edu kasi duk ung an pro ses ber duk a					
	4.De mo nstr asi tek nik rela ksa si nap as dal am.					

Jumlah total skore

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

F. Ringkasan

Konsep dukungan keluarga, peran *caregiver*, dan prinsip bereavement care dalam konteks keperawatan paliatif berbasis family-centered nursing (FCN).

Konsep dukungan keluarga, peran *caregiver*, dan bereavement care merupakan komponen inti dalam keperawatan paliatif berbasis Family-Centered Nursing (FCN) yang menempatkan pasien dan keluarga sebagai satu kesatuan unit asuhan. Pendekatan ini sejalan dengan World Health Organization yang menekankan bahwa perawatan paliatif bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga melalui pengurangan penderitaan secara komprehensif. Dalam perspektif ini, keluarga tidak hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam seluruh proses keperawatan.

Dukungan keluarga terdiri atas empat bentuk utama, yaitu emosional, instrumental, informasional, dan penilaian. Dukungan emosional memberikan rasa aman dan empati; dukungan instrumental berupa bantuan langsung dalam perawatan; dukungan informasional membantu pemahaman kondisi dan pengambilan keputusan; serta dukungan penilaian memperkuat kepercayaan diri pasien. Keempatnya berperan penting dalam meningkatkan coping dan adaptasi pasien maupun keluarga. Dalam praktik keperawatan, pelibatan keluarga dilakukan melalui tahapan proses keperawatan, mulai dari pengkajian kesiapan dan kebutuhan keluarga, perencanaan intervensi berbasis edukasi dan pemberdayaan, hingga evaluasi luaran seperti peningkatan coping dan fungsi keluarga. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kualitas hidup pasien serta efektivitas perawatan di rumah.

Peran *caregiver*, khususnya dari anggota keluarga, sangat dominan dalam perawatan paliatif, meliputi perawatan fisik, dukungan emosional, dan koordinasi layanan kesehatan. Namun, peran ini berisiko menimbulkan *caregiver* burden yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan finansial. Oleh karena itu, perawat perlu melakukan asesmen komprehensif serta memberikan intervensi berupa edukasi, pelatihan keterampilan, dukungan emosional, dan fasilitasi sumber daya. Selain itu, dukungan emosional dan pengambilan keputusan (*shared decision-making*) menjadi aspek penting dalam praktik paliatif. Perawat berperan sebagai fasilitator yang membantu pasien dan keluarga memahami pilihan perawatan, mengklarifikasi nilai, serta mengambil keputusan secara kolaboratif dan menghormati otonomi pasien. Komunikasi empatik menjadi kunci dalam membangun hubungan terapeutik dan menurunkan *distress* psikologis.

Bereavement care merupakan bagian lanjutan dari perawatan paliatif yang dimulai sejak fase terminal hingga setelah kematian pasien. Intervensi ini bertujuan membantu keluarga menjalani proses berduka secara adaptif serta mencegah

komplikasi seperti prolonged grief disorder. Prinsip utamanya meliputi pengakuan terhadap kehilangan, dukungan emosional dan spiritual, identifikasi risiko, serta tindak lanjut. Perawat berperan dalam melakukan pengkajian, memfasilitasi ekspresi emosi, memberikan edukasi tentang proses berduka, serta mendukung keluarga melalui pendekatan anticipatory grief.

Secara keseluruhan, integrasi dukungan keluarga, penguatan peran *caregiver*, dan penerapan bereavement care dalam kerangka FCN merupakan strategi penting untuk mewujudkan asuhan keperawatan paliatif yang holistik, empatik, dan berorientasi pada kualitas hidup pasien dan keluarga.

Tabel Red Flags & Eskalasi

Dukungan Keluarga, *Caregiver*, dan Bereavement Care

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
<i>Caregiver</i> tampak sangat lelah, tidak mampu melanjutkan perawatan	Risiko <i>caregiver</i> burden berat (fisik & psikologis)	Segera laporkan, lakukan asesmen beban <i>caregiver</i> (misalnya ZBI), pertimbangkan rujukan atau dukungan tambahan
<i>Caregiver</i> menunjukkan tanda depresi (menangis terus-menerus, putus asa)	Gangguan psikologis / risiko depresi	Eskalasi ke tim kesehatan, rujuk ke psikolog/konselor
Konflik keluarga terkait keputusan perawatan	Gangguan proses keluarga / <i>decision conflict</i>	Fasilitasi <i>family meeting</i> , eskalasi ke tim multidisiplin
Keluarga menolak kondisi terminal pasien (denial berat)	Koping tidak efektif / risiko <i>maladaptive coping</i>	Berikan komunikasi empatik, eskalasi untuk konseling lanjutan
Pasien/keluarga menunjukkan keputusan ekstrem	Risiko spiritual <i>distress</i> / ide bunuh diri	Segera laporkan, lakukan intervensi krisis dan rujukan profesional
Keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pasien	Risiko perawatan tidak adekuat	Eskalasi untuk bantuan sosial, home care, atau rujukan layanan
<i>Caregiver</i> tidak memahami instruksi perawatan	Risiko kesalahan tindakan/perawatan	Ulangi edukasi, gunakan metode teach-back, dokumentasikan
Beban finansial berat hingga mengganggu perawatan	Risiko putus pengobatan	Eskalasi ke pekerja sosial/akses bantuan finansial
Isolasi sosial <i>caregiver</i> /keluarga	Risiko penurunan koping dan dukungan	Hubungkan dengan support group atau komunitas
Respons berduka ekstrem (tidak bisa berfungsi, menarik diri total)	Risiko prolonged grief disorder	Eskalasi untuk konseling/psikiatri

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Tidak ada ekspresi emosi sama sekali setelah kehilangan	<i>Delayed grief / coping</i> terhambat	Lakukan asesmen lanjutan dan fasilitasi ekspresi emosi
Perilaku menyalahkan diri berlebihan setelah kematian	Risiko gangguan psikologis	Berikan dukungan emosional, rujuk bila perlu
Penurunan fungsi sehari-hari setelah kehilangan	Gangguan adaptasi berduka	Eskalasi untuk intervensi psikososial
Keluarga menolak dukungan sosial atau tenaga kesehatan	Hambatan dalam proses adaptasi	Pendekatan komunikasi empatik dan eskalasi bertahap
Tanda konflik spiritual (marah pada Tuhan, kehilangan makna hidup)	Spiritual <i>distress</i>	Libatkan dukungan spiritual/rohani

Form Checklist “Saya sudah bisa”**Bab Dukungan Keluarga, *Caregiver*, dan Bereavement Care**

Nama Mahasiswa :

NIM :

Tanggal :

Tempat Praktik / Skill Lab :

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep Family-Centered Nursing (FCN) dalam paliatif	☐	☐	
2	Saya sudah bisa mengidentifikasi peran keluarga sebagai unit of care	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi bentuk dukungan keluarga (emosional, instrumental, informasional, penilaian)	☐	☐	
4	Saya sudah bisa melakukan pengkajian dukungan keluarga secara komprehensif	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengidentifikasi <i>caregiver</i> utama dalam keluarga	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengkaji tugas dan beban <i>caregiver</i>	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menggunakan instrumen sederhana (misalnya ZBI/MCSI) untuk menilai beban <i>caregiver</i>	☐	☐	
8	Saya sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan dukungan <i>caregiver</i> (emosional, sosial, spiritual, dll)	☐	☐	
9	Saya sudah bisa menyusun diagnosis keperawatan terkait keluarga dan <i>caregiver</i>	☐	☐	
10	Saya sudah bisa merencanakan intervensi berbasis dukungan keluarga dan <i>caregiver</i>	☐	☐	
11	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada keluarga terkait perawatan pasien paliatif	☐	☐	
12	Saya sudah bisa melakukan komunikasi empatik kepada pasien dan keluarga	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
13	Saya sudah bisa memfasilitasi pengambilan keputusan (<i>shared decision-making</i>)	☐	☐	
14	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda <i>caregiver burden</i>	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menjelaskan konsep bereavement care	☐	☐	
16	Saya sudah bisa mengidentifikasi tahapan dan respons berduka	☐	☐	
17	Saya sudah bisa melakukan pengkajian berduka (emosional, sosial, spiritual)	☐	☐	
18	Saya sudah bisa memberikan dukungan emosional pada proses berduka	☐	☐	
19	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda risiko <i>prolonged grief disorder</i>	☐	☐	
20	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau rujukan	☐	☐	
21	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi asuhan keperawatan keluarga	☐	☐	
22	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, empatik, dan responsif	☐	☐	

G. Daftar Pustaka

- Aldridge, M. D., Hasselaar, J., Garralda, E., van Beek, K., McLaughlin, D., Stevenson, D., ... & Meier, D. E. (2022). Education, implementation, and policy barriers to greater integration of palliative care: A literature review. *Palliative Medicine*, 36(2), 225–239.
- Allender, J. A., Rector, C., & Warner, K. D. (2022). *Community & public health nursing: Promoting the public's health* (10th ed.). Wolters Kluwer.
- Back, A. L., Fromme, E. K., & Meier, D. E. (2019). Training clinicians with communication skills needed to match medical treatments to patient values. *Journal of the American Geriatrics Society*, 67(S2), S435–S441.
- Berman, A., Snyder, S., & Frandsen, G. (2022). *Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice* (11th ed.). Pearson.
- Bradt, J., & Dileo, C. (2020). Music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (8).
- Desy, R. I. G. A. P., Nugroho, F. C., Yusniarita, Y., Kurnia, T. A., Ame, A., Rudi, R., ... & Setiowati, R. (2025). SeLIMuT Therapy: Self-Selected Individual Music to Reduce Pain in Cancer Patients at Dharmais. *Lentera Perawat*, 6(1), 197-205.
- Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2019). *Nursing Care Plans: Guidelines for Individualizing Client Care Across the Life Span* (10th ed.). F.A. Davis.
- Elwyn, G., Frosch, D., & Rollnick, S. (2017). Dual equipoise shared decision making: Definitions for decision and behaviour support interventions. *Implementation Science*, 12(1), 46.
- Ferrell, B. R., Twaddle, M. L., Melnick, A., & Meier, D. E. (2020). National Consensus Project Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care (4th ed.). *Journal of Palliative Medicine*, 23(8), 1080–1083.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2019). *Family nursing: Research, theory, and practice* (6th ed.). Pearson.
- Gross, J. J. (2019). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry*, 30(1), 1–26.

- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2021). Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing (15th ed.). Wolters Kluwer.
- Hudson, P., Remedios, C., & Thomas, K. (2018). A systematic review of psychosocial interventions for family *caregivers* of palliative care patients. *BMC Palliative Care*, 17(1), 1–15.
- Kent, E. E., Ornstein, K. A., & Dionne-Odom, J. N. (2021). The family caregiving crisis meets an actual pandemic. *Journal of Pain and Symptom Management*, 61(1), e66–e69.
- Maglaya, A. S. (2009). *Nursing practice in the community* (5th ed.). Argonauta Corporation.
- Mealer, M., Jones, J., & Moss, M. (2017). A qualitative study of resilience and posttraumatic stress disorder in United States ICU nurses. *Intensive Care Medicine*, 43(10), 1445–1451.
- Northouse, L. L., Katapodi, M. C., Song, L., Zhang, L., & Mood, D. W. (2020). Interventions with family *caregivers* of cancer patients: Meta-analysis of randomized trials. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 70(2), 127–150.
- Pennebaker, J. W. (2018). Expressive writing in psychological science. *Perspectives on Psychological Science*, 13(2), 226–229.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2020). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI). Jakarta: DPP PPNI.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of Nursing*. Elsevier.
- Smeltzer, S. C., Bare, B., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2020). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing*. Wolters Kluwer.
- Stacey, D., Légaré, F., Lewis, K., Barry, M. J., Bennett, C. L., Eden, K. B., ... & Trevena, L. (2017). Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4).
- Taylor, C., Lillis, C., & Lynn, P. (2020). *Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Person-Centered Care* (9th ed.). Wolters Kluwer.

Worden, J. W. (2018). *Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook for the Mental Health Practitioner* (5th ed.). Springer Publishing.

World Health Organization. (2023). *Palliative Care*. Geneva: WHO.

BAB 5

MODEL LAYANAN PALIATIF, HOME CARE, DAN STUDI KASUS TERINTEGRASI

CPL

CPL dalam BAB ini Adalah

- CPL 1: Menguasai konsep dan filosofi keperawatan paliatif, pendekatan holistik, serta prinsip kualitas hidup dan *patient-centered care*.
- CPL 2: Mampu melakukan penilaian paliatif komprehensif (fisik, psikologis, sosial, spiritual) dan mengidentifikasi kebutuhan prioritas secara sistematis.
- CPL 4: Mampu melakukan komunikasi paliatif (kabar sulit, perencanaan perawatan/ACP) serta kolaborasi interprofesional dan advokasi pasien–keluarga.
- CPL 5: Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitivitas budaya, dan dukungan spiritual dalam asuhan paliatif termasuk akhir hayat.
- CPL 6: Mampu mengevaluasi luaran paliatif, melakukan dokumentasi, *discharge/home care planning*, serta dukungan caregiver dan bereavement berbasis kebutuhan.

CPMK

CPMK dalam bab ini Adalah

- CPMK 2: Melakukan identifikasi kebutuhan paliatif dan penilaian komprehensif (fisik–psikologis–sosial–spiritual) serta menetapkan prioritas kebutuhan.
- CPMK 6: Menginisiasi kolaborasi interprofesional, dukungan spiritual–budaya, serta advokasi dan koordinasi layanan (home care/rujukan).
- CPMK 7: Mengevaluasi luaran paliatif, menyusun dokumentasi dan rencana tindak lanjut, serta melakukan refleksi perbaikan mutu layanan berbasis indikator.

Sub CPMK

Sub CPMK dalam BAB ini Adalah:

- Sub-CPMK 1: 14.1 Mengidentifikasi model layanan paliatif dan kriteria rujukan/home care sesuai kebutuhan pasien.
- Sub-CPMK 2: 14.2 Menyusun rencana koordinasi layanan dan laporan kasus paliatif terintegrasi berbasis indikator luaran.

A. Peran Layanan Paliatif dalam Sistem Kesehatan Modern

Perkembangan sistem kesehatan modern tidak hanya ditandai oleh kemajuan teknologi diagnostik dan terapeutik, tetapi juga oleh meningkatnya perhatian terhadap kualitas hidup pasien, khususnya pada mereka yang hidup dengan penyakit kronis, progresif, dan mengancam jiwa (Ferrell et al., 2018). Dalam konteks ini, layanan paliatif hadir sebagai pendekatan yang menempatkan pasien sebagai pusat pelayanan, dengan fokus tidak hanya pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada pengelolaan gejala, dukungan psikososial, serta pemenuhan kebutuhan spiritual (Megari, 2013).

Layanan paliatif memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan karena menjembatani kesenjangan antara perawatan kuratif dan kebutuhan pasien yang tidak lagi dapat disembuhkan secara optimal (WHO, 2020). Banyak pasien dengan penyakit kronis lanjut, seperti kanker, penyakit jantung, penyakit paru, atau gangguan neurologis, mengalami beban gejala yang kompleks serta kebutuhan dukungan jangka panjang. Tanpa pendekatan paliatif, pelayanan kesehatan berisiko menjadi terfragmentasi, berorientasi semata pada intervensi medis, dan kurang memperhatikan aspek kenyamanan serta martabat pasien (Kluger et al., 2023).

Dalam praktiknya, pendekatan ini tidak terbatas pada fase akhir kehidupan, tetapi dapat diberikan sejak awal diagnosis penyakit serius dan berjalan secara paralel dengan terapi kuratif. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap masalah fisik, emosional, sosial, dan spiritual, sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkesinambungan. Dengan demikian, pelayanan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga, sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berpusat pada nilai-nilai pasien. Selain itu, pelayanan tersebut memainkan peran penting dalam mendukung efisiensi sistem kesehatan. Pendekatan yang menekankan pengelolaan gejala, komunikasi efektif, serta perencanaan perawatan yang matang dapat mengurangi penggunaan layanan kesehatan yang tidak perlu, seperti rawat inap berulang atau intervensi yang tidak sesuai dengan kondisi pasien. Dalam hal ini, integrasi layanan paliatif ke dalam sistem kesehatan menjadi salah satu indikator mutu pelayanan yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan pasien (Temel et al., 2017).

Perawat sebagai bagian dari tim interprofesional memiliki posisi yang sangat strategis dalam implementasi pendekatan paliatif. Perawat tidak hanya berperan dalam memberikan asuhan langsung, tetapi juga dalam melakukan pengkajian komprehensif, koordinasi layanan, edukasi pasien dan keluarga, serta memastikan

kesinambungan perawatan antar berbagai setting pelayanan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai model layanan paliatif, termasuk home care dan koordinasi antar layanan, menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa keperawatan (Anita et al., 2025).

Bab ini disusun untuk memberikan pemahaman yang terintegrasi mengenai model layanan paliatif dalam sistem kesehatan, termasuk pelayanan berbasis rumah sakit, komunitas, dan *home care*. Selain itu, bab ini juga menekankan pentingnya koordinasi layanan, perencanaan pulang (*discharge planning*), serta dokumentasi dan evaluasi sebagai bagian dari kesinambungan perawatan. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mampu tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mengaplikasikannya dalam konteks praktik klinik secara nyata dan berkelanjutan.

B. Pentingnya Kesenambungan Pelayanan (Continuity of Care)

Kesenambungan pelayanan (*continuity of care*) merupakan salah satu prinsip utama dalam layanan paliatif yang menekankan bahwa perawatan pasien harus berlangsung secara terintegrasi, berkelanjutan, dan tidak terputus meskipun terjadi perpindahan setting pelayanan. Pasien dengan penyakit kronis dan kondisi yang membatasi kehidupan sering kali membutuhkan layanan dari berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit, layanan rawat jalan, hingga perawatan di rumah. Tanpa koordinasi yang baik, perpindahan ini berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi, duplikasi tindakan, bahkan risiko kesalahan dalam pemberian asuhan (Morey et al., 2020).

Dalam konteks paliatif, kesinambungan pelayanan tidak hanya berkaitan dengan alur rujukan antar fasilitas, tetapi juga mencakup konsistensi pendekatan dalam memenuhi kebutuhan pasien secara holistik. Perubahan kondisi pasien yang bersifat dinamis menuntut adanya komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan serta keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, setiap rencana perawatan yang telah disusun dapat dilanjutkan secara konsisten di berbagai setting pelayanan tanpa kehilangan tujuan utama, yaitu peningkatan kualitas hidup pasien (Eerden et al., 2017).

Penerapan *continuity of care* juga berperan penting dalam mencegah fragmentasi layanan yang sering terjadi pada pasien dengan kondisi kompleks. Ketidakterpaduan pelayanan dapat menyebabkan pasien menerima intervensi yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, mengalami rawat inap berulang, atau tidak mendapatkan dukungan yang memadai setelah pulang dari fasilitas kesehatan. Melalui pendekatan yang berkesinambungan, tenaga kesehatan dapat memastikan bahwa setiap tahap perawatan saling terhubung, mulai dari pengkajian awal,

perencanaan, implementasi, hingga evaluasi dan tindak lanjut di rumah atau komunitas (Sumpter et al., 2022).

Perawat memiliki peran sentral dalam menjaga kesinambungan pelayanan, terutama sebagai penghubung antar layanan dan advokat bagi pasien. Perawat berkontribusi dalam memastikan bahwa informasi klinis terdokumentasi dengan baik, rencana perawatan dikomunikasikan secara jelas kepada tim dan keluarga, serta kebutuhan pasien tetap terpantau setelah terjadi transisi layanan. Kemampuan ini menjadi semakin penting dalam konteks *home care*, di mana keberhasilan perawatan sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan *caregiver* (Karam et al., 2021).

Dengan demikian, kesinambungan pelayanan bukan sekadar aspek administratif dalam sistem kesehatan, tetapi merupakan elemen kunci yang menentukan kualitas, keamanan, dan keberhasilan layanan paliatif secara keseluruhan. Pemahaman yang baik mengenai konsep ini akan membantu mahasiswa dalam melihat perawatan pasien secara utuh, tidak terpisah-pisah, serta mampu mengintegrasikan berbagai komponen layanan dalam praktik keperawatan yang berpusat pada pasien.

C. Transisi Perawatan: Rumah Sakit Rumah Komunitas

Dalam pendekatan paliatif, proses perawatan pasien tidak berhenti ketika pasien keluar dari rumah sakit, melainkan berlanjut dalam berbagai setting pelayanan, termasuk perawatan di rumah dan dukungan di komunitas. Transisi perawatan dari rumah sakit ke rumah atau komunitas merupakan fase yang krusial karena pada tahap ini pasien dan keluarga mulai mengambil peran yang lebih besar dalam pengelolaan kondisi kesehatan sehari-hari. Tanpa persiapan yang memadai, fase transisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan, ketidakpatuhan terhadap rencana perawatan, serta peningkatan risiko komplikasi (S. Cruz et al., 2025).

Perpindahan antar setting pelayanan sering kali melibatkan perubahan dalam pola asuhan, sumber daya yang tersedia, serta tingkat pengawasan tenaga kesehatan. Di rumah sakit, pasien mendapatkan pemantauan intensif dengan dukungan fasilitas yang lengkap, sedangkan di rumah, sebagian besar tanggung jawab perawatan dialihkan kepada keluarga atau *caregiver*. Oleh karena itu, keberhasilan transisi sangat bergantung pada kesiapan pasien dan keluarga, kejelasan rencana perawatan, serta efektivitas komunikasi antara tenaga kesehatan dan pihak yang terlibat dalam perawatan lanjutan. Dalam konteks ini, perencanaan transisi yang baik harus dimulai sejak pasien masih berada di rumah sakit (Barbosa et al., 2023). Tenaga kesehatan perlu memastikan bahwa pasien dan keluarga memahami kondisi penyakit, tujuan perawatan, serta tindakan yang perlu dilakukan

di rumah, termasuk pengelolaan gejala, penggunaan obat, dan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan. Selain itu, koordinasi dengan layanan lanjutan, seperti home care atau fasilitas kesehatan di komunitas, menjadi bagian penting untuk menjamin kesinambungan pelayanan. Transisi yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti *readmisi* yang tidak perlu, ketidaksesuaian terapi, hingga penurunan kualitas hidup pasien. Sebaliknya, transisi yang direncanakan secara sistematis dan terkoordinasi akan membantu pasien menjalani perawatan dengan lebih aman, nyaman, dan bermakna. Dalam hal ini, pendekatan paliatif menekankan pentingnya kesinambungan hubungan terapeutik serta dukungan berkelanjutan, sehingga pasien tidak merasa “ditinggalkan” setelah keluar dari rumah sakit (Morey et al., 2020).

Perawat memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses transisi ini, terutama melalui edukasi, koordinasi layanan, serta pemantauan tindak lanjut. Dengan memahami dinamika transisi perawatan, mahasiswa diharapkan mampu melihat bahwa asuhan keperawatan tidak bersifat episodik, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan dan terintegrasi lintas setting pelayanan.

D. Peran Perawat dalam Koordinasi Layanan Paliatif

Pendekatan paliatif yang dilakukan dengan koordinasi antar berbagai komponen pelayanan merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan asuhan. Kompleksitas kebutuhan pasien, yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, menuntut keterlibatan berbagai profesi kesehatan dalam satu kesatuan tim. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran strategis sebagai penghubung yang memastikan bahwa setiap komponen layanan berjalan secara selaras dan berfokus pada kebutuhan pasien (Siouta et al., 2016).

Peran koordinatif perawat tidak hanya terbatas pada lingkungan rumah sakit, tetapi juga meluas hingga ke layanan berbasis komunitas dan perawatan di rumah. Perawat berkontribusi dalam mengintegrasikan informasi klinis, menyampaikan rencana perawatan kepada pasien dan keluarga, serta menjembatani komunikasi antar anggota tim kesehatan. Dengan demikian, perawat membantu mencegah terjadinya kesenjangan informasi yang dapat berdampak pada kualitas dan keamanan pelayanan. Selain itu, perawat berperan sebagai advokat bagi pasien, terutama dalam memastikan bahwa keputusan perawatan yang diambil sejalan dengan nilai, preferensi, dan kondisi pasien. Dalam situasi di mana pasien menghadapi penyakit yang progresif dan kompleks, kemampuan perawat dalam berkomunikasi secara empatik dan efektif menjadi sangat penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan bersama (*shared decision-making*). Perawat juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan yang mungkin tidak

terungkap secara langsung, seperti dukungan emosional atau kebutuhan spiritual, dan mengoordinasikan layanan yang sesuai (Karam et al., 2021).

Dalam proses transisi layanan, perawat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana perawatan dapat dilanjutkan secara konsisten di setting berikutnya. Hal ini mencakup pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga, koordinasi dengan layanan lanjutan seperti home care, serta pemantauan tindak lanjut setelah pasien kembali ke rumah. Peran ini menuntut kemampuan klinis, komunikasi, serta pemahaman sistem layanan kesehatan secara menyeluruh. Dengan demikian, perawat dalam layanan paliatif tidak hanya berfungsi sebagai pemberi asuhan langsung, tetapi juga sebagai koordinator layanan yang memastikan kesinambungan, keamanan, dan kualitas perawatan (Mawarti & Simatupang, 2024). Pemahaman terhadap peran ini menjadi penting bagi mahasiswa keperawatan agar mampu berkontribusi secara optimal dalam tim interprofesional serta memberikan asuhan yang terintegrasi dan mampu mengaplikasikannya secara terintegrasi dalam berbagai setting pelayanan, sebagai bagian dari praktik keperawatan paliatif yang berkesinambungan dan berpusat pada pasien.

E. Definisi Model Layanan Paliatif

Model layanan paliatif merupakan suatu kerangka sistematis yang menggambarkan bagaimana pelayanan paliatif diselenggarakan dalam berbagai setting pelayanan kesehatan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pasien secara komprehensif dan berkesinambungan. Model ini tidak hanya mencakup bentuk layanan yang diberikan, tetapi juga mengatur bagaimana interaksi antar tenaga kesehatan, alur pelayanan, serta keterlibatan pasien dan keluarga dalam proses perawatan (Hui & Bruera, 2020).

Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, model layanan paliatif dikembangkan untuk memastikan pasien dengan penyakit kronis, progresif, dan mengancam jiwa memperoleh perawatan yang tidak terfragmentasi. Pendekatan ini menekankan integrasi antara berbagai tingkat pelayanan, mulai dari layanan berbasis rumah sakit, layanan rawat jalan, hingga perawatan di rumah dan komunitas. Dengan demikian, model layanan paliatif berfungsi sebagai panduan dalam mengoordinasikan berbagai komponen pelayanan agar tetap selaras dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Lebih lanjut, model ini berorientasi pada pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Hal ini berarti bahwa pelayanan tidak hanya berfokus pada pengendalian gejala, tetapi juga pada dukungan emosional, pemenuhan kebutuhan spiritual, serta peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga. Oleh karena itu, model layanan ini menuntut adanya

kolaborasi interprofesional yang efektif, di mana berbagai tenaga kesehatan bekerja secara terpadu dalam satu sistem pelayanan (Liendra & Himaladin, 2023).

Selain sebagai kerangka konseptual, model layanan paliatif juga memiliki fungsi praktis dalam membantu tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam menentukan bentuk pelayanan yang paling sesuai dengan kondisi pasien. Pemilihan model layanan yang tepat akan memengaruhi efektivitas asuhan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keberlanjutan perawatan. Dalam hal ini, pemahaman terhadap berbagai model pendekatan ini menjadi dasar penting bagi mahasiswa keperawatan untuk dapat memberikan asuhan yang terintegrasi dan berpusat pada pasien. Dengan demikian, model pelayanan tersebut dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai bentuk pelayanan dalam satu alur yang berkesinambungan, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga (Hui & Bruera, 2020). Pemahaman terhadap konsep ini menjadi landasan bagi pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis model layanan paliatif serta penerapannya dalam praktik klinik.

F. Prinsip Dasar Model Layanan Paliatif

1. Pendekatan Holistik dalam Layanan Paliatif

Salah satu prinsip utama dalam model layanan paliatif adalah pendekatan holistik, yaitu cara pandang yang melihat pasien sebagai individu yang utuh, bukan hanya sebagai seseorang yang mengalami penyakit. Pendekatan ini menekankan bahwa kondisi kesehatan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik, tetapi juga oleh aspek psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan (Wantonoro et al., 2022). Oleh karena itu, pelayanan paliatif dirancang untuk memenuhi seluruh dimensi kebutuhan tersebut secara seimbang dan berkesinambungan. Dalam praktiknya, pendekatan holistik mengharuskan tenaga kesehatan untuk melakukan pengkajian yang komprehensif terhadap kondisi pasien. Aspek fisik mencakup pengelolaan nyeri dan gejala lain yang mengganggu kenyamanan, sementara aspek psikologis berkaitan dengan respons emosional pasien seperti kecemasan, ketakutan, atau depresi. Aspek sosial melibatkan peran keluarga, dukungan lingkungan, serta kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi proses perawatan, sedangkan aspek spiritual mencakup makna hidup, keyakinan, dan harapan pasien yang sering kali menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi penyakit.

Pendekatan holistik juga menempatkan keluarga sebagai bagian integral dari unit perawatan. Dalam konteks paliatif, keluarga tidak hanya berperan sebagai pendamping, tetapi juga sebagai *caregiver* yang terlibat langsung dalam perawatan sehari-hari, terutama pada *setting home care*. Oleh karena itu,

kebutuhan keluarga, baik dalam bentuk edukasi, dukungan emosional, maupun kesiapan dalam merawat pasien, perlu menjadi perhatian dalam perencanaan layanan. Penerapan prinsip holistik menuntut adanya kolaborasi interprofesional yang efektif. Tidak satu pun tenaga kesehatan dapat memenuhi seluruh kebutuhan pasien secara mandiri. Perawat, dokter, psikolog, pekerja sosial, dan rohaniawan perlu bekerja secara terpadu untuk memberikan asuhan yang menyeluruh. Dalam hal ini, perawat sering kali berperan sebagai koordinator yang memastikan bahwa setiap aspek kebutuhan pasien teridentifikasi dan ditangani dengan tepat (Xu et al., 2024).

Pendekatan holistik juga berimplikasi pada cara tenaga kesehatan dalam berkomunikasi dan mengambil keputusan. Keputusan klinis tidak hanya didasarkan pada kondisi medis, tetapi juga mempertimbangkan nilai, preferensi, dan tujuan hidup pasien. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan menjadi lebih personal, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Dengan memahami prinsip holistik, mahasiswa diharapkan mampu melihat bahwa layanan paliatif bukan sekadar pengelolaan gejala, tetapi merupakan upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam pengembangan model layanan paliatif yang terintegrasi dan berpusat pada pasien.

2. Patient-Centered Care

Pendekatan *patient-centered care* merupakan prinsip fundamental dalam layanan paliatif yang menempatkan pasien sebagai pusat dari seluruh proses perawatan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan dan tindakan pelayanan harus didasarkan pada kebutuhan, nilai, preferensi, serta tujuan hidup pasien, bukan semata-mata pada pertimbangan klinis atau prosedur medis yang bersifat umum (Galekop et al., 2019). Dalam konteks paliatif, pendekatan ini menjadi sangat penting karena pasien sering kali berada pada kondisi penyakit yang kompleks dan progresif, di mana tujuan perawatan tidak lagi berfokus pada penyembuhan, melainkan pada peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, pemahaman terhadap apa yang dianggap bermakna oleh pasien, baik terkait kenyamanan, harapan, maupun pilihan dalam menjalani perawatan, menjadi dasar dalam penyusunan rencana asuhan.

Penerapan *patient-centered care* menuntut adanya komunikasi yang terbuka, empatik, dan berkesinambungan antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolaboratif melalui pendekatan *shared decision-making*, di mana pasien diberikan kesempatan untuk memahami kondisi yang dihadapi, pilihan tindakan yang tersedia, serta konsekuensi dari setiap Keputusan (Hashim, 2017). Dalam hal ini, perawat

memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi, memastikan informasi dipahami dengan baik, serta mendukung pasien dalam mengekspresikan preferensinya. Selain itu, pendekatan ini juga mengakui pentingnya konteks individu pasien, termasuk latar belakang budaya, keyakinan, serta kondisi sosial yang memengaruhi cara pasien memandang penyakit dan perawatan. Dengan mempertimbangkan aspek tersebut, pelayanan yang diberikan menjadi lebih personal dan relevan dengan kebutuhan pasien. Hal ini juga membantu meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga serta memperkuat hubungan terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan.

Dalam praktik layanan paliatif, pendekatan ini tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan keluarga sebagai bagian integral dari sistem perawatan pasien. Meskipun fokus utama tetap pada pasien, keluarga memiliki peran penting dalam membantu memahami kebutuhan pasien, mendukung proses perawatan, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pendekatan ini sering kali berkembang menjadi *patient- and family-centered care* dalam praktik nyata. Dengan demikian, prinsip *patient-centered care* menegaskan bahwa layanan paliatif harus bersifat individual, adaptif, dan berorientasi pada makna hidup pasien. Pemahaman terhadap prinsip ini akan membantu mahasiswa keperawatan dalam memberikan asuhan yang tidak hanya tepat secara klinis, tetapi juga bermakna dan sesuai dengan kebutuhan pasien secara menyeluruh.

3. Kolaborasi Interprofesional (Interprofessional Collaboration)

Kolaborasi interprofesional merupakan prinsip esensial dalam model layanan paliatif yang menekankan pentingnya kerja sama antar berbagai profesi kesehatan dalam memberikan asuhan yang komprehensif. Kompleksitas kebutuhan pasien paliatif, yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, tidak dapat dipenuhi secara optimal oleh satu profesi saja. Oleh karena itu, pendekatan tim menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan layanan paliatif (Kesonen et al., 2022).

Dalam praktiknya, tim paliatif terdiri atas dokter, perawat, psikolog, pekerja sosial, rohaniawan, serta profesi lain sesuai kebutuhan pasien. Setiap anggota tim memiliki peran dan kompetensi yang saling melengkapi, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih menyeluruh. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga integratif, di mana setiap keputusan dan tindakan dirumuskan secara bersama dengan mempertimbangkan berbagai perspektif profesional. Efektivitas kolaborasi interprofesional sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka, saling menghargai peran masing-masing profesi, serta adanya tujuan bersama yang berfokus pada pasien. Dalam konteks paliatif, tujuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengendalian gejala, tetapi juga

peningkatan kualitas hidup dan penghormatan terhadap nilai serta preferensi pasien. Dengan demikian, kolaborasi yang baik akan meminimalkan konflik antar profesi, mencegah duplikasi tindakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan (C. Cruz et al., 2025).

Perawat memiliki peran strategis dalam tim interprofesional, terutama sebagai koordinator yang menghubungkan berbagai komponen layanan. Perawat berkontribusi dalam menyampaikan informasi klinis, memfasilitasi komunikasi antar anggota tim, serta memastikan bahwa rencana perawatan dapat diimplementasikan secara konsisten di berbagai setting pelayanan. Peran ini menjadi semakin penting dalam situasi transisi layanan, seperti dari rumah sakit ke home care, di mana koordinasi yang efektif sangat menentukan keberhasilan perawatan lanjutan. Selain itu, kolaborasi interprofesional juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan berimbang. Setiap profesi dapat memberikan sudut pandang yang berbeda, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek medis, tetapi juga aspek psikososial dan spiritual pasien. Hal ini sejalan dengan prinsip layanan paliatif yang berorientasi pada kebutuhan pasien secara menyeluruh (Wise et al., 2021). Dengan demikian, kolaborasi interprofesional menjadi fondasi utama dalam model layanan paliatif yang memungkinkan penyelenggaraan asuhan secara terpadu, efektif, dan berpusat pada pasien. Pemahaman terhadap prinsip ini akan membantu mahasiswa keperawatan dalam bekerja secara kolaboratif dalam tim serta berkontribusi secara optimal dalam pelayanan paliatif.

G. Jenis Model Layanan Paliatif

1. Layanan Berbasis Rumah Sakit (*Hospital-Based Palliative Care*)

Layanan paliatif berbasis rumah sakit merupakan salah satu model utama dalam penyelenggaraan perawatan paliatif yang diberikan kepada pasien selama menjalani perawatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Model ini biasanya diterapkan pada pasien dengan kondisi penyakit serius yang membutuhkan pemantauan intensif, penatalaksanaan gejala yang kompleks, serta intervensi medis yang tidak dapat dilakukan di luar rumah sakit. Dalam praktiknya, pelayanan tersebut di rumah sakit dapat diberikan melalui beberapa bentuk, seperti konsultasi tim paliatif, perawatan terpadu di ruang rawat inap, maupun unit khusus paliatif apabila tersedia. Tim paliatif bekerja secara kolaboratif dengan tim perawatan utama untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien, mengelola gejala, serta memberikan dukungan psikososial dan spiritual kepada pasien dan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara perawatan kuratif dan paliatif secara simultan sesuai dengan kondisi pasien (Hui & Bruera, 2020).

Salah satu keunggulan layanan berbasis rumah sakit adalah ketersediaan sumber daya yang lebih lengkap, baik dari segi tenaga kesehatan maupun fasilitas penunjang. Hal ini memungkinkan penanganan gejala yang lebih cepat dan tepat, termasuk pada kondisi nyeri berat, sesak napas, atau komplikasi lain yang memerlukan intervensi segera. Selain itu, keberadaan tim interprofesional di rumah sakit mendukung pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi. Namun demikian, pelayanan tersebut di rumah sakit juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kesinambungan perawatan setelah pasien dipulangkan. Tanpa perencanaan yang baik, pasien berisiko mengalami kesenjangan layanan saat berpindah ke perawatan di rumah atau komunitas. Oleh karena itu, layanan ini perlu diintegrasikan dengan sistem rujukan dan *home care* untuk memastikan keberlanjutan asuhan (Vogel et al., 2019).

Peran perawat dalam pendekatan ini yang berbasis rumah sakit sangat penting, terutama dalam melakukan pengkajian komprehensif, pemantauan kondisi pasien, serta koordinasi dengan tim interprofesional. Perawat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga sebagai bagian dari persiapan transisi perawatan ke setting berikutnya.

Untuk memperjelas karakteristik model ini, berikut ringkasan layanan paliatif berbasis rumah sakit:

Tabel 5.1 Karakteristik Layanan Paliatif Berbasis Rumah Sakit

Aspek	Deskripsi
Setting pelayanan	Rumah sakit (rawat inap, rawat jalan, atau unit khusus paliatif)
Tujuan utama	Pengelolaan gejala kompleks dan dukungan komprehensif
Jenis pasien	Pasien dengan kondisi akut atau membutuhkan pemantauan intensif
Kelebihan	Fasilitas lengkap, tim interprofesional tersedia, respons cepat
Keterbatasan	Ketergantungan pada fasilitas, risiko terputus saat pulang
Peran perawat	Pengkajian, monitoring, edukasi, koordinasi tim

Dengan demikian, layanan paliatif berbasis rumah sakit merupakan fondasi penting dalam sistem pelayanan paliatif, terutama pada fase ketika pasien membutuhkan penanganan intensif. Pemahaman terhadap model ini akan membantu mahasiswa dalam menentukan kapan layanan rumah sakit menjadi pilihan yang tepat serta bagaimana mengintegrasikannya dengan layanan lain untuk menjamin kesinambungan perawatan.

2. Layanan Berbasis Komunitas (Community-Based Palliative Care)

Layanan paliatif berbasis komunitas merupakan model pelayanan yang diberikan kepada pasien di lingkungan tempat tinggalnya dengan melibatkan sumber daya yang tersedia di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada pasien, sehingga perawatan dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi sosial serta budaya setempat. Dalam model ini, pelayanan tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan formal, tetapi juga melibatkan berbagai elemen komunitas, seperti puskesmas, kader kesehatan, relawan, serta organisasi sosial. Peran komunitas menjadi sangat penting dalam memberikan dukungan berkelanjutan kepada pasien dan keluarga, terutama dalam hal pemantauan kondisi, pendampingan, serta penguatan aspek psikososial dan spiritual (Rosenberg et al., 2024).

Layanan berbasis komunitas umumnya ditujukan bagi pasien yang berada dalam kondisi relatif stabil, namun tetap membutuhkan pemantauan dan dukungan jangka panjang. Pelayanan dapat dilakukan melalui kunjungan berkala oleh tenaga kesehatan, pemantauan oleh kader, serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan apabila terjadi perburukan kondisi. Dengan demikian, model ini memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan kondisi pasien serta mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius (Kayentao et al., 2023).

Salah satu keunggulan utama dari layanan berbasis komunitas adalah kemampuannya dalam meningkatkan akses terhadap pelayanan, terutama bagi pasien yang memiliki keterbatasan mobilitas atau akses ke rumah sakit. Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat keterlibatan keluarga dan lingkungan sekitar dalam proses perawatan, sehingga pasien dapat tetap berada dalam lingkungan yang familiar dan mendukung secara emosional. Namun demikian, layanan berbasis komunitas juga memiliki tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya, variasi kompetensi tenaga pendukung di masyarakat, serta koordinasi antar layanan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem rujukan dan supervisi yang baik dari tenaga kesehatan profesional untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga (Gizaw et al., 2022).

Perawat memiliki peran penting dalam model ini, terutama sebagai fasilitator dan koordinator yang menghubungkan layanan kesehatan formal dengan sumber daya di komunitas. Perawat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada keluarga dan kader kesehatan, melakukan pemantauan kondisi pasien, serta memastikan bahwa rencana perawatan dijalankan secara konsisten. Untuk memperjelas karakteristik layanan ini, berikut ringkasannya:

Tabel 5.2 Karakteristik Layanan Paliatif Berbasis Komunitas

Aspek	Deskripsi
Setting pelayanan	Komunitas (puskesmas, lingkungan tempat tinggal pasien)
Tujuan utama	Meningkatkan akses dan kesinambungan perawatan
Jenis pasien	Pasien dengan kondisi relatif stabil dan membutuhkan pemantauan
Kelebihan	Dekat dengan pasien, berbasis lingkungan, dukungan sosial kuat
Keterbatasan	Sumber daya terbatas, variasi kompetensi, koordinasi menantang
Peran perawat	Edukasi, koordinasi, monitoring, penghubung layanan

Dengan demikian, layanan paliatif berbasis komunitas merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan yang mendukung kesinambungan perawatan di luar rumah sakit. Model ini memperkuat peran masyarakat dalam perawatan pasien serta menjadi jembatan antara layanan formal dan kebutuhan nyata pasien di lingkungan sehari-hari.

3. Hospice Care

Hospice care merupakan model layanan paliatif yang secara khusus ditujukan bagi pasien yang berada pada fase akhir kehidupan (*end-of-life care*), di mana fokus utama pelayanan tidak lagi pada upaya kuratif, melainkan pada peningkatan kenyamanan, kualitas hidup, serta penghormatan terhadap martabat pasien. Pendekatan ini menekankan bahwa kematian merupakan bagian alami dari kehidupan, sehingga perawatan difokuskan pada dukungan yang menyeluruh bagi pasien dan keluarga dalam menghadapi fase tersebut (Abbaspour & Heydari, 2021).

Layanan *hospice* dapat diberikan di berbagai setting, termasuk fasilitas khusus hospice, rumah sakit, maupun di rumah pasien, tergantung pada sistem pelayanan yang tersedia. Namun, ciri khas dari model ini adalah adanya pendekatan yang sangat berorientasi pada kenyamanan (*comfort care*), pengendalian gejala, serta dukungan emosional dan spiritual yang intensif. Dalam praktiknya, intervensi medis yang bersifat invasif atau agresif umumnya diminimalkan, kecuali jika diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Salah satu komponen penting dalam *hospice care* adalah dukungan terhadap keluarga, tidak hanya selama proses perawatan, tetapi juga setelah pasien meninggal dunia melalui layanan *bereavement support*. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan tersebut tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga pada keluarga sebagai bagian dari unit perawatan yang mengalami dampak emosional

dan psikologis yang signifikan. Keunggulan pelayanan tersebut terletak pada pendekatannya yang komprehensif dan berpusat pada kualitas hidup, sehingga pasien dapat menjalani fase akhir kehidupan dengan lebih bermakna dan bermartabat. Selain itu, model ini juga memberikan ruang bagi pasien untuk menentukan preferensi terkait tempat perawatan, intervensi yang diinginkan, serta dukungan spiritual yang sesuai dengan keyakinannya (Abbaspour & Heydari, 2021).

Namun demikian, penerapan hospice care masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat yang masih mengaitkan hospice dengan “menyerah” terhadap pengobatan, serta keterbatasan fasilitas khusus hospice di beberapa wilayah. Oleh karena itu, edukasi kepada pasien, keluarga, dan masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan penerimaan terhadap layanan ini. Perawat memiliki peran yang sangat sentral dalam hospice care, terutama dalam memberikan perawatan yang berfokus pada kenyamanan, melakukan pengelolaan gejala, serta memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga. Perawat juga berperan dalam memfasilitasi komunikasi terkait harapan pasien, membantu proses pengambilan keputusan, serta mendampingi keluarga dalam menghadapi proses kehilangan (Shalev et al., 2018). Untuk memperjelas karakteristik model ini, berikut ringkasannya:

Tabel 5.3 Karakteristik *Hospice Care*

Aspek	Deskripsi
Setting pelayanan	Fasilitas hospice, rumah sakit, atau rumah pasien
Tujuan utama	Meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pada fase akhir kehidupan
Jenis pasien	Pasien dengan kondisi terminal atau fase akhir kehidupan
Kelebihan	Fokus pada <i>comfort care</i> , dukungan emosional dan spiritual intensif
Keterbatasan	Ketersediaan fasilitas terbatas, persepsi masyarakat
Peran perawat	Pengelolaan gejala, dukungan emosional, komunikasi, pendampingan keluarga

Dengan demikian, *hospice care* merupakan model layanan paliatif yang memberikan perhatian khusus pada fase akhir kehidupan dengan pendekatan yang humanistik dan berpusat pada pasien. Pemahaman terhadap model ini penting bagi mahasiswa keperawatan agar mampu memberikan asuhan yang bermakna, menghormati pilihan pasien, serta mendukung keluarga dalam menghadapi proses kehilangan.

4. Home-Based Palliative Care (Perawatan Paliatif Berbasis Rumah)

Home-based palliative care merupakan model layanan paliatif yang diberikan kepada pasien di lingkungan rumah dengan tujuan mempertahankan kualitas hidup, kenyamanan, serta keberlanjutan perawatan di luar fasilitas kesehatan. Model ini memungkinkan pasien untuk menjalani perawatan dalam lingkungan yang familiar, dekat dengan keluarga, serta sesuai dengan preferensi dan nilai-nilai pribadi yang dimiliki. Dalam konteks pendekatan paliatif modern, perawatan berbasis rumah menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan pasien akan pelayanan yang berkesinambungan dan berpusat pada pasien. Banyak pasien dengan penyakit kronis dan kondisi terminal lebih memilih untuk dirawat di rumah dibandingkan di rumah sakit, terutama pada fase lanjut penyakit (Feliciano & Reis-Pina, 2024). Oleh karena itu, *home-based palliative care* hadir sebagai solusi yang mengintegrasikan aspek klinis dengan dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Pelayanan dalam model ini mencakup berbagai intervensi, antara lain pengelolaan gejala, pemantauan kondisi pasien, edukasi kepada keluarga, serta dukungan psikososial dan spiritual. Tenaga kesehatan, khususnya perawat, melakukan kunjungan rumah secara berkala untuk melakukan pengkajian, memberikan intervensi yang diperlukan, serta mengevaluasi perkembangan kondisi pasien. Selain itu, komunikasi jarak jauh juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pemantauan berkelanjutan (Nguyen et al., 2023).

Keunggulan utama dari *home-based palliative care* adalah kemampuannya dalam meningkatkan kenyamanan pasien serta memperkuat keterlibatan keluarga dalam proses perawatan. Lingkungan rumah yang lebih tenang dan familiar dapat memberikan efek positif terhadap kondisi psikologis pasien. Di sisi lain, keluarga memiliki kesempatan untuk berperan aktif sebagai caregiver, sehingga hubungan emosional antara pasien dan keluarga dapat terjaga dengan baik. Namun demikian, model ini juga memiliki tantangan, terutama terkait dengan kesiapan keluarga dalam merawat pasien, keterbatasan fasilitas medis di rumah, serta kebutuhan koordinasi yang intensif dengan tenaga kesehatan. Risiko keselamatan pasien juga perlu menjadi perhatian, terutama dalam pengelolaan obat, pencegahan komplikasi, serta pengenalan tanda bahaya yang memerlukan eskalasi ke fasilitas Kesehatan (Nguyen et al., 2023).

Perawat memiliki peran yang sangat dominan dalam *home-based palliative care*, baik sebagai pemberi asuhan langsung maupun sebagai koordinator layanan. Perawat bertanggung jawab dalam melakukan pengkajian kondisi pasien dan lingkungan rumah, memberikan edukasi kepada *caregiver*, memfasilitasi komunikasi dengan tim kesehatan, serta memastikan kesinambungan perawatan.

Selain itu, perawat juga berperan dalam mendukung keluarga secara emosional dan membantu mereka menghadapi beban caregiving (Wu et al., 2022). Untuk memperjelas karakteristik model ini, berikut ringkasannya:

Tabel 5.4 Karakteristik *Home-Based Palliative Care*

Aspek	Deskripsi
Setting pelayanan	Rumah pasien
Tujuan utama	Meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan di lingkungan rumah
Jenis pasien	Pasien kronis, progresif, atau terminal yang relatif stabil
Kelebihan	Nyaman, berpusat pada pasien, keterlibatan keluarga tinggi
Keterbatasan	Keterbatasan fasilitas, ketergantungan <i>caregiver</i> , risiko keselamatan
Peran perawat	Pengkajian, edukasi, monitoring, koordinasi, dukungan keluarga

Dengan demikian, *home-based palliative care* merupakan model layanan yang menekankan kesinambungan perawatan, keterlibatan keluarga, serta pendekatan yang lebih personal dan humanistik. Pemahaman terhadap model ini menjadi sangat penting bagi mahasiswa keperawatan, mengingat peran perawat yang dominan dalam memastikan kualitas dan keamanan perawatan di lingkungan rumah.

H. Karakteristik Setiap Model Layanan Paliatif

Setiap model layanan paliatif memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi tujuan pelayanan, populasi pasien yang dilayani, maupun kelebihan dan keterbatasannya. Pemahaman terhadap perbedaan ini penting agar tenaga kesehatan, khususnya perawat, dapat menentukan model layanan yang paling sesuai dengan kondisi klinis pasien serta konteks pelayanan yang tersedia (Ohana et al., 2023). Perbandingan karakteristik berbagai model layanan paliatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Perbandingan Model Layanan Paliatif

Model Layanan	Tujuan Layanan	Populasi Pasien	Kelebihan	Keterbatasan
<i>Hospital-Based</i>	Pengelolaan gejala kompleks	Pasien dengan	Fasilitas lengkap, akses	Ketergantungan pada fasilitas,

<i>Palliative Care</i>	dan stabilisasi kondisi pasien	kondisi akut atau membutuhkan pemantauan intensif	intervensi cepat, tim interprofesional tersedia	risiko terputus saat pulang
<i>Community-Based Palliative Care</i>	Meningkatkan akses dan kesinambungan pelayanan di masyarakat	Pasien dengan kondisi relatif stabil yang membutuhkan pemantauan jangka panjang	Dekat dengan pasien, berbasis lingkungan, dukungan sosial kuat	Sumber daya terbatas, variasi kompetensi, koordinasi menantang
<i>Hospice Care</i>	Meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pada fase akhir kehidupan	Pasien terminal atau fase akhir kehidupan	Fokus pada <i>comfort care</i> , dukungan emosional dan spiritual intensif	Ketersediaan fasilitas terbatas, persepsi masyarakat
<i>Home-Based Palliative Care</i>	Mempertahankan kualitas hidup dan kenyamanan di rumah	Pasien kronis, progresif, atau terminal yang relatif stabil	Lingkungan nyaman, keterlibatan keluarga tinggi, pelayanan personal	Ketergantungan <i>caregiver</i> , keterbatasan fasilitas, risiko keselamatan

Dengan pemahaman terhadap karakteristik masing-masing model layanan, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi pilihan layanan yang paling tepat sesuai dengan kondisi pasien. Dalam praktiknya, model-model tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam suatu sistem pelayanan yang terintegrasi. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai model layanan menjadi kompetensi penting dalam praktik keperawatan paliatif.

I. Konsep Home Care dalam Paliatif

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Home care dalam konteks paliatif merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di lingkungan rumah sebagai bagian dari kesinambungan perawatan. Layanan ini ditujukan bagi pasien dengan penyakit kronis, progresif, atau kondisi yang membatasi kehidupan, yang membutuhkan pemantauan dan intervensi berkelanjutan di luar fasilitas kesehatan. Pendekatan ini menempatkan rumah sebagai setting utama perawatan, dengan tetap mempertahankan standar pelayanan yang aman, terkoordinasi, dan berpusat pada pasien (Feliciano & Reis-Pina, 2024).

Ruang lingkup *home care paliatif* mencakup berbagai aspek pelayanan yang bersifat komprehensif dan holistik. Pelayanan tidak hanya terbatas pada tindakan klinis, tetapi juga meliputi pengelolaan gejala, dukungan psikologis, pendampingan sosial, serta pemenuhan kebutuhan spiritual pasien. Selain itu, layanan ini juga mencakup edukasi kepada keluarga atau *caregiver* terkait perawatan sehari-hari, penggunaan obat, serta pengenalan tanda bahaya yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Dalam praktiknya, pendekatan ini melibatkan koordinasi antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga, serta keterhubungan dengan fasilitas kesehatan rujukan apabila terjadi perubahan kondisi. Perawatan dilakukan melalui kunjungan rumah secara berkala maupun pemantauan berkelanjutan, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap masalah yang muncul serta intervensi yang tepat waktu. Dengan demikian, ruang lingkup pendekatan ini tidak hanya berfokus pada tindakan langsung, tetapi juga pada sistem koordinasi dan kesinambungan pelayanan (Seow & Bainbridge, 2018).

2. Tujuan Home Care Paliatif

Pelaksanaan *home care* dalam layanan paliatif memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga melalui pendekatan yang berpusat pada kenyamanan, keberlanjutan perawatan, serta dukungan yang menyeluruh. Tujuan ini tidak hanya berorientasi pada kondisi klinis pasien, tetapi juga pada pengalaman hidup pasien selama menjalani perawatan.

Secara lebih rinci menurut Seow & Bainbridge (2018) tujuan *home care paliatif* meliputi:

a. Meningkatkan kualitas hidup pasien

Melalui pengelolaan gejala yang optimal, dukungan emosional, serta pemenuhan kebutuhan spiritual, pasien diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan lebih bermakna meskipun dalam kondisi penyakit yang progresif.

b. Meningkatkan kenyamanan pasien

Perawatan di lingkungan rumah memungkinkan pasien berada dalam suasana yang familiar dan mendukung, sehingga dapat mengurangi stres dan meningkatkan rasa aman selama menjalani perawatan.

c. Mendukung keterlibatan keluarga dalam perawatan

Home care memberikan kesempatan kepada keluarga untuk berperan aktif sebagai *caregiver*, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka terhadap kondisi pasien dan cara merawatnya secara tepat.

d. Menjamin kesinambungan pelayanan

Layanan ini berfungsi sebagai penghubung antara perawatan di fasilitas kesehatan dengan perawatan di rumah, sehingga asuhan tetap berjalan secara konsisten dan tidak terputus.

Dengan demikian, pelayanan tersebut merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan yang tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga memperhatikan peran keluarga dan lingkungan sebagai bagian integral dari proses perawatan. Pemahaman terhadap konsep ini menjadi dasar bagi mahasiswa keperawatan dalam memberikan asuhan yang aman, terintegrasi, dan berpusat pada pasien di setting rumah.

J. Kriteria Pasien Home Care

Pemilihan pasien yang tepat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan *home care paliatif*. Tidak semua pasien dengan penyakit kronis atau kondisi terminal dapat langsung dialihkan ke perawatan di rumah tanpa pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, diperlukan kriteria tertentu untuk memastikan bahwa perawatan di rumah dapat berlangsung secara aman, efektif, dan berkesinambungan. Secara umum menurut Ribeiro et al (2024) kriteria pasien yang dapat menerima layanan *home care paliatif* meliputi beberapa aspek berikut:

1. Stabilitas Klinis Relatif

Pasien yang menjalani *home care* sebaiknya berada dalam kondisi klinis yang relatif stabil, meskipun tetap memiliki kebutuhan perawatan yang berkelanjutan. Stabilitas ini tidak berarti pasien bebas dari gejala, tetapi kondisi pasien cukup terkendali sehingga tidak memerlukan pemantauan intensif atau intervensi medis segera yang hanya dapat dilakukan di rumah sakit. Pasien dengan gejala yang masih dapat dikelola, seperti nyeri yang terkontrol, sesak ringan, atau kondisi umum yang tidak mengalami perburukan cepat, umumnya lebih sesuai untuk dirawat di rumah. Sebaliknya, pasien dengan kondisi akut atau komplikasi yang tidak stabil memerlukan perawatan di fasilitas kesehatan dengan dukungan yang lebih lengkap (Xu et al., 2024).

2. Dukungan Keluarga atau Caregiver

Ketersediaan dan kesiapan keluarga atau *caregiver* merupakan salah satu syarat utama dalam *home care paliatif*. Dalam setting rumah, sebagian besar perawatan sehari-hari akan dilakukan oleh keluarga, sehingga peran mereka menjadi sangat krusial dalam menjaga kualitas dan keselamatan perawatan. Keluarga diharapkan memiliki kesiapan dalam memahami kondisi pasien, mengikuti instruksi perawatan, serta mengenali tanda-tanda yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Selain itu, dukungan emosional dari keluarga juga berperan penting dalam meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan terhadap keluarga menjadi bagian integral dalam layanan *home care* (Xu et al., 2024).

3. Kebutuhan Perawatan Jangka Panjang

Pasien yang membutuhkan perawatan jangka panjang dengan fokus pada pengelolaan gejala dan peningkatan kualitas hidup merupakan kandidat yang sesuai untuk *home care paliatif*. Kondisi ini umumnya ditemukan pada pasien dengan penyakit kronis progresif atau kondisi terminal yang tidak lagi memerlukan intervensi kuratif intensif. Perawatan jangka panjang di rumah memungkinkan pasien mendapatkan pelayanan yang lebih personal dan berkelanjutan, tanpa harus mengalami rawat inap berulang yang dapat menambah beban fisik maupun psikologis. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan perawatan dengan kebutuhan dan preferensi pasien. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, tenaga kesehatan dapat menentukan kesesuaian pasien untuk menjalani *home care paliatif*. Penilaian ini tidak bersifat statis, melainkan perlu dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi pasien. Dengan demikian, perawatan yang diberikan tetap aman, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan pasien secara menyeluruh (Feliciano & Reis-Pina, 2024).

K. Peran Perawat dalam Home Care

Perawat memiliki peran yang sangat sentral dalam pelaksanaan *home care paliatif*, baik sebagai pemberi asuhan langsung maupun sebagai koordinator layanan. Dalam setting rumah, perawat tidak hanya berfokus pada tindakan klinis, tetapi juga harus mampu menyesuaikan asuhan dengan kondisi lingkungan, keterbatasan sumber daya, serta dinamika keluarga sebagai *caregiver*. Oleh karena itu, peran perawat dalam *home care* menurut Harini et al (2022) bersifat komprehensif dan mencakup berbagai aspek berikut:

1. Pengkajian Lingkungan Rumah

Pengkajian lingkungan rumah merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa perawatan dapat dilakukan secara aman dan efektif. Perawat

perlu menilai kondisi fisik rumah, seperti kebersihan, ventilasi, pencahayaan, serta ketersediaan ruang yang memadai untuk perawatan pasien. Selain itu, perawat juga perlu mengidentifikasi potensi risiko keselamatan, seperti risiko jatuh, penggunaan alat medis di rumah, serta keamanan penyimpanan obat. Aspek sosial juga menjadi bagian dari pengkajian, termasuk jumlah anggota keluarga, peran *caregiver*, serta dukungan yang tersedia. Hasil pengkajian ini menjadi dasar dalam menyusun rencana perawatan yang sesuai dengan kondisi nyata di rumah.

2. Manajemen Gejala di Rumah

Pengelolaan gejala merupakan fokus utama dalam *home care paliatif*. Perawat berperan dalam melakukan pengkajian gejala secara berkala, seperti nyeri, sesak napas, kelelahan, mual, atau gangguan tidur, serta memberikan intervensi yang sesuai untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Dalam setting rumah, perawat perlu menyesuaikan intervensi dengan sumber daya yang tersedia, termasuk penggunaan obat yang telah diresepkan serta teknik nonfarmakologis, seperti perubahan posisi, relaksasi, atau dukungan lingkungan. Perawat juga harus memastikan bahwa *caregiver* memahami cara memberikan perawatan yang aman serta mengetahui kapan harus melaporkan perubahan kondisi pasien.

3. Edukasi kepada Caregiver

Edukasi kepada *caregiver* merupakan bagian integral dari *home care paliatif*, mengingat sebagian besar perawatan sehari-hari dilakukan oleh keluarga. Perawat bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami terkait kondisi pasien, rencana perawatan, serta tindakan yang perlu dilakukan di rumah. Materi edukasi dapat meliputi cara pemberian obat, teknik perawatan dasar, pengenalan tanda bahaya, serta langkah yang harus diambil apabila terjadi perubahan kondisi pasien. Selain itu, perawat juga perlu memberikan dukungan emosional kepada *caregiver*, mengingat peran merawat pasien paliatif sering kali menimbulkan beban fisik dan psikologis.

4. Monitoring dan Follow-Up

Monitoring dan *follow-up* merupakan bagian penting dalam memastikan kesinambungan perawatan di rumah. Perawat melakukan kunjungan berkala untuk mengevaluasi kondisi pasien, menilai efektivitas intervensi, serta mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul selama perawatan. Selain kunjungan langsung, pemantauan juga dapat dilakukan melalui komunikasi jarak jauh untuk memastikan respons cepat terhadap perubahan kondisi pasien. Perawat juga berperan dalam melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan lain atau fasilitas rujukan apabila diperlukan tindakan lanjutan. Dengan demikian, *home care* tetap terhubung dengan sistem pelayanan kesehatan secara

keseluruhan. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, perawat berkontribusi dalam memastikan bahwa *home care paliatif* dapat berjalan secara aman, efektif, dan berpusat pada pasien. Pemahaman terhadap peran ini menjadi sangat penting bagi mahasiswa keperawatan agar mampu memberikan asuhan yang komprehensif serta menjaga kualitas dan keselamatan pasien dalam setting rumah.

L. Tantangan dan Risiko Home Care

Pelaksanaan *home care paliatif* memberikan banyak manfaat bagi pasien dan keluarga, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi secara cermat. Berbeda dengan setting rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap dan pengawasan intensif, perawatan di rumah berlangsung dalam kondisi yang lebih terbatas dan sangat bergantung pada kemampuan keluarga serta koordinasi layanan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap potensi kendala dan risiko menjadi penting untuk menjaga kualitas dan keamanan asuhan.

1. Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu tantangan utama dalam *home care* adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas, peralatan medis, maupun akses terhadap tenaga kesehatan. Tidak semua intervensi yang tersedia di rumah sakit dapat dilakukan di rumah, sehingga perawat perlu menyesuaikan rencana perawatan dengan kondisi yang ada. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kecepatan dan ketepatan penanganan apabila terjadi perubahan kondisi pasien. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, termasuk pemilihan intervensi yang realistis, penggunaan alat yang sesuai, serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan apabila diperlukan. Dalam konteks ini, perawat paliatif dituntut memiliki kemampuan klinis dan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif, mengingat kondisi pasien yang kompleks serta keterbatasan dukungan layanan di lingkungan rumah. Kemampuan untuk melakukan penilaian situasi secara cepat dan tepat menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan keamanan perawatan (Johannessen et al., 2020).

2. Risiko Keselamatan Pasien

Perawatan di rumah memiliki potensi risiko keselamatan yang berbeda dibandingkan dengan fasilitas kesehatan. Risiko tersebut dapat berupa kesalahan dalam pemberian obat, keterlambatan mengenali tanda bahaya, penggunaan alat yang tidak tepat, hingga kondisi lingkungan yang tidak aman, seperti risiko jatuh atau infeksi. Selain itu, keterbatasan pengawasan tenaga kesehatan secara langsung dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perawatan sehari-hari. Dalam situasi ini, *caregiver* sering menjadi pihak yang

berperan utama dalam memberikan perawatan, sehingga tingkat pengetahuan dan keterampilan mereka sangat memengaruhi keselamatan pasien.

Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi kunci utama, melalui edukasi yang tepat kepada *caregiver*, penyusunan prosedur perawatan yang sederhana dan jelas, serta pemantauan kondisi pasien secara berkala. Perawat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa *caregiver* mampu melakukan perawatan dengan aman, memahami penggunaan obat dengan benar, serta mengenali tanda-tanda yang memerlukan tindakan segera. Pendekatan yang berfokus pada keselamatan pasien dalam *home care* tidak hanya bergantung pada intervensi klinis, tetapi juga pada kemampuan sistem perawatan di rumah dalam mengantisipasi dan meminimalkan risiko. Dalam konteks ini, perawat dituntut memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi risiko secara dini, melakukan edukasi yang efektif, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan mempertimbangkan aspek keamanan sebagai bagian integral dari asuhan keperawatan (Johannessen et al., 2020).

3. Beban Caregiver

Peran keluarga sebagai *caregiver* dalam *home care paliatif* sering kali disertai dengan beban fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Tanggung jawab dalam merawat pasien dengan kondisi kronis atau terminal dapat menimbulkan kelelahan, stres, serta perasaan kewalahan, terutama apabila *caregiver* tidak memiliki pengalaman atau dukungan yang memadai. Beban ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan *caregiver*, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien. *Caregiver* yang mengalami kelelahan atau stres berisiko melakukan kesalahan dalam perawatan, kurang optimal dalam memantau kondisi pasien, atau mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan.

Oleh karena itu, dukungan terhadap *caregiver* menjadi bagian penting dalam *home care paliatif*. Peran *caregiver* yang berlangsung secara terus-menerus dalam merawat pasien dengan kondisi kompleks dapat menimbulkan kelelahan fisik, tekanan emosional, serta beban psikologis yang tidak ringan. Kondisi ini, apabila tidak dikelola dengan baik, berpotensi memengaruhi kualitas perawatan yang diberikan dan secara tidak langsung meningkatkan risiko terhadap keselamatan pasien. Dalam hal ini, perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi edukasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu *caregiver* beradaptasi dengan peran yang dijalani. Perawat perlu memberikan edukasi yang berkelanjutan, dukungan emosional, serta membantu *caregiver* dalam mengenali keterbatasan diri dan mengembangkan strategi coping yang efektif, seperti pembagian peran dalam keluarga, pemanfaatan dukungan sosial, serta

pengelolaan stres. Selain itu, keterlibatan tim kesehatan dan komunitas juga menjadi penting dalam mengurangi beban *caregiver*. Dukungan yang terintegrasi memungkinkan *caregiver* tidak merasa bekerja sendiri, serta membantu memastikan bahwa perawatan yang diberikan tetap aman, konsisten, dan berkesinambungan.

Dengan memahami berbagai tantangan dan risiko tersebut, perawat dapat merancang intervensi yang lebih adaptif dan berorientasi pada keselamatan. Dalam praktiknya, keberhasilan *home care paliatif* tidak hanya ditentukan oleh kemampuan klinis, tetapi juga oleh kesiapan sistem perawatan di rumah dalam mengelola risiko secara efektif. Oleh karena itu, pendekatan yang terencana, edukatif, dan kolaboratif menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan keamanan pelayanan (Johannessen et al., 2020).

M. Konsep Rujukan dalam Paliatif

Rujukan dalam layanan paliatif merupakan proses pengalihan atau pelibatan layanan kesehatan lain yang memiliki kompetensi atau fasilitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasien. Dalam konteks paliatif, rujukan tidak hanya dilakukan untuk tujuan kuratif, tetapi lebih luas mencakup pengelolaan gejala, dukungan psikososial, serta peningkatan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Berbeda dengan sistem rujukan pada pelayanan kuratif yang umumnya berorientasi pada penyembuhan penyakit, rujukan dalam paliatif bersifat lebih fleksibel dan berfokus pada kebutuhan pasien yang dinamis. Rujukan dapat terjadi tidak hanya ke tingkat layanan yang lebih tinggi, tetapi juga ke layanan yang lebih dekat dengan pasien, seperti *home care* atau layanan berbasis komunitas, sesuai dengan kondisi klinis dan preferensi pasien. Dalam praktiknya, rujukan menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan (*continuity of care*), terutama ketika pasien mengalami perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian jenis layanan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep rujukan dalam paliatif menjadi penting bagi perawat agar mampu mengambil keputusan yang tepat serta memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya (Hui et al., 2022).

1. Indikasi Rujukan

Rujukan dalam layanan paliatif dilakukan berdasarkan kebutuhan klinis dan nonklinis pasien yang tidak dapat dipenuhi secara optimal pada setting pelayanan saat ini. Indikasi rujukan tidak selalu berkaitan dengan kondisi yang memburuk, tetapi juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas perawatan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Beberapa indikasi rujukan menurut Chang et al (2022) dalam layanan paliatif antara lain:

a. Perburukan kondisi klinis pasien

Misalnya peningkatan nyeri yang tidak terkontrol, sesak napas berat, atau munculnya komplikasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

b. Kebutuhan intervensi medis atau fasilitas khusus

Pasien memerlukan tindakan atau alat yang tidak tersedia di setting perawatan saat ini, seperti terapi tertentu atau pemantauan intensif.

c. Kebutuhan dukungan psikososial atau spiritual yang lebih intensif

Pasien atau keluarga mengalami *distress* yang memerlukan intervensi dari tenaga profesional, seperti psikolog atau rohaniwan.

d. Keterbatasan *caregiver* atau lingkungan perawatan

Kondisi keluarga atau lingkungan tidak lagi mendukung perawatan yang aman dan efektif di rumah.

e. Kebutuhan transisi layanan

Misalnya dari rumah sakit ke *home care*, atau dari *home care* ke hospice, sesuai dengan fase penyakit dan tujuan perawatan.

Dengan memahami indikasi rujukan, perawat dapat melakukan penilaian secara komprehensif dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan rujukan, sehingga risiko keterlambatan penanganan dapat diminimalkan.

2. Sistem Rujukan Berjenjang

Sistem rujukan berjenjang merupakan mekanisme pengaturan alur pelayanan kesehatan yang menghubungkan berbagai tingkat layanan, mulai dari layanan primer, sekunder, hingga tersier. Dalam konteks paliatif, sistem ini tidak hanya bersifat linier (dari bawah ke atas), tetapi juga bersifat dinamis dan dua arah, sesuai dengan kebutuhan pasien. Pasien dapat dirujuk dari layanan primer, seperti puskesmas atau layanan komunitas, ke rumah sakit apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut. Sebaliknya, pasien juga dapat dirujuk kembali ke layanan primer atau *home care* setelah kondisi relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa rujukan dalam paliatif berfungsi sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi, bukan sekadar perpindahan layanan (Gong et al., 2024).

Perawat memiliki peran penting dalam sistem rujukan berjenjang, terutama dalam melakukan koordinasi, komunikasi, serta memastikan bahwa informasi terkait kondisi pasien tersampaikan dengan jelas kepada layanan tujuan. Selain itu, perawat juga berperan dalam mempersiapkan pasien dan keluarga sebelum proses rujukan, sehingga transisi layanan dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, sistem rujukan berjenjang dalam layanan paliatif merupakan bagian integral dari kesinambungan pelayanan yang memungkinkan pasien

mendapatkan perawatan yang tepat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Pemahaman terhadap sistem ini akan membantu mahasiswa dalam melihat layanan paliatif sebagai suatu sistem yang terintegrasi, bukan sebagai pelayanan yang terpisah-pisah (Karam et al., 2021).

N. Koordinasi Interprofesional

Koordinasi interprofesional dalam layanan paliatif merupakan proses pengintegrasian berbagai profesi kesehatan untuk memberikan asuhan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berpusat pada pasien. Kompleksitas kebutuhan pasien paliatif, yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, menuntut adanya kerja sama yang terstruktur dan saling melengkapi antaranggota tim. Berbeda dengan kerja tim pada layanan kesehatan umum yang sering bersifat paralel, koordinasi dalam paliatif lebih bersifat integratif, di mana setiap profesi tidak hanya menjalankan perannya masing-masing, tetapi juga berkontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bersama. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak terfragmentasi, melainkan menjadi satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan pasien.

1. Tim Paliatif: Dokter, Perawat, Psikolog, Rohaniawan

Tim paliatif terdiri atas berbagai profesi yang memiliki peran spesifik dalam memenuhi kebutuhan pasien. Setiap anggota tim berkontribusi berdasarkan kompetensi masing-masing, namun tetap bekerja menuju satu tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga.

- a. Dokter berperan dalam penegakan diagnosis, penatalaksanaan medis, serta pengambilan keputusan terkait terapi dan pengendalian gejala.
- b. Perawat berperan dalam pengkajian komprehensif, pemantauan kondisi pasien, pemberian asuhan keperawatan, serta komunikasi dengan pasien dan keluarga.
- c. Psikolog memberikan dukungan dalam aspek emosional dan psikologis, membantu pasien dan keluarga dalam menghadapi stres, kecemasan, maupun proses adaptasi terhadap penyakit.
- d. Rohaniawan berperan dalam memenuhi kebutuhan spiritual pasien, membantu pasien menemukan makna, serta memberikan dukungan sesuai dengan keyakinan yang dianut (De Lima Costa et al., 2024).

Dalam praktiknya, komposisi tim dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pasien, termasuk keterlibatan pekerja sosial atau tenaga kesehatan lain. Yang menjadi kunci bukan hanya keberadaan tim, tetapi bagaimana setiap anggota dapat bekerja secara terkoordinasi dan saling melengkapi.

2. Peran Perawat sebagai Koordinator

Dalam koordinasi interprofesional, perawat memiliki peran strategis sebagai koordinator layanan yang menghubungkan berbagai komponen tim dan memastikan kesinambungan asuhan. Perawat sering kali menjadi tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan pasien dan keluarga, sehingga memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap kondisi dan kebutuhan pasien. Peran koordinatif perawat mencakup pengintegrasian informasi klinis, penyampaian rencana perawatan kepada pasien dan keluarga, serta fasilitasi komunikasi antaranggota tim. Selain itu, perawat juga berperan dalam mengidentifikasi perubahan kondisi pasien dan mengoordinasikan tindak lanjut yang diperlukan, termasuk rujukan ke layanan lain apabila diperlukan (Karam et al., 2021).

Dalam konteks *home care*, peran perawat sebagai koordinator menjadi semakin penting karena keterbatasan akses terhadap tenaga kesehatan lain. Perawat harus mampu menjembatani komunikasi antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan, serta memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan tetap selaras dengan tujuan perawatan. Kemampuan koordinasi ini tidak hanya membutuhkan keterampilan klinis, tetapi juga keterampilan komunikasi, kepemimpinan, serta pemahaman terhadap sistem layanan kesehatan. Dengan demikian, perawat tidak hanya berperan sebagai pelaksana asuhan, tetapi juga sebagai penggerak sistem yang memastikan pelayanan berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berpusat pada pasien. Dengan adanya koordinasi interprofesional yang baik, layanan paliatif dapat berjalan secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Pemahaman terhadap peran masing-masing profesi serta kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa keperawatan dalam praktik paliatif (Anita et al., 2025).

O. Continuity of Care

Continuity of care dalam layanan paliatif merupakan prinsip yang menekankan bahwa perawatan pasien harus berlangsung secara berkesinambungan, terintegrasi, dan tidak terputus meskipun terjadi perpindahan setting pelayanan. Dalam konteks penyakit kronis dan kondisi yang membatasi kehidupan, pasien sering kali mengalami perubahan kebutuhan yang dinamis, sehingga memerlukan layanan dari berbagai tingkat pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kesinambungan pelayanan menjadi kunci dalam menjaga kualitas asuhan serta mencegah terjadinya kesenjangan layanan (Ljungholm et al., 2022).

Berbeda dengan pendekatan pelayanan yang bersifat episodik, *continuity of care* dalam paliatif menuntut adanya kesinambungan hubungan terapeutik,

konsistensi rencana perawatan, serta koordinasi yang efektif antara tenaga kesehatan. Hal ini memungkinkan pasien tetap mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya, tanpa harus memulai ulang proses perawatan setiap kali terjadi perpindahan layanan (Eerden et al., 2017).

1. Transisi Antar Setting (Rumah Sakit Rumah Komunitas)

Transisi antarsetting pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *continuity of care*. Dalam praktik paliatif, pasien dapat berpindah dari rumah sakit ke rumah (*home care*), kemudian mendapatkan dukungan lanjutan di komunitas, atau sebaliknya kembali ke rumah sakit apabila kondisi memburuk (Morey et al., 2020).

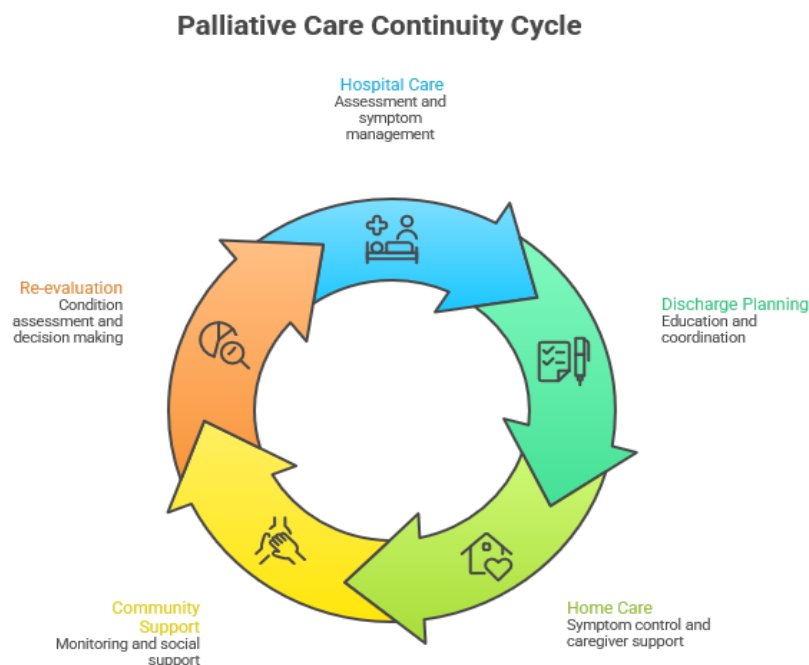
Setiap transisi membawa risiko terjadinya kesalahan komunikasi, kehilangan informasi klinis, serta ketidaksesuaian rencana perawatan. Oleh karena itu, proses transisi perlu direncanakan secara sistematis, dimulai sejak pasien masih berada di setting pelayanan sebelumnya. Informasi mengenai kondisi pasien, rencana perawatan, terapi yang sedang dijalani, serta kebutuhan lanjutan harus disampaikan secara jelas kepada pihak yang menerima pasien.

Perawat memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses transisi ini, terutama dalam memastikan bahwa pasien dan keluarga memahami rencana perawatan di setting berikutnya. Selain itu, perawat juga berperan dalam mengoordinasikan komunikasi antarlayanan serta memastikan bahwa tidak terjadi kehilangan informasi yang dapat memengaruhi kualitas dan keselamatan perawatan.

2. Pencegahan Fragmentasi Layanan

Fragmentasi layanan terjadi ketika pelayanan kesehatan diberikan secara terpisah-pisah tanpa koordinasi yang memadai, sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam perawatan pasien. Dalam layanan paliatif, kondisi ini dapat berdampak serius, seperti pemberian intervensi yang tidak sesuai, duplikasi tindakan, atau keterlambatan dalam penanganan masalah pasien. Pencegahan fragmentasi layanan memerlukan pendekatan yang terintegrasi, di mana setiap komponen pelayanan saling terhubung dan bekerja dalam satu sistem yang utuh. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi yang efektif, dokumentasi yang lengkap dan terstruktur, serta koordinasi yang berkelanjutan antaranggota tim kesehatan. Perawat berperan penting dalam mencegah fragmentasi layanan dengan memastikan bahwa informasi pasien terdokumentasi dengan baik, rencana perawatan dikomunikasikan secara jelas, serta tindak lanjut dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, perawatan yang diberikan kepada pasien tetap selaras dengan tujuan utama layanan paliatif, yaitu meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga (De Regge et al., 2024).

Dengan demikian, *continuity of care* menjadi fondasi penting dalam layanan paliatif yang menghubungkan berbagai setting pelayanan dalam satu sistem yang terintegrasi. Pemahaman terhadap konsep ini akan membantu mahasiswa keperawatan dalam melihat pelayanan kesehatan secara menyeluruh, serta mampu berperan aktif dalam menjaga kesinambungan dan kualitas asuhan pasien. Dalam layanan paliatif, *continuity of care* merupakan prinsip penting yang memastikan bahwa pasien tetap mendapatkan asuhan yang sesuai meskipun berpindah antarsetting pelayanan. Proses ini tidak bersifat linear, tetapi berlangsung secara dinamis sesuai dengan perubahan kondisi pasien (Eerden et al., 2017). Untuk memahami keterkaitan antar layanan, berikut ini disajikan alur kesinambungan pelayanan dalam paliatif:



Gambar 5.1 Alur *Continuity of Care* dalam Layanan Paliatif

Diagram ini menggambarkan kesinambungan pelayanan paliatif yang berlangsung secara siklik, dimulai dari perawatan di rumah sakit, dilanjutkan dengan *discharge planning*, perawatan di rumah, dukungan komunitas, serta proses evaluasi ulang yang memungkinkan pasien kembali ke fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan klinis.

Diagram tersebut menunjukkan bahwa pelayanan paliatif berlangsung sebagai suatu siklus yang berkesinambungan, bukan proses yang bersifat linier. Pasien dapat berpindah antarsetting pelayanan sesuai dengan perubahan kondisi klinis, dengan tetap mempertahankan kesinambungan asuhan. Dalam setiap tahap, diperlukan komunikasi, koordinasi, dan dokumentasi yang baik agar

pelayanan tetap terintegrasi. Perawat memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan tersebut, terutama dalam memastikan bahwa transisi antarlayanan berlangsung secara aman dan efektif.

P. Konsep Discharge Planning

1. Definisi dan Tujuan

Discharge planning dalam layanan paliatif merupakan proses perencanaan yang sistematis untuk mempersiapkan pasien dan keluarga dalam melanjutkan perawatan setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini tidak hanya berfokus pada kepulangan pasien, tetapi juga mencakup kesiapan pasien dan keluarga dalam menghadapi kebutuhan perawatan lanjutan secara aman dan berkesinambungan (Saunders et al., 2021).

Dalam konteks paliatif, *discharge planning* memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan pelayanan umum. Perencanaan tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien, serta kesiapan keluarga sebagai *caregiver*. Dengan demikian, *discharge planning* menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan (*continuity of care*) dan mencegah terjadinya kesenjangan layanan setelah pasien keluar dari rumah sakit.

Tujuan utama *discharge planning* menurut Benzar et al., (2011) dalam paliatif meliputi:

- a. Menjamin kesinambungan perawatan
Memastikan bahwa pasien tetap mendapatkan asuhan yang sesuai dengan kebutuhannya setelah keluar dari fasilitas kesehatan.
- b. Meningkatkan kesiapan pasien dan keluarga
Membantu pasien dan keluarga memahami kondisi yang dihadapi, rencana perawatan, serta tindakan yang perlu dilakukan di rumah.
- c. Mencegah komplikasi dan readmisi yang tidak perlu
Melalui persiapan yang matang, risiko kesalahan perawatan dan perburukan kondisi dapat diminimalkan.
- d. Mendukung kualitas hidup pasien
Dengan memastikan bahwa perawatan lanjutan tetap berfokus pada kenyamanan dan kebutuhan pasien.

Dengan demikian, *discharge planning* bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan bagian integral dari asuhan keperawatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan.

2. Waktu Memulai *Discharge Planning*

Salah satu prinsip penting dalam *discharge planning* adalah bahwa proses ini tidak dimulai saat pasien akan pulang, tetapi sejak awal pasien masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien secara dini serta merencanakan perawatan lanjutan secara lebih sistematis. Pada tahap awal perawatan, perawat perlu melakukan pengkajian terhadap kondisi pasien, kemampuan fungsional, dukungan keluarga, serta lingkungan tempat tinggal. Informasi ini menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan perawatan setelah pulang, termasuk apakah pasien memerlukan *home care*, layanan komunitas, atau rujukan ke fasilitas lain seperti *hospice*. Perencanaan yang dimulai sejak dini juga memungkinkan pemberian edukasi secara bertahap kepada pasien dan keluarga. Dengan demikian, mereka tidak menerima informasi secara mendadak menjelang kepulangan, tetapi memiliki waktu untuk memahami dan mempersiapkan diri secara lebih optimal. Selain itu, *discharge planning* yang dilakukan sejak awal membantu meningkatkan koordinasi antaranggota tim kesehatan, sehingga setiap intervensi yang diberikan selama perawatan di rumah sakit dapat selaras dengan rencana perawatan lanjutan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya fragmentasi layanan dan memastikan bahwa transisi perawatan berjalan secara aman dan efektif (Bechir & Bechir, 2025).

Dengan demikian, *discharge planning* dalam paliatif merupakan proses yang berkelanjutan dan terintegrasi, yang dimulai sejak awal perawatan dan berlanjut hingga pasien siap menjalani perawatan di setting berikutnya. Pemahaman terhadap konsep ini akan membantu mahasiswa keperawatan dalam mempersiapkan pasien secara optimal sebelum proses transisi layanan dilakukan.

Q. Komponen *Discharge Planning*

Discharge planning dalam layanan paliatif mencakup beberapa komponen penting yang perlu dipersiapkan secara sistematis sebelum pasien kembali ke rumah atau berpindah ke setting pelayanan lainnya. Setiap komponen saling berkaitan dan bertujuan untuk memastikan bahwa pasien dan keluarga memiliki kesiapan yang memadai dalam melanjutkan perawatan secara aman dan berkesinambungan.

1. Edukasi Pasien dan Keluarga

Edukasi merupakan komponen utama dalam *discharge planning*, karena menjadi dasar bagi pasien dan keluarga dalam memahami kondisi yang dihadapi serta perawatan yang perlu dilakukan setelah pulang. Edukasi tidak diberikan secara sekaligus menjelang kepulangan, tetapi dilakukan secara bertahap sejak awal perawatan. Materi edukasi mencakup kondisi penyakit, tujuan perawatan

paliatif, penggunaan obat, pengelolaan gejala, serta tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Selain itu, edukasi juga mencakup penjelasan mengenai peran *caregiver* dalam perawatan sehari-hari. Perawat perlu memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik oleh pasien dan keluarga, misalnya melalui metode *teach-back* atau demonstrasi sederhana (Parikh et al., 2025).

2. Rencana Perawatan di Rumah

Rencana perawatan di rumah merupakan bagian penting dari discharge planning yang berfungsi sebagai panduan bagi pasien dan keluarga dalam melanjutkan asuhan setelah keluar dari fasilitas kesehatan. Rencana tersebut disusun berdasarkan kondisi pasien, kebutuhan perawatan, serta sumber daya yang tersedia di rumah. Rencana perawatan mencakup jadwal pemberian obat, pengelolaan gejala, aktivitas yang dianjurkan atau dibatasi, serta langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi perubahan kondisi. Penjelasan rencana ini harus disampaikan secara jelas dan sederhana agar dapat diikuti oleh caregiver. Perlu ditekankan bahwa pada tahap ini, fokus utama adalah penyusunan dan penjelasan rencana, bukan pelaksanaan langsung perawatan di rumah. Secara operasional, hal ini dilakukan melalui pemberian instruksi tertulis maupun lisan, demonstrasi sederhana jika diperlukan, serta verifikasi pemahaman caregiver terhadap rencana yang telah disusun. Dengan demikian, pasien dan keluarga memiliki gambaran yang jelas mengenai perawatan yang akan dilakukan setelah pulang, tanpa harus langsung melakukan tindakan secara mandiri pada tahap ini (King et al., 2022).

3. Pengaturan Rujukan Lanjutan

Pengaturan rujukan lanjutan merupakan bagian dari *discharge planning* yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan pelayanan setelah pasien pulang. Rujukan dapat berupa layanan *home care*, fasilitas kesehatan tingkat primer, layanan komunitas, atau *hospice*, sesuai dengan kebutuhan pasien. Perawat berperan dalam mengoordinasikan proses rujukan, termasuk memastikan bahwa informasi terkait kondisi pasien dan rencana perawatan telah disampaikan kepada layanan tujuan. Selain itu, pasien dan keluarga juga perlu diberikan informasi mengenai layanan yang akan diakses, termasuk cara menghubungi dan prosedur yang perlu dilakukan (Donovan et al., 2017).

Secara operasional, pengaturan rujukan lanjutan dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain identifikasi kebutuhan rujukan berdasarkan kondisi pasien, komunikasi dengan layanan tujuan untuk memastikan ketersediaan layanan, serta penyusunan ringkasan informasi klinis yang relevan. Perawat juga perlu memastikan bahwa pasien dan keluarga memahami jenis layanan yang akan

diterima, waktu mulai layanan, serta langkah yang harus dilakukan apabila terjadi perubahan kondisi sebelum layanan tersebut dimulai. Dengan demikian, proses rujukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan bahwa transisi pelayanan berlangsung secara aman, terkoordinasi, dan berkesinambungan (Camicia et al., 2021).

4. Peralatan dan Kebutuhan Medis

Persiapan peralatan dan kebutuhan medis merupakan komponen penting untuk mendukung keberlangsungan perawatan di rumah. Peralatan yang dibutuhkan dapat berupa alat bantu sederhana, seperti alat mobilisasi, hingga peralatan medis tertentu sesuai dengan kondisi pasien. Perawat perlu memastikan bahwa pasien dan keluarga mengetahui jenis peralatan yang diperlukan, cara penggunaannya, serta cara perawatannya. Selain itu, ketersediaan obat-obatan dan perlengkapan medis juga perlu dipastikan sebelum pasien pulang, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam perawatan (Torrent-Vernetta et al., 2023).

Dalam praktiknya, tidak semua kebutuhan peralatan dan medis dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, perawat perlu membantu pasien dan keluarga dalam mengidentifikasi alternatif yang tersedia, seperti penggunaan alat yang lebih sederhana, pemanfaatan sumber daya di komunitas, atau koordinasi dengan layanan kesehatan lain untuk pemenuhan kebutuhan tertentu. Perawat juga perlu memastikan bahwa penggunaan alat yang tersedia tetap aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Dengan demikian, persiapan peralatan dan kebutuhan medis tidak hanya berfokus pada kelengkapan, tetapi juga pada kesesuaian, keamanan, serta kemampuan pasien dan keluarga dalam menggunakannya secara tepat.

R. Peran Perawat dalam Discharge Planning

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan *discharge planning*, terutama dalam memastikan bahwa pasien dan keluarga siap melanjutkan perawatan secara aman dan berkesinambungan setelah keluar dari fasilitas kesehatan. Dalam konteks paliatif, peran ini menjadi semakin kompleks karena perawat tidak hanya mempersiapkan aspek klinis, tetapi juga aspek psikososial, lingkungan, serta kesiapan *caregiver*.

Peran perawat dalam *discharge planning* mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Edukasi

Perawat berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga sebagai bagian dari persiapan sebelum kepulangan. Edukasi dilakukan secara

bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan pasien dan *caregiver* dalam menerima informasi. Materi edukasi mencakup kondisi pasien, tujuan perawatan paliatif, penggunaan obat, pengelolaan gejala, serta tanda bahaya yang perlu dikenali. Selain itu, perawat juga perlu memastikan bahwa *caregiver* memahami peran yang akan dijalankan setelah pasien pulang.

Secara operasional, edukasi dapat dilakukan melalui penjelasan lisan, pemberian instruksi tertulis, serta demonstrasi sederhana jika diperlukan. Perawat juga perlu melakukan verifikasi pemahaman, sehingga informasi yang diberikan tidak hanya diterima, tetapi benar-benar dipahami dan dapat diterapkan oleh pasien dan keluarga (Cutilli, 2020).

2. Koordinasi Layanan

Perawat berperan sebagai penghubung yang memastikan bahwa seluruh komponen layanan yang dibutuhkan pasien telah dipersiapkan sebelum kepulangan. Koordinasi ini mencakup komunikasi dengan tim kesehatan, layanan rujukan, serta pihak lain yang terlibat dalam perawatan pasien. Dalam praktiknya, perawat perlu memastikan bahwa rencana rujukan telah disusun dengan jelas, layanan lanjutan telah dihubungi, serta informasi terkait kondisi pasien telah disampaikan kepada pihak yang akan menerima pasien. Selain itu, perawat juga perlu memastikan bahwa pasien dan keluarga mengetahui alur layanan yang akan diakses setelah pulang. Peran koordinatif ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya kesenjangan layanan serta memastikan bahwa transisi perawatan berlangsung secara lancar dan terintegrasi (Lockwood & Mabire, 2020).

3. Dokumentasi Rencana

Dokumentasi merupakan bagian penting dalam *discharge planning* yang berfungsi sebagai dasar komunikasi antartenant kesehatan serta sebagai panduan bagi pasien dan keluarga dalam melanjutkan perawatan. Perawat bertanggung jawab dalam menyusun dokumentasi yang jelas, lengkap, dan sistematis, mencakup kondisi pasien, rencana perawatan, kebutuhan lanjutan, serta informasi rujukan. Dokumentasi ini tidak hanya digunakan dalam konteks pelayanan kesehatan internal, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi layanan lanjutan yang akan menerima pasien. Selain itu, dokumentasi yang baik juga berperan dalam menjaga kesinambungan pelayanan serta mengurangi risiko kesalahan akibat kurangnya informasi. Oleh karena itu, ketelitian dan kejelasan dalam pencatatan menjadi hal yang sangat penting dalam peran perawat. Dengan menjalankan peran edukasi, koordinasi, dan dokumentasi secara optimal, perawat berkontribusi dalam memastikan bahwa *discharge planning* tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari asuhan

yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan (Yahalom & Manias, 2024).

S. Pentingnya Dokumentasi dalam Paliatif

Dokumentasi merupakan bagian integral dalam pelayanan keperawatan paliatif yang berfungsi sebagai sarana pencatatan, komunikasi, serta evaluasi asuhan yang diberikan kepada pasien. Dalam konteks paliatif yang melibatkan berbagai aspek kebutuhan pasien dan koordinasi antarprofesi, dokumentasi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pelayanan berjalan secara terstruktur, konsisten, dan berkesinambungan. Berbeda dengan dokumentasi pada pelayanan akut yang cenderung berfokus pada tindakan medis dan respons klinis jangka pendek, dokumentasi dalam paliatif mencakup spektrum yang lebih luas, termasuk kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien, serta respons keluarga terhadap proses perawatan. Oleh karena itu, pencatatan yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mencerminkan proses berpikir klinis dan pengambilan keputusan dalam asuhan keperawatan (Sjöberg et al., 2021).

1. Mendukung Kontinuitas Pelayanan

Salah satu fungsi utama dokumentasi dalam layanan paliatif adalah menjaga kesinambungan pelayanan (*continuity of care*). Dokumentasi yang lengkap dan jelas memungkinkan setiap tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien untuk memahami kondisi terkini pasien, rencana perawatan, serta intervensi yang telah dilakukan. Dalam praktiknya, pasien paliatif sering berpindah antarsetting pelayanan, seperti dari rumah sakit ke rumah atau ke layanan komunitas. Tanpa dokumentasi yang baik, informasi penting dapat hilang atau tidak tersampaikan dengan optimal, yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam perawatan, duplikasi tindakan, atau ketidaksesuaian intervensi. Perawat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap perubahan kondisi pasien, respons terhadap intervensi, serta rencana tindak lanjut terdokumentasi dengan jelas. Dengan demikian, dokumentasi menjadi penghubung utama dalam menjaga kesinambungan pelayanan di berbagai setting (Sjöberg et al., 2021).

2. Aspek Legal dan Profesional

Selain mendukung kontinuitas pelayanan, dokumentasi juga memiliki nilai penting dalam aspek legal dan profesional. Catatan keperawatan merupakan bukti tertulis dari asuhan yang telah diberikan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban apabila terjadi permasalahan dalam pelayanan. Dokumentasi yang baik mencerminkan bahwa perawat telah melaksanakan asuhan sesuai dengan standar praktik yang berlaku, serta melakukan

pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan klinis yang tepat. Sebaliknya, dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menimbulkan risiko, baik bagi pasien maupun bagi tenaga kesehatan itu sendiri. Dalam konteks profesional, dokumentasi juga menunjukkan tingkat kompetensi dan akuntabilitas perawat dalam memberikan asuhan. Oleh karena itu, pencatatan harus dilakukan secara sistematis, akurat, dan tepat waktu, serta menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dipahami oleh tenaga kesehatan lain. Dengan demikian, dokumentasi dalam layanan paliatif tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai bagian penting dari proses asuhan yang mendukung kesinambungan pelayanan serta menjamin aspek legal dan profesional dalam praktik keperawatan (Doody et al., 2018).

T. Komponen Dokumentasi

Dokumentasi dalam layanan paliatif disusun berdasarkan proses keperawatan yang sistematis, sehingga mampu menggambarkan secara utuh kondisi pasien, penalaran klinis, serta intervensi yang diberikan. Setiap komponen dokumentasi saling berkaitan dan membentuk suatu alur yang berkesinambungan dalam asuhan keperawatan.

Adapun komponen utama dalam dokumentasi layanan paliatif menurut Hinkle & Cheever (2022) meliputi:

1. Pengkajian

Pengkajian merupakan dasar dari seluruh proses dokumentasi, yang mencakup pengumpulan data secara komprehensif mengenai kondisi pasien. Dalam paliatif, pengkajian tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Data yang dikumpulkan meliputi keluhan utama, riwayat penyakit, status fungsional, kondisi emosional, dukungan keluarga, serta kebutuhan spiritual pasien. Dokumentasi pengkajian harus dilakukan secara sistematis dan mencerminkan kondisi aktual pasien sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis.

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan hasil analisis terhadap data pengkajian yang menggambarkan masalah atau respons pasien terhadap kondisi yang dialami. Dalam konteks paliatif, diagnosis sering kali berfokus pada masalah yang berkaitan dengan kenyamanan, kualitas hidup, serta kebutuhan psikososial dan spiritual. Penulisan diagnosis harus jelas, spesifik, dan relevan dengan kondisi pasien. Diagnosis ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas masalah serta arah perencanaan asuhan keperawatan.

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan merupakan perencanaan tindakan yang disusun berdasarkan diagnosis keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan yang telah ditetapkan. Dalam dokumentasi, intervensi mencerminkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah pasien serta meningkatkan kualitas hidupnya. Intervensi harus disusun secara spesifik, realistis, dan sesuai dengan kondisi pasien, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dalam layanan paliatif, intervensi tidak hanya mencakup tindakan fisik, tetapi juga meliputi dukungan emosional, komunikasi terapeutik, serta pemenuhan kebutuhan psikososial dan spiritual. Dengan demikian, intervensi dalam dokumentasi berfungsi sebagai rencana tindakan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan asuhan keperawatan.

4. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap yang bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan dengan membandingkan kondisi pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kondisi pasien. Dalam layanan paliatif, evaluasi tidak hanya berfokus pada perubahan kondisi fisik, tetapi juga mencakup tingkat kenyamanan pasien, respons emosional, serta kepuasan pasien dan keluarga terhadap perawatan yang diberikan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian intervensi selanjutnya.

Dengan demikian, dokumentasi dalam layanan paliatif tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan administratif, tetapi juga sebagai refleksi dari proses berpikir klinis dan pengambilan keputusan dalam asuhan keperawatan. Kelengkapan dan ketepatan dokumentasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelayanan serta keselamatan pasien.

U. Evaluasi Luaran Paliatif

Evaluasi luaran dalam layanan paliatif merupakan proses penilaian terhadap hasil asuhan yang diberikan kepada pasien dan keluarga, dengan fokus pada pencapaian tujuan perawatan yang berorientasi pada kualitas hidup. Berbeda dengan pelayanan kuratif yang sering menitikberatkan pada penyembuhan penyakit, evaluasi dalam paliatif lebih menekankan pada kenyamanan pasien, pengendalian gejala, serta pengalaman pasien dan keluarga selama menjalani perawatan. Evaluasi luaran dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan klinis. Hasil evaluasi tidak hanya digunakan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai dasar dalam

menyesuaikan rencana perawatan sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan pasien (Kavalieratos et al., 2016).

1. Kualitas Hidup

Kualitas hidup merupakan indikator utama dalam layanan paliatif yang mencerminkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien secara menyeluruh. Evaluasi kualitas hidup tidak hanya didasarkan pada kondisi klinis, tetapi juga pada persepsi pasien terhadap kenyamanan, makna hidup, serta kemampuan menjalani aktivitas sesuai dengan kondisinya. Perawat berperan dalam mengkaji perubahan kualitas hidup pasien melalui observasi, komunikasi terapeutik, serta penggunaan alat ukur sederhana jika diperlukan. Penilaian ini membantu dalam menentukan apakah intervensi yang diberikan telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan pasien secara keseluruhan.

2. Kontrol Gejala

Pengendalian gejala merupakan salah satu tujuan utama dalam perawatan paliatif. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana gejala seperti nyeri, sesak napas, mual, kelelahan, atau gangguan tidur dapat dikendalikan dengan baik. Perawat perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap intensitas gejala, respons pasien terhadap intervensi, serta adanya efek samping dari terapi yang diberikan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian intervensi agar kenyamanan pasien tetap terjaga.

3. Kepuasan Pasien dan Keluarga

Kepuasan pasien dan keluarga merupakan indikator penting dalam menilai kualitas layanan paliatif. Evaluasi ini mencerminkan pengalaman pasien dan keluarga terhadap pelayanan yang diterima, termasuk aspek komunikasi, empati, dukungan emosional, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Perawat dapat memperoleh informasi mengenai kepuasan pasien dan keluarga melalui komunikasi langsung, umpan balik, atau refleksi terhadap pengalaman perawatan. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga bermakna bagi pasien dan keluarga. Dengan demikian, evaluasi luaran dalam layanan paliatif tidak hanya berfokus pada hasil klinis, tetapi juga pada pengalaman dan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Pemahaman terhadap berbagai indikator luaran ini akan membantu perawat dalam memberikan asuhan yang lebih responsif, adaptif, dan berpusat pada pasien.

V. Indikator Keberhasilan Layanan

Indikator keberhasilan dalam layanan paliatif digunakan untuk menilai sejauh mana asuhan yang diberikan mampu mencapai tujuan utama perawatan, yaitu meningkatkan kualitas hidup pasien serta memastikan pelayanan yang aman, efektif, dan berkesinambungan. Indikator ini tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga mencerminkan kualitas proses pelayanan serta keterlibatan pasien dan keluarga dalam perawatan. Penilaian indikator keberhasilan menjadi penting sebagai dasar dalam evaluasi mutu pelayanan, sekaligus sebagai umpan balik untuk perbaikan praktik keperawatan secara berkelanjutan (Tanaka et al., 2023).

1. Penurunan Gejala

Penurunan atau terkendalnya gejala merupakan indikator utama keberhasilan layanan paliatif. Gejala yang dimaksud dapat berupa nyeri, sesak napas, mual, kelelahan, atau gangguan tidur yang sering dialami pasien dengan penyakit kronis atau kondisi terminal. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi pasien sebelum dan setelah intervensi, baik melalui pengkajian subjektif maupun objektif. Penurunan intensitas gejala menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan efektif dalam meningkatkan kenyamanan pasien.

2. Tidak Terjadi *Readmission* yang Tidak Perlu

Keberhasilan layanan paliatif juga dapat dilihat dari rendahnya angka *readmission* yang tidak direncanakan atau tidak diperlukan. *Readmission* yang dapat dicegah sering kali berkaitan dengan kurangnya kesiapan pasien dan keluarga, ketidaktepatan pengelolaan gejala, atau kurang optimalnya *discharge planning*. Dengan perencanaan yang baik, edukasi yang memadai, serta koordinasi layanan yang efektif, pasien diharapkan dapat menjalani perawatan di rumah tanpa harus kembali ke rumah sakit akibat kondisi yang sebenarnya dapat ditangani di luar fasilitas tersebut.

3. Kepatuhan terhadap Perawatan di Rumah

Kepatuhan pasien dan keluarga terhadap rencana perawatan yang telah disusun merupakan indikator penting dalam keberhasilan layanan paliatif, khususnya pada fase setelah pasien keluar dari fasilitas kesehatan. Kepatuhan ini mencakup penggunaan obat sesuai anjuran, pelaksanaan perawatan dasar, pemantauan kondisi pasien, serta kemampuan mengenali dan melaporkan tanda bahaya. Tingkat kepatuhan yang baik menunjukkan bahwa proses edukasi dan *discharge planning* telah berjalan efektif. Perawat dapat menilai kepatuhan melalui pemantauan lanjutan, komunikasi dengan pasien dan keluarga, serta evaluasi terhadap kondisi pasien selama perawatan di rumah.

Dengan demikian, indikator keberhasilan layanan paliatif tidak hanya mencerminkan hasil akhir dari asuhan, tetapi juga menggambarkan kualitas

proses pelayanan yang telah dilakukan. Pemahaman terhadap indikator ini akan membantu perawat dalam mengevaluasi praktik secara kritis serta meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

W. Integrasi Layanan: Perspektif Kasus Klinis (Pengantar ke Aktivitas)

Pelayanan paliatif tidak dapat dipahami secara terpisah antara satu komponen dengan komponen lainnya. Seluruh aspek, mulai dari model layanan, *home care*, rujukan, koordinasi interprofesional, *discharge planning*, hingga dokumentasi dan evaluasi, merupakan bagian dari satu sistem pelayanan yang saling terhubung. Oleh karena itu, pendekatan terintegrasi menjadi kunci dalam memastikan bahwa asuhan yang diberikan benar-benar berpusat pada kebutuhan pasien dan keluarga (Pask et al., 2025).

1. Pentingnya Pendekatan Terintegrasi

Pendekatan terintegrasi dalam layanan paliatif menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus saling mendukung dan tidak berdiri sendiri. Pasien dengan kondisi kronis atau terminal sering mengalami perubahan kebutuhan yang dinamis, sehingga memerlukan pelayanan yang adaptif dan berkesinambungan di berbagai setting. Tanpa integrasi yang baik, pelayanan berisiko menjadi terfragmentasi, yang dapat berdampak pada ketidakkonsistenan perawatan, keterlambatan penanganan, serta meningkatnya risiko terhadap keselamatan pasien. Sebaliknya, pendekatan yang terintegrasi memungkinkan setiap komponen layanan bekerja secara sinergis, sehingga perawatan yang diberikan menjadi lebih efektif, efisien, dan bermakna bagi pasien.

2. Perawat sebagai Penghubung Sistem

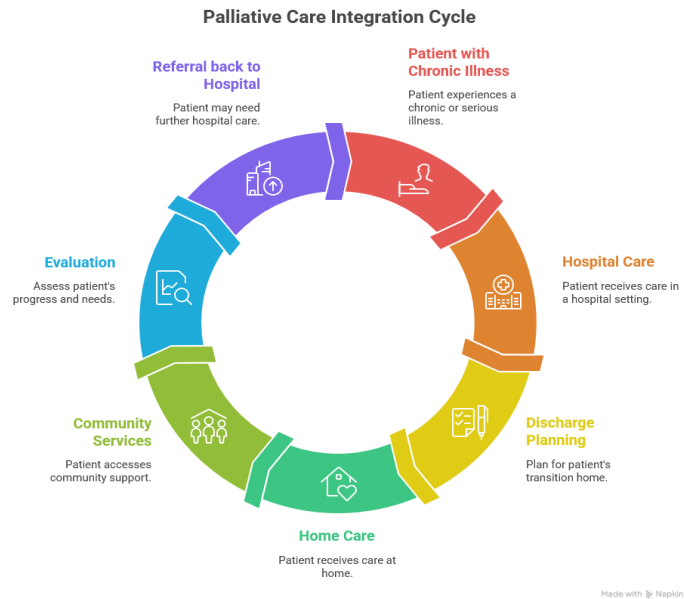
Dalam sistem layanan paliatif, perawat memiliki peran strategis sebagai penghubung yang mengintegrasikan berbagai komponen pelayanan. Perawat tidak hanya memberikan asuhan langsung, tetapi juga berperan dalam mengoordinasikan komunikasi antartenant kesehatan, memfasilitasi kebutuhan pasien dan keluarga, serta memastikan bahwa rencana perawatan berjalan secara konsisten di berbagai setting. Peran ini menjadi semakin penting terutama dalam proses transisi layanan, seperti dari rumah sakit ke rumah atau ke layanan komunitas. Perawat harus mampu memastikan bahwa informasi terkait kondisi pasien, rencana perawatan, serta kebutuhan lanjutan tersampaikan dengan jelas dan tidak terputus. Dengan demikian, perawat berperan sebagai penggerak yang menjaga kesinambungan dan keterpaduan layanan, sehingga pasien tetap mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya.

3. Gambaran Umum Alur Kasus

Untuk memahami bagaimana integrasi layanan paliatif diterapkan dalam praktik, mahasiswa perlu melihat alur pelayanan secara utuh dalam konteks kasus klinis. Secara umum, alur tersebut dimulai dari pengkajian kondisi pasien di fasilitas kesehatan, dilanjutkan dengan penentuan rencana asuhan dan *discharge planning*, kemudian berlanjut ke perawatan di rumah atau komunitas dengan dukungan layanan lanjutan. Dalam perjalanan tersebut, dapat terjadi perubahan kondisi pasien yang memerlukan penyesuaian rencana perawatan, termasuk kemungkinan rujukan kembali ke fasilitas kesehatan. Setiap tahap dalam alur ini memerlukan koordinasi yang baik, dokumentasi yang jelas, serta keterlibatan aktif pasien dan keluarga.

Gambaran alur ini menunjukkan bahwa layanan paliatif bukanlah proses yang statis, melainkan suatu rangkaian pelayanan yang dinamis dan saling terhubung. Pemahaman terhadap alur ini menjadi dasar bagi mahasiswa untuk menganalisis dan menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi klinis nyata. Dengan demikian, integrasi layanan paliatif merupakan landasan penting dalam praktik keperawatan yang menuntut kemampuan berpikir sistem, komunikasi yang efektif, serta koordinasi yang berkelanjutan. Bagian selanjutnya akan mengajak mahasiswa untuk mengaplikasikan konsep-konsep tersebut melalui analisis kasus klinis secara lebih mendalam.

Pendekatan terintegrasi dalam layanan paliatif menekankan bahwa seluruh proses perawatan pasien berlangsung sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Pasien tidak hanya berpindah antar layanan, tetapi juga mengalami proses perawatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak (Azizi et al., 2025). Untuk menggambarkan integrasi tersebut, berikut disajikan alur perjalanan pasien dalam layanan paliatif:



Gambar 5.2 Integrasi Layanan dalam Perjalanan Pasien Paliatif

Diagram ini menggambarkan perjalanan pasien dalam layanan paliatif yang berlangsung secara terintegrasi, dimulai dari kondisi penyakit kronis, perawatan di rumah sakit, *discharge planning*, perawatan di rumah, dukungan komunitas, hingga evaluasi dan kemungkinan rujukan kembali ke fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan klinis.

Diagram tersebut menunjukkan bahwa perjalanan pasien dalam layanan paliatif merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Pasien tidak hanya berpindah antarsetting pelayanan, tetapi juga mengalami proses perawatan yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga dan tim kesehatan. Setiap tahap dalam perjalanan tersebut saling terhubung melalui komunikasi, koordinasi, dan evaluasi yang berkesinambungan. Perawat memiliki peran strategis sebagai penghubung yang memastikan bahwa seluruh tahapan pelayanan berjalan secara konsisten dan berpusat pada kebutuhan pasien (Eerden et al., 2017).

X. Mini-Case: Integrasi Layanan Paliatif

Kasus

Seorang laki-laki berusia 68 tahun dengan diagnosis kanker paru stadium lanjut dirawat di rumah sakit karena keluhan sesak napas yang semakin memberat dalam tiga hari terakhir. Pasien juga mengeluhkan nyeri dada, kelelahan, dan penurunan nafsu makan. Selama perawatan, pasien mendapatkan terapi untuk pengendalian gejala dan menunjukkan perbaikan kondisi secara bertahap. Hasil pengkajian menunjukkan:

1. Pasien tampak lemah, tetapi masih dapat berkomunikasi dengan baik
2. Skala nyeri 5/10
3. Sesak napas berkurang setelah terapi
4. Nafsu makan masih rendah
5. Pasien menyatakan ingin dirawat di rumah bersama keluarga

Keluarga pasien terdiri dari istri dan satu anak yang tinggal serumah. Keluarga menyatakan bersedia merawat pasien di rumah, namun masih merasa kurang yakin dalam melakukan perawatan. Selain itu, rumah pasien berada cukup jauh dari fasilitas kesehatan dan belum pernah menggunakan layanan *home care*.

Tim mulai mempertimbangkan perencanaan kepulangan (*discharge planning*) dengan kemungkinan rujukan ke layanan paliatif berbasis rumah.

Petunjuk

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kasus di atas dengan pendekatan layanan paliatif terintegrasi.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi masalah utama pasien berdasarkan kondisi klinis dan kebutuhan paliatif.
2. Analisis kesiapan pasien dan keluarga untuk menjalani perawatan di rumah.
3. Jelaskan komponen *discharge planning* yang perlu dipersiapkan pada kasus tersebut.
4. Identifikasi kebutuhan rujukan lanjutan dan bentuk layanan yang paling sesuai untuk pasien.
5. Jelaskan peran perawat dalam memastikan kesinambungan pelayanan (*continuity of care*) pada kasus ini.

Instruksi Diskusi

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dengan mempertimbangkan aspek klinis, psikososial, dan fasilitas layanan. Setiap kelompok diminta untuk menelaah hasil diskusi secara sistematis dan mempresentasikannya di kelas.

Y. Soal Osce Keperawatan

Asuhan Keperawatan Paliatif Terintegrasi: Discharge Planning dan Edukasi Pasien

No	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan Paliatif Terintegrasi: Discharge Planning dan Edukasi Pasien

3	Waktu yang dibutuhkan	12–15 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan edukasi, komunikasi terapeutik, dan discharge planning pada pasien paliatif sebelum pulang ke rumah.
5	Kompetensi	1. Komunikasi terapeutik dan edukasi 2. Pengkajian singkat kesiapan pasien 3. Perencanaan discharge planning 4. Implementasi edukasi 5. Evaluasi pemahaman pasien/keluarga 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Paliatif 2. Komunikasi 3. Patient safety 4. Edukasi pasien 5. Continuity of care
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki berusia 68 tahun dengan kanker paru stadium lanjut direncanakan pulang dari rumah sakit. Kondisi pasien cukup stabil, namun masih mengalami nyeri ringan dan kelelahan. Pasien ingin dirawat di rumah. Keluarga bersedia merawat pasien, namun belum memahami perawatan di rumah. TUGAS: 1. Lakukan komunikasi terapeutik 2. Jelaskan rencana perawatan di rumah 3. Edukasi pengelolaan gejala dan obat 4. Jelaskan tanda bahaya 5. Verifikasi pemahaman pasien/keluarga
8	Instruksi untuk penguji	Poin Penilaian: 1. Ketepatan komunikasi terapeutik 2. Kejelasan edukasi rencana perawatan 3. Ketepatan penjelasan tanda bahaya 4. Kemampuan verifikasi pemahaman 5. Keselamatan pasien (hand hygiene, privasi) Penguji tidak diperbolehkan memberikan intervensi tambahan di luar penilaian.
9	Instruksi untuk klien standar	1. Identitas pasien: laki-laki 68 tahun dengan kanker paru stadium lanjut 2. Keluhan: nyeri ringan, lemah, nafsu makan menurun 3. Kondisi: ingin pulang dan dirawat di rumah 4. Keluarga: bersedia merawat tetapi ragu 5. Bila ditanya obat: pasien minum obat nyeri

		6. Bila ditanya tanda bahaya: tidak tahu 7. Ekspresi: tenang tetapi lemah 8. Keluarga tampak khawatir dan banyak bertanya
10	Setting station	Ruang perawatan pasien (simulasi) 1. Tempat tidur pasien 2. Kursi keluarga 3. Meja penguji 4. Handrub/hand hygiene station 5. Alat bantu edukasi
11	Peralatan yang dibutuhkan	1. Handrub/hand sanitizer 2. Lembar edukasi pasien 3. Alat tulis 4. Kursi pasien dan keluarga 5. Form discharge planning
12	Penulis	
13	Referensi	World Health Organization. (2020). Palliative care. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care Ferrell, B. R., Twaddle, M. L., Melnick, A., & Meier, D. E. (2018). National Consensus Project Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care (4th ed.). Journal of Palliative Medicine, 21(12), 1684–1689. https://doi.org/10.1089/jpm.2018.0431 Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). Fundamentals of nursing (11th ed.). Elsevier. Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing (15th ed.). Wolters Kluwer. World Health Organization. (2021). Global patient safety action plan 2021–2030. https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705 Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). Standar diagnosis keperawatan Indonesia. DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2019). Standar intervensi keperawatan Indonesia. DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). Standar luaran keperawatan Indonesia. DPP PPNI.

Sop Edukasi Dan Discharge Planning Pada Pasien Paliatif Terintegrasi

No.	Tahapan	Kegiatan	Dilakukan (Ya/Tidak)	Kompetensi (Ya/Tidak)

			Ya	Tidak	Ya	Tidak
A	Pra-interaksi					
1		Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan pasien				
2		Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Handrub/sabun cuci tangan b. Lembar edukasi pasien c. Alat tulis d. Form discharge planning e. Kursi untuk pasien dan keluarga				
3		Melakukan kebersihan tangan sebelum kontak dengan pasien				
B	Orientasi					
4		Memberikan salam terapeutik				
5		Memperkenalkan diri dan peran				
6		Mengecek identitas pasien secara aktif (nama dan tanggal lahir/umur)				
7		Menyampaikan maksud dan tujuan tindakan (edukasi dan discharge planning) serta kontrak waktu				
8		Memberi kesempatan bertanya				
9		Memulai tindakan dengan baik				
10		Menjaga privasi dan kenyamanan pasien serta keluarga				
C	Tahap Kerja					
11		Melakukan hand hygiene				
12		Mengkaji kondisi umum pasien (nyeri, sesak, kelemahan)				
13		Mengkaji kesiapan pasien dan keluarga untuk pulang				

14		Mengidentifikasi dukungan <i>caregiver</i> di rumah				
15		Menjelaskan kondisi pasien secara sederhana				
16		Menjelaskan tujuan perawatan paliatif di rumah				
17		Menjelaskan rencana perawatan di rumah secara sistematis				
18		Menjelaskan penggunaan obat (jadwal, tujuan, dan cara penggunaan)				
19		Menjelaskan pengelolaan gejala (nyeri, sesak, kelelahan)				
20		Menjelaskan aktivitas yang dianjurkan dan dibatasi				
21		Menjelaskan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan				
22		Menjelaskan kapan harus menghubungi tenaga kesehatan				
23		Menjelaskan rujukan lanjutan (home care/layanan komunitas)				
24		Memberikan instruksi secara jelas dan sederhana (lisan/tertulis)				
25		Meminta pasien/keluarga mengulang kembali penjelasan (<i>teach-back</i>)				
26		Memberi kesempatan pasien/keluarga bertanya kembali				
27		Menyimpulkan rencana perawatan bersama pasien/keluarga				
28		Merapikan pasien dan lingkungan serta melakukan kebersihan tangan				
D	Terminasi					

29		Menyimpulkan kegiatan				
30		Mengevaluasi respons pasien/keluarga secara subjektif dan objektif				
31		Memberikan reinforcement positif				
32		Membuat kontrak waktu selanjutnya (bila diperlukan)				
33		Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Dokumentasi					
34		Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi, respons pasien/keluarga, serta rencana tindak lanjut				
F	Perilaku Profesional					
35		Aman, empati, teliti, sistematis, tepat, dan responsif				

Z. Rubrik Penilaian Osce Keperawatan

Station: Asuhan Keperawatan Paliatif Terintegrasi: Discharge Planning dan Edukasi Pasien

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Risiko Infeksi Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian singkat dan terfokus pada pasien paliatif, meliputi kondisi umum pasien (nyeri, sesak, kelelahan), kesiapan pasien untuk pulang, serta kesiapan keluarga dan dukungan <i>caregiver</i> di rumah. Peserta diharapkan mampu menggali data secara sistematis dan menginterpretasikan kondisi pasien secara tepat sebagai dasar pengambilan keputusan.					2	

2. Diagnosis Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengidentifikasi masalah keperawatan utama berdasarkan data pengkajian, seperti masalah kenyamanan, kebutuhan edukasi, atau kesiapan perawatan di rumah. Peserta diharapkan menunjukkan penalaran klinik yang logis dan tepat.					2	
3. Intervensi Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam merumuskan rencana tindakan keperawatan yang sesuai dengan diagnosis, meliputi edukasi, pengelolaan gejala, serta perencanaan perawatan di rumah secara sistematis dan realistis.					3	
4. Implementasi: Edukasi dan discharge planning Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan edukasi kepada pasien dan keluarga secara komunikatif, aman, dan sistematis, termasuk penyampaian tanda bahaya dan verifikasi pemahaman (teach-back).					2	
5. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan sikap profesional, meliputi komunikasi empatik, menjaga privasi, bertindak aman, teliti, dan responsif.					1	

DOPS

Format Direct Observational Procedural Skills (DOPS)

Asuhan Keperawatan Paliatif Terintegrasi: Discharge Planning dan Edukasi Pasien

Nama :

Tanggal :

Tempat :

Kasus : Pasien paliatif dengan kebutuhan discharge planning dan edukasi perawatan di rumah

Setting kasus : ☐ Rawat jalan / poli ☐ Rawat inap

Penilai :

Petunjuk Penilaian

Beri tanda (√) pada salah satu kolom skor:

- 1–2 = tidak mencapai target
- 3 = cukup mencapai target
- 4 = mencapai target
- 5 = melebihi target
- Pilih "Tidak diamati" bila tidak dilakukan

No	Komponen Penilaian	Tidak diamati	1	2	3	4	5
A. Pengkajian							
1	Mengkaji kondisi umum pasien (nyeri, sesak, kelelahan)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Mengkaji kesiapan pasien dan keluarga untuk perawatan di rumah	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Mengidentifikasi dukungan <i>caregiver</i> dan lingkungan rumah	☐	☐	☐	☐	☐	☐
B. Diagnosis Keperawatan							
4	Mengidentifikasi masalah keperawatan utama secara tepat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Menentukan prioritas masalah sesuai kondisi pasien	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C. Intervensi Keperawatan							
6	Merumuskan rencana edukasi dan perawatan di rumah	☐	☐	☐	☐	☐	☐

7	Menentukan strategi pengelolaan gejala dan tindak lanjut	☐	☐	☐	☐	☐	☐
D. Implementasi (Edukasi & Discharge Planning)							
8	Menjelaskan rencana perawatan di rumah secara jelas dan sistematis	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	Menjelaskan penggunaan obat dan pengelolaan gejala	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	Menjelaskan tanda bahaya dan kapan harus mencari bantuan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	Melakukan verifikasi pemahaman (teach-back)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
E. Perilaku Profesional							
12	Komunikasi terapeutik (empati, jelas, menghargai pasien)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13	Menjaga privasi, keamanan, dan kenyamanan pasien	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14	Menunjukkan sikap profesional (teliti, sistematis, responsif)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Perhitungan Nilai

Nilai total = (Skor total × 100) / 70

(14 item × skor maksimal 5 = 70)

Komentar Penilai

.....

.....

.....

.....

Model Layanan Paliatif, Home Care, dan Studi Kasus Terintegrasi

Bab ini menekankan bahwa layanan paliatif merupakan bagian penting dalam sistem kesehatan modern yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis atau kondisi yang mengancam jiwa. Pelayanan paliatif tidak hanya berorientasi pada pengendalian gejala fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual secara holistik. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat *patient-centered*, interprofesional, serta berkelanjutan melalui berbagai setting pelayanan, mulai dari rumah sakit, rumah, hingga komunitas.

Mahasiswa perlu memahami bahwa layanan paliatif tidak berlangsung secara terpisah, melainkan dalam suatu alur yang terintegrasi. Transisi perawatan dari rumah sakit ke rumah (*home care*) dan ke komunitas merupakan bagian dari *continuity of care* yang harus dikelola secara sistematis. Dalam konteks ini, *discharge planning* menjadi komponen kunci yang tidak hanya dilakukan saat pasien akan pulang, tetapi juga sudah dimulai sejak awal perawatan. Perencanaan ini mencakup edukasi pasien dan keluarga, penyusunan rencana perawatan di rumah, pengaturan rujukan lanjutan, serta persiapan peralatan dan kebutuhan medis.

Alur asuhan keperawatan paliatif dimulai dari pengkajian menyeluruh terhadap kondisi pasien, meliputi gejala fisik seperti nyeri, sesak, dan kelelahan, serta kesiapan psikososial dan dukungan keluarga. Berdasarkan data tersebut, perawat mengidentifikasi diagnosis keperawatan yang relevan, seperti gangguan kenyamanan, intoleransi aktivitas, atau kebutuhan edukasi. Selanjutnya, intervensi disusun dengan menekankan pengelolaan gejala, edukasi keluarga, serta perencanaan perawatan berkelanjutan di rumah. Implementasi dilakukan melalui komunikasi terapeutik yang efektif, edukasi yang jelas dan sederhana, serta verifikasi pemahaman pasien dan keluarga untuk memastikan keselamatan pasien.

Pada tahap evaluasi, perawat menilai perubahan kondisi pasien dan kesiapan keluarga dalam melanjutkan perawatan di rumah. Keberhasilan asuhan ditunjukkan oleh pengendalian gejala yang lebih baik, peningkatan kenyamanan pasien, serta kemampuan keluarga dalam memahami dan melaksanakan perawatan. Namun, apabila ditemukan kondisi yang mengarah pada perburukan, seperti nyeri tidak terkontrol, sesak napas yang meningkat, penurunan kesadaran, atau ketidaksiapan *caregiver*, maka perawat harus segera melakukan eskalasi atau rujukan sesuai dengan sistem pelayanan yang tersedia.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa layanan paliatif harus dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai

koordinator layanan yang memastikan keterhubungan antarsetting pelayanan. Mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi dalam konteks nyata, serta menunjukkan kemampuan komunikasi, edukasi, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam praktik klinik. Inilah yang menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab maupun praktik klinik pada keperawatan paliatif.

Tabel. Red Flags & Eskalasi
Asuhan Keperawatan Paliatif Terintegrasi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Nyeri tidak terkontrol atau semakin berat	Menunjukkan kegagalan pengendalian gejala atau progresivitas penyakit	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/dokter, evaluasi regimen terapi, siapkan penyesuaian manajemen nyeri
Sesak napas atau peningkatan frekuensi napas	Dapat menunjukkan perburukan kondisi respirasi atau komplikasi akut	Eskalasi segera, lakukan pemantauan ketat, siapkan intervensi lanjutan sesuai instruksi medis
Penurunan kesadaran	Tanda kondisi serius yang dapat berkaitan dengan hipoksia, gangguan metabolik, atau progresivitas penyakit	Segera lakukan eskalasi, jangan menunda evaluasi lanjutan
Pasien tidak mampu makan atau minum	Risiko tinggi malnutrisi dan dehidrasi yang memperburuk kondisi umum	Laporkan segera, evaluasi kebutuhan dukungan nutrisi dan cairan
Muntah berulang atau tidak terkendali	Mengganggu pemberian obat dan asupan nutrisi	Laporkan, pantau kondisi pasien, siapkan evaluasi terapi lebih lanjut
Tanda infeksi (demam tinggi, menggigil)	Dapat menunjukkan infeksi yang memerlukan penanganan segera	Laporkan dan lakukan pemantauan ketat sesuai prosedur

Perubahan kondisi mendadak (lemas ekstrem, penurunan aktivitas)	Menunjukkan perburukan kondisi umum pasien	Eskalasi segera dan lakukan pemantauan intensif
Gangguan eliminasi (tidak BAK atau BAK sangat sedikit)	Menunjukkan kemungkinan gangguan perfusi atau fungsi ginjal	Laporkan segera dan dokumentasikan kondisi pasien
Kesalahan penggunaan obat di rumah	Berpotensi menyebabkan efek samping atau kegagalan terapi	Segera lakukan klarifikasi, edukasi ulang, dan koordinasi dengan tenaga kesehatan
Keluarga/ <i>caregiver</i> tidak memahami perawatan	Risiko tinggi kesalahan perawatan dan keterlambatan penanganan	Lakukan edukasi ulang, gunakan metode teach-back, dan pastikan pemahaman
Keterbatasan akses layanan kesehatan	Dapat menyebabkan keterlambatan penanganan kondisi darurat	Koordinasikan rujukan, berikan informasi kontak layanan kesehatan
Tanda kegawatan (misalnya napas sangat cepat/lambat, ekstremitas dingin)	Menunjukkan kondisi gawat darurat yang memerlukan tindakan segera	Panggil bantuan segera dan lakukan eskalasi sesuai alur layanan

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab Model Layanan Paliatif, Home Care, dan Studi Kasus Terintegrasi

Nama Mahasiswa: _____

NIM: _____

Tanggal: _____

Tempat Praktik / Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep layanan paliatif secara sederhana	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan prinsip dasar paliatif (holistik, patient-centered, interprofesional)	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan pengkajian pada pasien paliatif (nyeri, sesak, kelelahan, kondisi umum)	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengkaji kesiapan pasien dan keluarga untuk perawatan di rumah	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan pada pasien paliatif	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menyusun intervensi keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien paliatif	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menjelaskan rencana perawatan di rumah (discharge planning)	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang pengelolaan gejala (nyeri, sesak, kelelahan)	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menjelaskan penggunaan obat secara sederhana kepada pasien/keluarga	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya pada pasien paliatif kepada keluarga	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau rujukan	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga	☐	☐	_____

13	Saya sudah bisa melakukan edukasi dengan metode teach-back untuk memastikan pemahaman	☐	☐	_____ ____
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan paliatif	☐	☐	_____ ____
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional (aman, empati, teliti, dan responsif) dalam perawatan paliatif	☐	☐	_____ ____

Refleksi singkat mahasiswa:

BB. Daftar Pustaka

- Abbaspour, H., & Heydari, A. (2021). Concept Analysis of End-of-Life Care. *Journal of Caring Sciences*, 11, 172–177. <https://doi.org/10.34172/jcs.2022.037>
- Anita, A., Septian, R. B., & Ghazali, L. (2025). Nurses' Roles and Challenges in Interprofessional Home-Based Palliative Care: A Systematic Review of Qualitative Studies. *The American Journal of Hospice & Palliative Care*, 10499091251371144. <https://doi.org/10.1177/10499091251371145>
- Azizi, F., Mohebbi, Z., Jamalimoghadam, N., Ghanbarzadeh, S., & Fereidooni-Moghadam, M. (2025). Analysis of the Concept of Palliative Care Based on Rodgers' Approach. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 39 4. <https://doi.org/10.1111/scs.70144>
- Barbosa, S. M., Zacharias, F., Schönholzer, T., Carlos, D., Pires, M. E. L., Valente, S., Fabriz, L. A., & Pinto, I. (2023). Hospital discharge planning in care transition of patients with chronic noncommunicable diseases. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 76. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0772>
- Bechir, G., & Bechir, A. (2025). Start With the End: Early Hospital Discharge Planning as a Day-One Priority. *Cureus*, 17. <https://doi.org/10.7759/cureus.87019>
- Benzar, E., Hansen, L., Kneitel, A., & Fromme, E. (2011). Discharge Planning for Palliative Care Patients: A Qualitative Analysis. *Journal of Palliative Medicine*, 14, 65–69. <https://doi.org/10.1089/jpm.2010.0335>
- Camicia, M., Lutz, B., Summers, D., Klassman, L., & Vaughn, S. (2021). Nursing's Role in Successful Stroke Care Transitions Across the Continuum: From Acute Care

- Into the Community. *Stroke*, 52. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.121.033938>
- Chang, Y. K., Allen, L., McClung, J., Denvir, M., Philip, J., Mori, M., Perez-Cruz, P., Cheng, S.-Y., Collins, A., & Hui, D. (2022). Criteria for Referral of Patients With Advanced Heart Failure for Specialized Palliative Care. *Journal of the American College of Cardiology*, 80 4, 332–344. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.04.057>
- Cruz, C., Querido, A., & Pedrosa, V. V. (2025). Perceptions and Practices of Interdisciplinary Action in an Intra-Hospital Support Team for Palliative Care: A Qualitative Study. *Healthcare*, 13. <https://doi.org/10.3390/healthcare13101179>
- Cruz, S., Fernandes, C., & Magalhães, B. (2025). Patients' Experiences in the Transition From Hospital to Home Palliative Care: A Systematic Review and Thematic Synthesis of Qualitative Studies. *SAGE Open Nursing*, 11. <https://doi.org/10.1177/23779608251334031>
- Cutilli, C. (2020). Excellence in Patient Education: Evidence-Based Education that "Sticks" and Improves Patient Outcomes. *The Nursing Clinics of North America*, 55 2, 267–282. <https://doi.org/10.1016/j.cnur.2020.02.007>
- De Lima Costa, V. G., Rizzo, A. F. R., De Oliveira Souza, É., De Macedo Coelho Galvão, L. C., Voronkoff, O. S., Weigert, P. R., De Castro, R. A., Santos, S. M. A. V., & De Oliveira Costa, T. D. (2024). The role of the multidisciplinary team in decision-making at the end of life: an analysis of integrated palliative care management. *CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES*. <https://doi.org/10.55905/revconv.17n.2-157>
- De Regge, M., Gemmel, P., Ackaert, L., Dillen, L., Pype, P., Van Den Noortgate, N., Meijboom, B., & Eeckloo, K. (2024). Addressing integration in the organization of palliative care in Belgium: a multilevel ecosystems approach using the analytic hierarchy process (AHP) method. *BMC Palliative Care*, 23. <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01585-2>
- Donovan, K., Looney, E., McKiernan, M., & O'Connor, K. (2017). Introducing a discharge planning and resource folder on acute hospital wards: A simple intervention to improve communication and quality of care at discharge. *International Journal of Integrated Care*, 17, 565. <https://doi.org/10.5334/ijic.3885>
- Doody, O., Bailey, M., Moran, S., & Stewart, K. (2018). Nursing documentation in palliative care: an integrative review. *Journal of Nursing*, 5, 3.

<https://doi.org/10.7243/2056-9157-5-3>

- Eerden, M. D. H.-V. Der, Hasselaar, J., Payne, S., Varey, S., Schwabe, S., Radbruch, L., Van Beek, K., Menten, J., Busa, C., Csikos, A., Vissers, K., & Groot, M. (2017). How continuity of care is experienced within the context of integrated palliative care: A qualitative study with patients and family caregivers in five European countries. *Palliative Medicine*, 31, 946–955. <https://doi.org/10.1177/0269216317697898>
- Feliciano, D. R., & Reis-Pina, P. (2024). Enhancing End-of-Life Care with Home-Based Palliative Interventions: A Systematic Review. *Journal of Pain and Symptom Management*. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2024.07.005>
- Ferrell, B. R., Twaddle, M. L., Melnick, A., & Meier, D. E. (2018). National Consensus Project Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care (4th ed.). *Journal of Palliative Medicine*, 21(12), 1684–1689. <https://doi.org/10.1089/jpm.2018.0431>
- Galekop, M., Van Dijk, H., Van Exel, J., & Cramm, J. (2019). Views of professionals and volunteers in palliative care on patient-centred care: a Q-methodology study in the Netherlands. *BMC Palliative Care*, 18. <https://doi.org/10.1186/s12904-019-0479-5>
- Gizaw, Z., Astale, T., & Kassie, G. (2022). What improves access to primary healthcare services in rural communities? A systematic review. *BMC Primary Care*, 23. <https://doi.org/10.1186/s12875-022-01919-0>
- Gong, F., Luo, J., Wang, Z., Tang, P., Hu, G., Zhou, Y., & Lin, H. (2024). Network characteristics of referrals for chronic disease patients: results from hierarchical medical reform in Shenzhen, China. *BMC Public Health*, 24. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-21175-4>
- Harini, R., Hanum, F., Widyasari, T., & Nafik, N. (2022). Perawatan di Rumah (Home Care) pada Keluarga Ny. Ar Di Rt 3 Rw 02 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Wilayah Kerja Puskesmas Cimandala, Kab. Bogor. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)*. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i6.6009>
- Hashim, M. (2017). Patient-Centered Communication: Basic Skills. *American Family Physician*, 95 1, 29–34. <https://consensus.app/papers/patientcentered-communication-basic-skills-hashim/097ae7d094af5b648a17b16d9a1dd22b/>
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-*

surgical nursing (15th ed.). Wolters Kluwer.

- Hui, D., & Bruera, E. (2020). Models of Palliative Care Delivery for Patients With Cancer. *Journal of Clinical Oncology: Official Journal of the American Society of Clinical Oncology*. <https://doi.org/10.1200/jco.18.02123>
- Hui, D., Heung, Y., & Bruera, E. (2022). Timely Palliative Care: Personalizing the Process of Referral. *Cancers*, *14*. <https://doi.org/10.3390/cancers14041047>
- Johannessen, T., Ree, E., Aase, I., Bal, R., & Wiig, S. (2020). Exploring challenges in quality and safety work in nursing homes and home care – a case study as basis for theory development. *BMC Health Services Research*, *20*. <https://doi.org/10.1186/s12913-020-05149-x>
- Karam, M., Chouinard, M., Poitras, M.-È., Couturier, Y., Vedel, I., Grgurevic, N., & Hudon, C. (2021). Nursing Care Coordination for Patients with Complex Needs in Primary Healthcare: A Scoping Review. *International Journal of Integrated Care*, *21*. <https://doi.org/10.5334/ijic.5518>
- Kavalieratos, D., Kavalieratos, D., Corbelli, J., Zhang, D., Dionne-Odom, J., Ernecoff, N., Hanmer, J., Hoydich, Z., Ikejiani, D., Klein-Fedyshin, M., Zimmermann, C., Zimmermann, C., Morton, S., Arnold, R., Heller, L., & Schenker, Y. (2016). Association Between Palliative Care and Patient and Caregiver Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA*, *316*, 20, 2104–2114. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.16840>
- Kayentao, K., Ghosh, R., Guindo, L., Whidden, C., Treleaven, E., Chiu, C., Lassala, D., Traoré, M. B., Beckerman, J., Diakitè, D., Tembely, A., Idriss, B., Berthé, M., Liu, J., & Johnson, A. (2023). Effect of community health worker home visits on antenatal care and institutional delivery: an analysis of secondary outcomes from a cluster randomised trial in Mali. *BMJ Global Health*, *8*. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-011071>
- Kesonen, P., Salminen, L., Kero, J., Aappola, J., & Haavisto, E. (2022). An Integrative Review of Interprofessional Teamwork and Required Competence in Specialized Palliative Care. *Omega*, *89*, 1047–1073. <https://doi.org/10.1177/00302228221085468>
- King, L., Harrington, A., Nicholls, S., Thornton, K., & Tanner, E. (2022). Towards reduction of preventable hospital readmission: Older people and family members' views on planned self-management of care at home. *Journal of Clinical Nursing*. <https://doi.org/10.1111/jocn.16492>

- Kluger, B., Hudson, P., Hanson, L., Bužgová, R., Creutzfeldt, C., Gursahani, R., Sumrall, M., White, C., Oliver, D., Pantilat, S., & Miyasaki, J. (2023). Palliative care to support the needs of adults with neurological disease. *The Lancet Neurology*, 22, 619–631. [https://doi.org/10.1016/s1474-4422\(23\)00129-1](https://doi.org/10.1016/s1474-4422(23)00129-1)
- Liendra, V. M., & Himaladin, H. (2023). HUNIAN PALIATIF YANG BERKUALITAS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DHARMAIS. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*. <https://doi.org/10.24912/stupa.v4i2.21751>
- Ljungholm, L., Edin-Liljegren, A., Ekstedt, M., & Klinga, C. (2022). What is needed for continuity of care and how can we achieve it? – Perceptions among multiprofessionals on the chronic care trajectory. *BMC Health Services Research*, 22. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08023-0>
- Lockwood, C., & Mabire, C. (2020). Hospital discharge planning: evidence, implementation and patient-centered care. *JBIM Evidence Synthesis*, 18 2, 272–274. <https://doi.org/10.11124/jbies-20-00023>
- Mawarti, S., & Simatupang, L. (2024). Hubungan Perawatan Paliatif Perawat Dengan Kualitas Hidup Pada Pasien Penderita Nasopharyngeal Cancer (NPC) Di Ruang 3A West Murni Teguh Memorial Hospital. *Indonesian Trust Nursing Journal*. <https://doi.org/10.37104/itnj.v2i2.255>
- Megari, K. (2013). Quality of Life in Chronic Disease Patients. *Health Psychology Research*, 1. <https://doi.org/10.4081/hpr.2013.e27>
- Morey, T., Scott, M., Saunders, S., Varenbut, J., Howard, M., Tanuseputro, P., Webber, C., Killackey, T., Wentlandt, K., Zimmermann, C., Bernstein, M., Ernecoff, N., Hsu, A., & Isenberg, S. (2020). Transitioning From Hospital to Palliative Care at Home: Patient and Caregiver Perceptions of Continuity of Care. *Journal of Pain and Symptom Management*. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.12.019>
- Nguyen, V., Khanh, Q. T., Hocaoglu, M., Huyen, H. T. M., Thinh, D. H. Q., & Krakauer, E. (2023). Integrated hospital- and home-based palliative care for cancer patients in Vietnam: People-centered outcomes. *Journal of Pain and Symptom Management*. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2023.04.016>
- Ohana, S., Shaulov, A., & Ganz, D. (2023). Acute palliative care models: scoping review. *BMJ Supportive & Palliative Care*, 14. <https://doi.org/10.1136/spcare-2022-004124>
- Parikh, P., Jaisinghani, P., Kaloth, S., Konakanchi, A., Yanamala, N., & Kim, S. (2025).

Enhancing Patient Understanding of Hospitalization and Post-Discharge Needs: The Impact of Physician-Led Verbal Communication and Teach-Back Method. *Journal of General Internal Medicine*, 40, 2103–2110. <https://doi.org/10.1007/s11606-025-09510-w>

- Pask, S., Okwuosa, C., Mohamed, A., Price, R., Young, J., Curtis, T., Henderson, S., Winter-Luke, I., Sunny, A., Chambers, R., Greenley, S., Johansson, T., Bone, A., Barclay, S., Higginson, I., Sleeman, K., & Murtagh, F. (2025). *Models, components, and outcomes of palliative and end-of-life care provided to adults living at home: A systematic review of reviews*. <https://doi.org/10.1101/2025.02.14.25322267>
- Ribeiro, H., Rocha-Neves, J., Dourado, M., & Andrade, J. (2024). Evaluating the Benefits of Transition to Home Palliative Care: Pharmacological Prescriptions, Social, and Psychological Support Post-Referral. *Journal of Primary Care & Community Health*, 15. <https://doi.org/10.1177/21501319241285340>
- Rosenberg, J., Flynn, T., Merollini, K., Linn, J., Nabukalu, D., & Davis, C. (2024). Exploring the 'citizen organization': an evaluation of a regional Australian community-based palliative care service model. *Palliative Care and Social Practice*, 18. <https://doi.org/10.1177/26323524241260427>
- Saunders, S., Weiss, M., Meaney, C., Killackey, T., Varenbut, J., Lovrics, E., Ernecoff, N., Hsu, A., Stern, M., Mahtani, R., Wentlandt, K., & Isenberg, S. (2021). Examining the course of transitions from hospital to home-based palliative care: A mixed methods study. *Palliative Medicine*, 35, 1590–1601. <https://doi.org/10.1177/02692163211023682>
- Seow, H., & Bainbridge, D. (2018). A Review of the Essential Components of Quality Palliative Care in the Home. *Journal of Palliative Medicine*, 21, 37–44. <https://doi.org/10.1089/jpm.2017.0392>
- Shalev, A., Phongtankuel, V., Kozlov, E., Shen, M., Adelman, R., & Reid, M. (2018). Awareness and Misperceptions of Hospice and Palliative Care: A Population-Based Survey Study. *American Journal of Hospice and Palliative Medicine®*, 35, 431–439. <https://doi.org/10.1177/1049909117715215>
- Siouta, N., Beek, K., Eerden, M., Preston, N., Hasselaar, J., Hughes, S., Garralda, E., Centeno, C., Csikos, A., Groot, M., Radbruch, L., Payne, S., & Menten, J. (2016). Integrated palliative care in Europe: a qualitative systematic literature review of empirically-tested models in cancer and chronic disease. *BMC Palliative Care*, 15. <https://doi.org/10.1186/s12904-016-0130-7>

- Sjöberg, M., Edberg, A., Rasmussen, B., & Beck, I. (2021). Documentation of older people's end-of-life care in the context of specialised palliative care: a retrospective review of patient records. *BMC Palliative Care*, 20. <https://doi.org/10.1186/s12904-021-00771-w>
- Sumpter, I., Phillips, S., & Magwood, G. (2022). Approaches to reducing fragmented care in systemic lupus erythematosus (SLE) and other multimorbid conditions: A realist review. *International Journal of Care Coordination*, 25, 103–114. <https://doi.org/10.1177/20534345221121068>
- Tanaka, Y., Masukawa, K., Kawashima, A., Hirayama, H., & Miyashita, M. (2023). Quality indicators for palliative care in intensive care units: a systematic review. *Annals of Palliative Medicine*. <https://doi.org/10.21037/apm-22-1005>
- Temel, J., Greer, J., El-Jawahri, A., Pirl, W., Park, E., Jackson, V., Back, A., Kamdar, M., Jacobsen, J., Chittenden, E., Rinaldi, S., Gallagher, E., Eusebio, J., Li, Z., Muzikansky, A., & Ryan, D. (2017). Effects of Early Integrated Palliative Care in Patients With Lung and GI Cancer: A Randomized Clinical Trial. *Journal of Clinical Oncology: Official Journal of the American Society of Clinical Oncology*, 35 8, 834–841. <https://doi.org/10.1200/jco.2016.70.5046>
- Torrent-Vernetta, A., Soriano, M. M., Serrano, I. I., Izquierdo, A. D., Amigo, S. R., Messa, I., Gartner, S., & Moreno-Galdó, A. (2023). Arrangement of residence before hospital discharge for children on home-invasive mechanical ventilation. *Pediatric Pulmonology*, 59, 2080–2088. <https://doi.org/10.1002/ppul.26758>
- Vogel, J., Rising, K., Jones, J., Bowden, M., Ginde, A., & Havranek, E. (2019). Reasons Patients Choose the Emergency Department over Primary Care: a Qualitative Metasynthesis. *Journal of General Internal Medicine*, 34, 2610–2619. <https://doi.org/10.1007/s11606-019-05128-x>
- Wantonoro, W., Suryaningsih, E. K., Anita, D. C., & Van Nguyen, T. (2022). Palliative Care: A Concept Analysis Review. *SAGE Open Nursing*, 8. <https://doi.org/10.1177/23779608221117379>
- WHO. (2020). *Palliative care*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>
- Wise, S., Duffield, C., Fry, M., & Roche, M. (2021). Nurses' role in accomplishing interprofessional coordination. Lessons in "almost managing" an emergency department team. *Journal of Nursing Management*.

<https://doi.org/10.1111/jonm.13464>

- Wu, Y.-H., Hsieh, H., Kuo, Y.-L., & Wu, C.-Y. (2022). The experiences and needs of nurses providing home-based palliative care: A qualitative meta-synthesis. *Journal of Palliative Care*, 38, 490–502. <https://doi.org/10.1177/08258597221105167>
- Xu, Y., Liu, Y., Kang, Y., Wang, D., Zhou, Y., Wu, L., & Yuan, L. (2024). Experiences of family caregivers of patients with end-of-life cancer during the transition from hospital to home palliative care: a qualitative study. *BMC Palliative Care*, 23. <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01559-4>
- Yahalom, S., & Manias, E. (2024). Nurses engaging with referral letters and discharge summaries: A qualitative study. *Journal of Clinical Nursing*. <https://doi.org/10.1111/jocn.17054>

PROFIL PENULIS



Ns. I Gusti Ayu Putu Desy Rohana, M.Kep., Sp.Kep.Kom.

Lahir di Jakarta, 15 Oktober 1986. Telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana dan Profesi Ners di Universitas Pembangunan Negara (UPN) "Veteran" Jakarta pada tahun 2010. Melanjutkan Pendidikan Magister Keperawatan Dan Spesialis Keperawatan Dengan Peminatan Keperawatan Komunitas di Universitas Indonesia (UI), tahun 2015 – 2018.

Pernah bekerja sebagai dosen keperawatan pada STIKes. Pamentas, dan STIKes. Dr. Sismadi menjabat sebagai Sekretaris Program Studi S1 Keperawatan Tahun 2011 – 2015. Memiliki pengalaman klinikal sebagai Kepala Seksi Rawat Jalan Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) 2018 – 2020. Saat ini bekerja sebagai Aparatus Sipil Negara (ASN) Dosen pada bidang ilmu Keperawatan Poltekkes Kemenkes Palembang, aktif dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan terlibat sebagai Tim Champion Kementerian Kesehatan, selain itu juga berperan dalam pembinaan produk kreatif mahasiswa di Program Studi D III Keperawatan Baturaja.

Beberapa karya ilmiah terakhir yang dipublikasikan pada jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat (terakreditasi dan/atau berreputasi) sebanyak 47 artikel. Selain karya ilmiah yang terpublikasi, terdapat juga karya yang telah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HaKi) berupa video, poster, alat peraga, dan video virtual reality SOP Praktik Intervensi Keperawatan. Perolehan HaKi sebanyak 27 HaKi yang tersertifikat.

Email: igustiayu_desyrohana@poltekkespalembang.ac.id

Motto: "To be Yourself" Jangan pernah kehilangan jati diri, dan pastikan usahamu dalam hidup sudah maksimal dari apa yang Kau mampu, karena kesuksesan itu diraih, bukan dinanti.



Yuliatil Adawiyah Harahap, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Haji Sumatera Utara. Penulis lahir di Binjai tanggal 4 Juli 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Haji Sumatera Utara. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Sumatera Utara Medan dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis menekuni bidang Menulis dan aktif sebagai editor Jurnal Ilmu Keperawatan (JINTAN) dan Jurnal Medical. Penulis dapat dihubungi

melalui e-mail: yuliatil.adawiyah@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Ns. Weny Amelia, M.Kep., Sp.Kep.MB

Penulis lahir di Lubuk Sikaping, 24 September 1989. Penulis menjalani pendidikan mulai dari jenjang Strata 1 (S1) Keperawatan tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan Profesi Ners tahun 2011 di STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang. Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan dan tahun 2016 melanjutkan pendidikan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2017. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Mercubaktijaya sejak tahun 2012. Ketertarikan penulis dalam keperawatan paliatif telah dimulai sejak penulis menjalani pendidikan magister dan spesialis keperawatan. Pada pendidikan spesialis keperawatan medikal bedah penulis mengambil peminatan onkologi. Dan pada saat sekarang penulis menjadi koordinator mata kuliah keperawatan paliatif. Pada tahun 2017 penulis mulai bergabung organisasi "Himpunan Perawat Onkologi Indonesia" (HIMPONI) di Sumatera Barat sampai sekarang. Penulis juga aktif melakukan penelitian dalam bidang keperawatan paliatif yang telah didanai oleh internal Perguruan Tinggi (Hibah Yayasan) dan juga kemenristek DIKTI. Penulis juga aktif melakukan publikasi pada jurnal keperawatan. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini terutama bagi perawat.

Email Penulis: wenyamelia.wa@gmail.com



Dr. Hery Ernawati, S.Kep, Ns, M.Kep. Riwayat Pendidikan: Menyelesaikan pendidikan S1 dan Profesi Ners di Universitas Brawijaya Malang lulus pada tahun 2004

Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus pada tahun 2024. Riwayat Pekerjaan: Sejak tahun 2003 penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen keperawatan dan saat ini penulis aktif mengajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Riwayat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: Penulis aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui pendanaan internal (Universitas Muhammadiyah Ponorogo) maupun pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebanyak 3 kali (tahun 2020, 2021 dan 2026)

Penulis dapat dihubungi melalui email heryernawati@gmail.com atau hery_ernawati@umpo.ac.id

Pesan untuk para pembaca:

Membaca adalah jalan menuju profesionalitas»

PROFIL PENULIS



Sri Wianti, S.Kep., Ns., M.Kep. merupakan dosen tetap Program Studi Sarjana Keperawatan STIKES Panti Kosala Surakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan Diploma III Keperawatan di Akademi Keperawatan UBTH Tasikmalaya, kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Padjadjaran. Gelar Magister Keperawatan dengan peminatan Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan diperoleh dari Universitas Indonesia pada tahun 2016. Sejak memulai karier akademik pada tahun 2002, beliau aktif melaksanakan tridarma perguruan tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan bahan ajar dan publikasi ilmiah. Pengalaman akademiknya juga mencakup berbagai amanah struktural, antara lain sebagai Kepala Laboratorium Keperawatan, Sekretaris Program Studi, dan Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan. Bidang minat dan kepakaran yang ditekuni meliputi manajemen keperawatan, kepemimpinan, komunikasi keperawatan, pendidikan keperawatan, serta pelayanan keperawatan holistik dan paliatif. Melalui kegiatan akademik dan profesional, beliau berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan dan pembentukan perawat yang kompeten, beretika, dan berorientasi pada pelayanan yang berpusat pada pasien.

Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik: sriwianti17@gmail.com.

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Paliatif disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep dan penerapan asuhan keperawatan paliatif secara holistik. Buku ini membahas perawatan bagi pasien dengan penyakit kronis, progresif, mengancam jiwa, maupun pasien pada fase akhir kehidupan, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas hidup, pengurangan penderitaan, pengendalian gejala, serta dukungan kepada pasien dan keluarga.

Materi dalam buku ini mencakup konsep dasar keperawatan paliatif, pengkajian holistik, manajemen nyeri dan gejala, komunikasi terapeutik, dukungan psikologis, sosial, spiritual, budaya, serta aspek etik dan legal dalam pengambilan keputusan paliatif. Buku ini juga menekankan pentingnya peran perawat dalam memberikan asuhan yang empatik, menghormati martabat pasien, menjaga kenyamanan, mendampingi keluarga, serta berkolaborasi dengan tim kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pasien secara menyeluruh.

Melalui buku ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan kemampuan berpikir kritis dalam memberikan asuhan keperawatan paliatif. Buku ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pembelajaran teori, diskusi kasus, praktik laboratorium, maupun praktik klinik, serta menjadi referensi bagi dosen, praktisi keperawatan, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan paliatif yang aman, humanis, dan bermartabat.

Buku Ajar Keperawatan Paliatif disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep dan penerapan asuhan keperawatan paliatif secara holistik. Buku ini membahas perawatan bagi pasien dengan penyakit kronis, progresif, mengancam jiwa, maupun pasien pada fase akhir kehidupan, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas hidup, pengurangan penderitaan, pengendalian gejala, serta dukungan kepada pasien dan keluarga.

Materi dalam buku ini mencakup konsep dasar keperawatan paliatif, pengkajian holistik, manajemen nyeri dan gejala, komunikasi terapeutik, dukungan psikologis, sosial, spiritual, budaya, serta aspek etik dan legal dalam pengambilan keputusan paliatif. Buku ini juga menekankan pentingnya peran perawat dalam memberikan asuhan yang empatik, menghormati martabat pasien, menjaga kenyamanan, mendampingi keluarga, serta berkolaborasi dengan tim kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pasien secara menyeluruh.

Melalui buku ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan kemampuan berpikir kritis dalam memberikan asuhan keperawatan paliatif. Buku ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pembelajaran teori, diskusi kasus, praktik laboratorium, maupun praktik klinik, serta menjadi referensi bagi dosen, praktisi keperawatan, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan paliatif yang aman, humanis, dan bermartabat.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-86-2 (PDF)



9

786347

756862